



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN OKTOBER
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang..... 2

2.1 Visi..... 2

2.2 Misi 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama..... 2

2.5 Struktur Organisasi..... 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 4

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 10

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik..... 10

3.3.2 Rawat Inap 12

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 20

3.3.4 High Care Unit (HCU) 21

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 22

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 23

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 25

3.4.1 Instalasi Farmasi 25

3.4.2 Laboratorium 31

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran..... 33

3.4.4 Radiologi 35

3.4.5 Gizi 38

3.4.6 CSSD - Laundry 40

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan 43

3.5.1 SDM 40

3.5.2 MFK dan K3RS 51

3.5.3 Security 56

3.5.4 Parkir 59

3.5.5 Humas Marketing 55

3.5.6 Penjaminan 60

3.5.7 PIPP – MOD - MPP 66

3.5.8 *Cleaning Service* 76

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum..... 78

3.6 Komite dan Tim 80

3.6.1 Komite Mutu 80

3.6.2 Komite PPI..... 115

3.6.3 Tim PKRS..... 127

3.6.4 Tim Prognas 130

3.6.5 Tim PPRA..... 167

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 173

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 175

3.8 Profil SDM 183

Bab IV Kesimpulan dan Saran..... 188

Bab V Penutup 189

LAMPIRAN..... 191

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Oktober Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



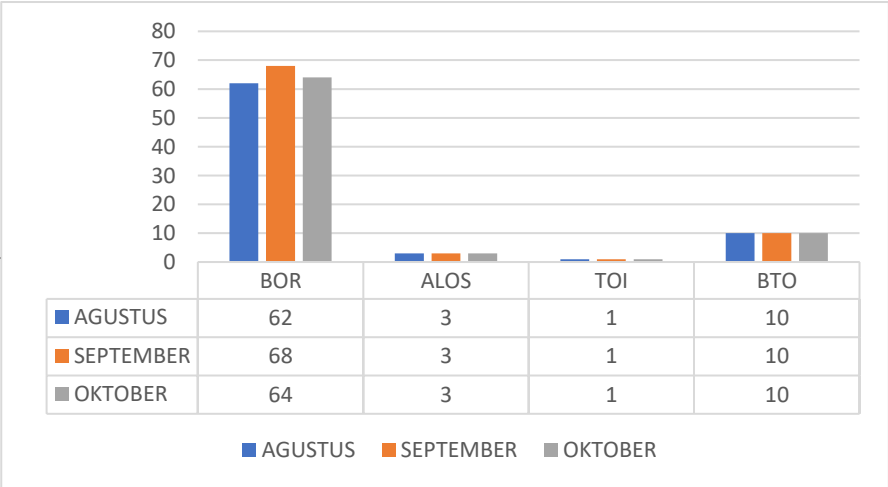
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
1	BOR	62	68	64
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	1	1	1
4	BTO	10	10	10

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



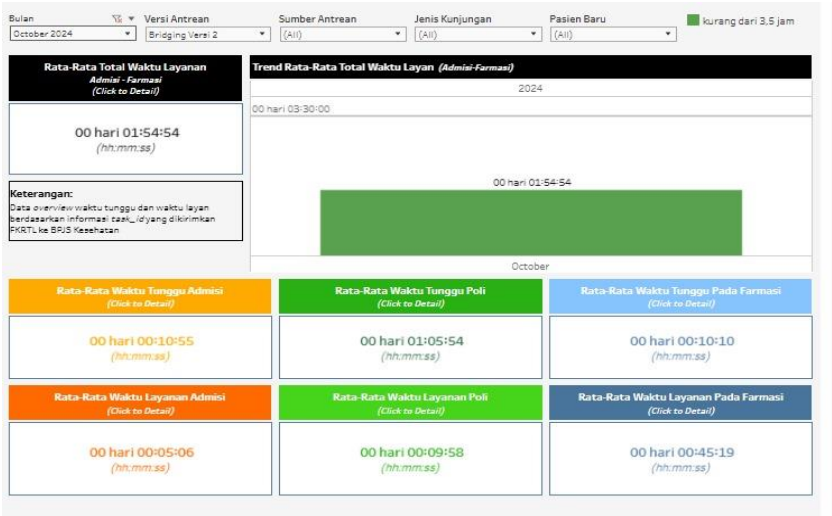
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

BOR mengalami penurunan dengan persentase sebesar 5,8% diakibatkan oleh karena menurunnya jumlah pasien yang dirawat inapkan. Hal ini karena regulasi BPJS yang semakin ketat dalam indikasi rawat inap.

ALOS masih tetap berada pada rata-rata 3 hari, yang masih berada di bawah standar 6-12 hari. Hal ini disebabkan karena pasien dominan jaminan BPJS, dimana terdapat keterbatasan plafon sehingga pasien yang sudah stabil dapat dipulangkan pada hari rawat ketiga hingga empat.

TOI masih relative sama dengan bulan sebelum-sebelumnya. BTO atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode berada pada sepuluh kali sedang standardnya yaitu 40-50 kali.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2024)			
	Waktu Rata-Rata	Rata-Rata Tahun 2023	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Total Waktu Layanan	02.17.21	01.56.32	01.47.49	02.01.40	01.54.54
2	Waktu Tunggu Admisi	00.17.46	00.07.29	00.09.10	00.11.18	00.10.55
3	Waktu Layanan Admisi	00.06.31	00.07.00	00.08.00	00.05.00	00.05.06
4	Waktu Tunggu Poli	01.05.06	01.02.53	01.05.15	01.02.43	01.05.54
5	Waktu Layanan Poli	00.15.40	00.16.25	00.17.00	00.13.25	00.09.58
6	Waktu Tunggu Farmasi	00.17.05	00.13.41	00.13.39	00.13.45	00.10.10
7	Waktu Layanan Farmasi	00.49.32	00.48.20	01.04.36	00.56.54	00.45.19

Analisis :
 Pada bulan Oktober 2024, total waktu layanan lebih baik karena mengalami penurunan waktu dibanding bulan sebelumnya dan masih dibawah rata-rata tahun 2023.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	JENIS	Target	MAR 24	APR 24	MEI 24	JUNI 24	JULI 24	AGT 24	SEP 24
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	34.86%	37.2%	34.88%	Tidak ada	37.82%	37.72%	39.21%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	94.57%	96.2%	94.62%	Tidak ada	94.9%	95.21%	95.64%

Analisis :
 Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 3x seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil	Senam hamil berjalan rutin	-
3	IRJA	Poli Eksekutif	Jumlah pasien menurun dibanding September karena harga kembali ke harga normal. Namun, mengalami peningkatan dibanding bulan Agustus yang notabene menggunakan harga promo	Hanya pasien ibu dan anak yang tertarik ke poli Sakura
4	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Membuat video edukasi	Sebelumnya sudah kordinasi dengan Kabid umum, akan di TL
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1. Website Primantara	1. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23-09-2024 2. Proses penyelesaian oleh Programmer PT.	Dalam antrian programmer.
		2. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	1. TTD elektronik untuk pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. 2. TTD elektronik untuk pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien pulang rawat inap masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan programer.	Dalam antrian programmer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		3. Fitur Iterisasi pada SIMRS	1. Fitur obat iter memudahkan untuk melayani resep	Monitoring dan evaluasi sistem elektronik

			iterisasi. 2. Melakukan rekap target resep ITER per DPJP. 3. Rekap jumlah pasien ITER per bulan : Agustus 2024 : 141. September 2024 : 134.	
		4. KPO elektronik (e-KPO)	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. Pengajuan ke progamer untuk dibuatkan fitur e-KPO yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien.	Dalam antrian programmer.
		5. Pengadaan LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.	1. Koordinasi dengan Kains Farmasi untuk melakukan pengajuan proposal ke PT terkait pemindahan ruang LAF, yaitu rencana diajukan di Lantai Maternitas (ex IKO Covid). 2. Proposal pengajuan sudah diterima PT → ACC	Dalam proses renovasi sebagai persiapan AKRE pada akhir Tahun 2026.
2	Gudang Farmasi	1. Repack sediaan farmasi sharing dose.	Repack sudah berjalan, tarif repack sudah ada.	1. Tidak ada lemari asam, sehingga repack formalin ditiadakan. 2. Alcohol repack terlalu kecil tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Stardine repack fastmoving.
		2. Scan Barcode	1. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT. 2. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04-10-2024.	Menunggu ACC.

			3. Sudah pengajuan kebutuhan alat.	
3	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada tanggal 19-10-2024.	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis.
		2. Serah terima DRM menggunakan system digital.	Serah terima menggunakan spreadsheet (sudah berjalan).	Monitoring dan Evaluasi.
		3. Permintaan form menggunakan system digital.	Permintaan form dari unit menggunakan google form, sudah berjalan mulai Bulan Juni 2024.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Dokumentasi DRM lama	1. Melakukan scanning form kedalam SIMRS. 2. Tarikan data bisa diambil pada rekap kunjungan di SIMRS. 3. Menunggu programmer membuatkan fitur scanning.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
4	Radiologi	Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Pengadaan BDRS.	1. Proposal dan surat permintaan pelatihan sudah dibuatkan. 2. Sudah ada daftar kebutuhan pengadaan BDRS dan sudah diajukan, menunggu penawaran. 3. Penyekatan ruangan	Progress BDRS : 1. Refrigerator proses dibuatkan PJB (Perjanjian Jual Beli) oleh PT, estimasi datang minggu kedua di Bulan November 2024.

			BDRS sudah dilakukan. 4. Legalitas dibantu pengurusan oleh Legal PT. 5. Review tarif disesuaikan dengan PHS.	2. KSO alat dengan PT Mutual Bahtera Santoso.
6	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan.	1. Kolaborasi dengan Humas&Marketing. 2. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.
		3. MCU Gizi.	Rencana diajukan review tarif ke Keuangan PT.	Dalam Proses.
		4. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
7	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilikator (steam plasma).	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.
		2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli.	1. Kolom tidak terisi lengkap. 2. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
8	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk permintaan linen.	Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. Belum terealisasi.	Dalam proses.
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP.	Dalam Proses.
9	Lain-lain	Rapat Bulanan masing-masing Unit dengan Kabid.	Dilakukan per Bulan November 2024. Supervisi pemahaman pelaksana tentang pedoman pelayanan, pengorganisasian, dan	Berkala.

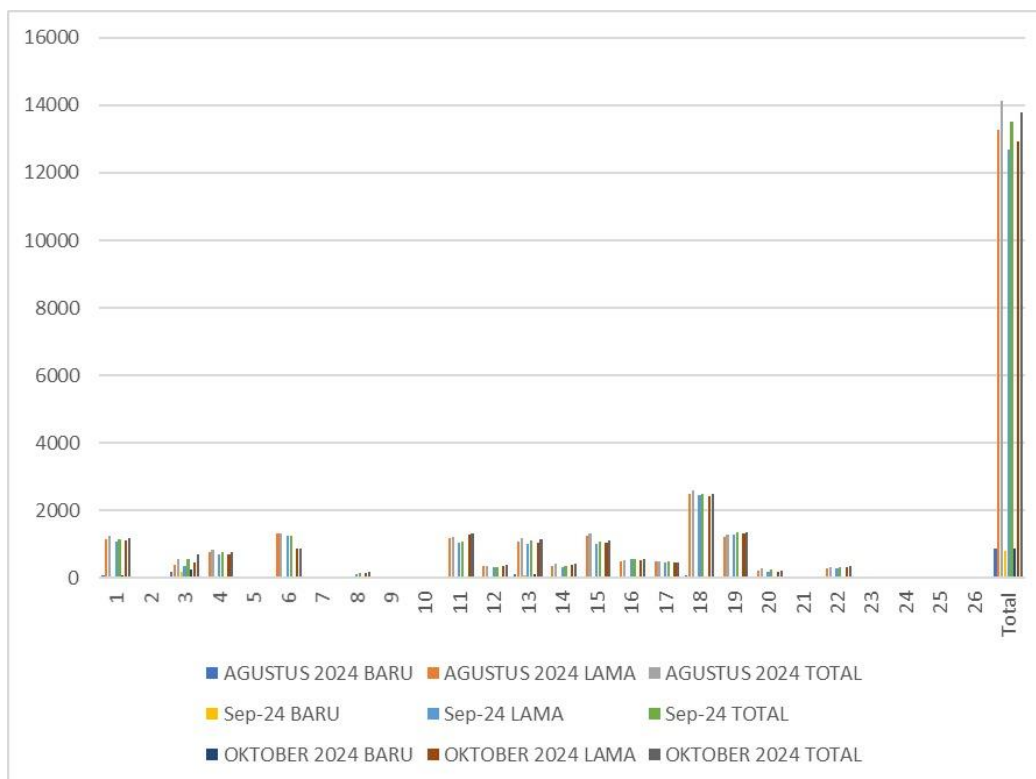
			pelayanan sesuai dengan akreditasi. Pelaksanaan : 1) Tanya Jawab 2) Role Play	
--	--	--	---	--

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	AGUSTUS 2024			SEPTEMBER 2024			OKTOBER 2024		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	97	1164	1261	58	1090	1148	69	1122	1191
2	Anak sakura	1	2	31	1	7	8	0	6	7
3	IGD	179	379	558	196	371	567	249	455	704
4	Klinik Bedah	48	775	823	44	710	754	43	715	758
5	Klinik Bedah Plastik	0	34	34	2	39	41	1	31	32
6	Klinik Fisioterapi	1	1309	1310	2	1257	1259	1	889	890
7	Klinik Gigi Periodonti	5	32	37	9	24	33	3	37	40
8	Gigi spesialis pedodontis	16	46	62	19	120	139	21	163	184
9	Gigi Ortodonti	4	15	19	5	11	16	1	10	11
10	Klinik Ibu dan Anak	0	6	6	0	15	15	0	12	12
11	Klinik Jantung	32	1181	1213	22	1051	1073	15	1303	1318
12	Klinik Jiwa	10	352	362	14	321	335	19	372	391
13	Klinik Kandungan	127	1070	1197	97	1016	1113	104	1061	1165
14	Klinik Kulit dan Kelamin	42	373	415	34	334	368	34	385	419
15	Klinik Mata	56	1250	1306	61	1024	1085	61	1054	1115
16	Klinik Orthopedi	20	508	528	31	549	580	27	542	569
17	Klinik Paru	10	484	494	18	468	486	12	454	466
18	Klinik Penyakit Dalam	71	2508	2579	58	2442	2500	51	2432	2483
19	Klinik Syaraf	51	1231	1282	49	1303	1352	46	1316	1362
20	Klinik THT	52	225	277	49	189	238	45	168	213
21	Klinik Umum	20	10	30	15	13	28	25	20	45
22	Klinik Urologi	28	291	319	26	285	311	25	332	357
23	Gizi	1	0	1	0	0	0	2	3	5
24	Bedah Saraf	2	19	21	2	21	23	1	22	23
25	Obgyn Sakura	3	5	8	5	18	23	2	12	14
26	Penyakit dalam sakura	0	2	2	0	0	0	0	2	2
Total		874	13274	14148	817	12678	13495	858	12918	13776



Analisis :

1. Kunjungan di bulan Oktober naik dari bulan sebelumnya, sebanyak 2% dari bulan september 2024. Analisnya karena bulan oktober 2024 terdapat 31 hari. Kunjungan tidak meningkat signifikan karena beberapa DPJP cuti dalam jangka waktu yang panjang seperti dr fachri SpBs, dr zora SpPD, dr Eko Sp.KFR,dr Oka, SpOT, dr Dewi, SPS dan dr Syharir,SpN
2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 283 pasien.Kunjungan tersebut menurun dari bulan sebelumnya sebanyak 2500 pasien,karena DPJP penyakit dalam (dr zorida, SpPD) cuti dan sebagian pasien IPD yang stabil sudah di PRB
3. Kunjungan poli gigi ortodonti masih sedikit,sebesar 11 pasien,karena hanya menerima pasien umum saja,dan tidak bisa melayani pemasangan behel atau kawat gigi.Sehingga hanya menangani kasus poli gigi non spesialis pada umumnya
4. Kunjungan poli pedodonti anak meningkat tiap bulanya sejak melayani pasien BPJS. Bulan oktober kunjungan poli gigi anak naik 12,96% di banding bulan sebelumnya
5. Kunjungan poli penyakit dalam dr ardany Sp.PD yang baru 2 minggu sudah mendapatkan 18 pasien karena selalu di dampingi oleh manajemen untuk mendapatakan pasien
6. Kunjungan poli sakura adalah 22 kunjungan. Kunjungan terbanyak adalah dari Obgyn sakura 14 pasien,anak Sakura 6 pasien, IPD sakura :2 pasien. Klinik IPD dr Zorida,SpPD, dr. Dewi, SpS dan dr syharir, SpN masih belum ada kunjungan bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :

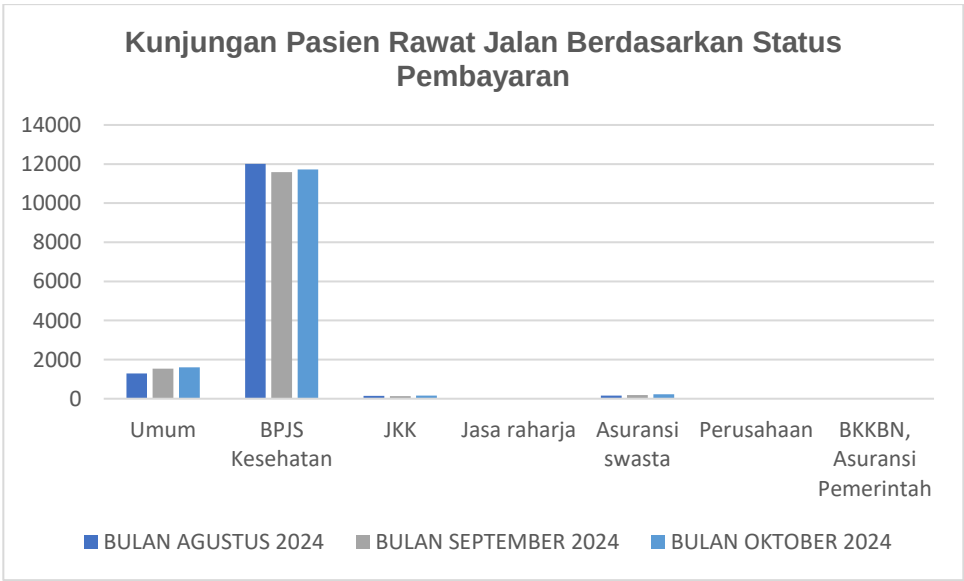
1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
2. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
3. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
4. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
5. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
6. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.
7. Sosialisasi pada komunitas pasien geriatri maupu prolanis klinis MS,bahwa dokter gigi ortodonti (perawat gigi) dan poli sakura

- 8. Sosialisasi pada perusahaan dan stakeholder bahwa ada poli sakura yang menyediakan layanan one stop service
- 9. Mengajukan pelayanan baru otho,bedah,uro dan kulit di Poli Sakura

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN AGUSTUS 2024	%	BULAN SEPTEMBER 2024	%	BULAN OKTOBER 2024	%
1	Umum	1287	9,65%	1536	11,38%	1601	11,38%
2	BPJS Kesehatan	12005	88,43%	11587	85,86%	11723	85,13%
3	JKK	150	0,82%	138	1,02%	162	1,18%
4	Jasa raharja	23	0,16%	15	0,11	14	0,11%
5	Asuransi swasta	156	1,14%	184	1,36%	227	1,65%
6	Perusahaan	19	0,23%	28	0,21	39	0,28%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	17	0,12	7	0,05%	5	0,05%
	Total	14148	100%	13495	100%	13771	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan pasien selama 3 bulan terakhir berdasarkan cara bayar menurun terutama pada bulan September 2024 menurun 4,8% penurunan 653 pasien dibandingkan Agustus 2024

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak.

3.3.2 Rawat Inap

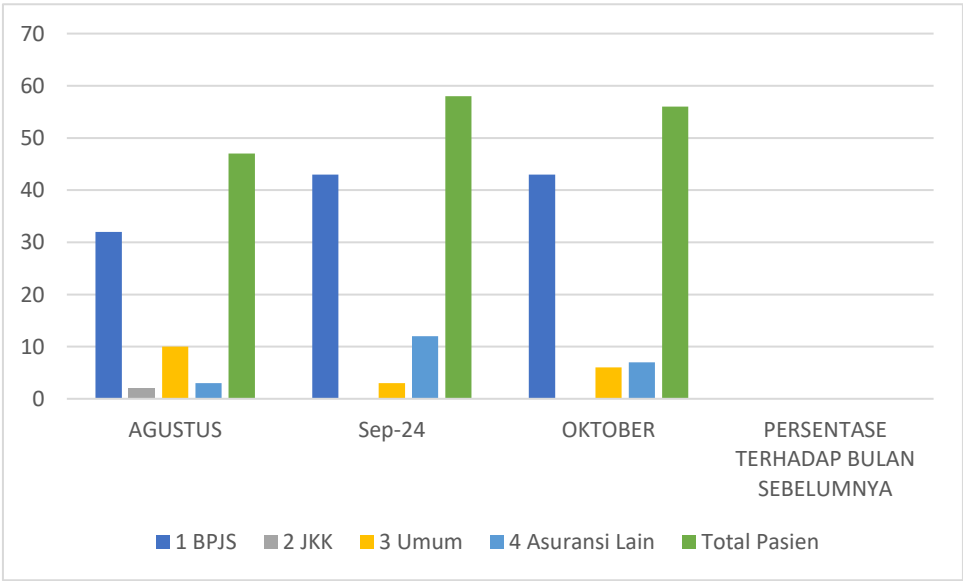
3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.3.2.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2024)

NO	HAL	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	32	43	43	0%
2	JKK	2	0	0	0% ↓

3	Umum	10	3	6	↑ 50%
4	Asuransi Lain	3	12	7	↓ 71%
Total Pasien		47	58	56	↓ 3,5

3.1.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Agustus - Oktober 2024)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

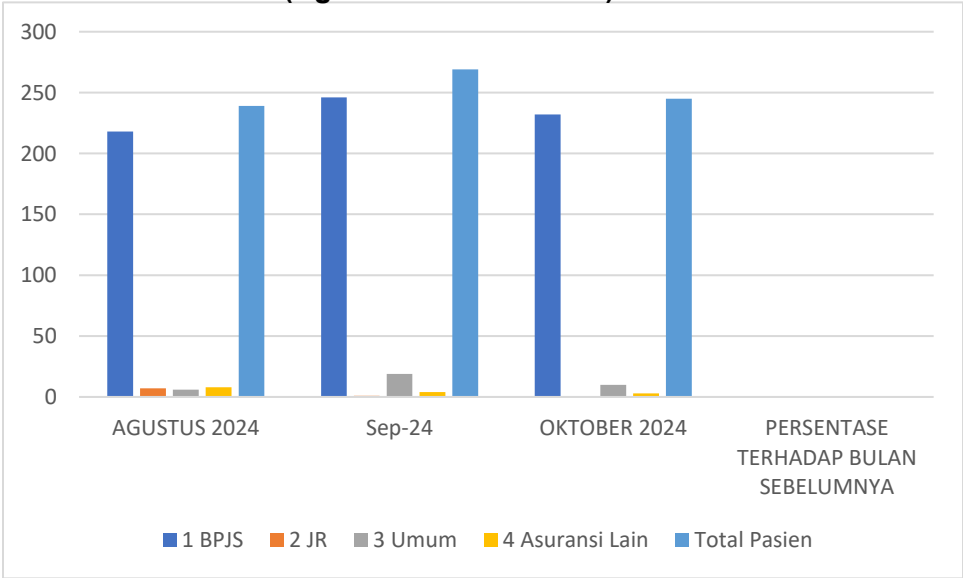
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Oktober 2024	43	6	0	7	56
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 masih tetap dari bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 50% dari bulan september 2024	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober tidak ada peningkatan	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 71% (5 pasien) dari september 2024	Total pasien bulan oktober mengalami penurunan 3,5% (2 pasien)dari bulan september 2024
	RTL	1. Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, 2. memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP 3. meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap 4. bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama peusahaan perusahaan yang baru 5. Meningkatkan pelayanan yang lebih ekstra kepada pasien 6. Mempromosikan ruangan vip/vvip lewat sosial media				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar
(Agustus-Oktober 2024)

NO	HAL	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	218	246	232	↓ 6%
2	JR	7	1	0	↓ 100%
3	Umum	6	19	10	↓ 90%
4	Asuransi Lain	8	4	3	↓ 33%
Total Pasien		239	269	245	↓ 9,7%

3.1.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Agustus-Oktober 2024)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

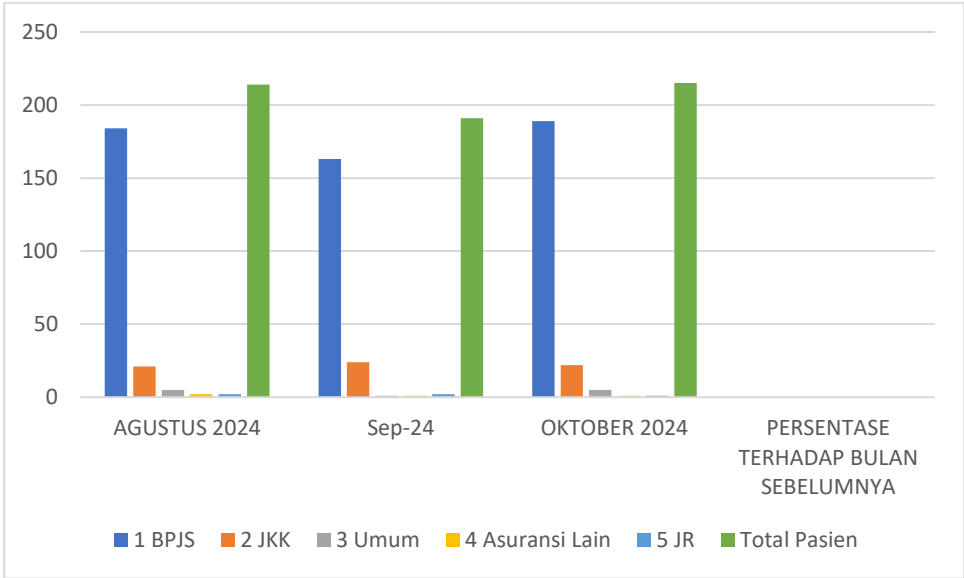
NO.	BULAN SEPTEMBER 2024	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 6% (14 pasien) dari bulan september 2024	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 90% (9 pasien)dari bulan september 2024	Pasien JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 100% (1 pasien) dari bulan september 2024	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 33% (1 pasien)dari bulan september 2024	Total keseluruhan bulan oktober mengalami penurunan 9,7% dari bulan september 2024 (24 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya 2.Memperbaiki setiap fasilitas yang ada di unit jika ada yang rusak 3. Promosi ruangan anak lewat media sosial ,tiktok dan IG 4. Harus mempunyai program untuk tahun 2025 terutama program taman bermain anak				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2024)

NO	HAL	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	184	163	189	↑ 15,9%
2	JKK	21	24	22	↓ 9,0%
3	Umum	5	1	5	↑ 400%
4	Asuransi Lain	2	1	1	0%
5	JR	2	2	1	↓ 100%
Total Pasien		214	191	215	↑ 12,5%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2024)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

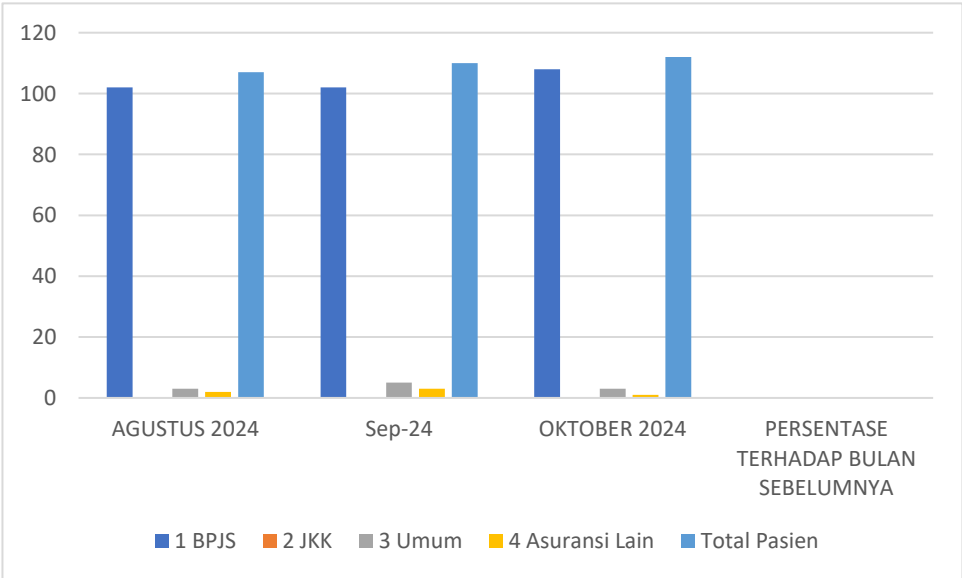
NO.	BULAN OKTOBER	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Oktober 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 15,9% (26 pasien) dari bulan september 2024	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 400% (4 pasien dari bulan september 2024)	Pasien JKK 3 dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 9% (2 pasien)dari bulan september 2024	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami penurunan 100% (1 pasien) dari bulan september 2024	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengalami peningkatan1 2,5% (24 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5.Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6.Pemberian edukasi yang baik				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.1.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2024)

NO	HAL	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	102	102	108	↑ 5,8%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	3	5	3	↓ 66,6%
4	Asuransi Lain	2	3	1	↓ 200%
Total Pasien		107	110	112	↑ 1,96%

3.1.1.1.3 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2024)



3.1.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN OKTOBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan oktober meningkat 5,8%(6 pasien) dari bulan september 2024 di karenakan banyaknya kunjungan pasien BPJS kelas 1 dan pasien TB	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami penurunan 66,6% (2 pasien) di bandingkan bulan september 2024, di karenakan kunjungan di IGD pasien umum tidak banyak untuk kelas 1	Dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien JKK	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 200% (2 pasien) di bandingkan bulan september 2024,di karenakan kunjungan di IGD pasien asuransi hanya rawat jalan	Pada bulan september total pasien mengalami peningkatan 1,96% (2 pasien)dari bulan september 2024
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

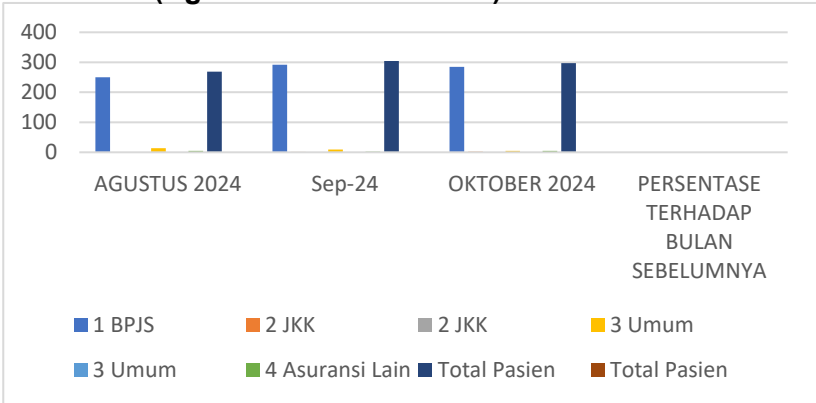
		2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5.Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6.Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada	
--	--	--	--

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.1.4 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2024)

NO	HAL	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	250	292	285	↓2,3%
2	JKK	0	1	2	↑ 100%
3	Umum	14	9	5	↓44,4%
4	Asuransi Lain	5	2	5	↑ 150%
Total Pasien		269	304	297	↓2,3%

3.1.1.1.5 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2024)



3.1.1.3.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

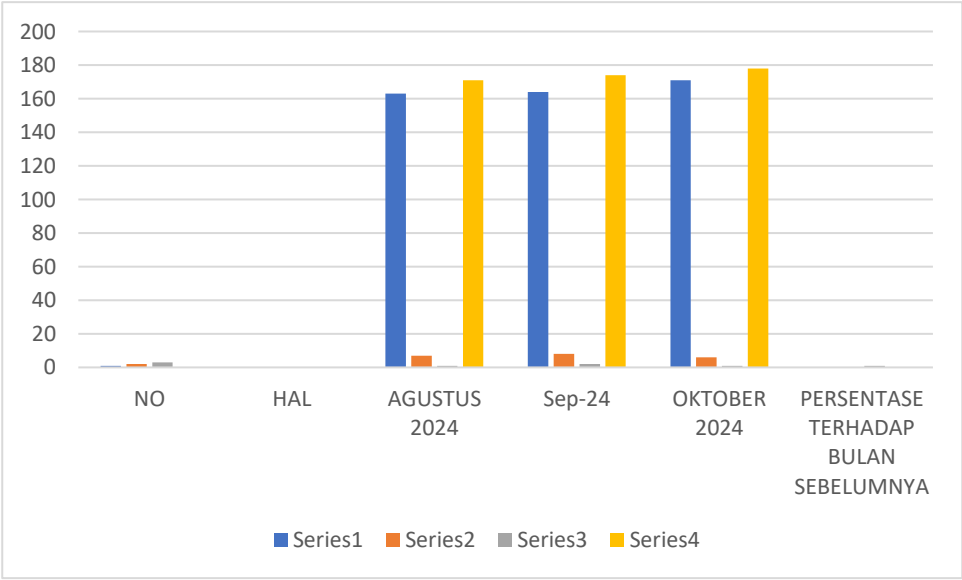
NO.	BULAN OKTOBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami penurunan 2,3% (7 pasien) dari bulan september 2024	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 44,4% (4 pasien)dari bulan september 2024	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 100% (1 pasien) dari bulan september 2024	Pasien Asuransi / JR mengalami dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 150% (3 pasien)dari bulan september 2024	Total semua pasien mengalami penurunan 2,3% dari september 2024
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5.Meningkatkan kualitas fasilitas di unit				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.1.6 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus - Oktober 2024)

NO	HAL	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	163	164	171	↑ 4,2%
2	Umum	7	8	6	↓ 25%
3	Asuransi	1	2	1	↓100%
Total Pasien		171	174	178	↑2,2 %

3.1.1.1.7 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus- Oktober 2024)



3.1.1.4.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Agustus - Oktober 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus untuk bulan oktober mengalami peningkatan 4,2% (7 pasien)dari bulan september 2024 di karenakan banyaknya rujukan dari bidan yang sudah di kunjungi oleh humas marketing rumah sakit	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 25% (2 pasien) di bandingkan bulan september 2024 di karenakan sebagian pasien dari rumah sakit prima husada sudah menggunakan kartu bpjs	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami penurunan 100% di bandingkan dengan bulan september 2024	Total pasien bulan september mengalami peningkatan 2,2% dari bulan september 2024 (4 pasien)
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa	

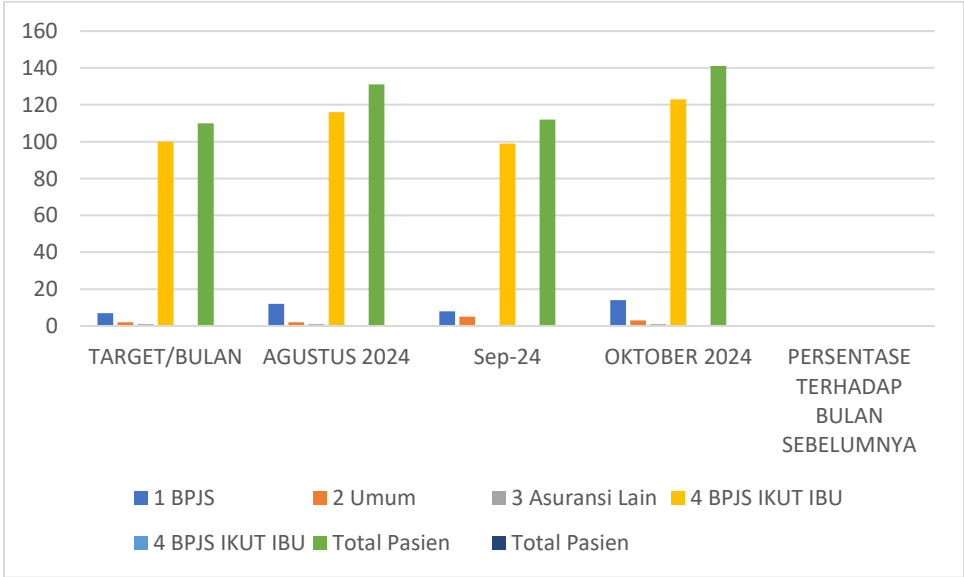
		bisa mencapai target disetiap bulan bekerja sama dengan humas marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan	bisa mencapai target disetiap bulan ,bekerjasama dengan humas marketing untuk posting di ig tentang pelayanan di maternitas	mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan setiap 1 tahun sekali	
--	--	---	---	---	--

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus- Oktober 2024)

NO	HAL	TARGET/BULAN	AGUSTUS 2024	SEPTEMBE R 2024	OKTOBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	12	8	14	↑ 75%
2	Umum	2	2	5	3	↓ 66,6%
3	Asuransi Lain	1	1	0	1	↑ 100%
4	BPJS IKUT IBU	100	116	99	123	↑ 24%
Total Pasien		110	131	112	141	↑ 25,9%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus- Oktober 2024)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	Oktober 2024	14	3	1	123	141
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan oktober mengalami peningkatan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami penurunan 66,6% (2 pasien) dari bulan september	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami peningkatan	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami peningkatan 24% (24 pasien) dari	Total pasien dalam bulan oktober 2024 mengalami peningkatan dari bulan september 25,9% (29 pasien)

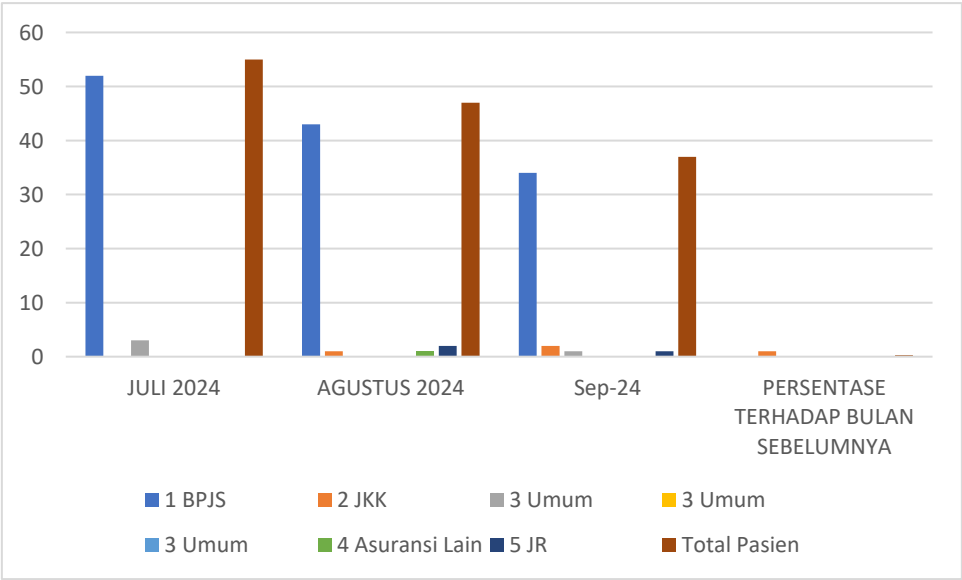
		75% (6 pasien)dari bulan september		100% dari bulan september 1 pasien	bulan september	
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, dan berkoordinasi dengan marketing untuk menginformasikan ke bidan bidan jejaring	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing, membuat program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing, membuat program foto bayi dari unit neo

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus-Oktober 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	September 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	52	43	34	↓26,4%
2	JKK	0	1	2	↑100%
3	Umum	3	0	1	↑ 100%
4	Asuransi Lain	0	1	0	↓ 100%
5	JR	0	2	1	↓ 100%
Total Pasien		55	47	37	↓27%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus-Oktober 2024)



3.1.1.2 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

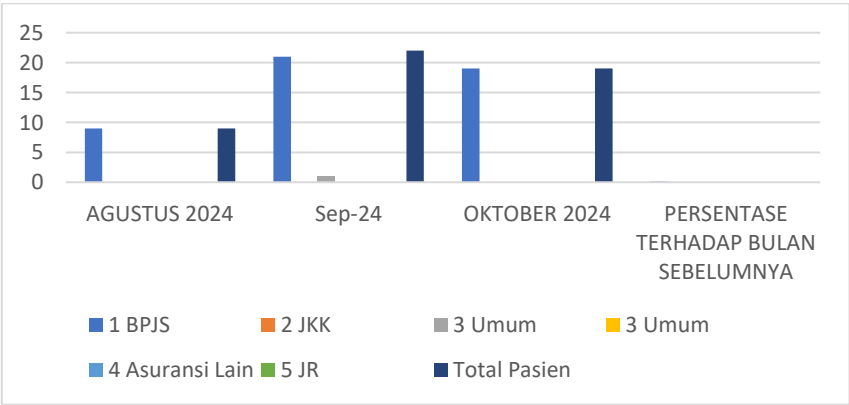
NO.	BULAN OKTOBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 26,4% (9 Pasien dari bulan september 2024 di karena DPJP memastikan plafon tinggi jika akan memasukan pasien ke ICU	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 100% (1 pasien)di bandingkan bulan september 2024	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan, untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 100%(1 pasien)di bandingkan bulan september 2024	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 100% (1 pasien) di bandingkan bulan september 2024	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien yang ada di ICU mengalami penurunan secara terus menerus untuk bulan oktober 2024 menurun 27% dari bulan september 2024 10 pasien
2	RTL	1.Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3.Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4.Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.1.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus-Oktober 2024)

NO	HAL	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	9	21	19	↓10%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	0	1	0	↓ 100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		9	22	19	↓ 10%

3.1.1.3 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus-Oktober 2024)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

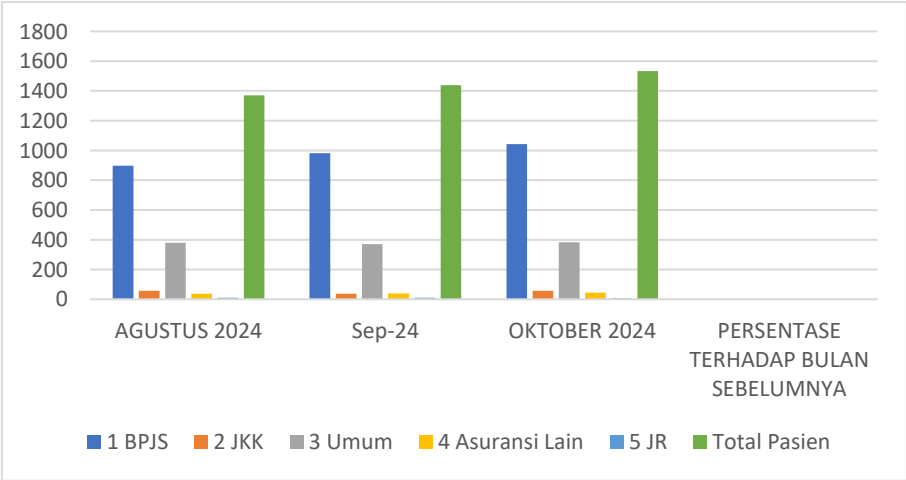
NO.	BULAN OKTOBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 10% (2 pasien)di bandingkan bulan september 2024 di karenakan pasien dari igd tidak ada indikasi pindah ke HCU	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 100% di bandingkan bulan september 2024	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien yang ada di HCU mengalami penurunan 10% (2 pasien) di bandingkan bulan september 2024
2	RTL	1.Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3.Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4.Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.1.4 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus – Oktober 2024)

NO	HAL	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	897	981	1043	↑ 6%
2	JKK	57	38	57	↑ 33%
3	Umum	379	371	384	↑ 3,38%
4	Asuransi Lain	37	39	44	↑ 11,36%
5	JR	10	10	6	↓ 66%
Total Pasien		1370	1439	1534	↑ 6,19%

3.1.1.5 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus – Oktober 2024)



3.1.3.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

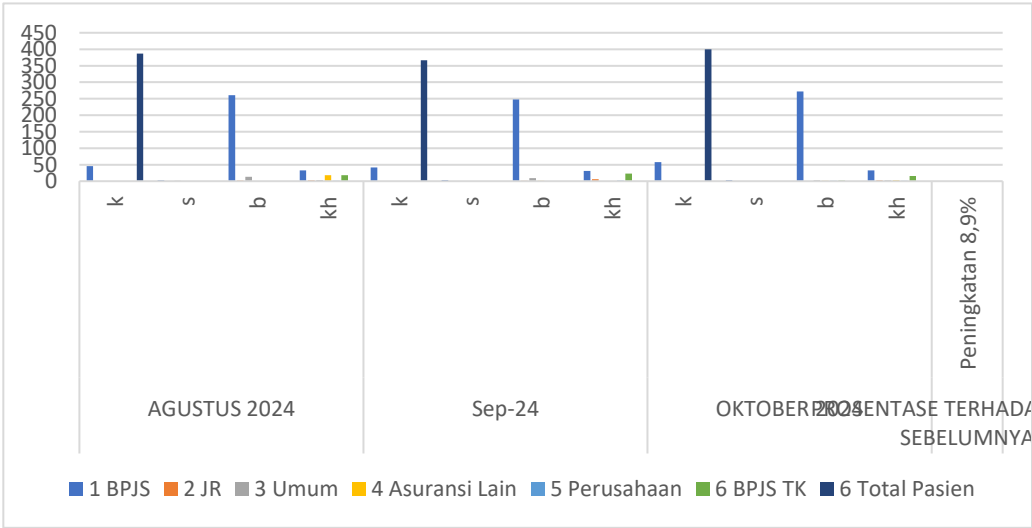
NO.	BULAN OKTOBER	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir belum stabil ,untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 6% (62 pasien)dari bulan september 2024 di karenakan respon IGD sudah sangat cepat jadi untuk perunjuk sennag dan terus merujuk	Kunjungan pasien UMUM 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 3,38% (13 pasien)dari bulan september 2024 karena banyak diagnosa yang tidak terkafer BPJS	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami peningkatan 33% (19 pasien) dari bulan september 2024 di karenakan humas marketing yang selalu aktif jika ada pasien rencana rujuk ke prima husada malang	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 66% (4 pasien)dari bulan september 2024 di karenkan angka kecelakaan di wilayah malang utara yang turun	Total Kunjungan pasien IGD semua jaminan mengalami peningkatan di bandingkan bulan September 2024 6,19% (95 pasien)
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD dengan memperbaiki pelayanan dan mengurangi komplain serta bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.1.6 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Agustus-Oktober 2024)

NO	HAL	AGUSTUS 2024				SEPTEMBER 2024				OKTOBER 2024				PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh	
1	BPJS	46	3	26	33	4	4	24	31	58	4	272	33	Peningkatan 8,9%
2	JR	0	0	2	3	0	0	1	6	0	0	0	3	
3	Umum	0	1	13	4	0	0	9	0	0	0	3	3	
4	Asuransi Lain	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	1	3	
5	Perusahaan	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	
6	BPJS TK	0	0	0	18	0	0	0	23	0	0	2	16	
	Total Pasien	387				367				400				

3.1.1.7 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Agustus-Oktober 2024)



3.1.4.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN OKTOBER	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami peningkatan 8,9% (33 pasien) dari bulan september 2024 di karenakan lodingan bulan oktober meningkat dan banyaknya rujukan dari bidan	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penurunan 27,7 % (5 pasien) di bandingkan dengan bulan september 2024 di karenakan kunjungan di IGD juga menurun untuk pasien BPJS TK	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan oktober mengalami penurunan 50% dari bulan september 2024 di karenakan sebagian besar penduduk/ atau pelanggan rumah sakit prima husada sendiri mayoritas pasien BPJS	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober tetap dari bulan sebelumnya 2 pasien	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami penurunan 80% di bandingkan bulan september 2024 di sebabkan pasien jr menurun di IGD	Total pasien untuk bulan oktober 400 pasien meningkat 8,9%
2	RTL	1.Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2.Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vynil 3.Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4.Berkoordinasi dengan humas marketing,terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang					

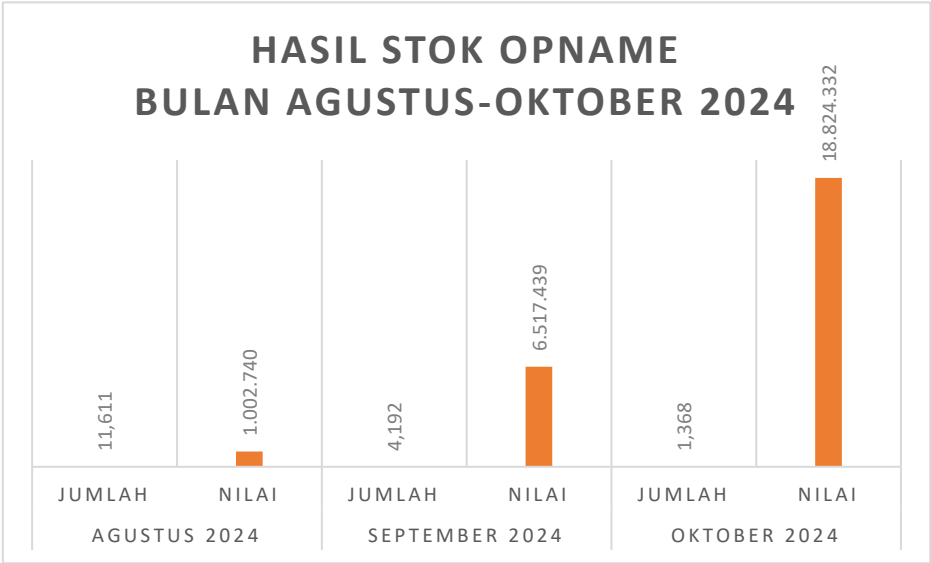
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Agustus-Oktober 2024

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH SEDIAAN					
		AGUSTUS 2024		SEPTEMBER 2024		OKTOBER 2024	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	Fisik	732.380	2.267.670.139	733.807	2.350.377.739	807.380	2.420.406.240
	Sistem	732.927	2.285.414.509	734.059	2.350.612.541	807.236	2.411.603.005
	Selisih	547	-17.744.369	-252	-234.802	144	+8.803.236
DEPO FARMASI	Fisik	147.379	519.778.015	141.256	513.820.725	144.667	497.691.225
	Sistem	136.326	510.064.361	136.874	508.681.432	143.338	491.060.927
	Selisih	11.053	+9.713.656	4.382	+5.139.293	1.331	+6.630.304
IKO	Fisik	2.479	111.929.273	2.275	99.246.881	2.304	104.523.149
	Sistem	2.490	102.895.820	2.213	97.633.933	2.411	101.132.358
	Selisih	11	+9.033.453	62	+1.612.948	107	+3.390.792
GUDANG RETUR	Fisik	0	0	0	0	0	0
	Sistem	0	0	0	0	0	0
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		11.611	+1.002.740	4.192	+6.517.439	1.368	+18.824.332

3.2.1.2. Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Agustus - Oktober 2024



3.2.1.2 Analisis dan Tindak Lanjut

NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
Gudang Farmasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +8.803.236 , hal ini disebabkan karena :		
1.	Master Barang Tidak Sesuai. Contoh : 3) F01175 CHARBACHOL MIO-CHOL dan F02242 CHARBACHOL. 4) Rak SO di system kode F01175 sedangkan fisik yg ada di gudang F02242. Sehingga selisih kurang 10 kode F01175.	Penonaktifan kode F01175 Charbachol dan untuk selanjutnya F02242 dimasukan ke dalam rak system.
2.	Penyebab selisih SO yang signifikan :	Evaluasi kinerja di Gudang Farmasi :

a. F02868 TONGUE SPATEL STAINLESS Terdapat selisih kurang 100 pcs. SO dari September di kartu stok 300 pcs tetapi inputan 400 pcs. Barang tidak ada mutasi selama Bulan Oktober 2024, stok fisik tetap 300 pcs. b. ACARBOSE tab 50 mg Gudang Farmasi selisih kurang 100 tab, depo selisih lebih 100 tab. Tidak dilakukan release. c. F01986 SPUIT 10 CC - GIDCARE Gudang Farmasi selisih kurang 200 pcs, Depo Farmasi selisih lebih 134 pcs. d. F01978 SPUIT 10 CC - TERUMO Gudang Farmasi lebih 100pcs, Depo Farmasi selisih kurang 48pcs. e. PDS II VIO 5/0 70 CM Z1013H Terdapat selisih lebih fisik 1 box (36pcs). f. SPUIT 5 CC - GIDCARE F01992 Terdapat selisih lebih 100pcs. g. MASKER KARET – GIDCARE Terdapat selisih lebih 6box (300pcs).	Pada Bulan Oktober 2024, petugas Gudang hanya 2 orang, dimana admin sebelumnya resign. 1) Analisa Beban Kerja kurang, per Bulan November 2024 ditambahkan admin dengan kualifikasi Pendidikan SMA (rotasi dari CSSD). 2) Melakukan teguran lisan kepada petugas baru yang sebelumnya juga dirotasi, untuk meningkatkan ketelitian dalam penginputan dan release stok. 3) Melakukan pengajuan scan barcode untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien.
Depo Farmasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +6.630.304, hal ini disebabkan karena :	
1. Kartu stok belum berjalan maksimal. Kartu stok tidak di rekap setelah akhir shift Contoh : ACETYLCYSTEINE CAPS 200 mg.	1) Meningkatkan kedisiplinan petugas dalam menuliskan kartu stok, dilakukan arsip setiap akhir bulan. 2) Menunjuk PJ Supervisi setiap shift, yaitu Apoteker untuk mengawasi pelaksana dalam menulis kartu stok. 3) Melakukan random stok sediaan farmasi yang keluar pada saat itu, dan melakukan teguran langsung kepada petugas yang berdinasi. 4) Penulisan kartu stok wajib ditulis sisa stok setiap kali ambil obat untuk mempermudah perhitungan.
2. Terjadi kesalahan input barang rusak : Contoh : ACTIMOVE CERVICAL COLLAR MEDIUM L 2pcs Kondisi barang baik.	1) Membuat BA penyesuaian stok. 2) Telusur petugas input SO dan konseling untuk melakukan setiap pekerjaan sesuai dengan SPO (evaluasi kinerja staff an Faiqotul).

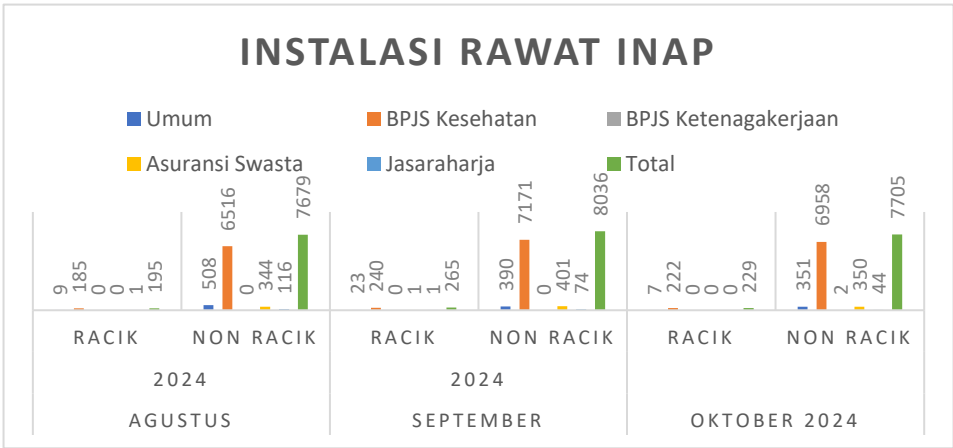
		3) Lakukan croscek dan validasi data inputan stok opname oleh Kains sebelum dilakukan Verifikasi oleh PT.
4.	Penyebab selisih SO yang signifikan : a. ACETYLCYSTEINE Caps 200mg. Selisih kurang 2 box (200 tab). Kartu stok tertulis 138 tab, buffer 200 tab. Total 338 tab sedangkan pada sistem 538tab. b. BISOPROLOL tab 5mg. Selisih kurang 131 tab. c. RAMIPRIL tab 10mg. Selisih kurang 111 tab d. SPIRONOLACTONE tab 100mg. Selisih lebih 96 tab. e. KETOROLAC Inj 30mg. selisih lebih 44 amp. f. ACARBOSE tab 50mg. Gudang Farmasi selisih kurang 100 tab, Depo Farmasi selisih lebih 100 tab. g. CLOPIDOGREL tab 75mg. Selisih lebih 187 tab. h. MINIASPI tab 80mg. Selisih lebih 100 tab. Fisik di box emergency indikasi bulan kemarin tidak ter-SO. i. HANDSCOON NON STERIL ukuran XS. Selisih lebih 327 pcs. j. JARUM NEOLUS 25 G X 1". Selisih lebih 117pcs.	1) Melayani permintaan barang sesuai dengan inputan kecuali IGD. 2) Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan untuk mendisiplinkan perawat IGD untuk melakukan inputan barang yang sudah diambil sesuai dengan resep manual tanpa diubah jumlahnya dan melakukan retur sesuai dengan nama pasien. 3) Melakukan cek monitoring stok setelah permintaan barang ke Gudang Farmasi, untuk double cek apakah petugas Gudang farmasi sudah melakukan release atau belum. 4) Penulisan kartu stok wajib ditulis sisa stok setiap kali ambil obat untuk mempermudah perhitungan.
Instalasi Kamar Operasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +3.390.792, hal ini disebabkan karena :		
1.	Masih banyak ditemukan selisih barang di IKO. Penyebab : a. Masih ditemukan barang return yang tidak jadi digunakan saat operasi dan di tandon dalam ruang OK. b. Tidak semua perawat patuh dalam melakukan inputan resep obat dan BHP terlebih dahulu sebelum disiapkan oleh Farmasi.	Melakukan rapat dengan IKO untuk membuat kesepakatan alur : 1) Jika ada operasi cito dari IGD, pastikan billing pasien sudah dipulangkan dan dikunjungi rawat inap untuk memudahkan petugas IKO melakukan input resep dan BHP terlebih dahulu, jika belum maka petugas IGD memulangkan pasien dan koordinasi dengan Pendaftaran IGD untuk merawat inapkan. 2) Jika TTK IKO tidak ada maka petugas IKO melakukan penyiapan sesuai dengan inputan dan menyerahkan nota resep untuk dilakukan validasi oleh TTK IKO (cek kartu stok dan barang). 3) Mengumpulkan barang yang tidak terpakai dan dalam keadaan utuh didalam satu keranjang per nama pasien untuk dilakukan retur oleh TTK IKO. 4) Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan untuk melakukan supervise IKO. 5) Perawat Shift Malam bisa melakukan screanshoot resep dan dikirim ke HP untuk membantu dalam penyiapan

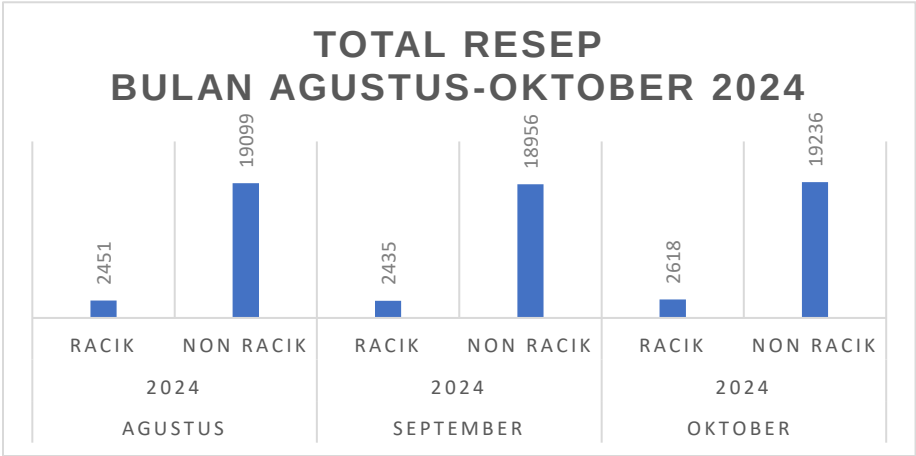
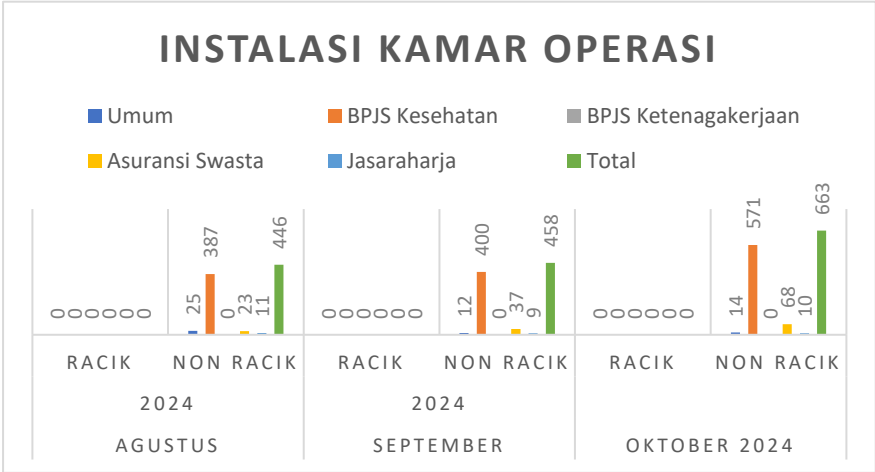
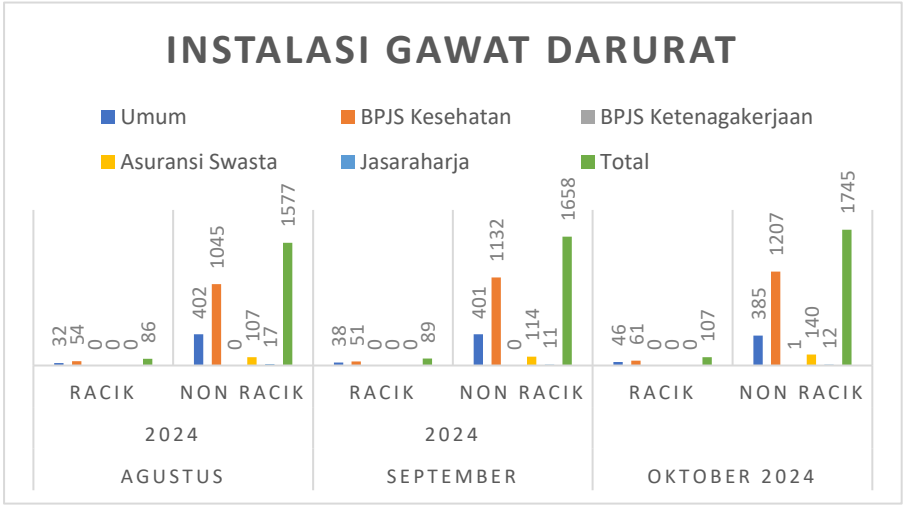
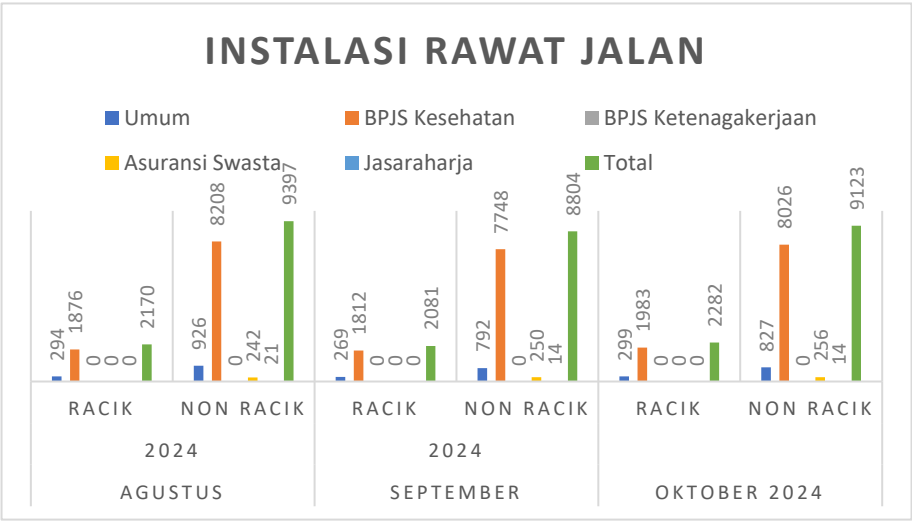
		obat selama belum ada printer nota resep, tidak lagi memanggil TTK Depo Farmasi.
Gudang Retur Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah mencapai target, namun masih ada kendala saat stok opname yaitu :		
1.	Tidak terdapat rak Gudang Retur	1) Sentralisasi master barang PT. DPM dan mengajukan gudang retur kembali dimunculkan. 2) Meminimalisasi obat tertinggal dengan cara pengantaran obat, mendata nama pasien dan poli spesialis untuk diserahkan ke DPJP supaya pasien diedukasi saat control ulang.

3.2.1.3 Tabel Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Agustus – Oktober 2024

NO	UNIT	PENJAMIN	BULAN/JENIS RESEP					
			AGUSTUS 2024		SEPTEMBER 2024		OKTOBER 2024	
			RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
1.	IRNA	Umum	9	508	23	390	7	351
		BPJS Kesehatan	185	6516	240	7171	222	6958
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	2
		Asuransi Swasta	0	344	1	401	0	350
		Jasaraharja	1	116	1	74	0	44
Total			195	7679	265	8036	229	7705
2.	IRJA	Umum	294	926	269	792	299	827
		BPJS Kesehatan	1876	8208	1812	7748	1983	8026
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	242	0	250	0	256
		Jasaraharja	0	21	0	14	0	14
Total			2170	9397	2081	8804	2282	9123
3.	IGD	Umum	32	402	38	401	46	385
		BPJS Kesehatan	54	1045	51	1132	61	1207
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	1
		Asuransi Swasta	0	107	0	114	0	140
		Jasaraharja	0	17	0	11	0	12
Total			86	1577	89	1658	107	1745
4.	IKO	Umum	0	25	0	12	0	14
		BPJS Kesehatan	0	387	0	400	0	571
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	23	0	37	0	68
		Jasaraharja	0	11	0	9	0	10
Total			0	446	0	458	0	663
Total Resep			2451	19099	2435	18956	2618	19236

3.2.1.4 Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Agustus – Oktober 2024





Analisis :

1. Hasil jumlah resep selama 3 bulan mengalami peningkatan jumlah resep pada Bulan Oktober 2024.
2. Kunjungan pasien umum pada Bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Bulan September 2024, dengan total resep yaitu : Bulan September sebanyak 1925 resep umum dan Bulan Oktober 2024 sebanyak 1929 resep umum. Peningkatan resep umum tidak signifikan, karena pada Bulan Agustus 2024 mencapai 2196 resep umum. Salah satu penyebabnya adalah pasien dengan kunjungan pertama menggunakan umum memilih pengurusan BPJS Kesehatan karena dijadwalkan control rutin oleh DPJP.
3. Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada Bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Bulan September 2024, dengan total resep yaitu : Bulan September 2024 sebanyak 18554 resep BPJS dan Bulan Oktober 2024 sebanyak 19028 resep BPJS.
4. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasaraharja pada Bulan Oktober 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Bulan September 2024, dengan total resep yaitu : Bulan September 2024 sebanyak 912 resep Asuransi Swasta dan Jasaraharja, sedangkan Bulan Oktober 2024 sebanyak 894 resep Asuransi Swasta dan Jasaraharja. Hal ini disebabkan, kunjungan pasien rawat inap dengan penjamin jasaraharja mengalami penurunan, penyebab lainnya pasien memilih menggunakan BPJS Kesehatan sebagai pilihan utama dibandingkan Asuransi Swasta dimana benefit yang didapat sesuai dengan diagnose yang tertera pada polis asuransi, dan berkompeten selisih biaya di akhir perawatan.
5. Secara keseluruhan total resep pada Bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan, hal ini ditunjang dengan peningkatan kunjungan pasien rawat jalan, namun kunjungan pasien rawat inap mengalami penurunan, karena diagnose pasien yang berkunjung di IGD bisa dilayani di Faskes Tingkat 1.
6. Kunjungan rawat jalan mengalami peningkatan dikarenakan ada Dokter Spesialis baru yang bergabung pada Bulan Oktober 2024.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di social media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
3. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
4. Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran IGD untuk menjaring pasien-pasien yang mempunyai jaminan Kesehatan lebih dari 1 untuk menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
5. Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
6. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
7. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru, jumlah pasien yang menggunakan layanan pengantaran obat pada Bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 1277 pasien.

3.1.1 Laboratorium

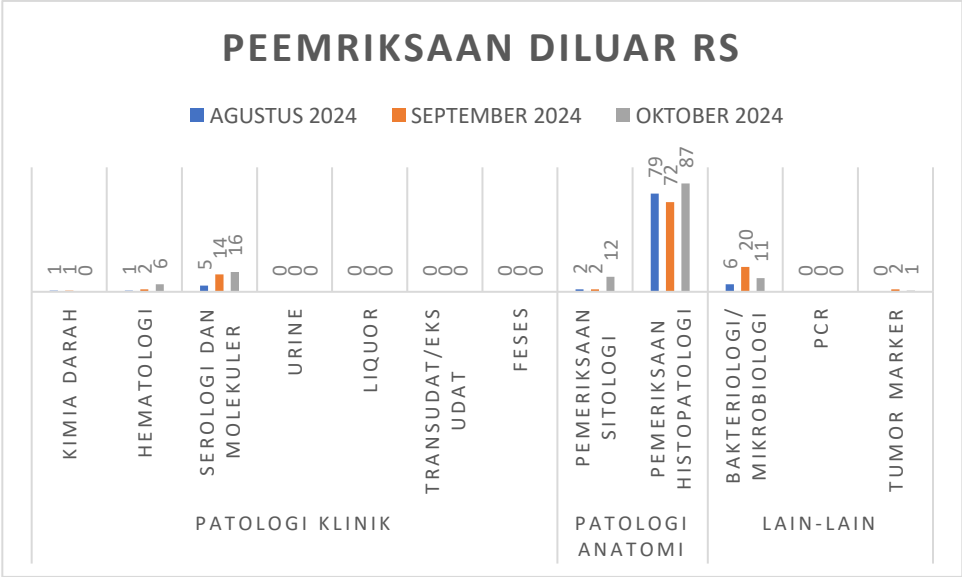
3.1.1.1 Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Agustus - Oktober 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
Dilakukan di RS				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4799	5063	4568
	Hematologi	2444	2441	2581
	Serologi dan Molekuler	453	522	536
	Urine	521	518	451
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	32	19	7
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	27	23	37
4.	Narkoba	35	21	23
5.	Covid-19	17	7	8
Dirujuk				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	1	1	0
	Hematologi	1	2	6
	Serologi dan Molekuler	5	14	16
	Urine	0	0	0
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	0	0	0
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	2	2	12
	Pemeriksaan Histopatologi	79	72	87
3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	6	20	11
4.	PCR	0	0	0
5.	Tumor Marker	0	2	1
6.	Cholinesterase	0	0	0

3.1.1.2 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit Bulan Agustus - Oktober 2024



3.1.1.1 Grafik Pemeriksaan Diluar Rumah Sakit Bulan Agustus - Oktober 2024



- Analisis :**
- 1. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, rincian Bulan Oktober 2024 yaitu :
 - a) Patologi Anatomi : 99 sampel
 - b) Patologi Klinik : 22 sampel
 - c) Bakteri/Mikrobiologi : 12 sampel
 - 2. Terjadi peningkatan rujukan pemeriksaan patologi anatomi pada Bulan Oktober 2024, yaitu Bulan September 2024 sebanyak 74 pemeriksaan sedangkan Bulan Oktober 2024 sebanyak 99 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit belum memiliki Laboratorium Patologi Anatomi, ditunjang dengan meningkatnya jumlah tindakan excise yang membutuhkan pemeriksaan penunjang.

Rencana Tindak Lanjut

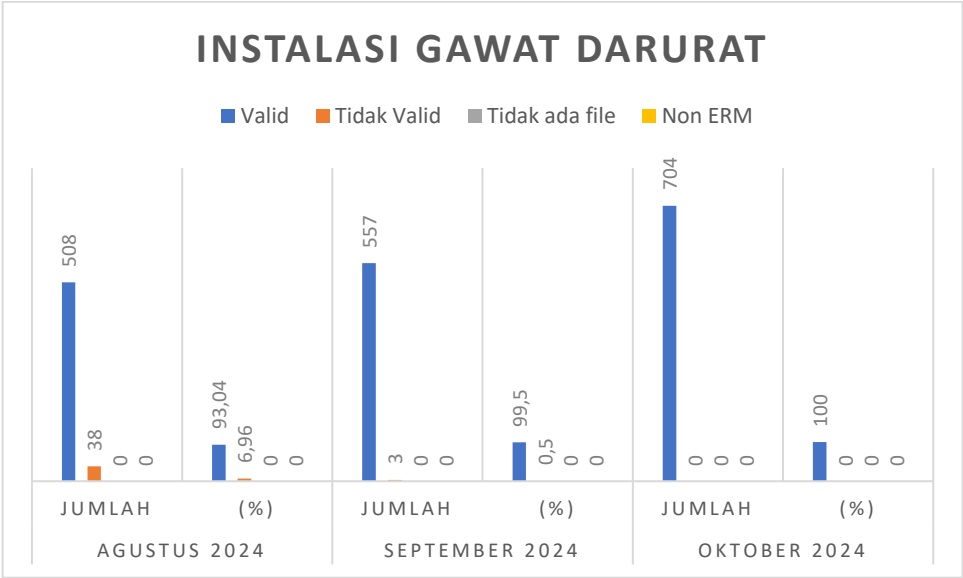
- 1. Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan BDRS di RS Prima Husada Malang, untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu.
Progress BDRS sampai dengan menunggu alat datang dan akan mengirimkan petugas laboratorium untuk magang di PMI Kepanjen.
- 2. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 3. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
- 4. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.

3.1.2 Rekam Medis – Pendaftaran

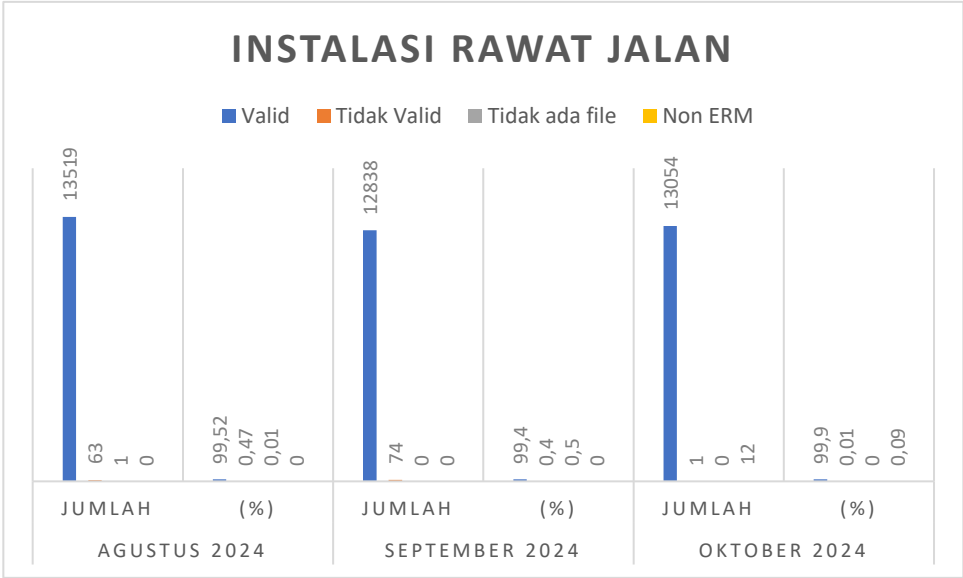
3.1.2.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Agustus - Oktober 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			AGUSTUS 2024		SEPTEMBER 2024		OKTOBER 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	508	93,04	557	99,5	704	100
		Tidak Valid	38	6,96	3	0,5	0	0
		Tidak ada file	0	0	0	0	0	0
		Non ERM	0	0	0	0	0	0
Total			546		560		704	
2.	IRJA/POLI	Valid	13519	99,52	12838	99,4	13054	99,90
		Tidak Valid	63	0,47	74	0,4	1	0,01
		Tidak ada file	1	0,01	0	0,5	0	0
		Non ERM	0	0	0	0	12	0,09
Total			13583		12912		13067	

3.1.2.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Agustus - Oktober 2024



3.1.2.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Agustus - Oktober 2024



Analisis :

1. Validasi Data E-RM di IGD sudah mencapai 100% dari 704 data yang diterima.
2. Capaian 100% validasi data E-RM di IGD dikarenakan temuan masalah seperti “Skrining IGD” yang masih kosong meskipun sudah diisi oleh perawat langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh programmer.
3. Pada Bulan Oktober 2024 tidak ditemukan tarikan data yang tidak ada file baik di IGD maupun di IRJA, yaitu 0%.
4. Masih ditemukan layanan IRJA yang belum E-RM, yaitu Poli KIA dan Poli Gizi.

Masalah :

1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
2. Pencatatan Poli Gizi masih menggunakan lembar konsultasi manual, resiko hilang dan tidak terekap dengan baik pada system sehingga DPJP tidak bisa membaca hasil pada Billing E-RM.
3. Ditemukan kunjungan Poli KIA saat petugas RM melakukan review dan belum masuk kedalam E-RM.
4. Berikut link permasalahan yang ditemui

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYgeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidaklengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
2. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
3. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat menyetorkan berkas ke kasir jaminan.
4. Pada akhir Bulan Oktober 2024 casemix yang disetor sudah tidak dicetak,

RS sudah menerapkan E-Casemix.

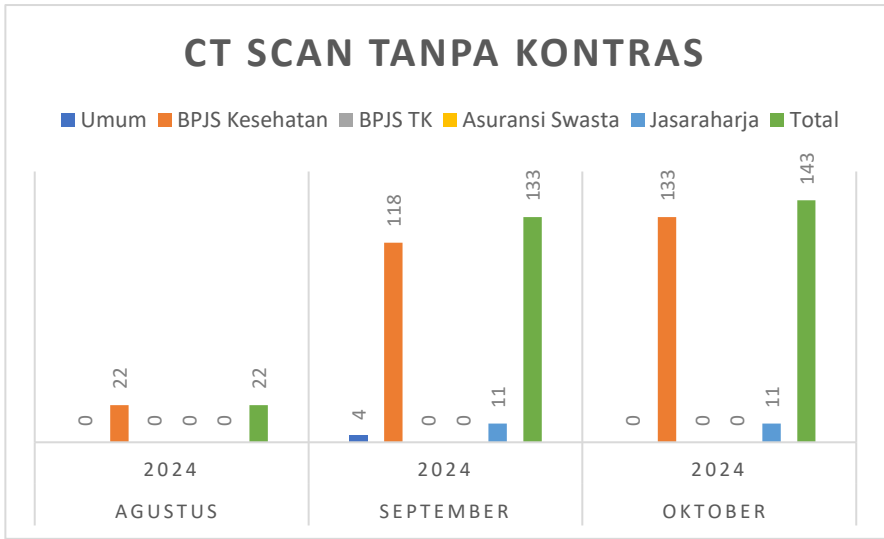
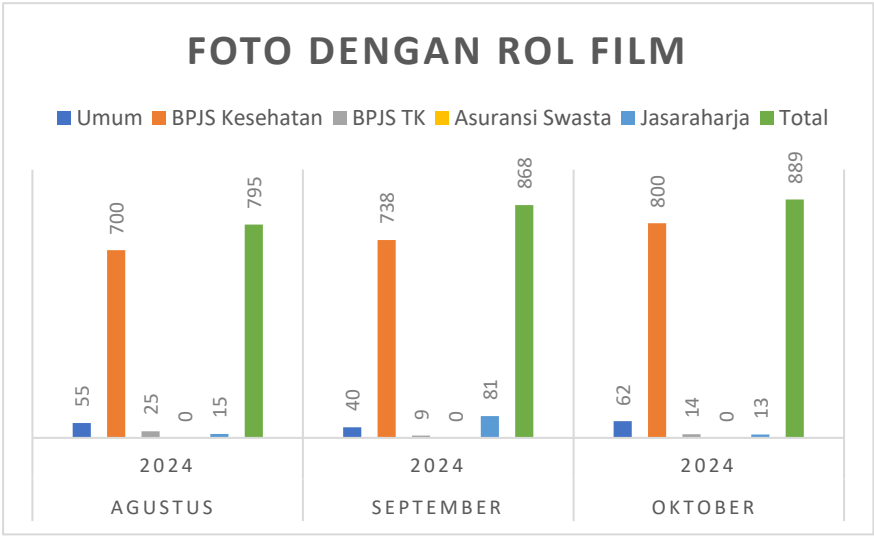
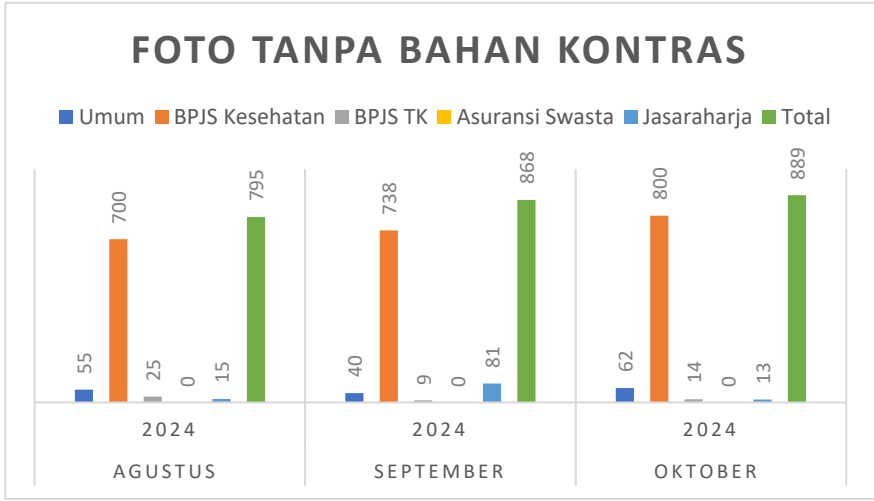
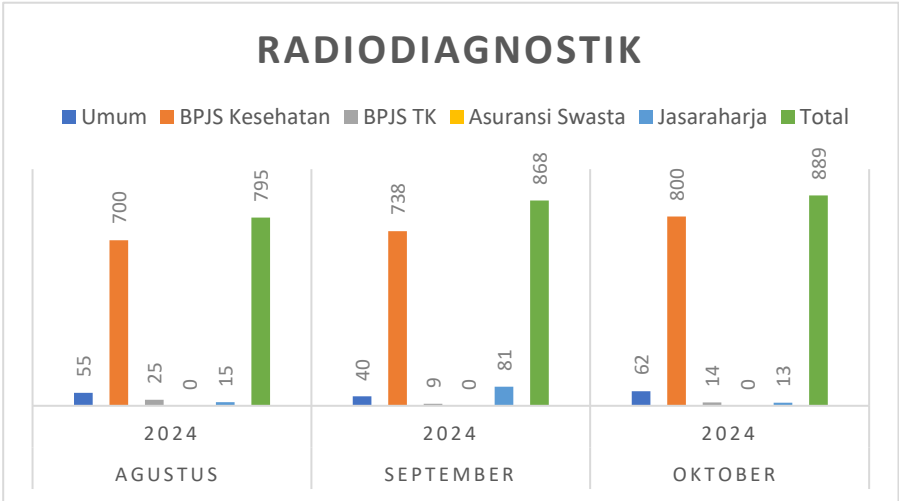
- 5. Melakukan pencatatan kunjungan pasien harian setiap DPJP pada google spreadsheet untuk dilakukan cek kesesuaian dan kelengkapan data oleh Petugas RM dan Verifikator RS.
- 6. Flow Chart alur pelayanan Poli Gizi sudah diberikan kepada Programmer PT.

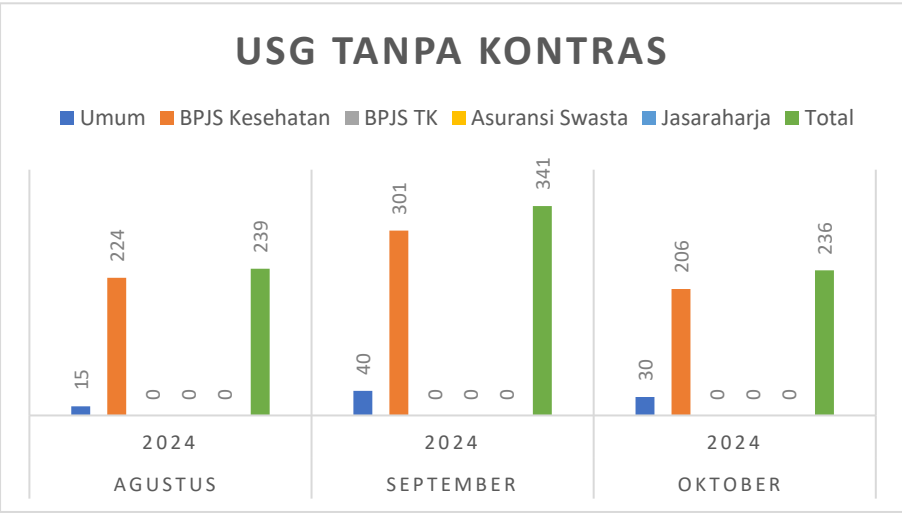
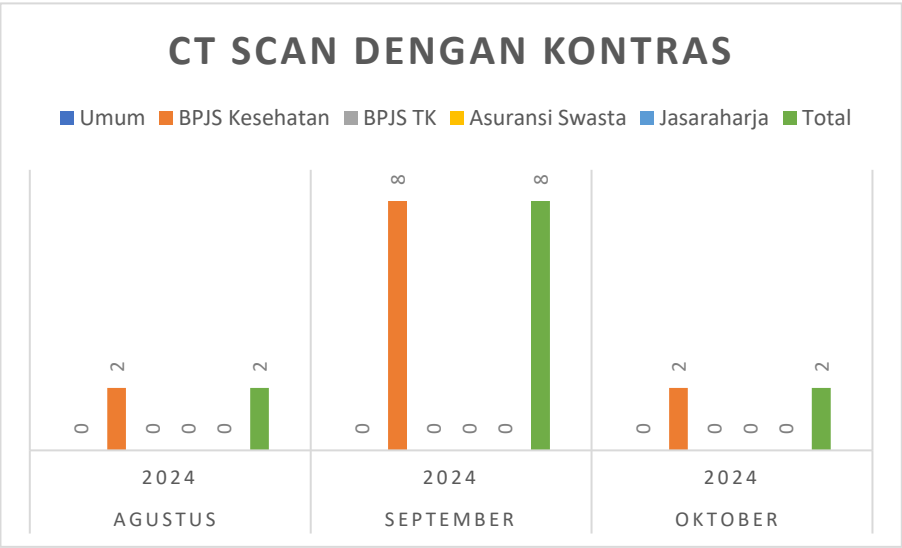
1.1.1 Radiologi

1.1.1.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Agustus-Oktober 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1.	Radiodiagnostik	Umum	55	40	62
		BPJS Kesehatan	700	738	800
		BPJS TK	25	9	14
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	15	81	13
	TOTAL		795	868	889
2.	Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	55	40	62
		BPJS Kesehatan	700	738	800
		BPJS TK	25	9	14
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	15	81	13
	TOTAL		795	868	889
3.	Foto Dengan Rol Film	Umum	55	40	62
		BPJS Kesehatan	700	738	800
		BPJS TK	25	9	14
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	15	81	13
	TOTAL		795	868	889
4.	CT Scan Tanpa Kontras	Umum	0	4	0
		BPJS Kesehatan	22	118	133
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	0	11	11
	TOTAL		22	133	143
5.	CT Scan Dengan Kontras	Umum	0	0	0
		BPJS Kesehatan	2	8	2
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	0	0	0
	TOTAL		2	8	2
6.	USG Tanpa Kontras	Umum	15	40	30
		BPJS Kesehatan	224	301	206
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	0	0	0
	TOTAL		239	341	236

1.1.1.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Agustus-Oktober 2024





Analisis :

- Pelayanan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - Radiodiagnostik : 889
 - USG Tanpa Kontras : 236
 - CT Scan Tanpa Kontras :143
- Pada Bulan Oktober 2024 pemeriksaan Radiodiagnostik mengalami peningkatan, berbanding lurus dengan peningkatan pasien dengan penjamin JKK dan UMUM di IGD. Akan tetapi, kunjungan pasien jasaraharja mengalami penurunan secara drastic.
- Terjadi penurunan pada pemeriksaan USG Tanpa Kontras, sebanyak 236 pasien dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 341 pasien atau sebesar 30%.

Rencana Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.

- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
- 3. Melakukan review tarif tindakan yang dibutuhkan DPJP atau bisa dilakukan di RS, namun belum ada di Billing.

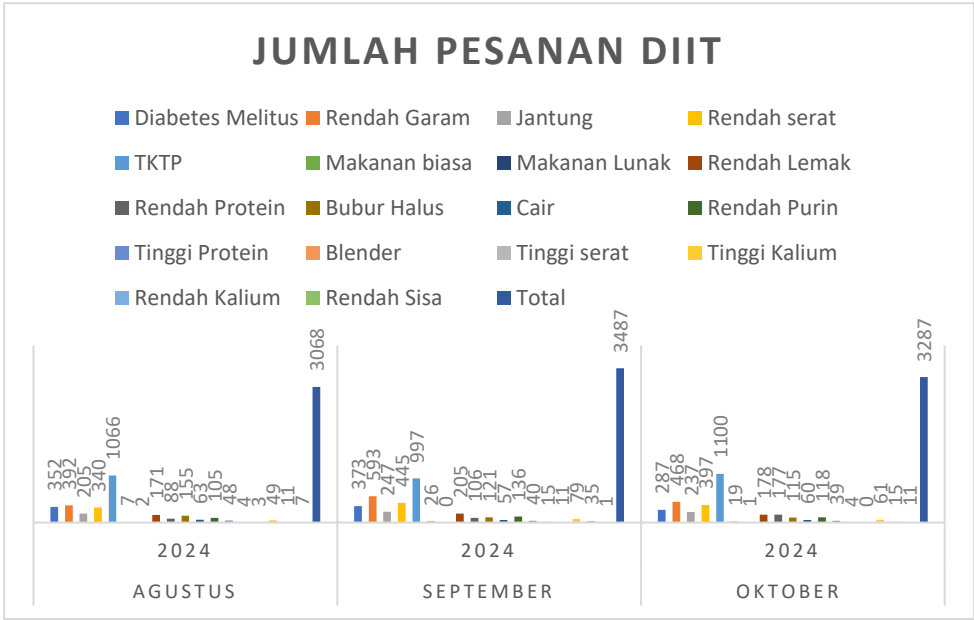
Contoh : CTA Cardiac.

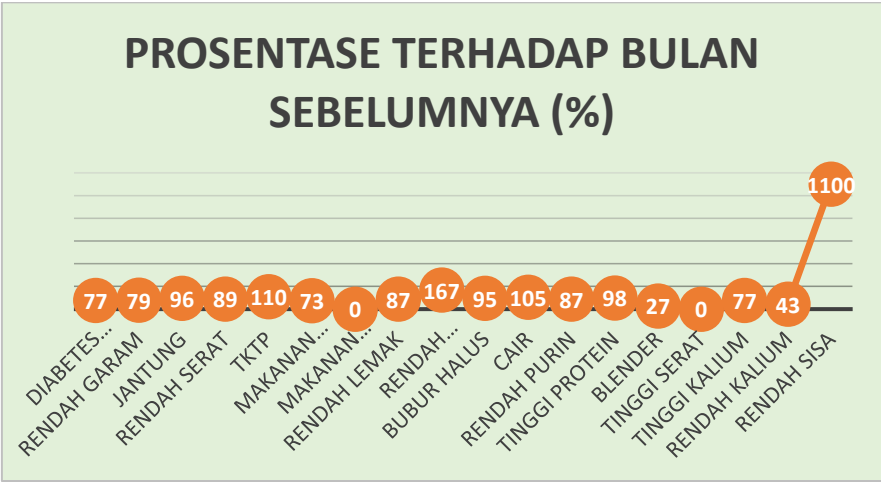
4.4.5 Gizi

4.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Agustus-Oktober 2024

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIIT			PRESENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	
1.	Diabetes Melitus	352	373	287	77
2.	Rendah Garam	392	593	468	79
3.	Jantung	205	247	237	96
4.	Rendah serat	340	445	397	89
5.	TKTP	1066	997	1100	110
6.	Makanan biasa	7	26	19	73
7.	Makanan Lunak	2	0	1	0
8.	Rendah Lemak	171	205	178	87
9.	Rendah Protein	88	106	177	167
10.	Bubur Halus	155	121	115	95
11.	Cair	63	57	60	105
12.	Rendah Purin	105	136	118	87
13.	Tinggi Protein	48	40	39	98
14.	Blender	4	15	4	27
15.	Tinggi serat	3	11	0	0
16.	Tinggi Kalium	49	79	61	77
17.	Rendah Kalium	11	35	15	43
18.	Rendah Sisa	7	1	11	1100
TOTAL		3068	3487	3287	94

4.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Agustus-Oktober 2024





Analisis :

Dari grafik jumlah pemesanan diit diatas, jumlah pemesanan mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Jenis diit fluktuatif menyesuaikan kebutuhan pasien sesuai dengan advice DPJP dan berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasien rawat inap pada Bulan Oktober 2024.

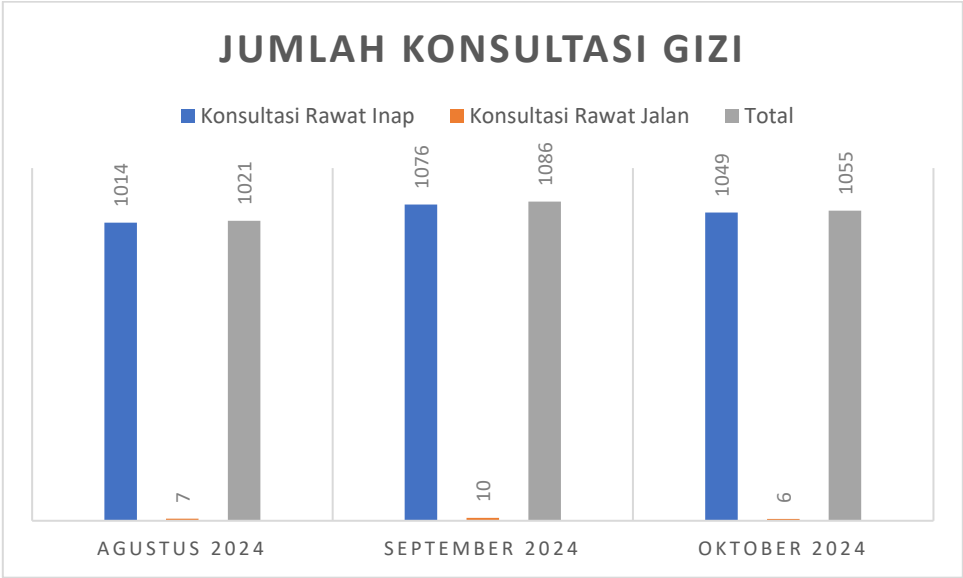
Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
 2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
 3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.

4.4.5.3 Jumlah Konsultasi Gizi Agustus-Oktober 2024

NO	INDIKASI	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1.	Konsultasi Rawat Inap	1014	1076	1049
2.	Konsultasi Rawat Jalan	7	10	6
Total		1021	1086	1055

4.4.5.4 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi Agustus-Oktober 2024



Analisis :

- 1. Data jumlah konsultasi gizi pada pasien rawat inap mengalami penurunan, berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
- 2. Data jumlah konsultasi gizi pada rawat jalan mengalami penurunan, yaitu 6 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi.
- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan MCU Gizi.
- 3. Menjalankan Prima Health Meals.
- 4. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward dan menarik pasien supaya bisa merasakan layanan MCU Gizi terlebih dulu, sebanyak 10 pasien yang akan mendapatkan MCU Gizi gratis pada Bulan November 2024.

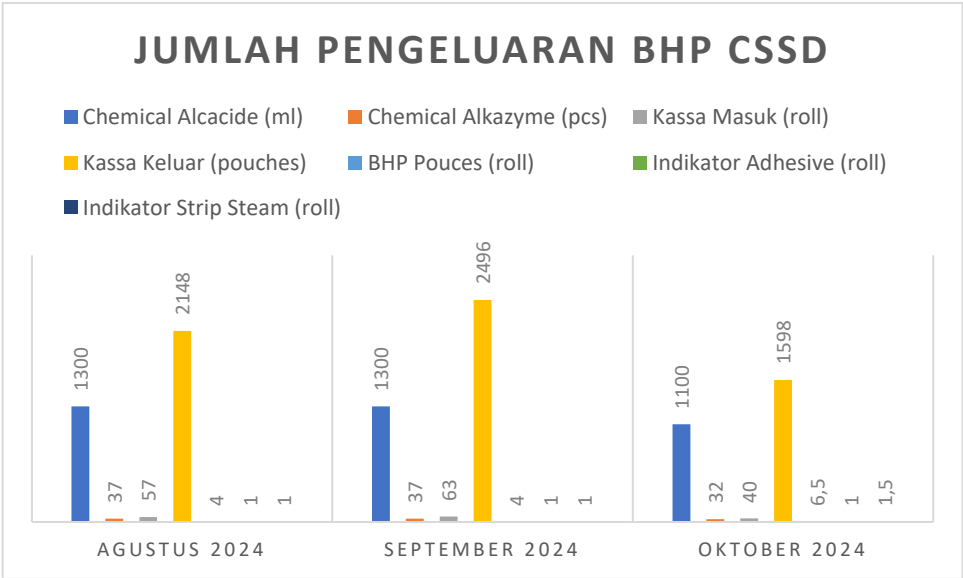
4.4.5 CSSD – Laundry

4.4.5.1 CSSD

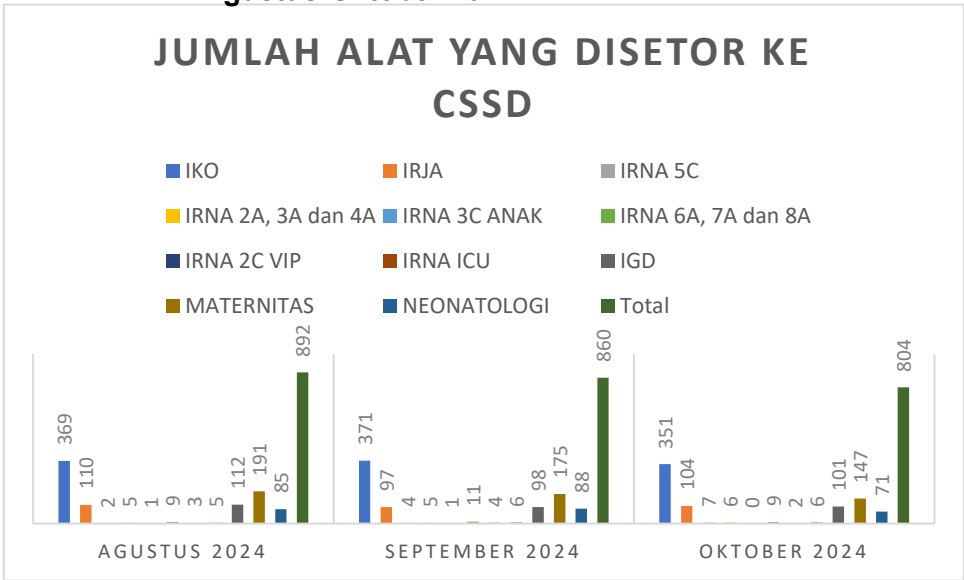
4.4.5.1.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD di Bulan Agustus-Oktober 2024

NO	HAL	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	1300	1300	1100
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	37	37	32
3.	Kassa Masuk (roll)	57	63	40
4.	Kassa Keluar (pouches)	2148	2496	1598
5.	BHP Pouces (roll)	4	4	6,5
6.	Indikator Adhesive (roll)	1	1	1
7.	Indikator Strip Steam (roll)	1	1	1,5
Alat yang disetor (set)				
8.	IKO	369	371	351
9.	IRJA	110	97	104
10.	IRNA 5C	2	4	7
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	5	5	6
12.	IRNA 3C ANAK	1	1	0
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	9	11	9
14.	IRNA 2C VIP	3	4	2
15.	IRNA ICU	5	6	6
16.	IGD	112	98	101
17.	MATERNITAS	191	175	147
18.	NEONATOLOGI	85	88	71
Jumlah		892	860	804

4.4.5.1.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai CSSD di Bulan Agustus-Oktober 2024



4.4.5.1.3 Grafik Jumlah Alat Yang disetor ke CSSD di Bulan Agustus-Oktober 2024



Analisis :

- 1. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terakhir yaitu sejumlah 1.091 set, diikuti dari Unit Maternitas 513 set dan IGD 311 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
- 2. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.
- 3. Terjadi peningkatan penggunaan alat di IRJA dan IGD, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pasien JKK yang datang ke IGD dan dilanjutkan control ke Poli Spesialis.
- 4. Terjadi penurunan produktifitas kinerja dalam pembuatan kasa steril, hal ini disebabkan adanya rotasi petugas sebanyak 2 orang dan stok kasa di Gudang Farmasi masih cukup.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.

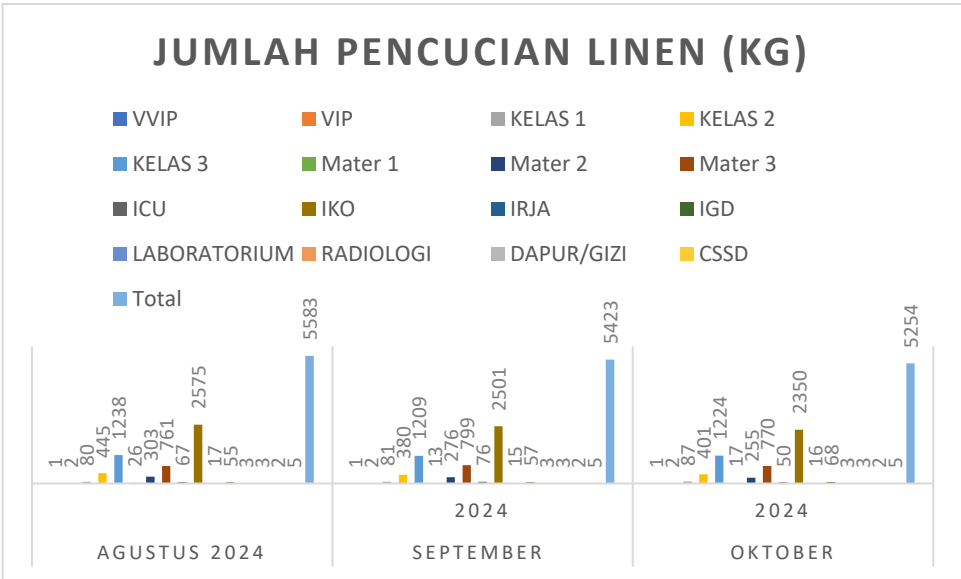
- 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
- 3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
- 4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.5.2 Laundry

4.4.5.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan Agustus-Oktober 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN (KG)		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1.	VVIP	1	1	1
2.	VIP	2	2	2
3.	KELAS 1	80	81	87
4.	KELAS 2	445	380	401
5.	KELAS 3	1238	1209	1224
6.	Mater 1	26	13	17
7.	Mater 2	303	276	255
8.	Mater 3	761	799	770
9.	ICU	67	76	50
10.	IKO	2575	2501	2350
11.	IRJA	17	15	16
12.	IGD	55	57	68
13.	Laborat	3	3	3
14.	Radiologi	3	3	3
15.	Dapur/Gizi	2	2	2
16.	CSSD	5	5	5
TOTAL		5583	5423	5254

4.4.5.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan Agustus-Oktober 2024

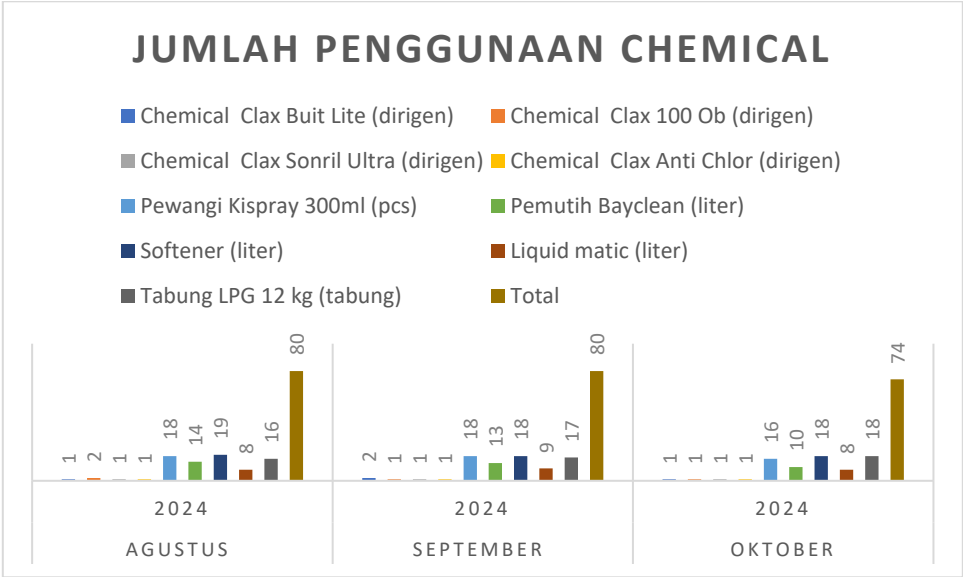


4.4.5.2.3 Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Bulan Agustus-Oktober 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	1	2	1
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	2	1	1
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	1	1	1
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	18	18	16
6.	Pemutih Bayclean (liter)	14	13	10
7.	Softener (liter)	19	18	18

8.	Liquid matic (liter)	8	9	8
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	16	17	18
TOTAL		80	80	74

4.4.5.2.4 Grafik Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Agustus - Oktober 2024



Analisa :

1. Terdapat penurunan jumlah pencucian linen dari bulan sebelumnya yaitu sebanyak 169kg, berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap, dan sebanding dengan penggunaan chemical yang juga mengalami penurunan.
2. Pada Bulan Oktober 2024, sudah tidak ditemukan benda asing didalam linen kotor dari ruang perawatan, sehingga menjadi salah satu penyebab berkurangnya berat linen kotor yang diterima.
3. Pencatatan penimbangan linen menggunakan timbangan beras masih manual, resiko angka tidak terbaca dengan baik, sehingga jumlah yang dihasilkan kurang valid.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Rencana akan dilakukan permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan.
2. Rencana akan dilakukan pencatatan menggunakan google spreadsheet per hari nya.
3. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.

4.5 Kinerja Umum dan Keuangan

4.5.5 SDM

3.5.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0

4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	41	14	0	14	0
		S1 Farmasi		4	3	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		D3 Farmasi		19	3	16	0
		SMK		3	0	7	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	11	1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	0	8	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	2	1	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
		SMK		2	1	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	3	1	2	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	1
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketng	Profesi Ners	2	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	25	10	2	8	0
		D3 Keperawatan		9	0	9	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	2	0
		D3 Kebidanan		3	0	3	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	2	5	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	0	1	0

		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
19	IRJA	Profesi Ners	27	7	4	3	0
		D3 Keperawatan		15	5	10	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		4	3	1	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	7	4	1	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		2	0	2	0
21	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	20	16	1	15	0
		D3 Keperawatan		4	0	4	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	16	6	0	6	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		8	0	8	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
23	IRNA 5C Anak	Profesi Ners	9	2	0	2	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		6	0	6	0
24	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	24	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		D3 Keperawatan		12	0	12	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Kebidanan		8	0	8	0
26	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	1	4	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		2	1	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		3	3	0	0
		SMA		1	0	1	0
28	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	0	2	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	0	8	0
29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	4	6	0

31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Ilmu Sosial		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	0	1	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	2	4	0
		SMK		5	0	5	0
		SMA		1	1	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	6	2	1	1	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
36	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	0	3	0
38	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	25	5	20	0
		SMA		15	0	15	0
40	Security	SMK	12	7	4	3	0
		SMA		5	2	3	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0
		SMP		2	0	2	0
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
48	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter	4	4	0	4	0

		Spesialis					
50	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
51	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
52	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
53	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
54	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
56	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			459				

Keterangan :

Pada bulan September terdapat penggantian di unit Cleaning Service 1 orang, penggantian Dokter Spesialis Anestesi 1 orang.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang perempuan

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	01 Oktober 2024	Orientasi Khusus	Davit Krisdianto	SMK	Umum – Cleaning Service	01 Oktober 2024	-
2	01 Oktober 2024	Orientasi Khusus	Tomi Candra Wardhana	SMK	Umum – Security	01 Oktober 2024	Mengundurkan diri per 15 Oktober 2024

Keterangan : Pada bulan Oktober 2024 terdapat orientasi khusus staf baru

3.5.1.4 Diklat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
1	31 Oktober 2024	Internal	Komunikasi Efektif untuk Nakes	Seluruh tenaga kesehatan RS Prima Husada Malang	Diklat ditujukan untuk 260 karyawan tenaga kesehatan dan dihadiri oleh hamper seluruhnya	Materi diklat, pre-test dan post-tes diklat diupload ke google classroom

Keterangan : Pada bulan Oktober 2024 terdapat 1 pelaksanaan diklat internal yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			BAIK	JELEK	SB	B	C	K	
1	Manajemen	Umum	12 staf	0 staf	10	2	0	0	Unit Manajemen RS Prima Husada secara keseluruhan mendapat

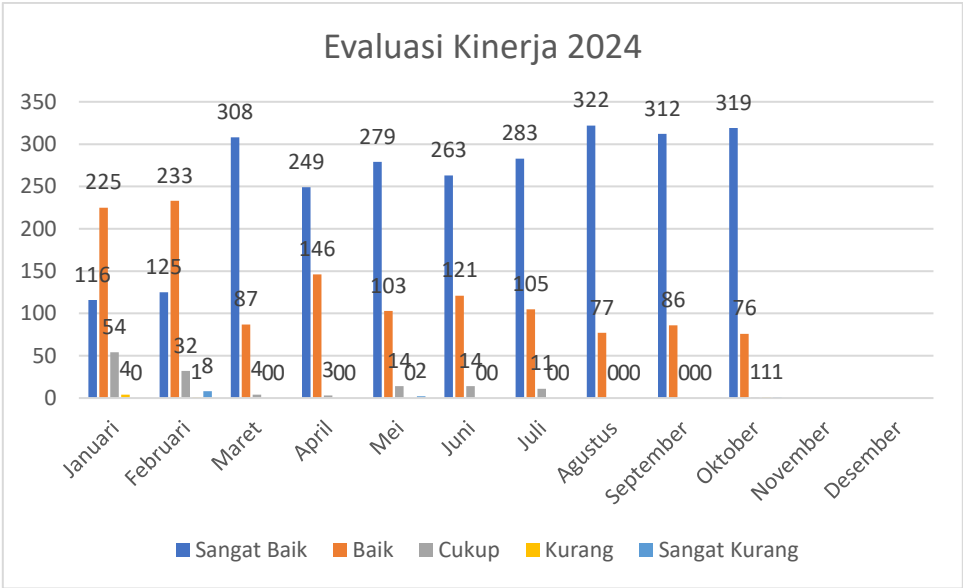
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			BAIK	JELEK	SB	B	C	K	
									catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Asuransi Center	Umum	11 staf	0 staf	10	1	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	IRNA 2C	Umum	7 staf	0 staf	6	1	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
4	IRNA 3C Anak	Umum	16 staf	0 staf	11	5	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	IRNA 234A	Umum	20 staf	0 staf	17	3	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	IRNA 5C	Umum	9 staf	0 staf	7	2	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	IRNA 678A	Umum	24 staf	0 staf	19	5	0	0	Unit IRNA 678A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Maternitas	Umum	12 staf	0 staf	12	0	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	Neonatologi	Umum	8 staf	0 staf	7	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	IGD	Umum	26 staf	0 staf	22	4	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	ICU dan HCU	Umum	11 Staf	0 staf	7	4	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	IKO	Umum	12 staf	0 staf	12	0	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	Gizi	Umum	17 staf	0 staf	17	0	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	Farmasi	Umum	43 staf	0 staf	30	13	0	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	Laboratorium	Umum	10 staf	0 staf	9	1	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			BAIK	JELEK	SB	B	C	K	
									penilaian kinerja umum.
16	Radiologi	Umum	7 staf	0 staf	5	1	0	1	Unit radiologi terdapat 1 staf dengan penilaian kinerja kurang baik karena merangkap bekerja di instansi lain
17	Rekam Medis	Umum	10 staf	0 staf	8	2	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	Pendaftaran	Umum	18 staf	0 staf	10	8	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	CSSD dan Laundry	Umum	10 staf	0 staf	10	0	0	0	Unit CSSD & Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	Keuangan dan Akuntansi	Umum	10 staf	0 staf	1	9	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	PIPP	Umum	6 staf	0 staf	5	1	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	Cleaning Service	Umum	44 staf	1 staf	40	4	1	0	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IT SIMRS	Umum	3 staf	0 staf	1	2	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	IPSRS	Umum	6 staf	0 staf	4	2	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Gudang Umum	Umum	2 staf	0 staf	1	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Driver	Umum	5 staf	0 staf	5	0	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Security	Umum	12 staf	0 staf	11	1	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	IRJA	Umum	27 staf	0 staf	24	3	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis : Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Oktober 2024.

Rencana Tindak Lanjut : -

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Analisis :
Peningkatan pada kategori “sangat baik”, dari bulan sebelumnya sebesar 7 orang.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 - 3. Mempertahankan staf yang masih terlambat

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2024

NO	JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT
1	Konseling	0	13	11	12	5	2	8	20	2	0

Analisis :
Tidak ada konseling di bulan Oktober.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.2 MFK dan K3RS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

NO	KET	TARGET	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1	Capaian Maintenance	90%	93,94	90,91	79.41	70.59	88.24	82.85	45,71%	94,73%

Analisa :
Pada bulan ini, capaian maintenance meningkat dari beberapa bulan sebelumnya. Jumlah alat yang termaintenance 187 dari 287. Beberapa factor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis klinik Mutiara sehat.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

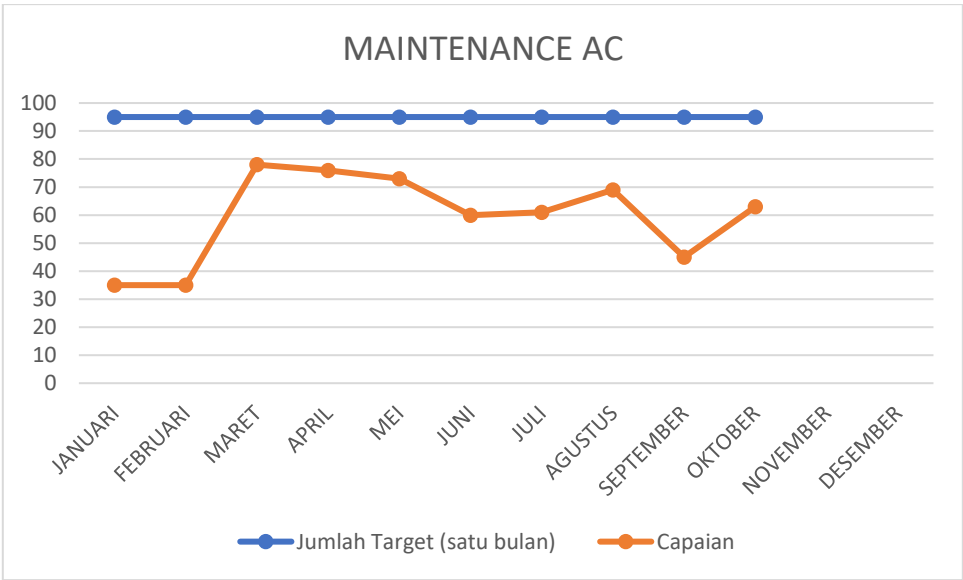
3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

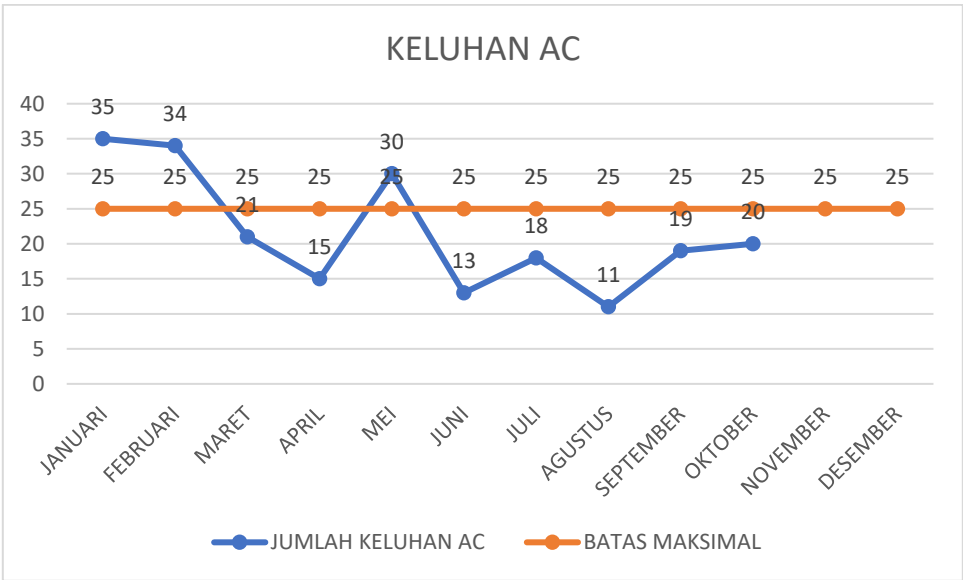
3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	95	54	57%	Belum Mencapai Target
2	Februari	95	69	73%	Belum Mencapai Target
3	Maret	95	94	99%	Belum Mencapai Target
4	April	95	61	64%	Belum Mencapai Target
5	Mei	95	94	99%	Belum Mencapai Target
6	Juni	95	89	94%	Belum Mencapai Target
7	Juli	95	60	63%	Belum Mencapai Target
8	Agustus	95	69	72%	Belum Mencapai Target
9	September	95	45	47%	Belum Mencapai Target
10	Oktober	95	63	66%	Belum Mencapai Target

3.5.2.2.1.2 Grafik Target Capaian Maintenance AC



3.5.2.2.1.3 Grafik Keluhan AC Split dari Unit



Analisis :
Terjadi kenaikan pemeliharaan AC pada bulan Oktober menjadi sebesar 66%, karena
Di bulan ini tidak terlaui banyak perbaikan utilitas, Karena banyak ruangan (pasien kosong) sehingga dapat melakukan pemeliharaan, Karena kunjungan DPJP sering kosong sehingga dapat melakukan pemeliharaan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi terutama terkait system pencatatan dan target perbulan.

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
10	Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
 Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	3x/bulan	2x/bulan	67%	Sudah mencapai target
4	April	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
10	Oktober	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
 Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 3x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil supervisi, petugas sudah berkeliling dan melakukan dokumentasi.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

OKTOBER 2024							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	keterangan	pengiriman	
01/10/2024	2724	2501	223	MMHG			
02/10/2024	2501	2290	211	MMHG			
03/10/2024	2290	1977	313	MMHG			
04/10/2024	1977	1781	196	MMHG			
05/10/2024	1781	1506	275	MMHG			
06/10/2024	1506	1336	170	MMHG			
07/10/2024	1336	1098	238	MMHG	Sebelum pengisian		
07/10/2024	1098	3128		MMHG	Sesudah pengisian	2030	
08/10/2024	3128	2998	130	MMHG			
09/10/2024	2998	2725	273	MMHG			
10/10/2024	2725	2352	373	MMHG			
11/10/2024	2352	2160	192	MMHG			

12/10/2024	2160	2025	135	MMHG			
13/10/2024	2025	1965	60	MMHG			
14/10/2024	1965	1761	204	MMHG			
15/10/2024	1761	1497	264	MMHG			
16/10/2024	1497	1120	377	MMHG	sebelum pengisian		
16/10/2024	1120	3230		MMHG	setelah pengisian	2110	
17/10/2024	3230	2956	274	MMHG			
18/10/2024	2956	2813	143	MMHG			
19/10/2024	2813	2575	238	MMHG			
20/10/2024	2575	2320	255	MMHG			
21/10/2024	2320	2156	164	MMHG			
22/10/2024	2156	1945	211	MMHG	sebelum pengisian		
22/10/2024	1829	3455			setelah pengisian	1616	
23/10/2024	3455	3300	155	MMHG			
24/10/2024	3300	3100	200	MMHG			
25/10/2024	3100	2812	288	MMHG			
26/10/2024	2812	2615	197	MMHG			
27/10/2024	2615	2423	192	MMHG			
28/10/2024	2423	2306	117	MMHG			
29/10/2024	2306	2060	246	MMHG			
30/10/2024	2060	1820	240	MMHG			
31/10/2024	1820	1497	323	MMHG			
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			6443	MMHG			
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						5756	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			433,5517241	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						2878	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL
 1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1	Pemeliharaan IPAL	1x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air
3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	OKT
1	Pemeliharaan filter air	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift
1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1	Pemeliharaan lift	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS
1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1	Pemeliharaan UPS	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

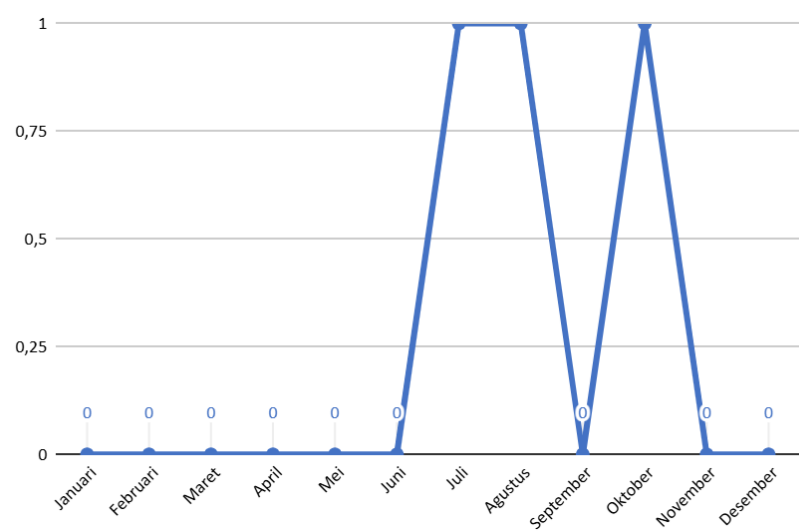
Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security
3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1

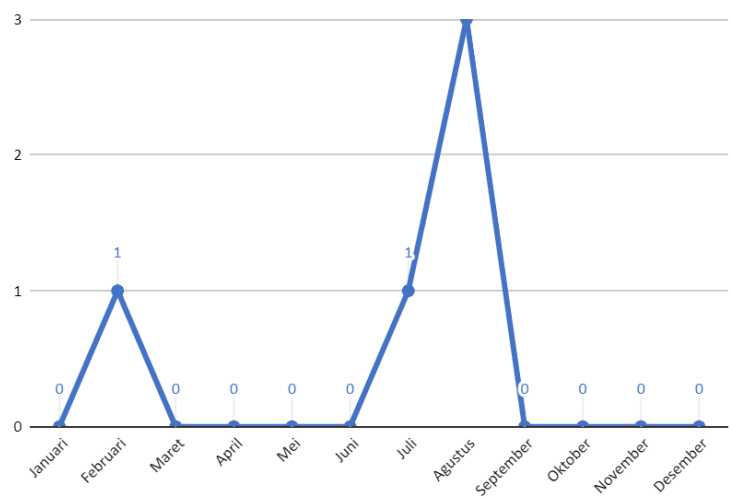
3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	1	0	0	0	0	1	3	5	1

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



Analisis :
Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
26 – 10 – 2024	Telah ditemukan dompet terjatuh di depan meja cso , tanpa identitas berisi uang sejumlah 1.020.000 diamankan di pos IGD	Telah diambil oleh pemilik dengan menunjukkan bukti identitas dan keterangan pemilik

Analisa :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

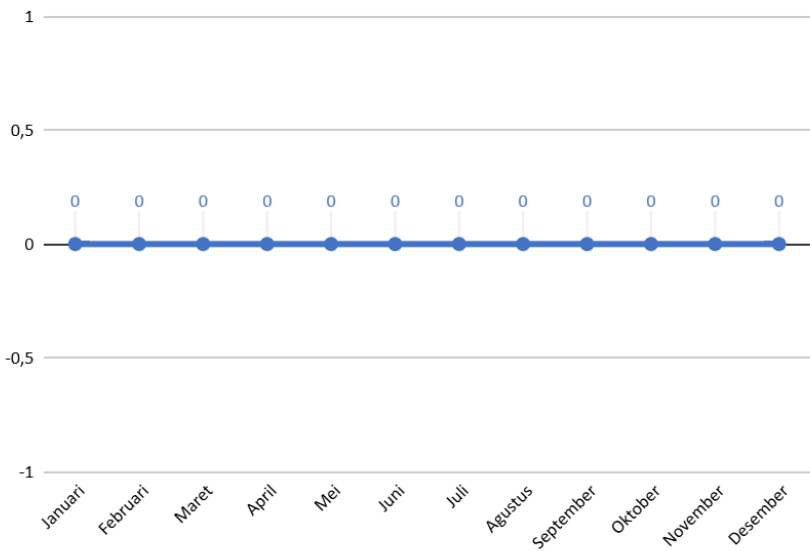
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



Analisis :

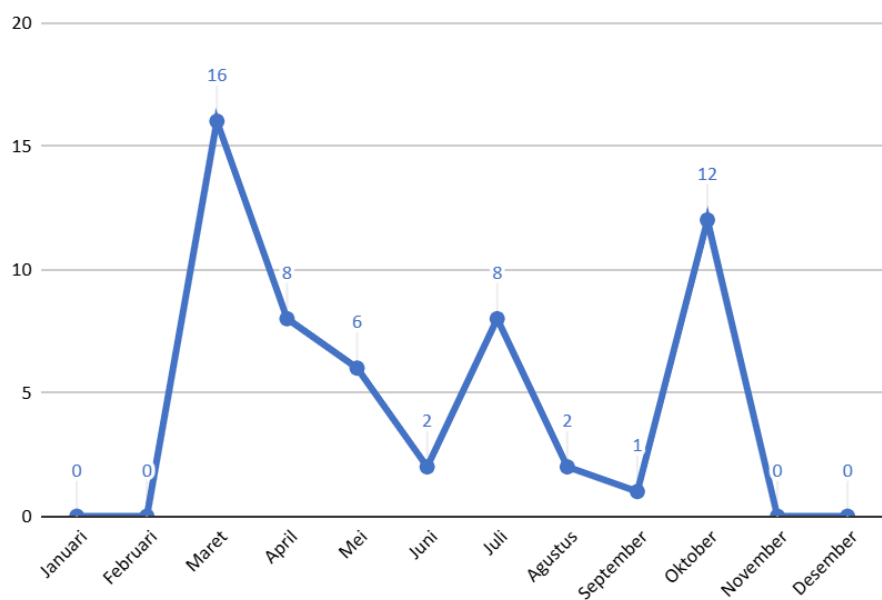
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	Tidak tercatat	Tidak tercatat	16	8	6	2	8	2	1	12

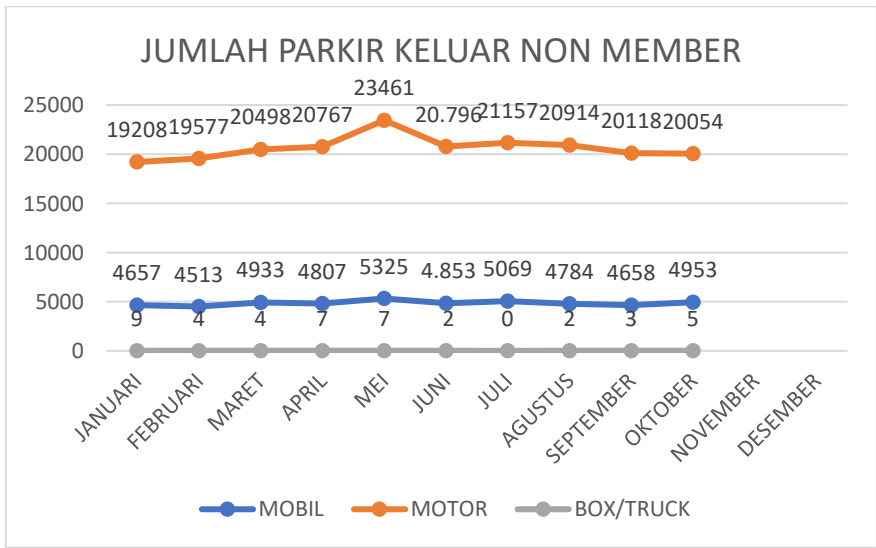


- Analisis :**
- Angka kejadian merokok mengalami kenaikan pada bulan ini. Beberapa faktor yang mengakibatkan:
1. Karakter pasien berbeda-beda setiap bulannya
 2. Tanda dilarang merokok tidak terlihat dengan baik
 3. Ruang dibelakang Samator menjadi tempat yang tertutup untuk istirahat dan merokok

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



- Analisis :**
- Peningkatan jumlah parkir, mengikuti banyaknya jumlah pasien rumah sakit bulan Oktober 2024.
- Rencana Tindak Lanjut :**
Monitoring dan evaluasi

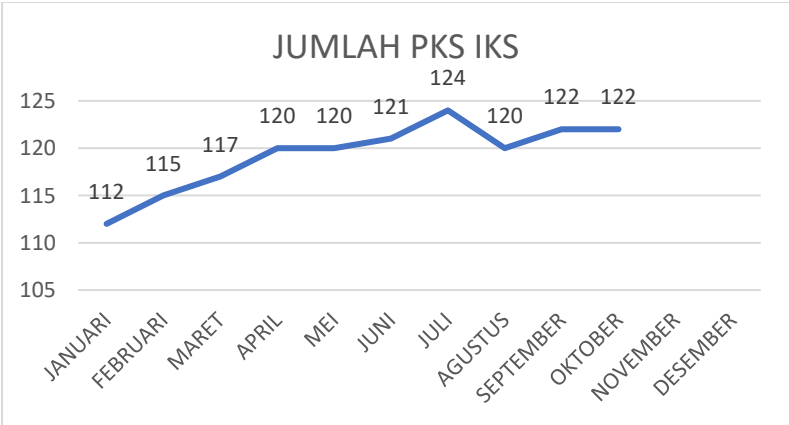
3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Tabel Jumlah PKS-IKS Aktif

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1	Jumlah PKS IKS AKTIF	112	115	117	120	120	121	124	120	122	122

3.5.5.1.2 Grafik Jumlah PKS – IKS



3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Bulan Oktober 2024

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Pesta Pora Abadi	Review pihak kedua	-
2	PT Tentrem Sejahtera	Review pihak kedua	-
3	PT Ustegra	Review pihak kedua	-
4	PT Randi Cones Indonesia	Review pihak kedua	-
5	PT Kharisma Selaras	Review pihak kedua	-
6	RS Universitas Brawijaya	Review ulang oleh RSUB	Ada beberapa notice terkait kesepakatan
7	PT New Minatex	Review pihak kedua	-
8	CV Barokah Plywood	Review Pihak Kedua	-
9	PT Indostar Building Material	Review Pihak kedua	-
10	PT Enak Jaya Makmur (Enak Eco)	Review Pihak kedua	-
11	PT Indonusa Algaemas Prima	Review Pihak Kedua	-
12	PT Duta Kharisma Sentosa	Review Pihak Kedua	-
13	PT Mahadaya Karya Sentosa	Review Pihak Kedua	-
14	PT Bangun Sarana Wreksa	Review Pihak Kedua	-
15	Rajawali Plastik	Review Pihak Kedua	-
16	PT Indonesian Tobacco	Review Pihak Kedua	-

Analisis :

- 1. Pada bulan Oktober, PKS baru dengan instansi lain masih dalam progress
- 2. MOU masih dalam tahap review oleh pihak kedua

Rencana Tindak Lanjut :

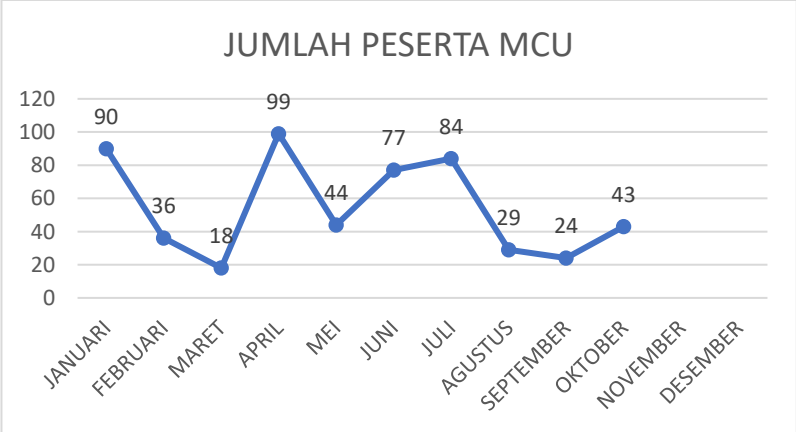
- 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua
- 2. Mengajukan surat permohonan PKS kepada Instansi Perusahaan, BPM, DPM, Klinik kesehatan, yang belum bekerjasama dengan RS Prima Husada Malang

3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Tabel Jumlah Peserta MCU

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	JUMLAH PESERTA MCU	90	36	18	99	37	50	84	29	24

3.5.5.2.2 Grafik Jumlah Peserta MCU



NO	BULAN	JUMLAH PASIEN	REVIEW
1	Januari	90	Analisis : Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Review hasil kunjungan dengan PDSA Plan 1. Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan dan universitas 2. Mempromosikan program MCU 3. Mereview tarif/biaya pemeriksaan Do 1. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan dan universitas 2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain Study 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU. 2. Perusahaan dan universitas memilih harga MCU paling murah diantara vendor.
2	Februari	36	
3	Maret	18	
4	April	37	
5	Mei	37	
6	Juni	50	
7	Juli	46	
8	Agustus	29	
9	September	24	
10	Oktober	43	

			3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan. Action 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan untuk calon karyawan baru dan ke Institusi Pendidikan untuk calon Mahasiswa baru 2. Review harga pemeriksaan khusus untuk MCU
--	--	--	---

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT
1	Jumlah Kunjungan	6	10	19	4	7	17	16	4	4	1

3.5.5.2.3.2 Grafik Jumlah Kunjungan Marketing Eksternal



Analisis :

Penurunan kunjungan berkurang karena focus marketing pada followup dan maintenance mitra melalui jarak jauh. 1 Kunjungan adalah pelatihan inhouse training.

Rencana Tindak Lanjut :

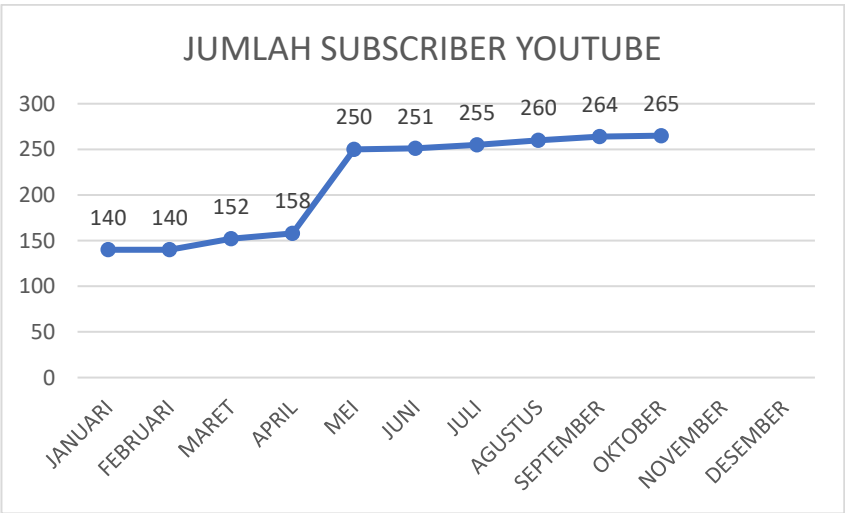
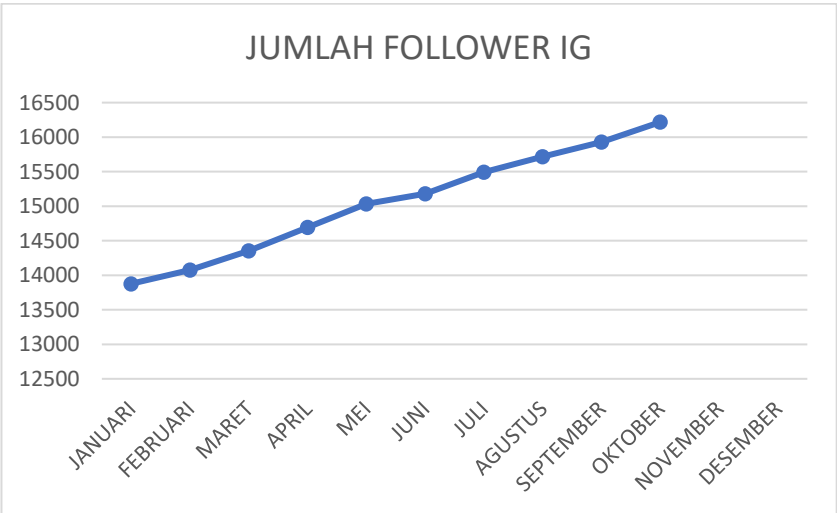
Monitoring dan evaluasi berkala.

3.5.5.2.4 Digital Marketing

3.5.5.2.4.1 Tabel Follower Media Sosial yang Dikelola RS Prima Husada Malang

BULAN	FOLLOWER			UNFOLLOW		
	INSTAGRAM	OUTUBE	TIKTOK	INSTAGRAM	YOUTUBE	TIKTOK
Januari	13877	140	-	265	0	-
Februari	14076	140	-	22	0	-
Maret	14353	152	-	22	0	-
April	14692	158	-	18	0	-
Mei	15034	250	-	29	0	-
Juni	15181	251	-	31	0	-

Juli	15493	255	-	13	0	-
Agustus	15716	260	-	8	0	-
September	15931	264	65	30	0	-
Oktober	16218	265	121	23	0	0
Analisis : 1. Digital marketing untuk mengelola Youtube belum ada masih menjadi satu di PT. 2. Follower Instagram meningkat karena tim PKRS aktif melakukan upload dan promosi di media sosial. 3. Akun baru Tiktok RSPH membantu dalam digital marketing						



3.5.6 Penjaminan

3.5.6.1 Piutang

3.5.6.1.2 Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler Oktober 2024

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
							-
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
5	FPK 'OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636		-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500		-
12	FPK OBAT KRONIS DES 2023	469.804.704	25.03.2024	03.04.2024	469.804.704		-
13	FPK OBAT KRONIS Pend Des 23	10.367.860	08.05.2024	20.05.2024	10.367.860		-
PELAYANAN 2024							
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024	16.04.2024	6.015.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024	16.04.2024	12.485.000		-
	FPK OR Januari 2024	516.543.814	08.05.2024	20.05.2024	516.543.814		-
	FPK Pending Januari 2024	468.390.779	08.05.2024	20.05.2024	468.390.779		-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024	16.04.2024	7.740.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024	16.04.2024	3.795.000		-
	FPK OR Februari 2024	498.722.702	08.05.2024	20.05.2024	498.722.702		-
	FPK PEND REGULER FEBRUARI	373.212.100	10.06.2024	19.06.2024	373.212.100		-
	FPK PEND II FEB 2024	58.112.500	09.07.2024	17.07.2024	58.112.500		-
3	FPK Maret 2024	7.372.267.949	26.04.2024	08.05.2024	7.350.598.749	21.669.200	-
	FPK AMBULANCE MARET 24	5.280.000	14.06.2024	10.06.2024	5.280.000		-
	FPK ALKES MARET 24	3.465.000	14.06.2024	10.06.2024	3.465.000		-
	FPK OR MARET 24	471.764.386	15.07.2024	22.07.2024	471.764.386		-
	FPK PEND MARET 2024	383.291.100	09.07.2024	17.07.2024	309.918.000	73.373.100	-
	FPK PEND MARET 2 2024	90.791.600	20.08.2024	29.08.2024	90.791.600		-
4	FPK April 2024	6.926.723.374	20.05.2024	29.05.2024	6.901.742.874	24.980.500	-
	FPK OBAT KRONIS APRIL 2024	477.096.910	26.07.2024	05.08.2024	477.096.910		-
	FPK AMBULANCE APRIL 24	3.270.000	14.06.2024	10.06.2024	3.270.000		-
	FPK ALKES APRIL 24	3.630.000	14.06.2024	10.06.2024	3.630.000		-
	FPK Pending April 2024	289.580.800	07.08.2024	19.08.2024	289.580.800		-
	FPK Pending II April 2024	125.899.300	10.09.2024	18.09.2024	125.899.300		-
	FPK Pending III April 2024	4.353.500	10.10.2024	21.10.2024	4.353.500		-
	FPK Obat Pend April 2024	5.989.571	06.09.2024	17.09.2024	5.989.571		-
5	FPK MEI 2024	7.537.333.400	23.06.2024	01.07.2024	7.493.109.800	44.223.600	-
	FPK OBAT KRONIS MEI 2024	487.109.484	26.07.2024	12.08.2024	487.109.484		-
	FPK Alkes Mei 2024	3.465.000	24.07.2024	07.08.2024	3.465.000		-
	FPK Ambulance Mei 2024	5.145.000	24.07.2024	07.08.2024	5.145.000		-
	FPK Obat Pend Mei 2024	10.593.498	06.09.2024	17.09.2024	10.593.498		-
	FPK PEND MEI 2024	334.480.400	23.09.2024	30.09.2024	296.561.200	37.919.200	-
	FPK PEND II MEI 2024	67.517.700	05.11.2024				67.517.700
6	FPK JUNI 2024	6.959.035.980	24.07.2024	31.07.2024	6.868.943.180	90.092.800	-
	FPK Alkes Juni 2024	8.470.000	24.07.2024	07.08.2024	8.470.000		-
	FPK Ambulance Juni 2024	6.945.000	24.07.2024	07.08.2024	6.945.000		-
	FPK Obat Kronis Juni 2024	468.625.741	15.09.2024	23.09.2024	468.625.741		-
7	FPK JULI 2024	7.160.148.298	20.08.2024	29.08.2024	7.122.971.498	37.176.800	-
	FPK Alkes Juli 2024	6.655.000	25.09.2024	09.10.2024	6.655.000		-
	FPK Ambulance Juli 2024	8.085.000	25.09.2024	09.10.2024	8.085.000		-
	FPK Obat Kronis Juli 2024	498.756.047	24.10.2024	04.11.2024	490.002.657	8.753.390	-
8	FPK Reguler Agustus 2024	6.671.460.900	25.09.2024	02.10.2024	6.662.482.200	8.978.700	-
	FPK Alkes Agustus 2024	6.160.000	25.09.2024	09.10.2024	6.160.000		-
	FPK Ambulance Agustus 2024	6.510.000	25.09.2024	09.10.2024	6.510.000		-
9	FPK Reguler RI September 2024	4.225.116.643	22.10.2024	28.10.2024	4.219.384.343	5.732.300	-
	FPK Reguler RJ September 2024	2.700.053.100	31.10.2024			7.844.000	2.692.209.100
10	Pengajuan Oktober 2024 Belum FPK	7.479.484.100					7.479.484.100
		85.679.281.423			75.040.943.633	399.126.890	10.239.210.900

3.5.6.1.3 Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND
1	JUNI 24	RJ	11.095	11.090	-	5	0,0%
		RI	1.024	922	-	102	10%
2	JULI 24	RJ	12.691	12.682	-	9	0,1%
		RI	995	924	-	71	7%
3	AGT 24	RJ	12.179	12.158	2	21	0%
		RI	951	873	-	78	8%
4	SEPT 24	RJ	11.573	11.447		126	1%
		RI	1.011	922		89	9%

3.5.6.1.4 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG													
PERIODE 2024													
								Y	Z	AA	AB		
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG				JUMLAH PIUTANG
		a	b	(a-b-c= d)	e	f	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	Total
PERIODE OKTOBER 2024 :													
1	Asuransi	179.925.419	93.199.172	85.392.325	231.200.012	24.725.830	205.689.308	291.081.634	264.753.208	1.770.242	2.476.336	21.335.960	291.081.634
2	Perusahaan	241.986.464	50.683.095	191.300.469	94.431.953	6.498.471	87.913.482	279.213.951	236.546.678	2.063.692	12.115.991	19.903.133	279.213.951
3	Mandiri Inhealth	62.217.811	24.074.311	37.446.040	34.339.781	-	34.339.781	71.785.821	71.413.781	-	-	372.039	71.785.821
4	Jasa Raharja	110.405.659	110.405.659	0	137.565.048	85.001.976	52.563.073	52.563.073	52.563.073	-	-	-	52.563.073
5	BPJS Ketenagakerjaan	2.001.171.391	931.656.360	1.069.489.941	565.965.394	-	565.965.394	1.635.455.335	1.597.557.973	31.582.224	1.125.432	2.780.144	1.635.455.335

Keterangan :

1. Cut off Piutang per 31 Oktober 2024 saldo akhir Rp 1.635.455.335
2. Piutang Perusahaan PT Karya Bina Sentausa terdapat beberapa permintaan revisi invoice penjamin anak Perusahaan PT karya bina sentausa dan sudah dilakukan revisi dan dikirim Kembali di bulan oktober 2024.
3. Asuransi dan perusahaan Proses Kirim surat pemberitahuan Outstanding Piutang
4. Penerimaan pembayaran BPJS TK Rp 931.656.360,-

3.5.6.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Indikasi tidak langsung dirujuk dan ditagihkan rawat inap Rajal	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Diagnosa pneumoni tidak sesuai dengan PNPk untuk diranapkan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Tidak sesuai standar pelayanan, indikasi ditagihkan rawat inap Rajal	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Tidak sesuai standar pelayanan GERD tanpa endoskopi Reseleksi DU menjadi K30	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Tidak sesuai kaidah pengkodean klinis I11.0 jika concentric hipertrofi, hasil ekokardiografi eksentrik hipertrofi, kode I11.0 tidak sesuai	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

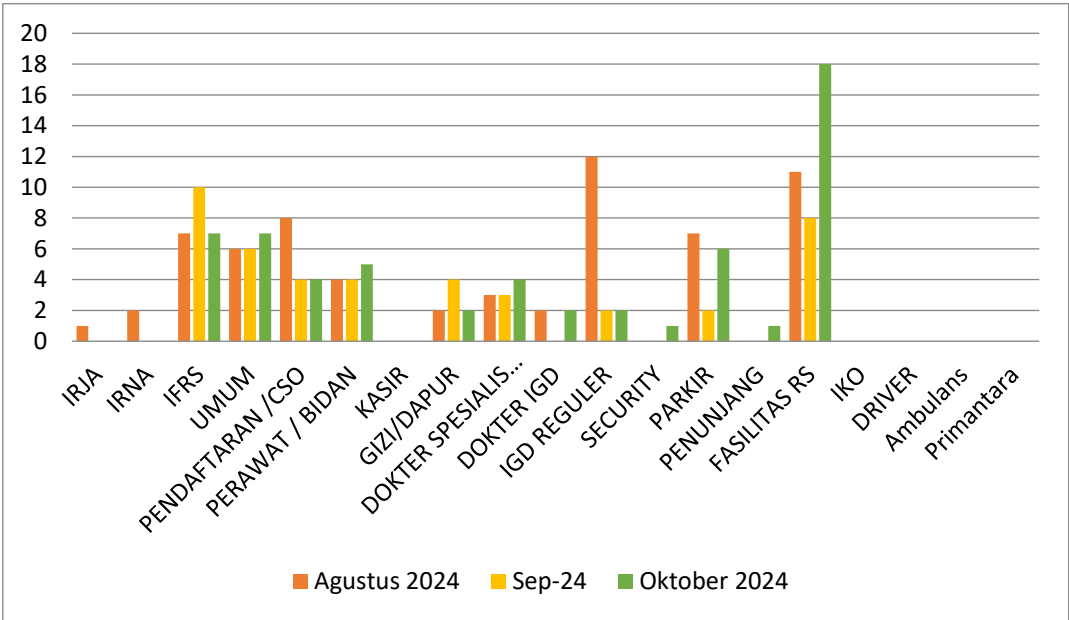
3.5.7 PIPP – MOD – MPP

3.5.7.1 Laporan Komplain Pasien

3.5.7.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Oktober 2024

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	AGT 2024	SEP 2024	OKT 2024
1.	IRJA	1	0	0
2.	IRNA	2	0	0
3.	IFRS	7	10	7
4.	UMUM	6	6	7
5.	PENDAFTARAN	8	4	4
6.	PERAWAT / BIDAN	4	4	5
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	2	4	2
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	3	3	4
10.	DOKTER IGD	2	0	2
11.	IGD REGULER	12	2	2
12.	SECURITY	0	0	1
13.	PARKIR	7	2	6
14.	PENUNJANG	0	0	1
15.	FASILITAS RS	11	8	18
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		65	43	40

3.5.7.1.2 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Oktober 2024



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Oktober 2024 mengacu pada komplain pasien. Asal komplain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan Oktober 2024 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan Agustus naik menjadi 65 kasus komplan, pada bulan September 2024 sebanyak 43 kasus complain Sedangkan pada bulan oktober 2024 turun menjadi 40 kasus
2. Komplain terbanyak pada bulan Oktober 2024 yaitu dari Fasilitas RS sebanyak 18 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 17 jenis complain dengan rincian :
 - 1) Fasilitas RS sebanyak 11 kasus yang meliputi :

Akses internet atau wifi saat rawat inap belum ada, busa kasur keras, kelas 1 1 kamar 1 orang agar tidak mengganggu pasien lain, permintaan kamar mandi basah ada gayung dan bak mandi, tidak ada wastafel di setiap kamar, ventilasi udara kamar masih kurang, RM ringkasan pulang tidak terbaca karena tulisan tidak jelas, kurang nindas saat menulis atau bisa juga karbon kurang.
 - 2) Parkir sebanyak 4 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :

Keluar masuk parkir pasien harusnya pembayaran 1 kali saja. Tiap kali keluar harus bayar foto kopi juga sulit, Perluas area parkir.
 - 3) Umum sebanyak 2 kasus terkait masih banyaknya perokok di area rumah sakit prima husada malang dan juga pengunjung yang masih banyak saat jam kunjung sudah selesai.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan September 2024

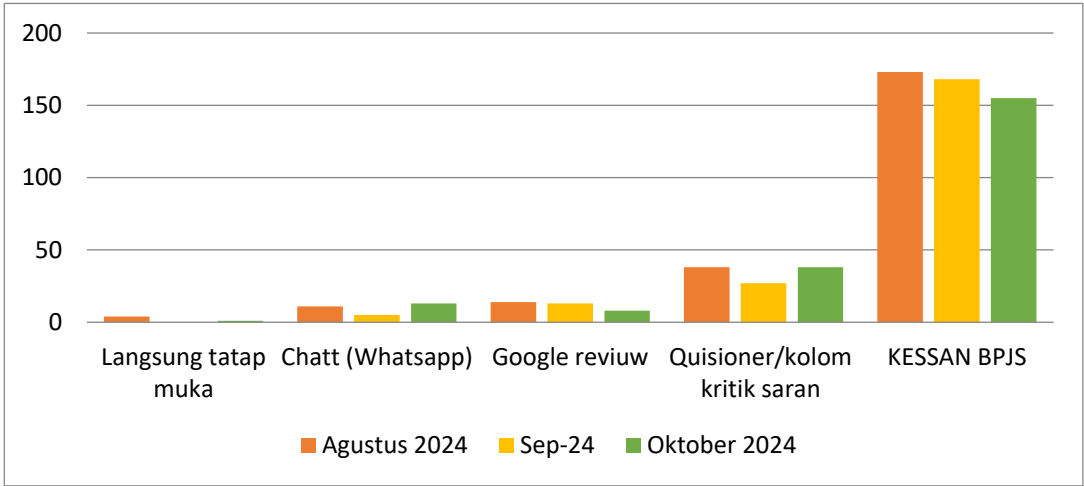
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1.	Langsung tatap muka	4	0	1
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	11	5	13
	b. Google review	14	13	8
3.	Quisioner/kolom kritik saran	38	27	38
4.	KESSAN BPJS	173	168	155

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	0	0	5	35	115

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Oktober 2024



Analisis :
Pada bulan Oktober 2024 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 38 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari WA sebanyak 13, google review sebanyak 8 kasus, tatap muka sebanyak1 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan September 2024

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 '	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 '	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	0	0	0
						100%	
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	12	0	1
					98%		2%
3.	Google review	100%	100%	100%	13	0	0
					100%		
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	22	0	16
					58%		42%
5.	KESSAN	100%	0	100%	155	0	0
					100%		

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Oktober 2024 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Kuisisioner dengan capaian 58%, melalui chat 98% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS dan parkir yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 17 jenis complain dengan rincian :

- 1) Fasilitas RS sebanyak 11 kasus yang meliputi :
Akses internet atau wifi saat rawat inap belum ada, busa kasur keras, kelas 1 1 kamar 1 orang agar tidak mengganggu pasien lain, permintaan kamar mandi basah ada gayung dan bak mandi, tidak ada wastafel di setiap kamar, ventilasi udara kamar masih kurang, RM ringkasan pulang tidak terbaca karena tulisan tidak jelas, kurang nindas saat menulis atau bisa juga karbon kurang.
- 2) Parkir sebanyak 5 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :
Keluar masuk parkir pasien harusnya pembayaran 1 kali saja. Tiap kali keluar hrus bayar foto copy juga sulit, Perluas area parkir
- 3) Umum sebanyak 2 kasus terkait masih banyaknya perokok di area rumah sakit prima husada malang dan juga pengunjung yang masih banyak saat jam kunjung sudah selesai.

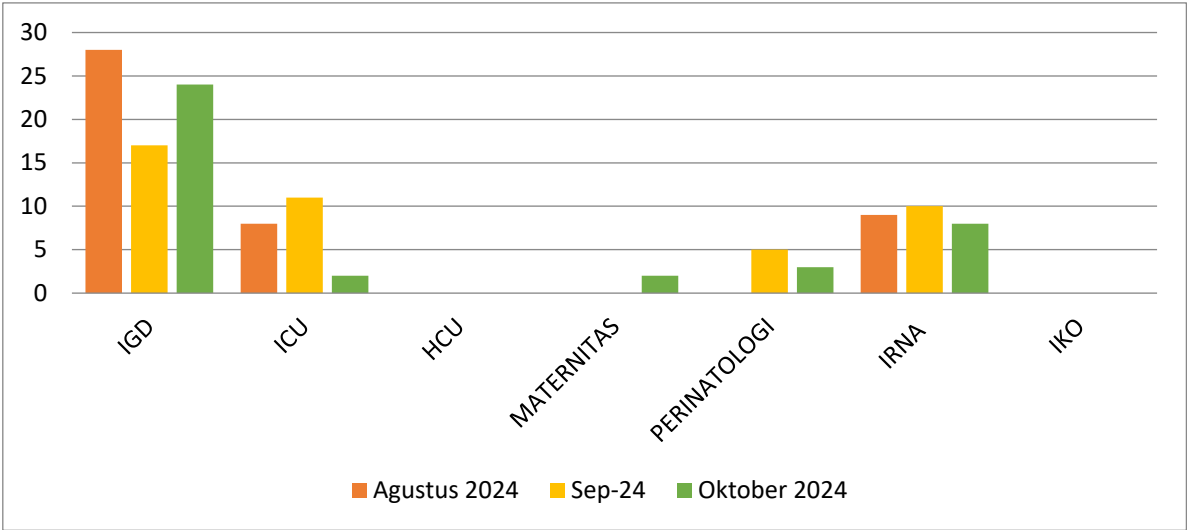
Rencana Tindak Lanjut :

Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Oktober 2024

NO	UNIT PERUJUK	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1.	IGD	28	17	24
2.	ICU	8	11	2
3.	HCU	0	0	0
4.	MATERNITAS	0	0	2
5.	PERINATOLOGI	0	5	3
6	IRNA	9	10	8
7	IKO	0	0	0
Total		41	43	39

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Oktober 2024



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	Tn. DARMAJI	IGD	Efusipleura S masif, Susp tumor paru Susp pneumonia dd metastasis proses paru D, Transaminitis	dr. Yunita, Sp. P	RST dr. Soepraoen	Pro tindakan pungsi karena DPJP paru tidak ada	1	Tidak
2	Tn. ABDUL KOHAR	IGD	Acites susp ileus obs dd paralitik, Abdominal Pain, leukositosis, Ikterik, hematemesis	dr. Anton, Sp. B	RST dr. Soepraoen	Pro ICU pasca OP	2	Tidak
3	Tn. Abdullah Syuhud	IGD	SVT, DIABETIC FOOT, DM TYPE 2, HIPOVOLEMIC SHOCK, HIPOKALEMIA	dr. Yoga Sp.JP	RSSA	Pro PCI	2	Tidak
4	Tn. Bernadi	IGD	GANGREN NECROTIZING FASCITIS R/ CRURIS SIN, DM HIPERGLIKEMIA, OF H2, LEUKOSITOSIS, DERMATITIS NUMULARIS, CAD	dr. Anton Sp.B konsul dr. Yoga Sp.JP	RSSA	Pro CVCU	2	Tidak
5	Ny. Malichah	IGD	CVA ICH IVH DEX VOLUME 32,9 CC, PVC TRIGEMINI, HIPOKALEMIA	dr. Dewi Sp.S	RS Wava Husada	Pro stroke unit	1	Tidak
6	Tn. Miskan	IGD	CVA ICH DD TRANSFORMASI HEMORAGIC, SUSP AF	dr. Heri Sp.PD	RSSA	Pro stroke unit	1	Tidak
7	Tn. Koesnan	IGD	STEMI INFERIOR	dr. Yoga Sp.JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
8	Ny. Siami	IGD	CVA ICH DD TRANSFORMASI HEMORAGIC, SUSP AF	dr. Dewi Sp.S	RS Lavalette	Pro stroke unit	1	Tidak
9	Ny.	IGD	Ckd st 5, Anemia	dr. Zora,	RS	Pro HD	1	Tidak

	MUSAROFAH		due to CKD, Obs dispneu, pneumonia	Sp. PD	Lavalette			
10	Ny. SUMARDI	IGD	STEMI Anteroseptal	dr. Mira, Sp. JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
11	Ny. DIAN PURWATI	IGD	CVA ICH	dr. Syahrir, Sp. N	RST dr. Soepraoen	Pro Stroke Unit	2	Tidak
12	Tn. Bambang Sujianto	IGD	ALO Cardiogenik dd non Cardiogenik, Pneumonia, gagal Nafas Type 2, Septic condition, DM 2	dr. Miryanti, Sp. JP k/ ndr. Andy, Sp. P k/ dr.Ardhi, Sp. PD	RSSA	Pro CVCU	2	Tidak
13	Tn. Christian Eka Wijaya	IGD	Re fraktur 1/3 distal tibia fibula dex post ORIF, Post ORIF radius ulna dex, Leukositosis dt susp osteomyelitis akut	dr. Kuntadi Sp.OT	RST dr. Soepraoen	Pro OP berulang	1	Tidak
14	Ny. Nurizza'aroh	IRNA	Empiema dex, Abses paru, TB paru, Pneumonia. Paroxymal SVT	dr. Elvi Sp.P raber dr. Miryanti Sp.JP	RST dr. Soepraoen	Pro WSD	3	Tidak
15	Ny. Mutrapin	IRNA	hydrocephalus ec susp ruptur aneurisma	dr. Farid, Sp.S k/ dr.Ira, Sp.JP	RS dr Soetomo	Pro DSA Angiography	2	Tidak
16	BY NY RIRIS	NEO	Obs. Distress nafas ok neonatal pneumonia dd RDS	dr Ratih, Sp.A	RSSA	tatalaksana distress nafas dengan labiognatopalatoschizis	1	Tidak
17	BY NY INTAN AULIA	NEO	NP-SP, BBLSR, neonatal pneumonia dd RDS, Apnue of prematurity, Feeding Difficulty, Hematom regio cruris Dex	dr. Ratih, Sp. A	RS Lavalette	Gagal CPAP, Periodic Apneu	3	Tidak
18	Ny. Diah Ika Safitri	MTS	Post Op Histerektomi H6 a/i Myoma Uteri (gebron Akar di Fundus) + Anemia Gravis Berulang + Sepsis + Joundice	dr. Humaira, Sp. OG	RSSA	Pro Perawatan Intensive	3	Tidak
19	Ny. Windarti	IGD	Jaundice, TB Paru On Therapy, Hipocalcemia, Hiperkalemia	dr. Yunita, Sp. P	RSSA	Pro Perawatan Intensive Infeksius	1	Tidak
20	BY NY Silvia	NEO	Neonatal pneumonia, NEC, feeding problem of newborn, Na-SC	dr. Ratih, Sp. A	RST dr. Soepraoen	Pro NIV/Ventilator	4	Tidak
21	Tn. Rusman Hadi	IGD	Gagal napas tipe 2, Pneumonia, CAP,S epsis, Susp Tumor Paru Sin dd Susp TB Paru, Hipokalemia, Takikardi susp HF	r. Yunita, Sp.P , konsul dr. Yoga, Sp.JP	RST dr. Soepraoen	Pro ICU TB	2	Tidak
22	ANAYA ALENA	IGD	Acute Abdomen dt Peritonitis	dr Zaki, Sp.B	RSSA	Pro Bedah digestif	1	Tidak

			Generalisata suspek Perforasi Appendix					
23	Tn Afandi	IRNA	Urosepsis	dr Pradana, Sp.U	RSSA	Pro ICU post OP	2	Tidak
24	Ny. Ngatmini	ICU	COPD, ACUTE RESPIRATORY FAILUIRE, TRANSAMINITIS	dr. Andy Sp.P	RSSA	Pro ICU isolasi	2	Tidak
25	Ny. Shefiera Deannisa	MTS	G1POABO UK. 8- 10mgg dengan HEG, Colic Abdomen, Hipokalemia	dr. Humaira, Sp. OG	RSSA	Pro ICU	4	Tidak
26	Tn. Tolib	IRNA	SUSP CVA INFARK, DKA EC SUSP DRUG ERUPTION, ANEMIA, CKD STAGE 5	dr. Farid Sp.S	RS Lavalette	Pro HD	3	Tarif rs : 5.259.797 Plavon : 3.501.400 Minus : 1.758.397
27	ny. DJUWARIJAH	IRNA	AF RVR	dr. ira Sp.JP	RSSA	Pro TPM	4	Tidak
28	ny. SUNAMI	IGD	ADHF	dr. ira Sp.JP	RST dr. Soepraoen	Pro Evakuasi Cairan Pleura	1	Tidak
29	NY. YUNIAR TUTI	IGD	Susp CVA hemoragic	dr. Farid Sp.S	RSSA	stroke unit	1	Tidak
30	Tn. Suden	IGD	Hernia Scrotalis, Gangrene Diabetic Digiti 2 Pedis Sinistra	dr. Anton Sp.B	RSSA	pro Joint OP Herniotomy	2	Tidak
31	Ny. HILDA JULIANI	IGD	CKD st V	dr Ardhi, Sp.PD	RSSA	Pro HD	2	Tidak
32	Ny. Wasiati	IRNA	Fraktur Kompresi Lumbal 1 Post KLL	dr. Farid Sp.N Konsul dr. Arianto, Sp.OT	RSSA	MRI dan Pro Penatalaksanaan lebih lanjut konsultan spine	3	Tidak
33	tn. Muhamad Nurudin	IGD	STEMI	dr Ira, Sp.JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
34	An. ARINDA PRADISTA PRAYOGO	IGD	Multiple Vulnus appertum fascial, ICH	dr. Sigit Sp.BP	RST dr. Soepraoen	Pro bedah saraf	1	Tidak
35	Ny. Suratun	IRNA	CVA Infark, CAD 3VD post PCL, HF	dr. Farid Sp.S	RS Lavalette	Pro Unit Stroke	3	Tidak
36	sdr Muhammad Bahri	IGD	Multiple Fracture, Trauma Thorax	dr. Oka, Sp. OT	RSUD dr. Soetomo	PRO Orif femur, tibia, patela, phalanx Kategori khusus 2 sayatan + backup bank darah dan tatalaksana lebih lanjut	1	Tidak
37	ARIK PURWANTO	IGD	ME +HCN pro vp shunt	dr. Farid Sp.S	RS Karsa Husada	PRO VP Shunt	2	Tidak
38	AZIZATUL AINIYAH	ICU	Dyspneu dt Suspek Pneumonia Aspirasi, Ileus, Septic condition	dr. Ardany Sp.PD co dr. Sigit Sp.BP	RSSA	Pro ICu isolasi	4	Tarif rs : 6.598.815 Plavon : 3.326.200 Minus : 3.272.615
39	ROFIATUL LAILI	IRNA	Morbid obesity, AKI, Pneumonia	dr. Ardany Sp.PD	RSUB	Pro HD	4	Tidak

Analisis :

1. Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan oktober 2024, pada bulan agustus 2024 sebanyak 43 pasien pada bulan agustus sebanyak 43 pasien Sedangkan pada bulan oktober 2024 sebanyak 39 pasien
2. Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :

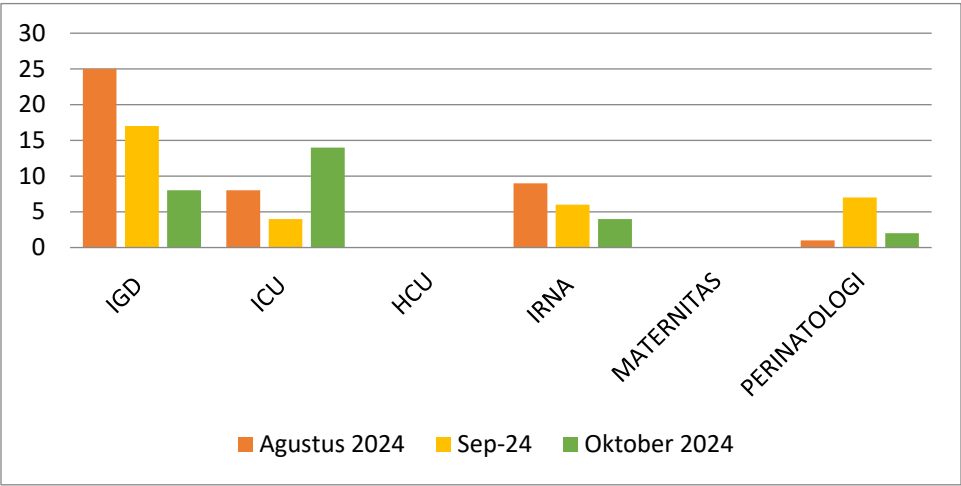
- 1) Pro Evakuasi Cairan Pleura = 2
 - 2) Pro ICU pasca OP = 1
 - 3) Pro PCI = 4
 - 4) Pro CVCU = 2
 - 5) Pro stroke unit = 6
 - 6) Pro HD = 4
 - 7) Pro OP berulang = 1
 - 8) Pro WSD = 1
 - 9) Pro DSA Angiography
 - 10) Tatalaksana distress nafas dengan labiognatopalatoschizis = 1
 - 11) Gagal CPAP, Periodic Apneu = 1
 - 12) Pro Perawatan Intensive = 3
 - 13) Pro Perawatan Intensive Infeksius = 1
 - 14) Pro NIV/Ventilator = 1
 - 15) Pro ICU TB = 1
 - 16) Pro Bedah digestif
 - 17) Pro ICU isolasi = 2
 - 18) pro Joint OP = 1
 - 19) Pro TPM = 1
 - 20) MRI
 - 21) Pro bedah saraf
 - 22) Membutuhkan alat khusus
 - 23) PRO VP Shunt
3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya bulan September 2024 tidak ditemukan plavon minus pada kasus rujukan
Sedangkan pada bulan Oktober 2024 terdapat 2 pasien dengan jumlah total minus :
Rp. 5.031.012

Rencana Tindak Lanjut:

1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Oktober 2024

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1.	IGD	25	17	8
2.	ICU	8	4	14
3	HCU	0	0	0
4.	IRNA	9	6	4
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	PERINATOLOGI	1	7	2
Total		31	43	34



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Sdr.Muhammad Fitroni	IGD	DOA	dr. Rohman
2	Ny. SINTAWATI HOSANA	IGD	DOA	dr. Rohman
3	An. Mafaza Syakila Ikhsani	IRNA	OF H-2, Vomitting Dehidrasi sedang	dr. Dicky, Sp. A
4	Tn. Djari	ICU	Respiratory Failure, COB	dr. Fachry, Sp. BS
5	Ny. Dewi Mariyah	IGD	SYOK CARDIOGENIK	dr. Yoga, Sp. JP
6	Ny. Sumartini	IGD	DOC ec DM Hipeglíkemia dd Ensefalopati Hepatikum	dr. Heri, Sp. PD
7	Ny. Tukinah	ICU	DM Hipeglíkemia, Syoc Septic,s elulitis	dr. Ardhi, Sp. PD
8	Ny. Sulastri Wijianti	ICU	RF, CVA ICH POST EVD	dr. Farid Sp.S raber dr. Fachri Sp.BS raber dr. Heru Sp.An
9	An. Arshakafa Ibrahim Alvarizki	IGD	DOA	dr. endra
10	By Ny Maulidatul Islamiyah	NEO	Neonatal Imatur	
11	Tn. M Syafii Yusuf	IGD	DOA	dr. Ardy
12	Tn. Sanali	IGD	DOA	dr. yeni
13	Ny. Djumani	ICU	Susp Pneumonia, DM Hiperqlikemia, Azotemia	dr. Andy, Sp. P k/ dr. Heri, Sp. PD k/ dr. Fahimma, Sp. S
14	Tn Wasukin	ICU	Acute RF	dr. Andy sp P Konsul dr ardhany sp pd konsul dr. Heru Sp.An konsul dr mira sp jp
15	Tn Sukrapno	ICU	Respiratory failure	dr. Andy sp P Konsul dr Hery sp pd
16	Tn Penny Widhiarti	IRNA	ALO	dr Ira, SP.JP
17	An. Muhammad Viki Aditya R	ICU	Vomiting dehidrasi sedang RPD penebalan dinding jantung	dr. Dicky Sp.A
18	Tn Didik Pudjianto	ICU	Post Turp dengan BPH, Susp Pneumonia Aspirasi	dr Edi, Sp.U
19	Tn.ARIEF YULIANTO	ICU	Sirosis Hepatis, edema	dr Ardhi, Sp.PD

			paru, syok septic	
20	Ny. Endang Kukuk	ICU	DOC, CVA Infark, Long OT	dr. Farid Sp.S konsul dr. Yoga Sp.JP konsul dr. Heru Sp.An
21	Tn. Chasrol Sani	IGD	CVA Infark, DM, Hiponatremi, Selulitis, Peritonitis	dr. Farid Sp.S konsul dr. Yoga Sp.JP konsul dr. Ardhi Sp.PD konsul dr. iwan Sp.B konsul dr. Heru Sp.An konsul dr. Vita Sp.KK
22	Ny. Istika Yuliana	ICU	DOA	dr. Naufal
23	Ny. Neny Lia Fantiny Sari	ICU	ARDS, Pneumonia, TB on OAT, DM Hiperglikemia, Septic condition, syok septic	dr. Andy Sp.P raber dr. Robby Sp.An konsul dr. Ardhi Sp.PD
24	Tn. Djoeri	IRNA	ARDS, Pneumonia, COPD	dr. Elvi Sp.P konsul dr. Heru Sp.An konsul dr. ira Sp.JP
25	Ny. Dasmiah	ICU	CKD ST III, Anemia, Hipokalemia	dr. Ardhanay, Sp.PD
26	Tn. Kasiyadi	ICU	SVT Unstable	dr. Miryanti Sp.JP
27	Ny Supat	ICU	gagal nafas type 1	dr. Miryanti Sp.JP
28	By. Ny Robiatul Adawiyah	NEO	Prematur, BBLASR	dr. Fiona Sp.A

Analisa :

- 1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Oktober 2024 sebanyak 28 pasien
- 2. Jumlah terbanyak yaitu dari ICU : 14 pasien, IGD sejumlah 8 pasien, IRNA 4 pasien, dan Neonatologi sebanyak 2 pasien.
- 3. Pada bulan Oktober 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 6 kasus.
- 4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

1.5.7.1 Laporan MPP

1.5.7.1.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Usia lanjut	372	370	317
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastrofik	620	723	560
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	4	0	0
4	Perkiraan biaya tinggi	142	132	77
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	34	40	17
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	1	0	0
7	Potensial komplain tinggi	42	58	9
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	751	756	719
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangnya	146	105	60
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	964	1011	834
11	Berpotensi masalah hukum	0	0	0
12	Naik kelas pelayanan	15	40	36
13	Lain - lain	115	79	74

1.5.7.1.2 Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
1	Habis PKS	43	11	12
2	BPJS status Denda	22	30	7
3	BPJS status Premi	9	7	6
4	BPJS status Denda dan Premi	21	12	32
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	6	0	4

3.5.8 Cleaning Service

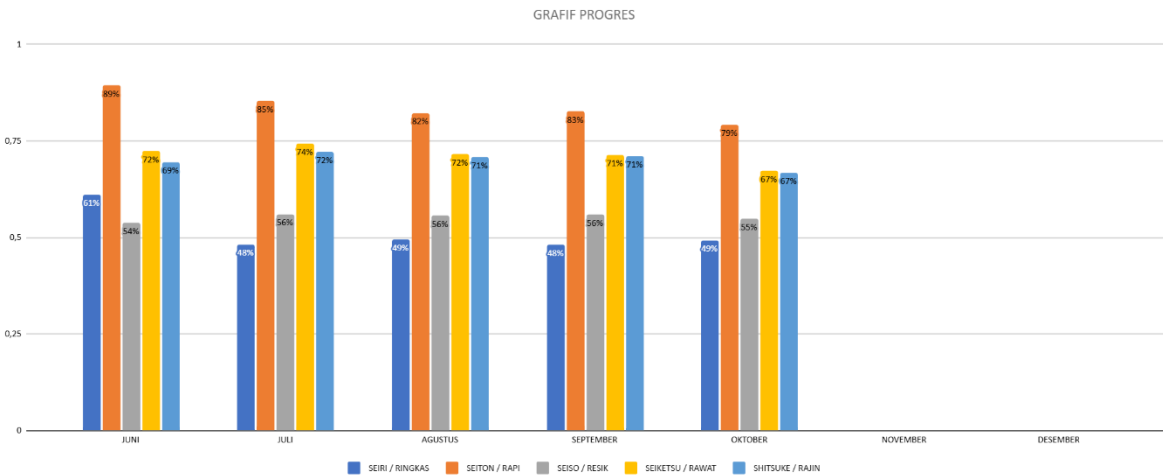
3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

SEIRI / RINGKAS	DESKRIPSI
Penempatan Alat Kebersihan di Janitor	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Janitor. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Janitor, peralatan kenbersihan ditempatkan ppada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Penempatan alat kebersihan di Trolley	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Trolley. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Trolley, peralatan kebersihan ditempatkan pada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Kondisi bak pembersih / kereta peras	Kondisi bahan pembersih yang ada di bak pembersih / ketreta peras tidak kotor. Maksimal 2x penggantian. Jika sebelum 2x sudah kotor amaka harus diganti. Pel harus dalam kondisi bersih
SEITON / RAPI	
Kerapian baju petugas CS	CS menggunakan baju sesuai seragam dengan rapi dan bersih
Penggunaan ID card	CS Menggunakan id card sesuai aturan
Penanganan sampah Medis dan Non Medis	
Penempatan sampah medis dan nonmedis	tempat sampah diberi kantong plastik sesuai warna dan fungsinya. Sampah medis dan nonmedis tidak boleh tercampur.
Penempatan plastik	Tempat sampah dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh, tidak kotor, tidak ada sampah berceceran
SEISO / RESIK	
Lantai	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih, dan sudut lantai harus bebas noda.
Langit – Langit / Plafon	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kaca Luar – Dalam	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, bebas noda, dan mengkilap.
Jendela / Tralis	Jendela / tralis bersih, tidak berdebu, dan tidak bernoda.
Tirai (vertical blind, gordyn)	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan rapi.
Lampu	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Saklar & stopkontak	Tidak berdebu, tidak bernoda, dan tidak basah.
Sarana pemadam kebakaran	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan tidak digunakan untuk menyimpan barang.

Objek Berbahan Stainless	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, tidak berminyak, dan tidak ada lawa – lawa.
Dinding	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Wastafel dan eye wash	Pembuangan mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, kering, kaca cermin bersih, bening, tidak berdebu, tidak bernoda, kran tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Kamar Mandi	Kebersihan dan bau
Ruangan	Tidak bau amis, pesing, dan anyir.
Plafon/langit-langit	Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kasa nyamuk	Bersih, tidak bernoda, tidak ada lawa – lawa, dan tidak berdebu.
Dinding Keramik	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, dan nat dinding bersih.
Closed	Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada percakan air disekelilingnya, dan tidak bau.
Kran	Tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Pintu	Bersih, tidak ada noda, dan mengkilap.
Urinoir	Bersih, tidak ada noda, tidak bau, dan tidak berkarat.
Bak Mandi	Tidak menguning karena lumut, tidak kotor, dan tidak ada jentik.
Ember dan Gayung	Bersih dan tidak berlumut.
Lantai	Bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak bau, dan sudut lantai harus bebas noda.
Keset	Tidak berdebu, tidak basah, tidak bau, dan tidak ada sampah.
Tempat Sampah	Dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh (terisi kurang dari 2/3 bagian), tidak kotor, dan tidak ada sampah berceceran
Tangga	Bersih dan bebas sawang
Railing	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan bila diusap tidak membekas.
Lantai (anak tangga & Bordes)	Tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak basah, dan tidak bau.
Dinding	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan tidak ada bercak.
Plafon	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Lift	Lantai dan dinding tidak berdebu, tidak bernoda, mengkilat, harum, dan sudut lantai harus bebas noda.
Dek Level	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa / sampah / daun kering.
Pagar	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Spoel hock/Dapur	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Pembersihan Tempat Sampah / Trolly	Pembersihan tempat sampah / trolly dilakukan secara rutin, kondisi tidak berdebu, dan ada jadwal pembersihannya juga.
SEIKETSU / RAWAT	
Poles lantai di ruangan	Sudah dilakukan dan/atau dijadwalkan poles lantai, baik basah dan atau kering maksimal 1x/bulan
Pemakaian APD	APD masker, sepatu, sarung tangan
Penandaan alat kebersihan	Hijau strip 1 (-) : kantor, Hijau strip 2 (=) : dapur, Biru (selasar), kuning (r. perawatan/pelayanan, merah : kamar mandi
Kebersihan Diri Petugas	Pakaian bersih, Badan bersih, Tidak berbau tidak sedap
SHITSUKE / RAJIN	

Kompetensi CS Memperagakan Cuci tangan dengan benar	Dapat mempraktekan lengkap sesuai SOP cuci tangan
Kompetensi CS dalam menanggapi response keluhan	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup
Kompetensi CS dalam mengikuti arahan kordinator	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup

JENIS	TARGET	CAPAIAN JUNI	CAPAIAN JULI	CAPAIAN AGUSTUS	CAPAIAN SEPTEMBER	CAPAIAN OKTOBER
SEIRI / RINGKAS	30	61%	48%	49,38%	48%	49,3%
SEITON / RAPI	40	89%	85%	82,21%	83%	79,2%
SEISO / RESIK	330	54%	56%	55,67%	56%	54,8%
SEIKETSU / RAWAT	40	72%	74%	71,51%	71%	67,2%
SHITSUKE / RAJIN	60	69%	72%	70,74%	71%	66,9%



Analisis :
 Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih fluktuatif namun tidak signifikan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

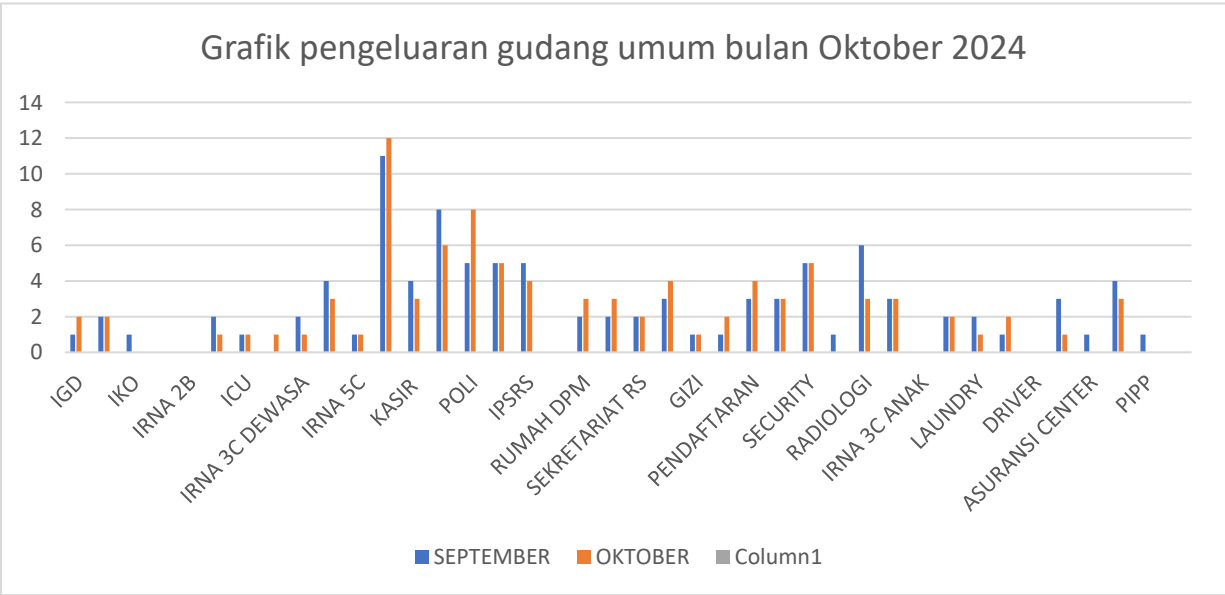
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		STATUS
		SEPTEMBER	OKTOBER	
1	IGD	1	2	Naik
2	MATERNITAS	2	2	Tetap
3	IKO	1	0	Turun
4	IRNA 2A	0	0	Tetap
5	IRNA 2B	0	0	Tetap
6	IRNA 2C	2	1	Turun
7	ICU	1	1	Tetap
8	IRNA 3A	0	1	Turun
9	IRNA 3C DEWASA	2	1	Turun

10	IRNA 4C+4A	4	3	Turun
11	IRNA 5C	1	1	Tetap
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	11	12	Turun
13	KASIR	4	3	Turun
14	DAPUR	8	6	Turun
15	POLI	5	8	Naik
16	CLEANING SERVICE	5	5	Tetap
17	IPSRs	5	4	Turun
18	GUDANG FARMASI	2	3	Naik
19	RUMAH DPM	2	3	Naik
20	SEKRETARIAT PT	2	2	Tetap
21	SEKRETARIAT RS	3	4	Naik
22	CSSD	1	1	Tetap
23	GIZI	1	2	Naik
24	REKAM MEDIS	3	4	Naik
25	PENDAFTARAN	3	3	Tetap
26	DEPO FARMASI	5	5	Tetap
27	SECURITY	1	0	Turun
28	LABORATORIUM	6	3	Turun
29	RADIOLOGI	3	3	Tetap
30	FISIOTERAPI	0	0	Turun
31	IRNA 3C ANAK	2	2	Tetap
32	NS NICU	2	1	Turun
33	LAUNDRY	1	2	Naik
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	Tetap
35	DRIVER	3	1	Turun
36	SIMRS	1	0	Turun
37	ASURANSI CENTER	4	3	Turun
38	DPW	1	0	Turun
39	PIPP	0	0	Tetap

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang



Analisis :
 Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara Sehat dan dapur,poli

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.6 Komite dan Tim

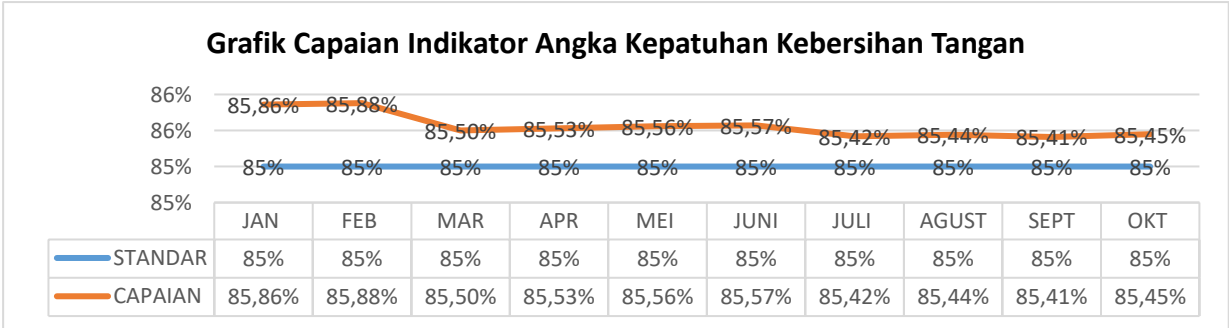
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

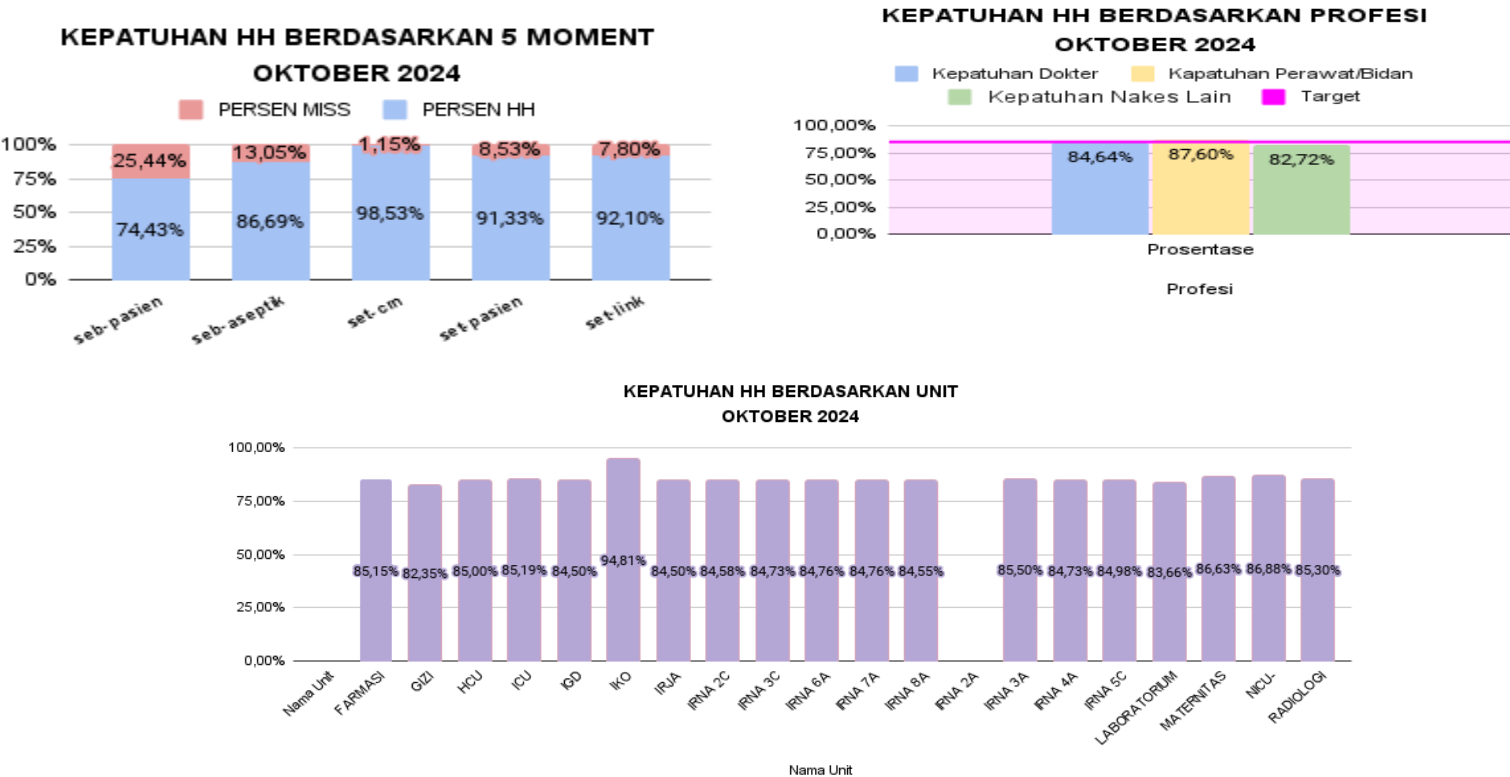
NO	JUDUL	STAND	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sep '24	Okt '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL												
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,86%	85,88%	85,50%	85,53%	85,56%	85,57%	85,42%	85,44%	85,41%	85,45%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,04%	93,15%	93,3%	93,52%	93,73%	93,8%	93,92%	93,24%	92,15%	92,21%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%	99,99%	99,95%	99,93%	99,96%	99,99%	99,98%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	95,2%	91,7%	95,74%	52,7%	63,8%	72,8%	80,97%	85,74%	88,65%	82,77%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	76,19%	79,08%	79,28%	78,06%	76,32%	78,47%	78,3%	79,04%	77,89%	74,83%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,46%	97,5%	98,9%	99,69%	100%	100%	100%	97,91%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	63,8%	71,62%	67,56%	66,7%	100%	92,5%	100%	100%	100%	100%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%	95,86%	96,51%	98,64%	98,72%	95,94%	95,92%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	93,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100%	91,89%	99,63%	99,82%	99,63%	100%	100%	99,38%	99,81%	99,7%

3.6.1.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

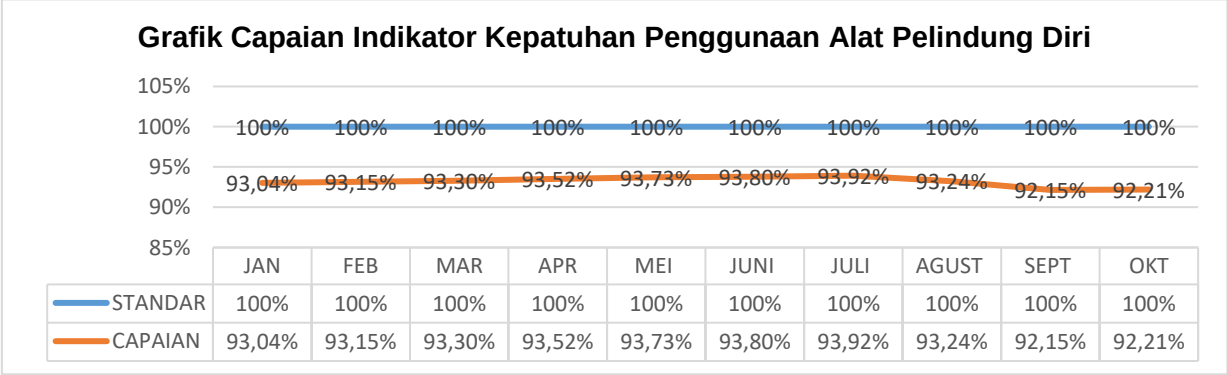


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan.\n 2. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat.\n 3. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan.\n 4. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,45%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (84,64%) dan nakes lain (82,72%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (74,43%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena persepsi yang salah dan kurangnya kesadaran petugas terkait pentingnya kebersihan tangan seperti pada profesi dokter yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan. (mementingkan keselamatan diri sendiri)				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan



3.6.1.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

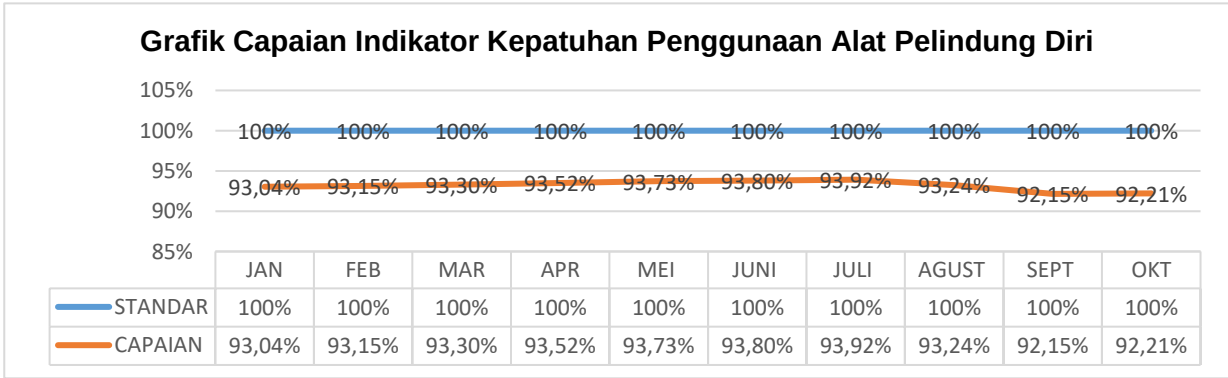
3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,21% menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

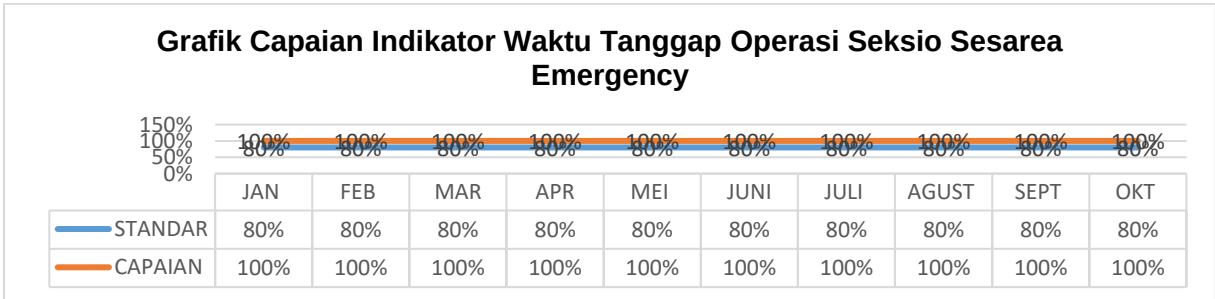
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga Oktober capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, perawat dan petugas farmasi yang salah memberikan obat, petugas primantara yang salah dalam pengantaran obat serta kesalahan pemberian obat karena dokter IGD mengganti resep dan tidak melakukan konfirmasi pada farmasi. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

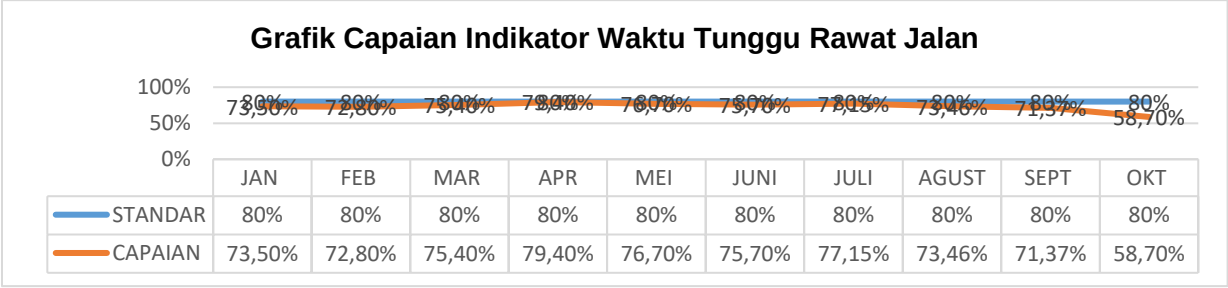
3.6.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisa Capaian : Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator waktu rawat jalan hingga mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang sering datang terlambat.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 belum mencapai standrart, hasil tersebut sesuai dengan hasil supervisi dan juga keluhan terkait keterlambatan dokter untuk praktek poli. Berdasarkan hal tersebut, mutu melakukan penilaian dengan observasi langsung dan juga mengevaluasi keterlambatan DPJP.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA
Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Waktu tunggu rawat jalan <80%	Mengevaluasi dpjp yang sering terlambat dan juga memberikan teguran melalui komdik dan kabit pelayanan		Satu bulan

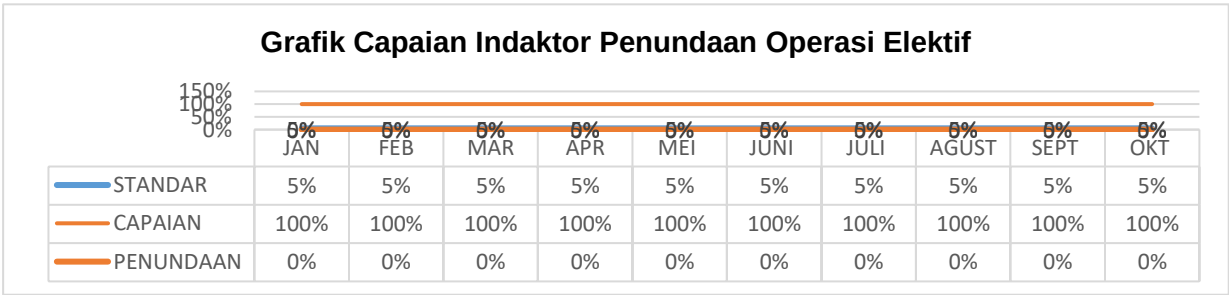
Rekap Data Dokter Terlambat Oktober 2024

NO	NAMA DPJP	JUMLAH JAM PRAKTEK SESUAI JADWAL	JUMLAH KEHADIRAN	JUMLAH IJIN TIDAK PRAKTEK /TIDAK HADIR	PRESENTASI KEHADIRAN	TERLAMBAT	TIDAK TERLAMBAT	% TERLAMBAT
1	dr. Rossy Zaki,Sp B	19	17	2	10,53%	17	0	100,00%
2	dr. Miryanti, Sp.JP	27	27	0	0,00%	26	1	96,30%
3	dr. Ratih Kusumawardhani, SpA,M.Biomed	13	12	1	7,69%	10	2	83,33%
4	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	23	21	2	8,70%	17	4	80,95%
5	dr. Andy, Sp. P	23	19	4	7,84%	15	4	78,95%
6	dr. Nurhadi Sp.M	51	45	6	11,76%	33	12	73,33%
7	dr. Meyrna, Sp.THBKL	14	11	3	21,43%	7	4	63,64%
8	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	27	24	3	11,11%	15	9	62,50%
9	drg. ega lucida Sp.Perio	14	11	3	21,43%	5	6	45,45%
10	drg. Bhakti Sp.Ortho	18	17	1	5,56%	7	10	41,18%
11	dr Iwan, SpB	13	13	0	0,00%	5	8	38,46%
12	dr. Fahimma, Sp. N	9	9	0	0,00%	3	6	33,33%
13	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	14	14	0	0,00%	4	10	28,57%
14	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	32	21	11	35,48%	5	16	23,81%
15	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	31	30	1	3,23%	6	24	20,00%

16	dr. Nimim, SpTHTBKL	40	27	13	32,50%	5	22	18,52%
17	dr. Huda Sp.KJ	81	81	0	0,00%	11	16	13,58%
18	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	31	31	0	0,00%	4	27	12,90%
19	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	13	8	5	38,46%	1	7	12,50%
20	dr Arianto Prabowo SpOT	9	9	0	0,00%	1	8	11,11%
21	dr Pradana Nurhadi Sp.U	14	14	0	0,00%	1	13	7,14%
22	dr. Eko N, Sp. KFR	54	32	22	40,74%	2	30	6,25%
23	dr Heriyatmo SpPD	26	26	0	0,00%	1	22	3,85%
24	dr Rudi, SpOG	4	0	4	100,00%	0	0	0,00%
25	dr Aida Musyarofah SpOG	23	23	0	0,00%	0	23	0,00%
26	dr Humaira Rahma, SpOG	41	38	3	7,32%	0	38	0,00%
27	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP- RE.MM	5	5	0	0,00%	0	5	0,00%
28	dr. Catur Elvi, Sp.P	9	8	1	11,11%	0	8	0,00%
29	dr. Dewi Maharani, Sp. S	23	13	10	43,48%	0	13	0,00%
30	dr. Edi Wibowo, SpU	13	10	3	23,08%	0	10	0,00%
31	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	26	26	0	0,00%	0	26	0,00%
32	dr. Didit Roesono, SpKJ	39	39	0	0,00%	0	13	0,00%
33	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	26	17	9	34,62%	0	17	0,00%
34	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	31	31	0	0,00%	0	0	0,00%
35	dr. Fiona Paramita Sp.A	23	21	2	8,70%	0	0	0,00%
36	dr Anton Setiadi SpB	50	50	0	0,00%	0	50	0,00%
37	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	10	10	0	0,00%	0	10	0,00%
38	dr. Andi Abdillah, SpB	9	9	0	0,00%	0	9	0,00%
39	drg. Ajeng Sp.KGA	23	23	0	0,00%	0	23	0,00%
40	dr. Adya Sp.DV	57	57	0	0,00%	0	19	0,00%
41	dr. Fachriy Balafif, SpBS	8	6	2	25,00%	0	6	0,00%
		1016	905			201	531	

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

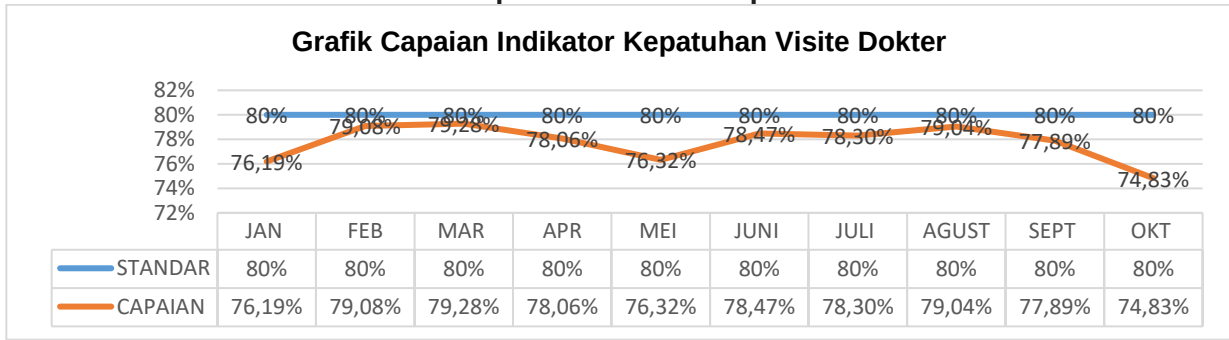


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 tidak ada penundaan operasi elektif.

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

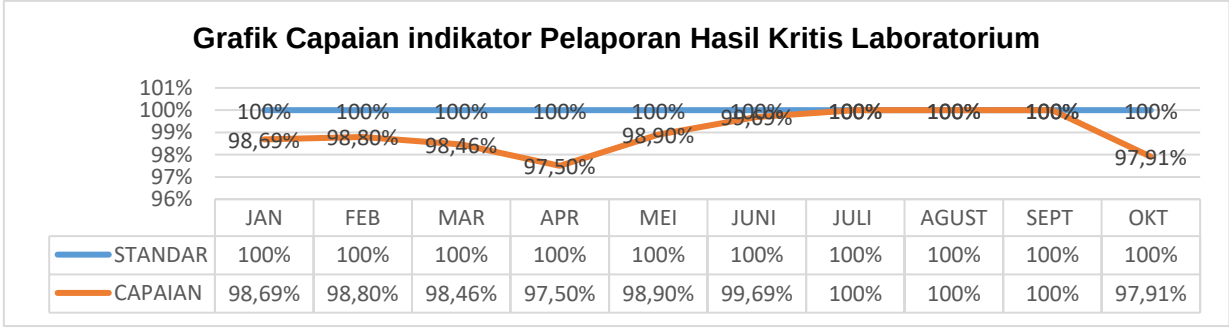
3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkan.nya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	Satu bulan

3.6.1.1.4 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

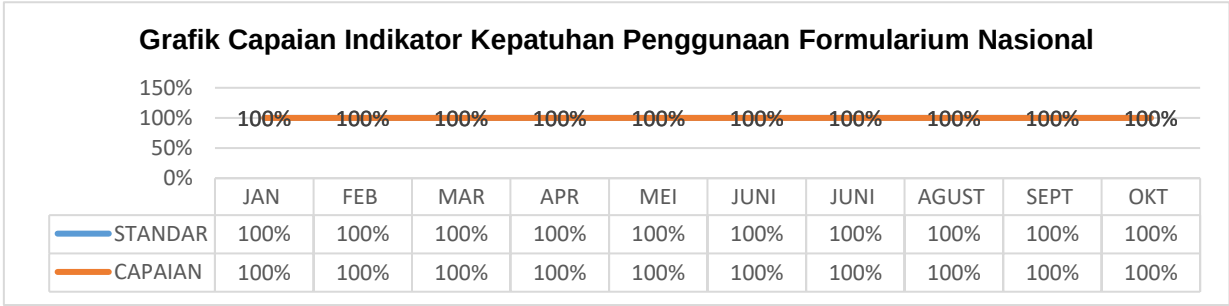
3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 masih belum mencapai standart. Capaian meningkat pada bulan Juli hingga September, pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Juli hingga September telah mencapai standart 100% tetapi menurun di bulan Oktober menjadi 97,91%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu bulan

3.6.1.1.5 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

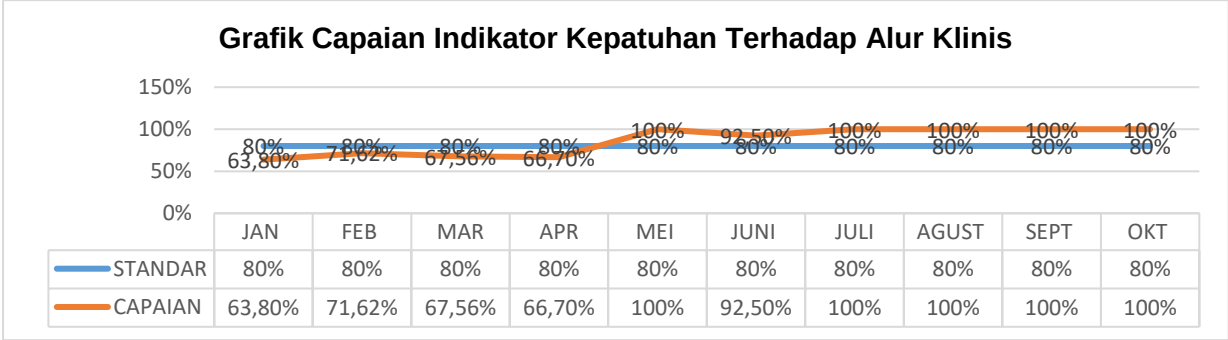
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional pada Bulan Januari hingga Oktober Tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.1.6 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



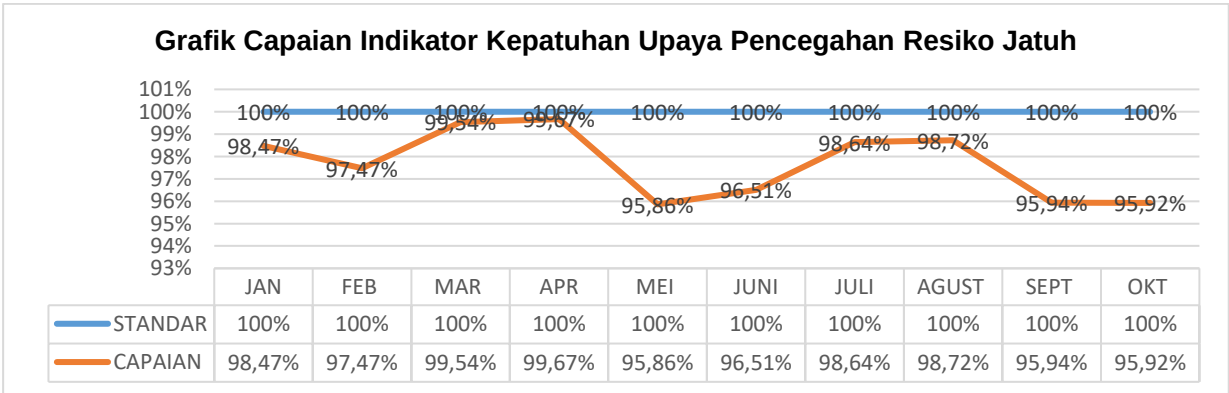
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.				
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadapa alur klinis dapat dianalisa.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadapa alur klinis dapat dianalisa.	Komite mutu	Satu bulan

Daftar Clinical Pathway

DIAGNOSA	JUMLAH	PATUH	TIDAK PATUH
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea	23	23	0
Partus Normal	35	35	0
Jumlah	58	58	0

3.6.1.1.7 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

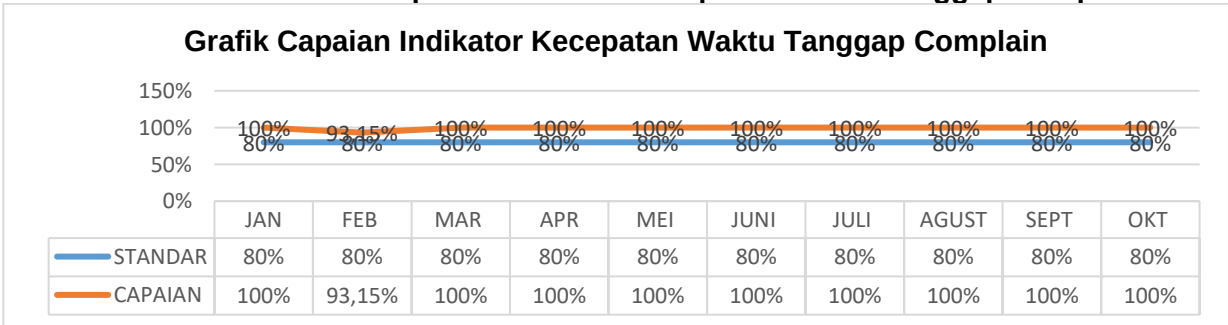
3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu <u>memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.</u> Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan pada 21 keluarga pasien ditemukan hasil bahwa 16 keluarga pasien mengatakan tidak menerima KIE dari perawat ruangan mengenai upaya pencegahan resiko jatauh.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Meningkatkan supervisi guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap kompalin pada bulan Januari tahun 2024 capaian telah mencapai 80%. PIPP dan bidang terkait telah menanggapi complain kurang dari 5 menit . Pada bulan Februari capaian menurun menjadi 93,15% tetapi masih diatas standart, pada bulan Maret hingga September capaian kembali meningkat menjadi 100%.

Distribusi Laporan Komplain Pasien per unit bulan Oktober 2024 di RS Prima Husada Malang

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1.	IRJA	1	0	0
2.	IRNA	2	0	0
3.	IFRS	7	10	7
4.	UMUM	6	6	7
5.	PENDAFTARAN /CSO	8	4	4
6.	PERAWAT / BIDAN	4	4	5
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	2	4	2
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	3	3	4
10.	DOKTER IGD	2	0	2
11.	IGD REGULER	12	2	2
12.	SECURITY	0	0	1
13.	PARKIR	7	2	6
14.	PENUNJANG	0	0	1
15.	FASILITAS RS	11	8	18
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	AMBULANS	0	0	0
19.	PRIMANTARA	0	0	0
Total		65	43	40

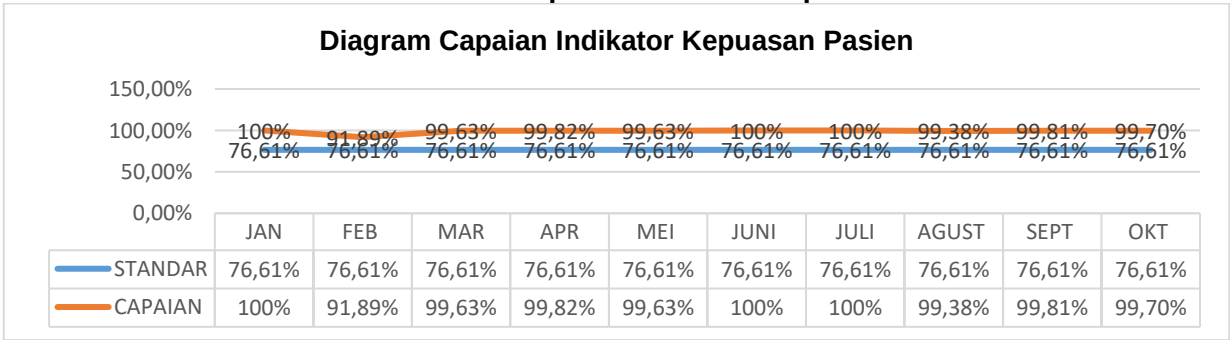
- Analisis :**
- Jumlah pasien komplain selama Bulan Oktober 2024 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.
- Jumlah complain Pada bulan Oktober 2024 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan Agustus naik menjadi 65 kasus komplai, pada bulan September 2024 sebanyak 43 kasus complain Sedangkan pada bulan oktober 2024 turun menjadi 40 kasus
 - Komplain terbanyak pada bulan Oktober 2024 yaitu dari Fasilitas RS sebanyak 18 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
 - Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 17 jenis complain dengan rincian :
 - Fasilitas RS sebanyak 11 kasus yang meliputi : Akses internet atau wifi saat rawat inap belum ada, busa kasur keras, kelas 1 1 kamar 1 orang agar tidak terganggu pasien lain, permintaan kamar mandi basah ada gayung dan bak mandi, tidak ada wastafel di setiap kamar, ventilasi udara kamar masih kurang, RM ringkasan pulang tidak terbaca karena tulisan tidak jelas, kurang nindas saat menulis atau bisa juga karbon kurang.
 - Parkir sebanyak 4 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi : Keluar masuk parkir pasien harusnya pembayaran 1 kali saja. Tiap kali keluar hrus bayar foto kopi juga sulit, Perluas area parkir
 - UMUM sebanyak 2 kasus terkait masih banyaknya perokok di area rumah sakit prima husada malang dan juga pengunjung yang masih banyak saat jam kunjung sudah selesai.

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 '	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 '	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	0	0	0
					100%		
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	12	0	1
					98%		2%
3.	Google review	100%	100%	100%	13	0	0
					100%		
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	22	0	16
					58%		42%
5.	KESSAN	100%	0	100%	155	0	0
					100%		

Analisis :
Waktu tanggap dan penyelesaian complain pasien pada bulan Oktober 2024 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Kuisioner dengan capaian 58%, melalui chat 98% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS dan parkir yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

3.6.1.1.9 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis :
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 sudah mencapai standar. Dari 336 pasien yang mengisi kuesioner survey kepuasan pasien, hanya 1 pasien yang menjawab tidak puas akasn keseluruhan pelayanan.

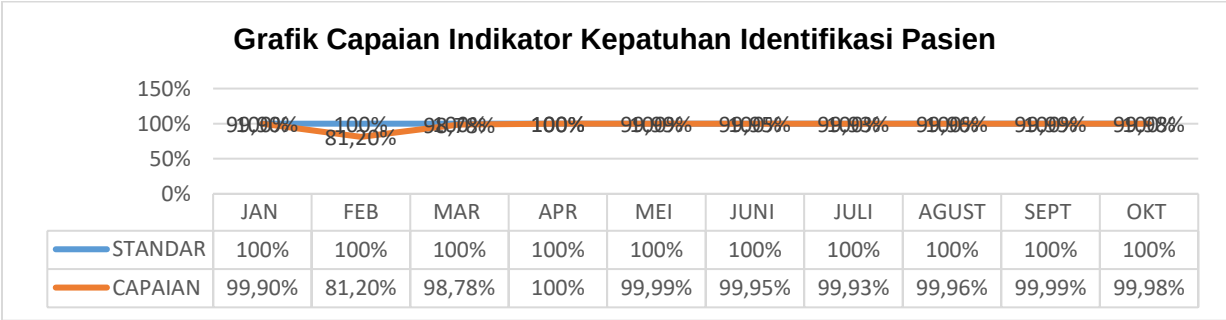
3.6.1.2 Indikator Mutu Prioritas

3.6.1.2.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78 %	100%	99,99 %	99,95 %	99,93 %	99,96%	99,99%	99,98%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,86%	85,88 %	85,5%	85,53 %	85,56 %	85,57 %	85,42 %	%	85,41%	85,45%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	98,47%	97,47 %	99,54 %	99,67 %	95,86 %	95,51 %	98,64 %	98,72%	95,94%	95,92%

3.6.1.2.1.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

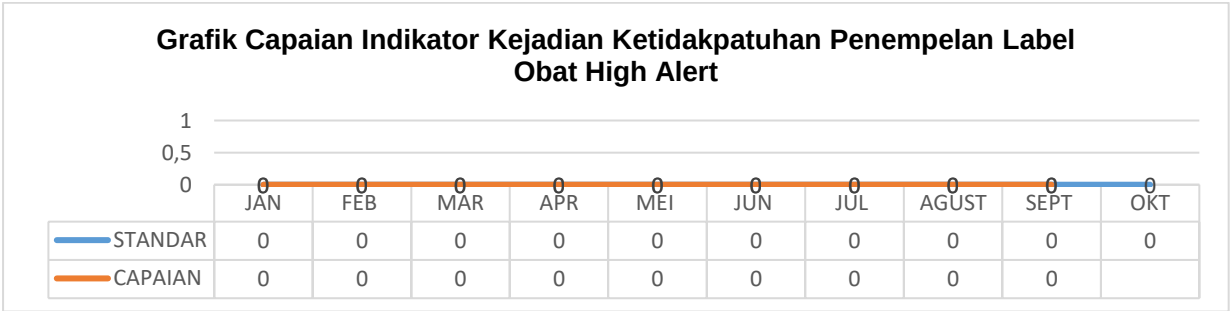
3.6.1.2.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga Oktober capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, perawat dan petugas farmasi yang salah memberikan obat, petugas primantara yang salah dalam pengantaran obat serta kesalahan pemberian obat karena dokter IGD mengganti resep dan tidak melakukan konfirmasi pada farmasi. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.1.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

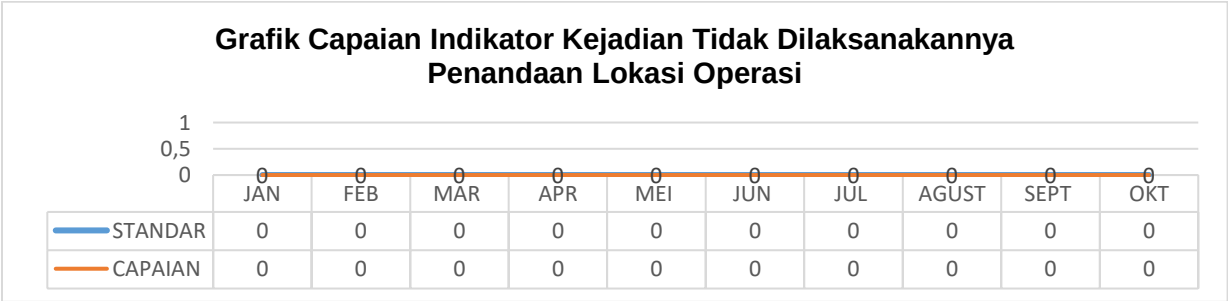
3.6.1.2.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan Januari hingga September tahun 2024 telah mencapai standar. Hasil tersebut sesuai dengan hasil supervisi pada unit rawat inap, di semua unit rawat inap tidak ditemukan obat obat haigh alert yang tidak berlabel.

3.6.1.2.1.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

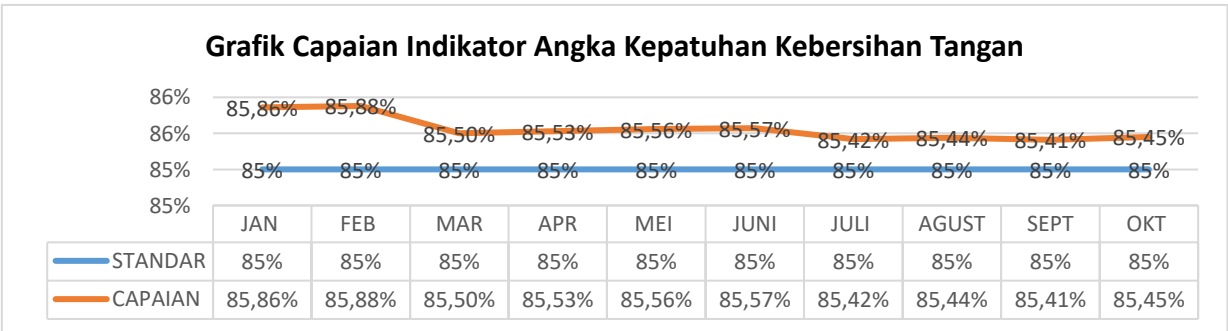
3.6.1.2.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi



Analisis :
Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Januari hingga September tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.1.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.2.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

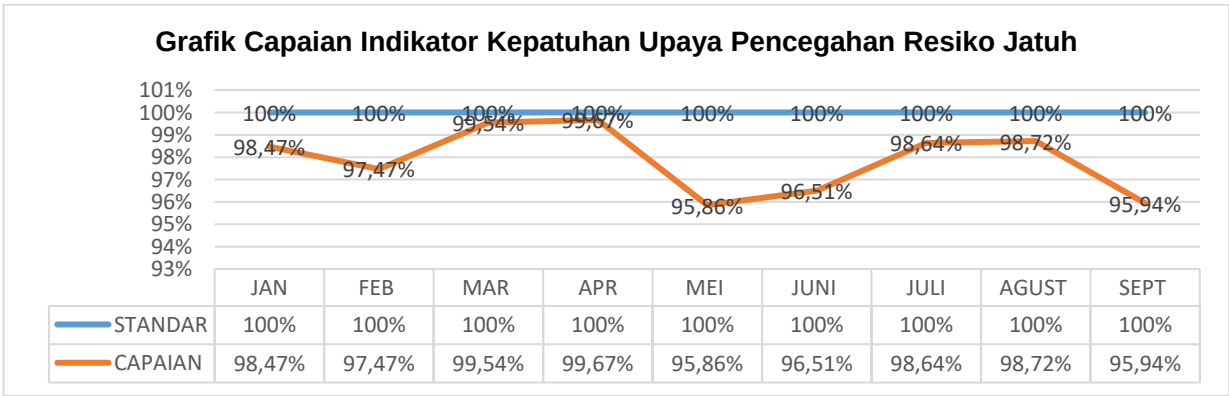


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,41%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum

	melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran. 4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.1.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.2.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



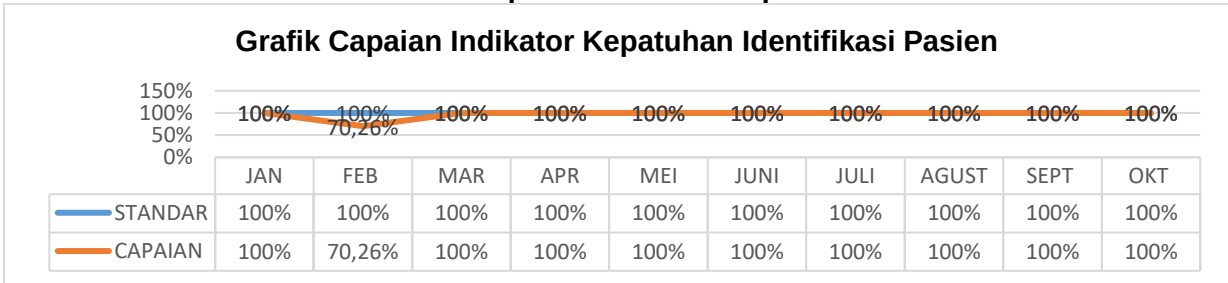
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga September tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

3.6.1.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81 %	69,59 %	73,43 %	79,11 %	78,13 %	74,88 %	71,82 %	72,73 %	76,95 %	74,36 %
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48 %	50,77 %	56,18 %	61,29 %	58,52 %	54,92 %	50,64 %	53,25 %	59,94 %	50,92 %
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

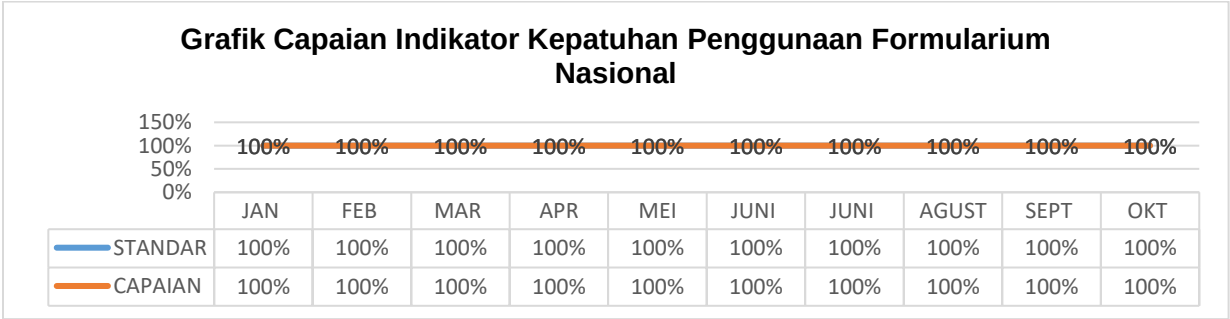
3.6.1.2.2.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.6.1.2.2.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



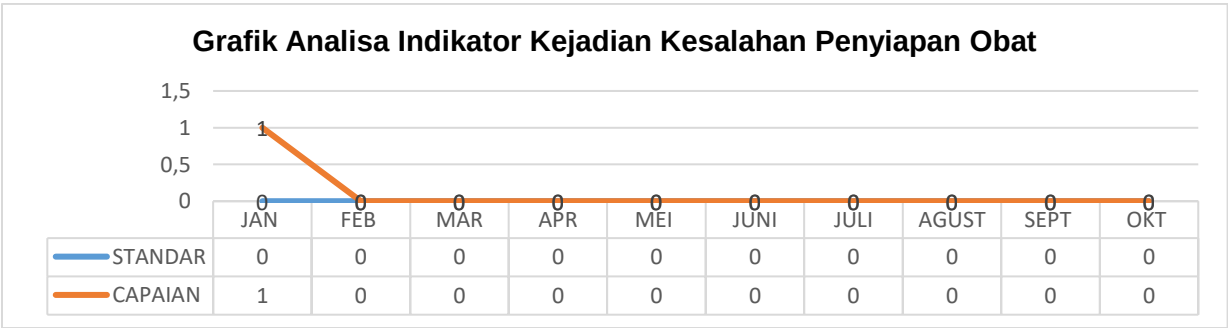
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien masih belum mencapai standart di bulan Februari, pada bulan Januari hingga Oktober capaian telah mencapai standart 100%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Meningkatkan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
3.6.1.2.2.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 telah mencapai standart.

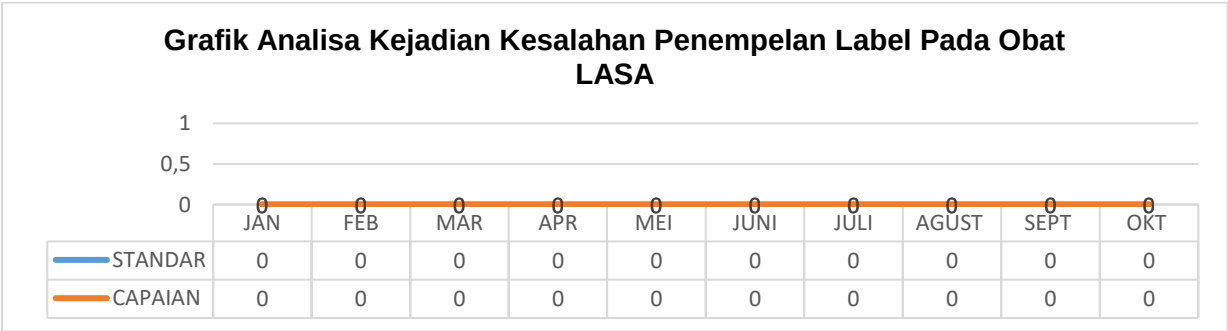
3.6.1.2.2.3 Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat
3.6.1.2.2.3.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari hingga Oktober tahun 2024 diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat.				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahan kan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Mempertahan kan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	1. Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.4 Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

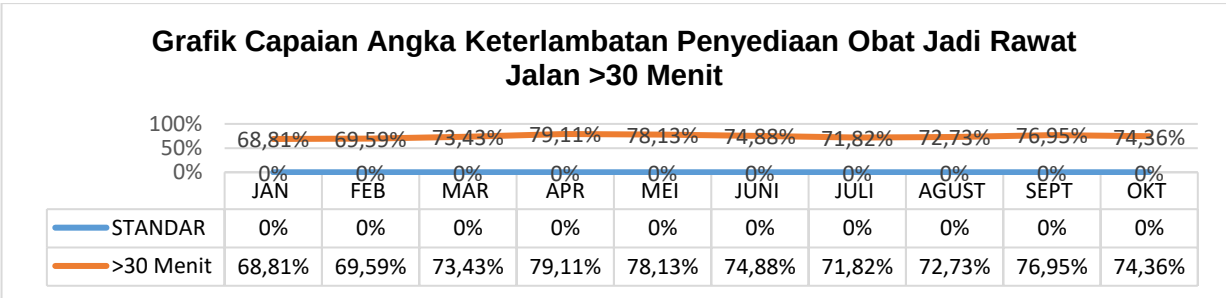
3.6.1.2.2.4.1 Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024

3.6.1.2.2.5 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

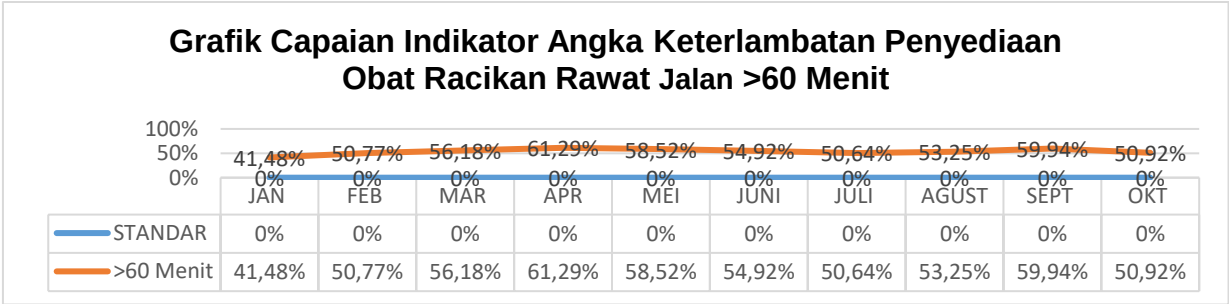
1.2.1.2.2.5.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena petugas farmasi seringkali melakukan klik selese obat tdak realtime ketika obat selesai atau klik obat selesai dilkaukan ketika 5 atau 10 resep selesai dikerjakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Mengurangi angka keterlambat an penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.6 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

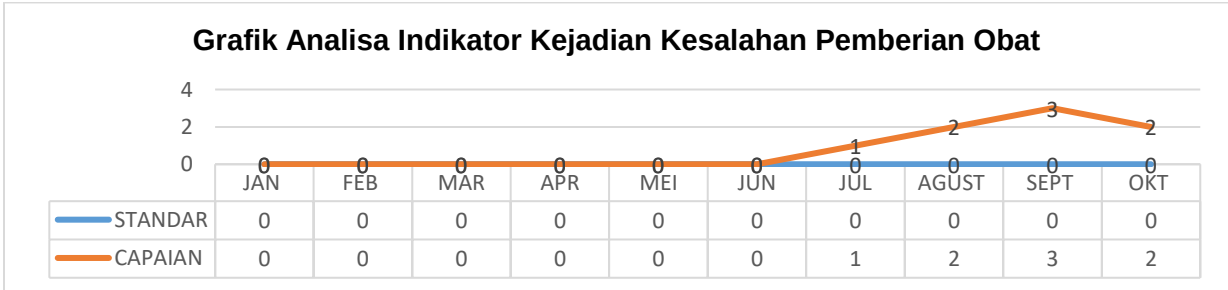
3.6.1.2.2.6.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena petugas farmasi seringkali melakukan klik selese obat tdak realtime ketika obat selesai atau klik obat selesai dilkaukan ketika 5 atau 10 resep selesai dikerjakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Mengurangi angka keterlambat an penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.7 Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

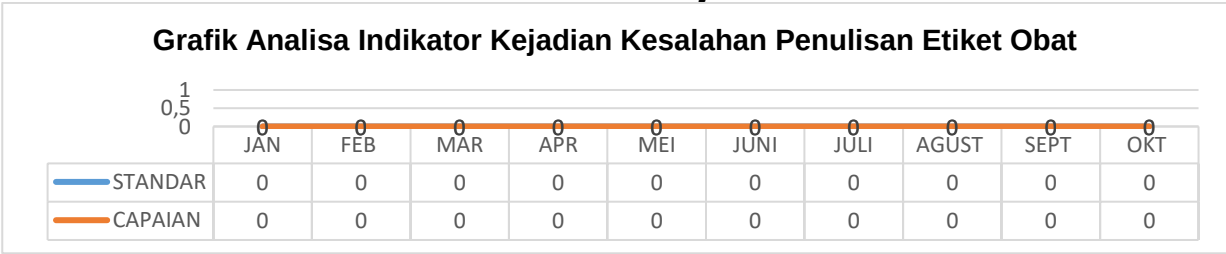
3.6.1.2.2.7.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kejadian kesalahan pemberian obat hingga mencapai standart yaitu 0 kejadian				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien yang mendapatkan resep 2. Melakukan rapat berasama kepala instalasi farmasi guna melakukan supervisi terkait kepatuhan identifikasi pasien dalam proses pemberian obat.				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Juni tahun 2024 tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat. Pada bulan Juli tahun 2024 ditemukan 1 kejadian kesalahan pemberian obat, pada bulan Agustus ditemukan 2 kejadian kesalahan pemberian obat ,pada bulan September terjadi 3 kejadian kesalahan pemberian obat dan bulan Oktober terdapat 2 kejadian kesalahan pemberian obat. Kesalahan pemberian obat disebabkan karena petugas tidak teliti muali proses penyiapan hingga pemberian obat ke pasien. Di bulan Oktober ini kejadian kesalahan pemberian obat terjadi karena DPJP salah melakukan input dan petugas primantara salah melakukan pengantaran.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Meningkatkan ketelitian Diklat khusus petugas primantara 2. Meningkatkan ketelitian dan Diharapakn perawat poli juga membantu DPJP untuk melakukan pengkajian sehingga dapat mengingatkan ketika DPJP ada kesalahan ketika input e resep	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.8 Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

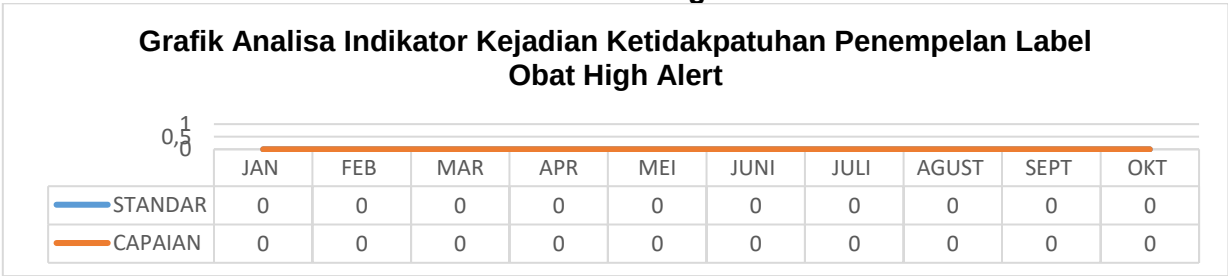
3.6.1.2.2.8.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



Analisis :
 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Januari hingga Oktober tahun 2024.

3.6.1.2.2.9 Kejadian Ketidapatuhan Penempelan Label Obat High Alert

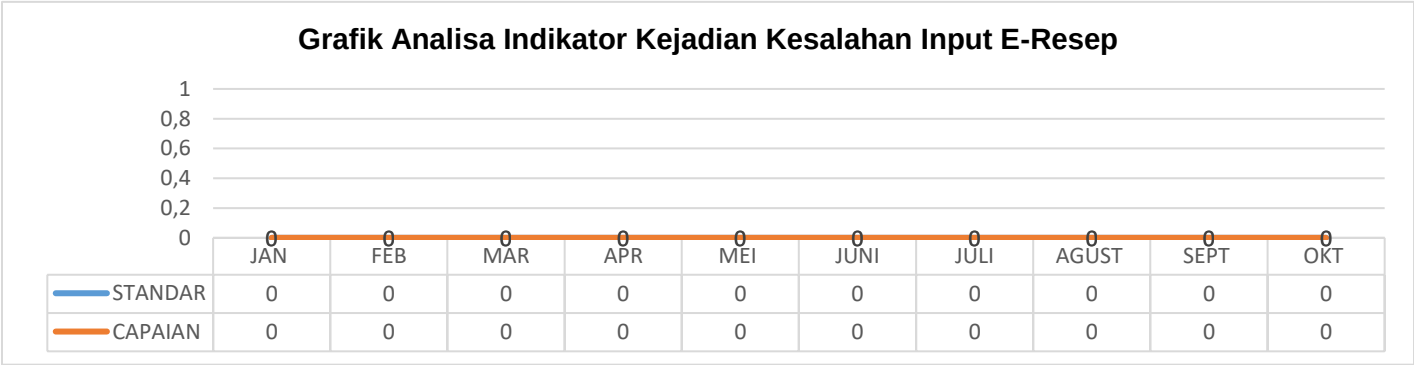
3.6.1.2.2.9.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidapatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis:
 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidapatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga Oktober tahun 2024.

3.6.1.2.2.10 Kejadian Kesalahan Input E-Resep

3.6.1.2.2.10.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep

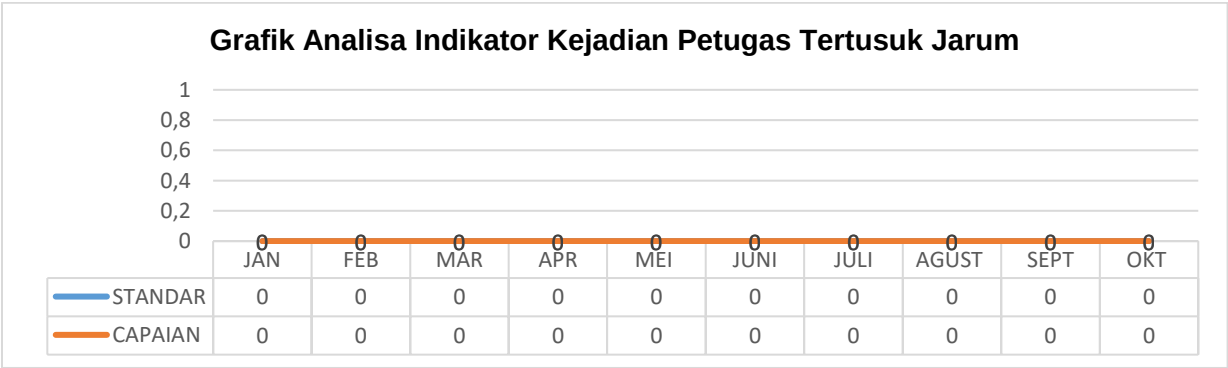


Analisis :

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024.

3.6.1.2.2.11 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

3.6.1.2.2.11.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

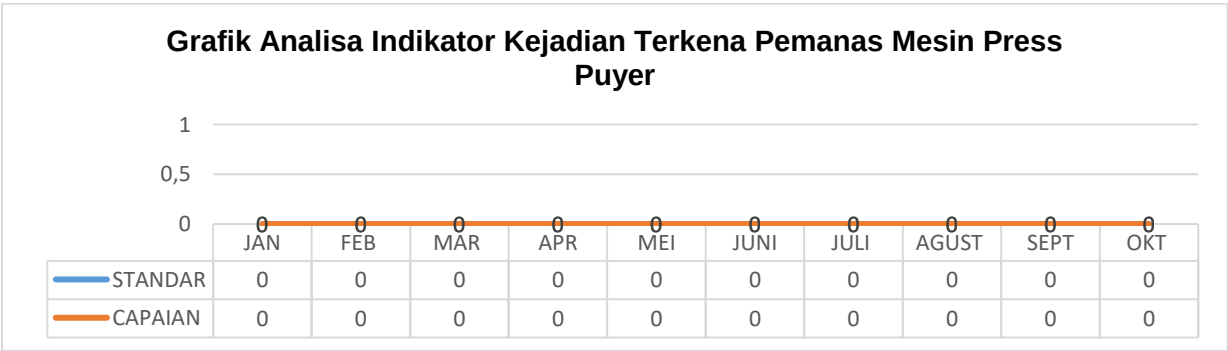


Analisis:

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum sejak bulan Januari hingga Oktober tahun 2024.

3.6.1.2.2.12 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.6.1.2.2.12.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

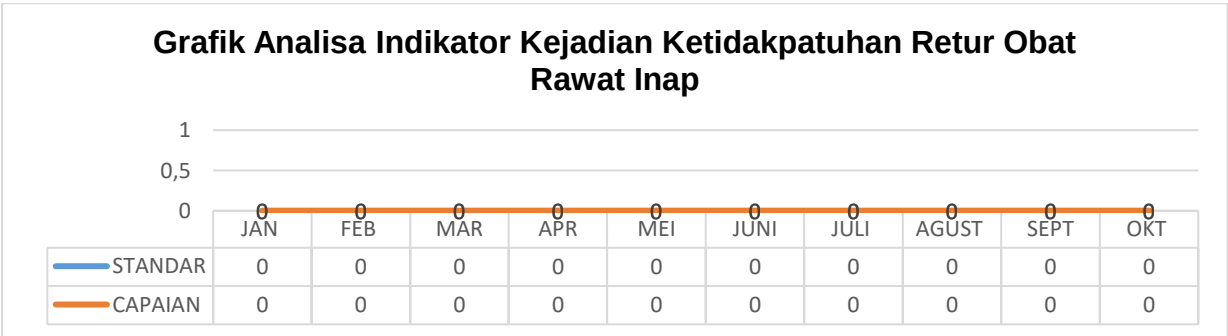


Analisis :

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga Oktober tahun 2024.

3.6.1.2.2.13 Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap

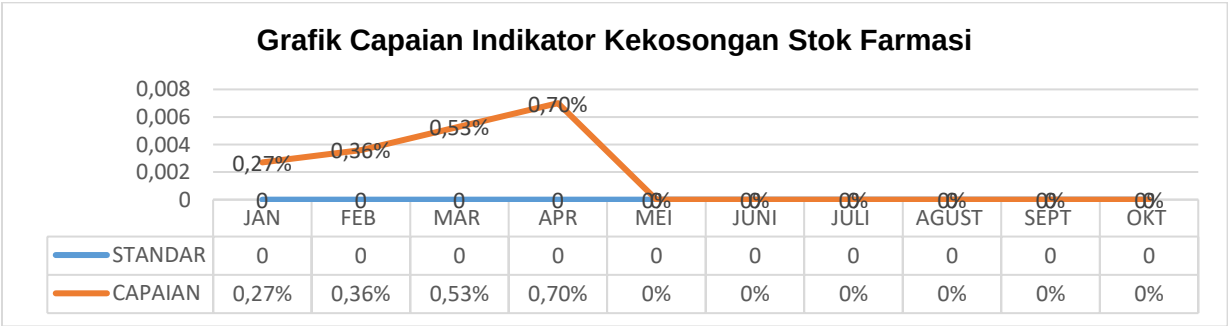
3.6.1.2.2.13.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap



Analisis Capaian :
Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap sejak bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024.

3.6.1.2.2.14 Kekosongan Stok Sediaan Farmasi

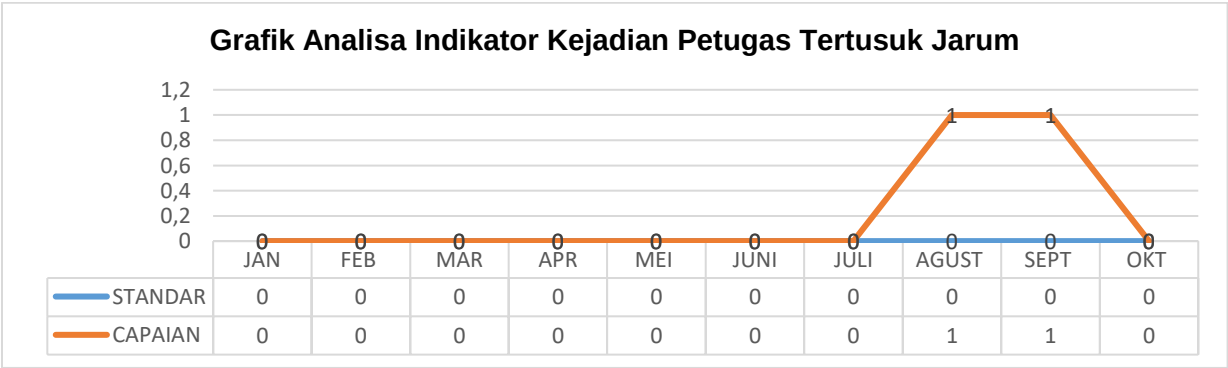
3.6.1.2.2.14.1 Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi				
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi pada bulan Januari hingga April. Pada bulan Mei hingga Oktober masih ada kekosongan obat teratasi dengan adanya substitusi sehingga tidak mengganggu pelayanan. Kekosongan obat farmasi disebabkan karena : - Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : - Barang sedang kosong distributor - Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf - Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada - Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan - Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali - Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf - Ijin edar obat tertentu belum di setujui bpom, seperti kasus per sirup an kemarin				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbaruhi surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	- Kepala Instalasi farmasi - Pengadaan Farmasi PT	Satu bulan

3.6.1.2.3 Manajemen Resiko												
NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

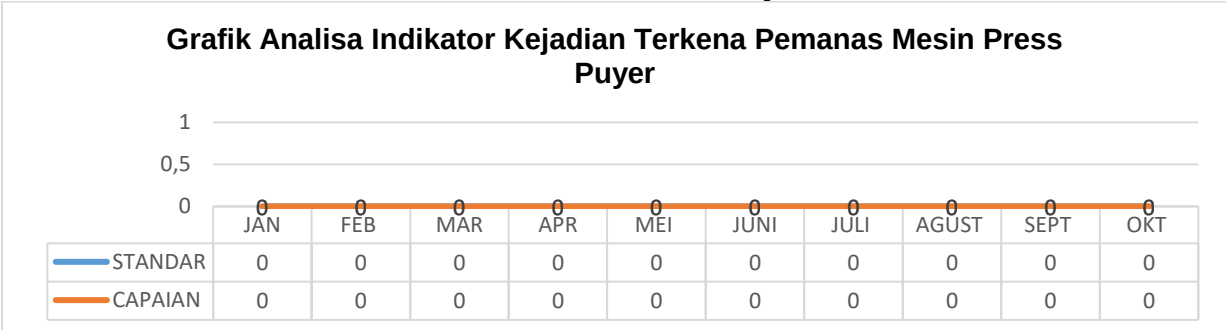
3.6.1.2.3.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
3.6.1.2.3.1.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. 2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. 4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan Agutus terdapat 1 kejadian petugas tertusuk jarum dan pada bulan September terdapat 1 kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien. 5. Supervisi petugas terkait pembuangan jarum bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.3.2 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.6.1.2.3.2.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024.

3.6.1.3 Mutu Unit

3.2.1.3.1 Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	96,25 %	100%	100%	100%	100%	97,35 %	100%	100%	100%
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0,17 %	0%	0,28 %	0,15 %	0,67 %	0,15 %	0,29%	5,2%	5,87%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,08 %	91,35 %
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,7%	0,85 %	0,61 %	0,73 %	0,5%	2,61 %	1,62 %	1,82%	2,82%	1,82%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.1.1 Kunjungan IGD

HAL	AGT'24	SEPT'24	OKT'24	HASIL PROSENTASE KUNJUNGAN PASIEN OKT 2024
BPJS	907	981	1043	↑6%
Umum	379	371	384	↑3,38%
JKK	57	38	57	↑33%
Asuransi Lain	38	39	44	↑11,36%
JR	10	10	6	↓66%
Total Pasien	1.391	1.439	1.534	↑6,19%

3.2.1.3.1.2 Data Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri

01/10/2024	1	MUHAMMAD AXEL BARA ALFARIZKI	L	3 BLN	220515	UMUM	GEA + VOMITING PROFUSE	EKONOMI
02/10/2024	2	OMAR SURYANA	L	56 THN	169076	BPJS	CHEST PAIN	LAIN - LAIN

03/10/2024	3	SI'IN	P	66 THN	206658	UMUM	PNEUMONIA	EKONOMI
04/10/2024	4	JUMA'ATI	P	65 THN	220685	UMUM	CHEST PAIN	ALASAN PRIBADI
04/10/2024	5	DZAKIRA TALITA RAHMADHANI	P	11 THN	220703	UMUM	COLIC ABDOMEN	ALASAN PRIBADI
05/10/2024	6	MUHAMMAD HANAN NADHIF	L	3 THN	220722	UMUM	VOMITING	ALASAN PRIBADI
05/10/2024	7	ACHMAL MUSTOFA	L	21 THN	220750	JKK	VULNUS APPERTUM	ALASAN PRIBADI
06/10/2024	8	MUHAMMAD SAADAN ARKANANTA	L	3 THN	186695	BPJS	BRONCHOPNEUMONIA	PENGOBATAN ALTERNATIF
06/10/2024	9	DEA AULIA AZMI SARJONO	P	29 THN	046068		CF METACARPAL	ALASAN PRIBADI
07/10/2024	10	RIZA YUSTIAWAN	L	36 THN	159740	UMUM	OPEN FRAKTUR PROXIMAL + DISTAL	LAIN - LAIN
08.10/2024	11	NUR ISTIQOMAH	P	62 THN	216832	BPJS	VERTIGO	ALASAN PRIBADI
09/10/2024	12	SUMARTO	L	37 THN	220930	BPJS	FINGER TIP INJURY DIGITI 5 MANUS DEXTRA	ALASAN PRIBADI
07/10/2024	13	SUNARYO	L	67 THN	188101	BPJS	CKD ST V	ALASAN PRIBADI
11/10/2024	14	ANINDYA KHANZA MAHESWARI	P	4 THN	159921	UMUM	STATUS EPILEPTIKUS	ALASAN PRIBADI
11/10/2024	15	MOCHAMAD ARIFIN	L	57 THN	220993	UMUM	SUSP CF SHOULDER (D)	ALASAN PRIBADI
12/10/2024	16	YANTI	P	18 RHN	220649	BPJS	COLIC ABDOMEN	ALASAN PRIBADI
12/10/2024	17	RUSMINI	P	50 THN	221041	BPJS	CHEST PAIN	ALASAN PRIBADI
14/10/20224	18	AHMAD BALYA AL KHAWARIZMI	L	1 THN 1 BLN	207342	BPJS	TF	LAIN - LAIN
14/10/20224	19	BERNADI	L	62 THN	127891	BPJS	DERMATITIS NUMULARIS	ALASAN PRIBADI
14/10/20224	20	RUDI HARTONO	L	34 THN	221147	BPJS	INJURY	ALASAN PRIBADI
16/10/2024	21	MUHAMMAD DEFAN ALFARIDZY	L	6 THN	132462	BPJS	FEBRIS	ALASAN PRIBADI
16/10/2024	22	HOIRI	L	49 THN	221215	UMUM	CF CRURIS (S)	EKONOMI
18/10/2024	23	ARFAN RASYA	L	2 TH 6 BLN	206279	UMUM	FEBRIS	EKONOMI
18/10/2024	24	MUH EDY KURNIAWAN	L	38 THN	221325	BPJS	ABSES	LAIN - LAIN
19/10/2024	25	ZALFA AISYAH KUSUMA AMIDAH	P	24 THN	221332	UMUM	CKR 456 + CF NASAL	EKONOMI
20/10/2024	26	AZZAM ALKHALIFI ZAINUDIN	L	3 THN	171114	BPJS	FEBRIS	LAIN - LAIN
25/10/2024	27	AGUS HADI SANTOSA	L	56 THN	103444	UMUM	TF	LAIN - LAIN
28/10/2024	28	MUHAMMAD YUSUF ADITYA SAPUTRA	L	7 thn	221741	BPJS	KEJANG DEMAM	ALASAN PRIBADI

1.2.1.3.2 IRNA 2A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%					97,64 %	100%	100%	-	-	-
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%					45,54 %	76,92%	90%	-	-	-
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%					-	-	-	-	-	-

4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%					100%	100%	100%	-	-	-
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%					0%	0%	0%	-	-	-
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%	-	-	-
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%	-	-	-

3.2.1.3.2 IRNA 2C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,41 %	100%	97,22 %	100%	100%	100%	100%	100%	94,32%	90,91%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80%	73,53 %	74,84 %	73,57 %	73,23 %	62,6%	62,6%	62,6%	81,55%	66,94%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,8%	100%	95,93 %	100%	93,75 %	100%	100%	100%	87,5%	95,6%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	1,03%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	94,7%	100%	100%	97,14 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49 %	86,36 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.3 IRNA 3A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,18 %	89,4%	91,28 %	80,29 %	87,79 %	91,45 %	86,99 %	84,21%	82,22%	86,5%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	98,61 %	100%	100%	97,41%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	84,96 %	87,65 %	82,43 %	83,94 %	89,17 %	91,45 %	93,15 %	92,11%	86,67%	87,73%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.4 IRNA 4A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	94,84 %	78,2 3%	86,54 %	86,84 %	89,19 %	95%	95%	92,86%	90,16%	86,36%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	71,83 %	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,85%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam	100%	100%	90,7 5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)											
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.5 IRNA 3C ANAK

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	97,4%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0,37%	0%	0,39%	0%	0,94%	0,43%	0,42%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.6 IRNA 5C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	62,07%	66,86%	64,86%	55,35%	67,48%	67,48%	66,67%	68,42%	75,76%	59,24%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54%	0,55%	0,74%	0%	0%	0%	0%	0,52%	0,52%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	99,13%	97,75%	93,02%	96,38%	95,58%	95,58%	94,59%	96,33%	95,99%	93,56%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.7 IRNA 6A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	61,11%	79,63%	84,92%	83,21%	82,79%	76,47%	71,01%	79,69%	77,27%	76,54%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,39%	100%	89,52%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	3,57%	3,85%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.2.1.3.8 IRNA 7A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	97,92 %	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	58,22 %	76,67 %	75%	84,56 %	76,74 %	63,78 %	72,73 %	72,44 %	69,54 %	65,79 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,67 %	100%	100%	100%	97,12 %	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	0%	0,9%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100 %	86,52 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	91,09 %	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.9 IRNA 8A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100 %	92,21 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	54,39 %	78,49 %	81,45 %	84,56 %	71,76 %	75,93 %	82,14 %	89,23 %	90,14 %	96,55 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	99,15 %	100%	100%	96,72 %	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100 %	98,91 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.10 ICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '23	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	98,2%	100%	100%	100%	100%	100%	98,5%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	98,7%	100%	100%	94,4%	98,8%	97,2%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%										
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	81,8 %	92,53 %	86%	90,4%	100%	100%	80%	90,2%	73,7%	85,96%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	83,33%	100%	100%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%	100%	90,7%	95,4%	94,4%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-	0%	0%

3.2.1.3.2.11 HCU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-			
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	96,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	%	0%	0%

3.2.1.3.2.12 IRJA

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,75 %	100%	95,71 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	95,2%	91%	95,74 %	52,7%	63.8%	72,8%	80,97 %	85,74%	88,65%	82,77%
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	84,42 %	82,35 %	84,04 %	84,04 %	70,04 %	81,72 %	81,72 %	81,88%	81,79%	58,67%
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%	0%	37,03 %	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.13 Maternitas

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	99,44 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,63 %	100%	94,67%	100%	100%
6	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
10	Kejadian partus lama	0	1	0	0	0	0	3	4	1	0	1
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	3	1	0	0	0	0	0	4	5	7
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	3,82 %	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85 %	11,38%	5,77%	15,49%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	3,82 %	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85 %	11,38%	5,77%	15,49%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,54%

3.2.1.3.2.14 NICU												
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,92 %	90,63 %	84,72 %	90,8%	84,82 %	82,35 %	88,79 %	81,01%	84,81%	93,75%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	4,17%	3,26%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kematian Bayi	0%	0%	0%	0%	0%	3,7%	1,28%	4,55%	0%	7,41%	3,57%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HAL	TARGET /BULAN	AGUSTUS '24	SEPTEMBER '24	OKTOBER '24	PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
BPJS	7	12	8	14	75%
UMUM	2	2	5	3	40%
Asuransi Lain	1	1	0	1	100%
BPJS IKUT IBU	100	116	99	123	24%
Total Pasien	110	131	112	141	25,9%

NO	NAMA PASIEN	DPJP	DIAGNOSA	TGL MRS	TGL MENINGGAL	PEWS (PEDIATRIC EARLY WARNING SYSTEM)	UNIT
1.	By. Ny. Robiatul Adawiyah	Dr. Fiona, Sp.A	Prematur BBLASR, RDS ok HMD neonatal pneumonia	31/10/2024	31/10/2024	7+	NICU

3.2.1.3.2.15 IKO												
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%	0%	23,08%	0%	0%	20,3%	20,96%	23,81%	0%	0%

3.2.1.3.2.16 Laboratorium

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,48%	97,5%	98,9%	99,68%	100%	98,03%	100%	97,91%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	3	2	4	2	2	12	15	11	4	7
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.17 Radiologi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,54%	100%	100%	100%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,72%	3,61%	2,65%	3,81%	3,81%	1,63%	0%	0%	0%	0%
3	Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.1.3.2.18 Gizi

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0

3.2.1.3.2.19 Farmasi												
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100 %	70,26 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,8 1%	69,59 %	73,43 %	79,11 %	78,13 %	75,45 %	71,82 %	71,82%	76,95%	74,36%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,4 8%	50,77 %	56,18 %	61,29 %	58,52 %	54,92 %	50,64 %	50,64%	59,94%	50,92%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.20 Pengadaan Farmasi												
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.21 PPI												
NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%	0 %	0,24 %	0 %	0,25 %	0,52%	0,54%	0,25%
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,28%	0,22%	0,4%	0,25%	0,34%	0,15%	0,15%	0,04%	0,15%	0,08%
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53 %	85,62%	85,62%	85,42%	%	%	85,45%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,3%	93,52%	93,73%	93,73%	93,92%	93,24%	92,15%	92,21%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan	100%	91,91%	92,09%	92,22%	92,29%	92,19%	92,19%	92,18%	92,07%	91,94%	91,99%

	Non Infeksius di Unit Pelayanan											
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

3.2.1.3.2.22 PIPP

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100 %	93,15 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	100 %	91,89 %	99,63 %	99,82 %	99,63 %	99,63 %	99,63 %	99,38 %	99,81 %	99,38 %
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	86,94 %	75,31 %	57,76 %	52,92 %	55,36 %	55,36 %	43,54 %	38,63 %	44,13 %	36,01 %

3.2.1.3.2.23 SDM

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,99 %	98,97 %	99,14 %	98,76 %	95,9%	98,93 %	98,96 %	99,62%	98,66%	98,61%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,32%	3,34%	2,97%	14,3%	4,12%	5,09%	3,88%	3,48%	3,48%	3,54%

3.2.1.3.2.24 Rekam Medis

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	-	-	96,65 %	93,04 %	94,08 %	93,81 %	93,56 %	92,8%	91,52%	91,6%
3.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	0%	0%	7,06 %	9,44 %	7,88%	5,68 %	4,56 %	5,91%	8,35%	7,07%

3.2.1.3.2.25 Keuangan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim	0%	7,7%	6%	3,86%	10,98 %	1,57%	0,78%	0,81%	1,1%	0,9%	0,54%

2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.26 K3RS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.27 Asuransi Center

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	1,07%	1,04 %	0,78 %	0,97 %	0,87%	0,62%	0,89%	0,26%	0,26%	0,45%
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,69%	1,04 %	2,17 %	1,66 %	2,55%	1,66%	1,31%	2,21%	2,21%	1,71%
3	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	9,73%	0,57 %	0,44 %	0,42 %	0,47%	0,46%	0,55%	0,26%	0,26%	2,01%
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1

3.2.1.2.28 IPSRS

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100 %	91%	89%	89,4 7%	91,6 7%	91,6 7%	91,8 4%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.29 UMUM

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	7	4	3	6	6	2	2	3	2
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	11	4	5	2	4	5	9	6	1	4

JUDUL MUTU	OKTOBER
Pengajuan barang ke Pengadaan	surat permintaan pembelian
Keterlambatan barang datang	2 Aitem * Jaket u/ primantara *Flasdisk
Ketidak patuhan jadwal pengambilan barang(barang tidak di ambil	4 UNIT *Driver tgl 21 *CSSD tgl 28 *IGD tgl 28 *iko tgl 28

3.2.1.3.2.30 Cleaning Service

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	0,25 %	1,67 %	29,17 %	28,9 5%	91,6 7%	3,45 %	8,7 %	18,75 %	0%	0%

3.2.1.3.2.31 Kesekretariatan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	34,21 %	0%	20,69 %	78,38 %	48,72 %	26,67 %	36,59 %	42,5%	40%	29,27%
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	25%	100%	62,5%	71,83 %	56,25 %	41,67 %	0%	68,75%	31,25%	30,77%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	65%	-	60,71 %	86,21 %	22,73 %	17,86 %	0%	12,82%	33,33%	28%

3.2.1.3.2.31 Laundry

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0%	5,2%	1,95%	4,19%	1,35%	1,48%	0,96 %	2,42%	2,29%	4,5%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.33 CSSD

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kejadian instrument kurang	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0	3

3.2.1.3.2.34 Humas dan Pemasaran

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '34	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	99,17 %	90,88 %	100%	100%	100%	98,65 %	99,64 %	99,8%	100%	99,4%
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%	93,71	100%	92,82 %	92,82 %	91,73 %	87,44 %	94,21 %	92,72%	90,69%	93,3%

3.2.1.3.2.35 IT

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Resptime penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.36 Kamar Jenazah

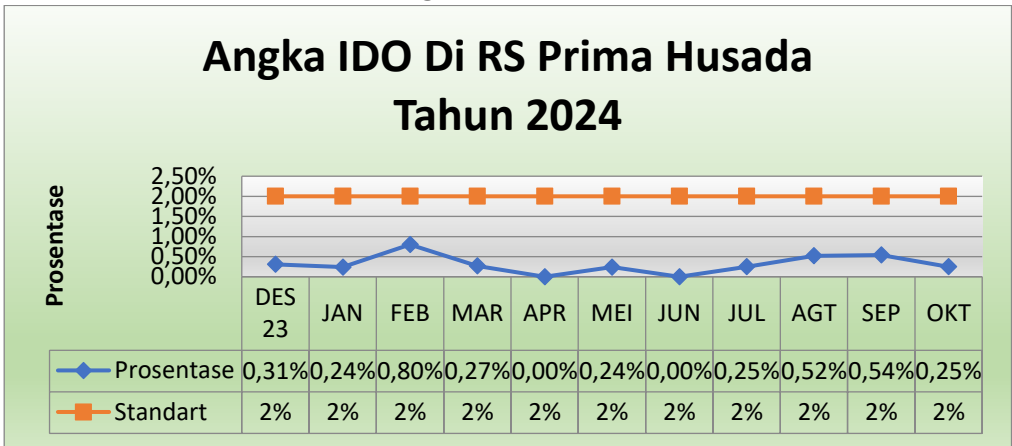
NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

3.6.2 Komite PPI

3.6.2.1 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

3.6.2.1.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

3.1.1.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO):

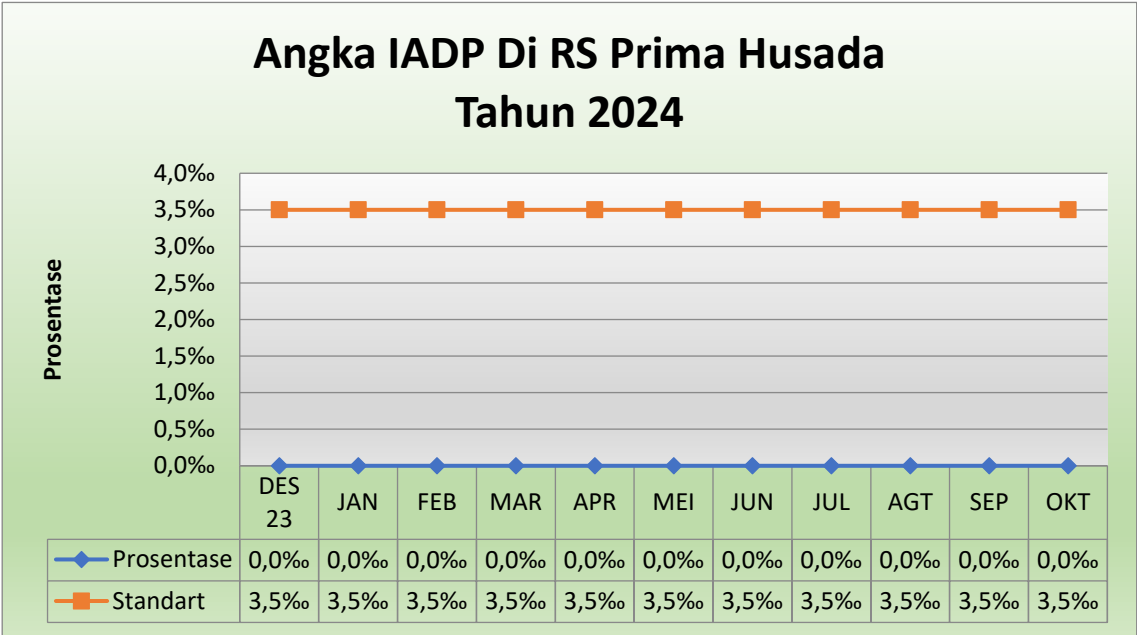


Analisa	Dari grafik diatas diperoleh data terdapat penurunan angka infeksi daerah operasi pada bulan ini jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu mencapai 0,25%. Dimana pada bulan ini hanya terjadi 1 laporan kasus IDO yang ditemukan pada pasien post histerektomy (mioma uteri gebron akar di fundus). Dari hasil assesmen pasien diperoleh data bahwa pasien memiliki riwayat anemia gravis & sepsis. Kondisi sebelum operasi juga sudah mengalami leukositosis dengan kadar leukosit 12.700 (melebihi nilai normal) dengan kadar hb hanya 6,8. Sebelum operasi, pasien sudah melakukan mandi dengan sabun (dettol). Saat MRS kembali, pasien juga mengalami diare dan kadar hb kembali turun walaupun sebelumnya sudah dilakukan transfuse darah. Pasien dirujuk, curiga ada keganasan karena menunggu hasil PA masih belum jadi. Dari keterangan keluarga, nafsu makannya juga menurun dan lebih banyak bed rest di tempat tidur. Dari penjadwalan operasi, pasien ini merupakan pasien pertama yang operasi di kamar operasi tersebut (OK 1) pada pagi hari itu. 
Masalah saat ini	1. Kondisi terdapat penyakit penyerta (anemia & leukositosis) sangat berisiko tinggi terjadi infeksi luka operasi, edukasi perawatan pasien di rumah belum dilakukan maksimal karena pasien masih tidak banyak bergerak.
Permasalahan sebelumnya	2. Proses desinfeksi ruangan operasi yang belum terpantau sepenuhnya. 3. Edukasi pada pasien post operasi belum dilakukan maksimal, komponen feed back belum dilakukan dengan benar. 4. Penjadwalan operasi elektif belum maksimal.
Tindakan yang dilakukan	5. Melakukan koordinasi dengan tim Kamar operasi terkait penggunaan kamar operasi dan pembersihannya saat ada operasi estafet (memakai kamar operasi yang berbeda, jika kamar operasi lainnya kosong). 6. Melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembersihan dan desinfeksi kamar operasi pada operasi estafet paling cepat berjeda 30 menit dengan operasi berikutnya. 7. Melakukan evaluasi proses desinfeksi petugas cs kamar operasi dimana diawal belum menyeluruh, hanya area yang terjangkau saja. 8. Meminta petugas cs kamar operasi untuk membersihkan lagi area yang masih terlihat kotor dan menjalankan tugas sesuai dengan ceklist cs kamar operasi. 9. Berkolaborasi dengan Karu kamar operasi untuk memantau proses pembersihan dan penjadwalan operasi setidaknya berjarak 30 menit dari operasi sebelumnya. 10. Lebih sering melakukan evaluasi langsung terkait kebersihan kamar operasi. 11. Koordinasi dengan kbid keperawatan dan kbid penunjang terkait temuan ppi di dalam kamar operasi. 12. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai di ruang perawatan pasien.

	13. Melakukan evaluasi proses edukasi pada pasien post operasi dengan memastikan pemahaman dari pasien/keluarganya, terutama terkait perawatan saat di rumah dan diit tinggi protein yang baik untuk pasien post operasi.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik terutama pada pasien dengan riwayat penyakit penyerta.	Resiko IDO pada pasien dengan penyakit penyerta dapat berkurang/hilang.	Pasien operasi dengan penyakit penyerta	1. Melakukan monitoring status kesehatan pasien yang akan dilakukan operasi. 2. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 3. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dengan penyakit penyerta. 4. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik)	1. Perawat /Bidan/Gizi 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
2. Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien di rumah	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi gizi pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan ahli gizi terkait pemberian edukasi pasien post operasi dan saat pasien KRS. 2. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 3. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti diit pasien tersebut. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik) 4. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien.	1. Perawat /Bidan 2. Ahli Gizi 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
3. Pertahankan Evaluasi proses pembersihan kamar operasi	Meminimalisir risiko terjadinya infeksi daerah operasi.	Kebersihan kamar operasi	1. Koordinasi dengan Karu IKO terkait penjadwalan pasien operasi estafet. 2. Mendahulukan pasien operasi bersih (non infeksi) jika kamar operasi dipakai estafet. 3. Mengevaluasi proses pembersihan kamar operasi saat dilakukan operasi estafet.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN 5. CS	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

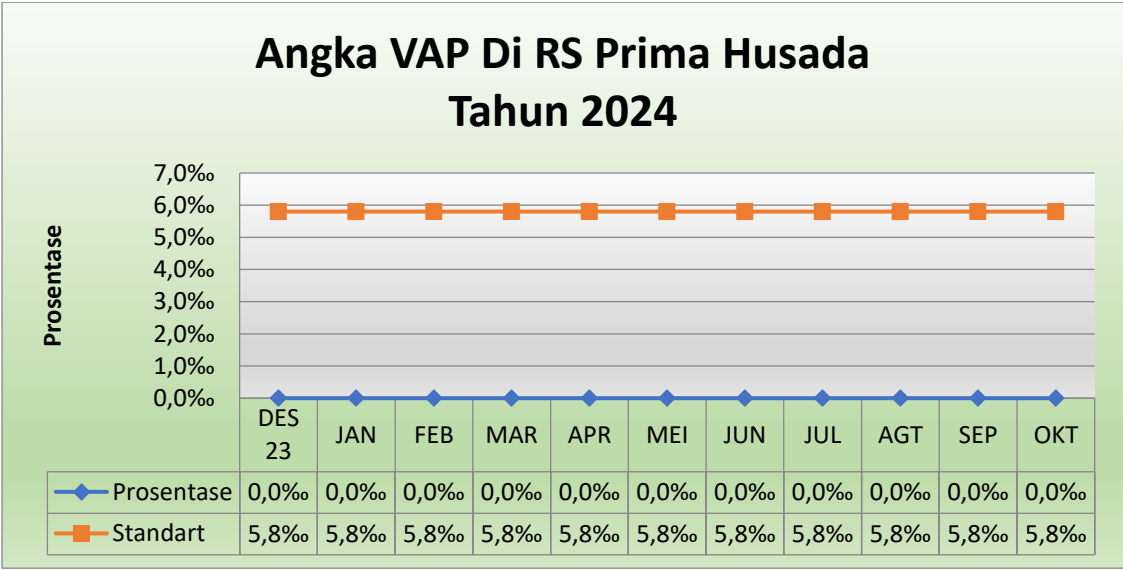
3.6.1.1.2.1 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 28 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
1. Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan

3.6.1.1.3 VAP

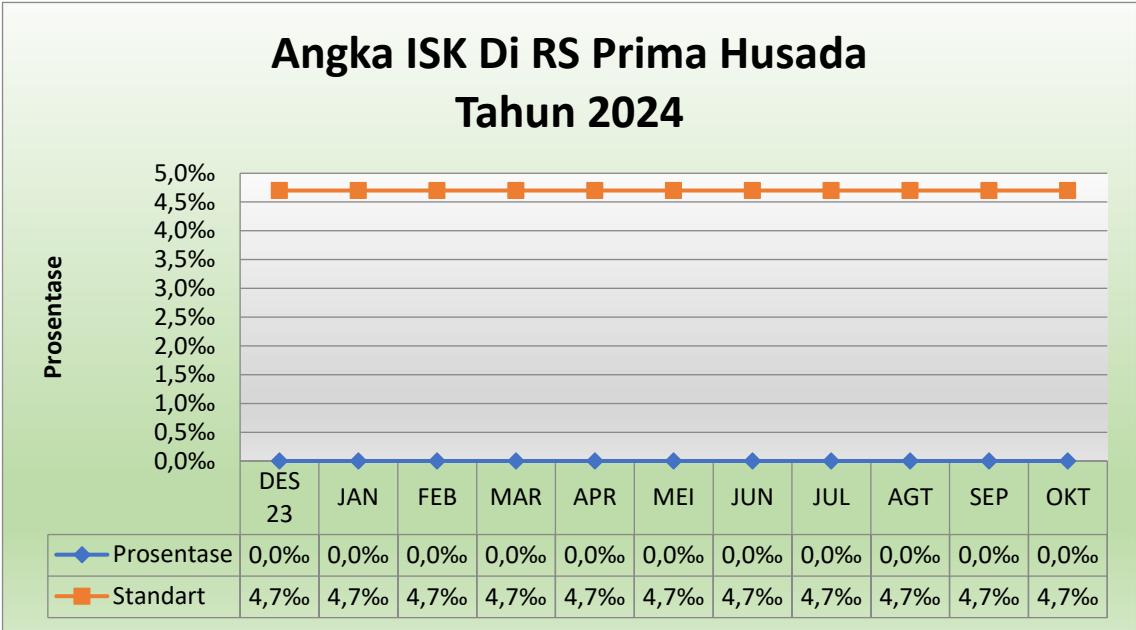
3.6.1.1.3.1 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 35 hari lama pemasangan ventilator.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien dengan ventilator. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Mengusulkan pemeriksaan thorax ulang setelah pemasangan ventilator. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan ventilator, pemberian profilaksis dan perawatan oral hygiene.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle VAP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP.	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan ventilator, pemberian profilaksis dan perawatan oral hygiene.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.4 ISK

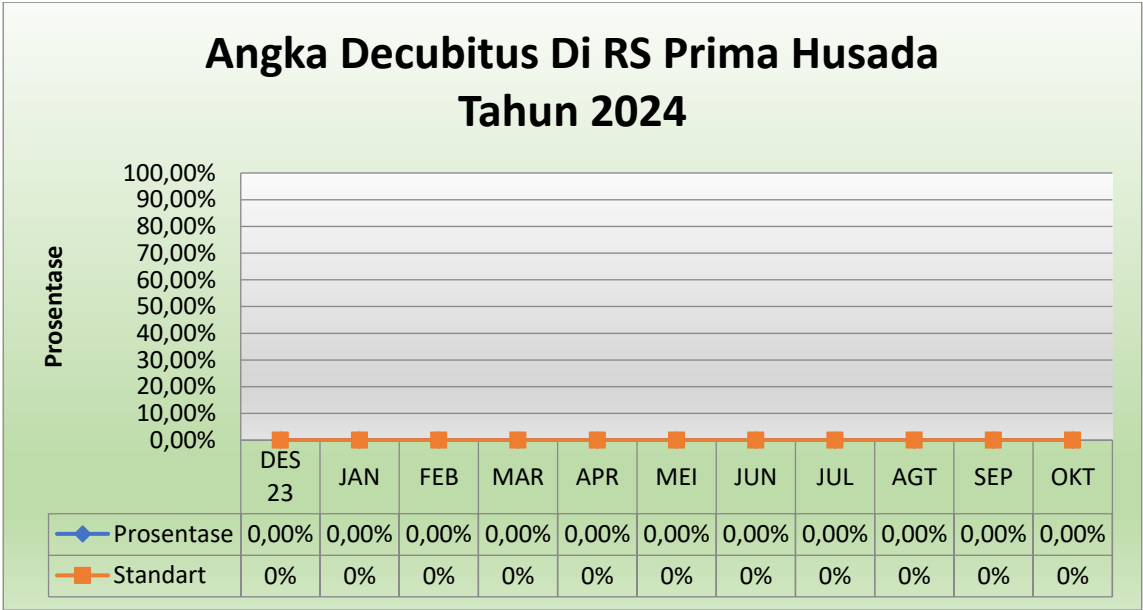
3.1.1.1.4.1 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 936 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
1. Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.5 Decubitus

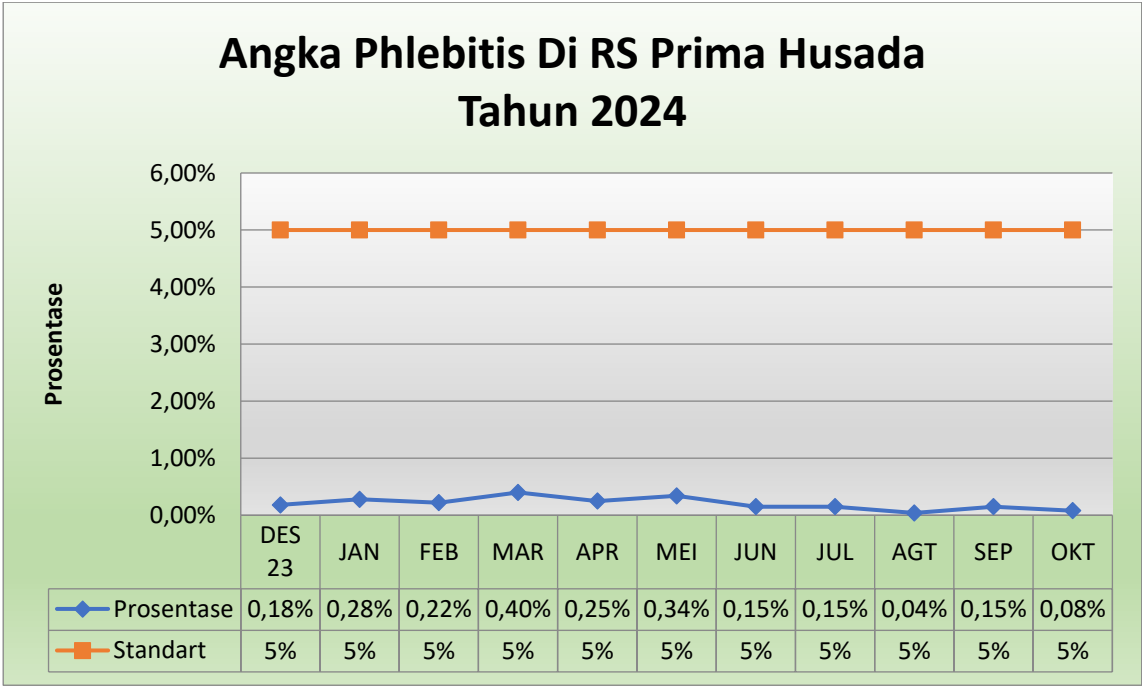
3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 13 pasien tirah baring lama (>3x24 jam).				
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
1. Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.6 Phlebitis

3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

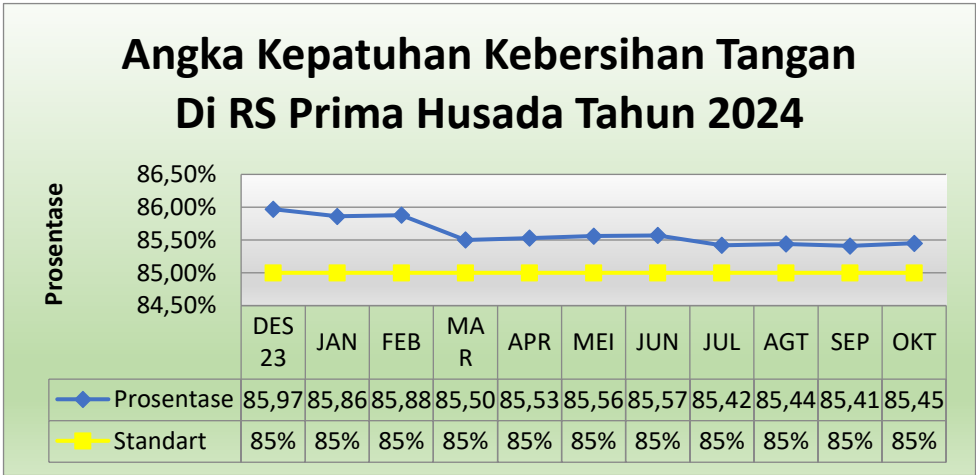


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2591 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,08%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 2 pasien yang mengalami phlebitis karena mendapat cairan infus pekat NS 3% karena kondisi perbaikan elektrolit. Dari 10 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, meskipun sediaannya sudah berupa cairan infus 500 ml, namun karena pemberiannya rutin untuk menaikkan kadar elektrolit s.d normal.				
Permasalahan sebelumnya	1. Penggunaan antibiotik pekat menimbulkan resiko phlebitis tinggi, proses penyuntikan yang cepat juga menyebabkan mudah phlebitis. 2. Penggunaan cairan pekat seperti D40% yang memang pemberiannya tidak diencerkan dan pemberian KCL berkala meskipun sudah dimasukkan dalam cairan infus masih beresiko tinggi phlebitis. 3. Perawatan luka infus khususnya pada pasien anak dan lansia belum rutin dilakukan. 4. Pengontrolan infus saat pemberian transfuse darah juga belum dilakukan secara maksimal.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan atau tetesan terlalu cepat karena jika yang dimasukkan adalah cairan pekat dapat beresiko tinggi phlebitis. 2. Menganjurkan perawat untuk memilih iv canula yang sesuai dengan kebutuhan pasien (lihat besarnya pembuluh darah & rencana pengobatan yang akan diberikan, usahakan menggunakan iv canula ukuran besar). 3. Menganjurkan perawat unit untuk melakukan pengecekan/rawat luka infus setiap hari (setelah injeksi pagi) dengan mengecek apakah ada perubahan pada luka tusukan infus, mengganti balutan plester yang kotor/rusak. 4. Menganjurkan untuk memberikan transfuse darah menggunakan iv canula no 18/20 dan memonitoring proses pemberiannya (tetesan dan lama pemberian transfuse darah tidak lebih dari 2 jam). 5. Memastikan kondisi darah yang akan dimasukkan dalam kondisi hangat supaya tidak gampang menggumpal. 6. Mengkonfirmasi apoteker terkait keamanan pemberian obat injeksi secara bersamaan. 7. Mengajarkan perawat saat memberikan obat injeksi dengan melancarkan aliran infus dan mengusap aliran infus pada pasien dengan alkohol swab untuk melancarkan dan mengurangi nyeri.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

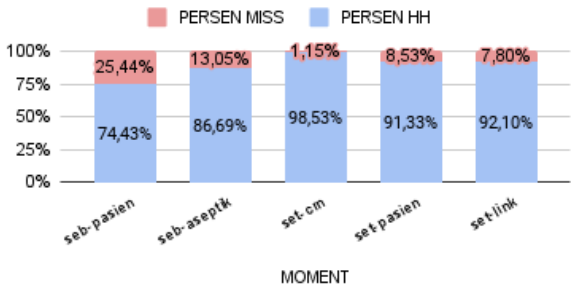
1. Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 2. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 3. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 4. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 5. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat. 6. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
--	---	-----------------------------	---	--	------------

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

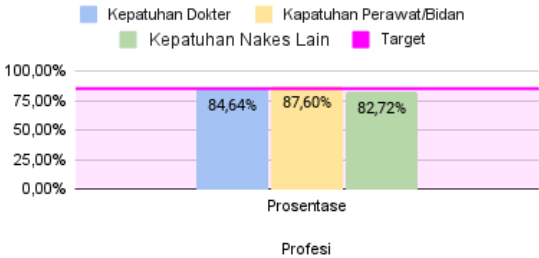
3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



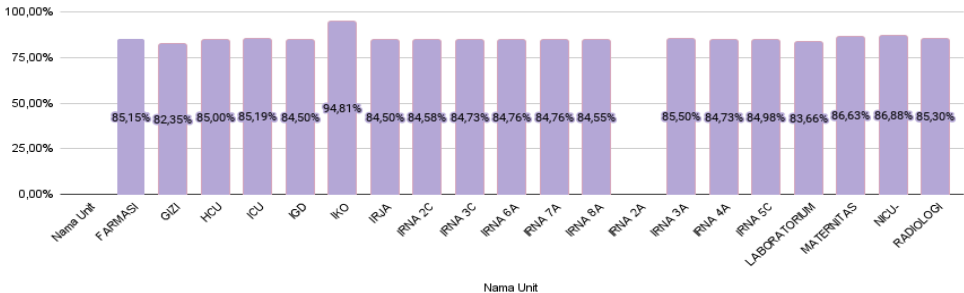
KEPATUHAN HH BERDASARKAN 5 MOMENT
OKTOBER 2024



KEPATUHAN HH BERDASARKAN PROFESI
OKTOBER 2024



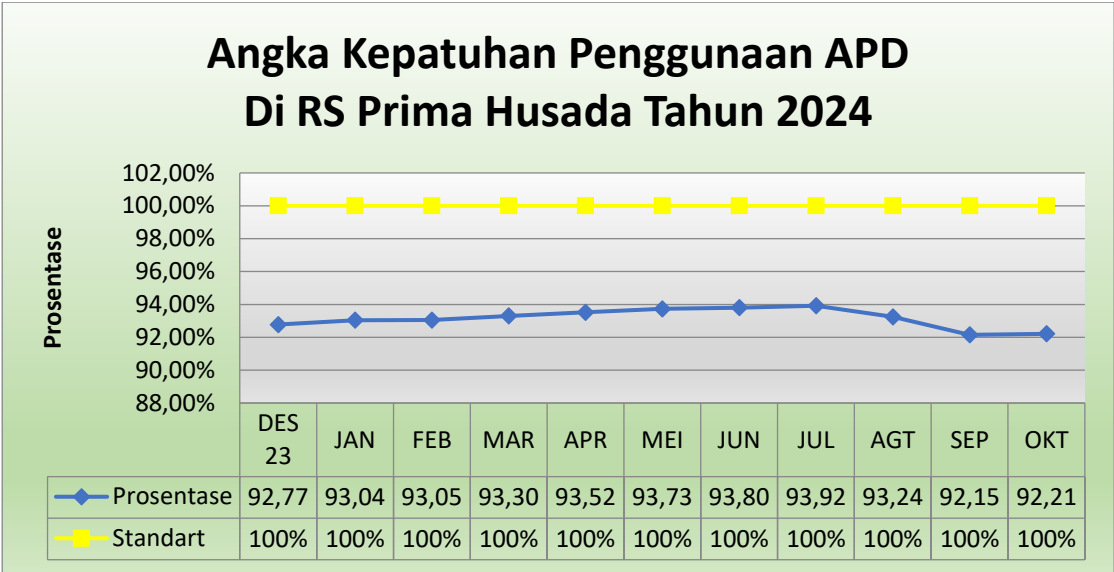
KEPATUHAN HH BERDASARKAN UNIT
OKTOBER 2024



Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,45%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (84,64%) dan nakes lain (82,72%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (74,43%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena persepsi yang salah dan kurangnya kesadaran petugas terkait pentingnya kebersihan tangan seperti pada profesi dokter yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan. (mementingan keselamatan diri sendiri)				
Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap pentingnya cuci tangan dan persepsi kebersihan tangan yang salah.				
Permasalahan sebelumnya	1. Petugas paham terkait 5 momen cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien. 2. Penggunaan APD berlebihan (handscoon) menyebabkan petugas malas melakukan cuci tangan, bahkan ada yang handrub dengan memakai sarung tangan.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



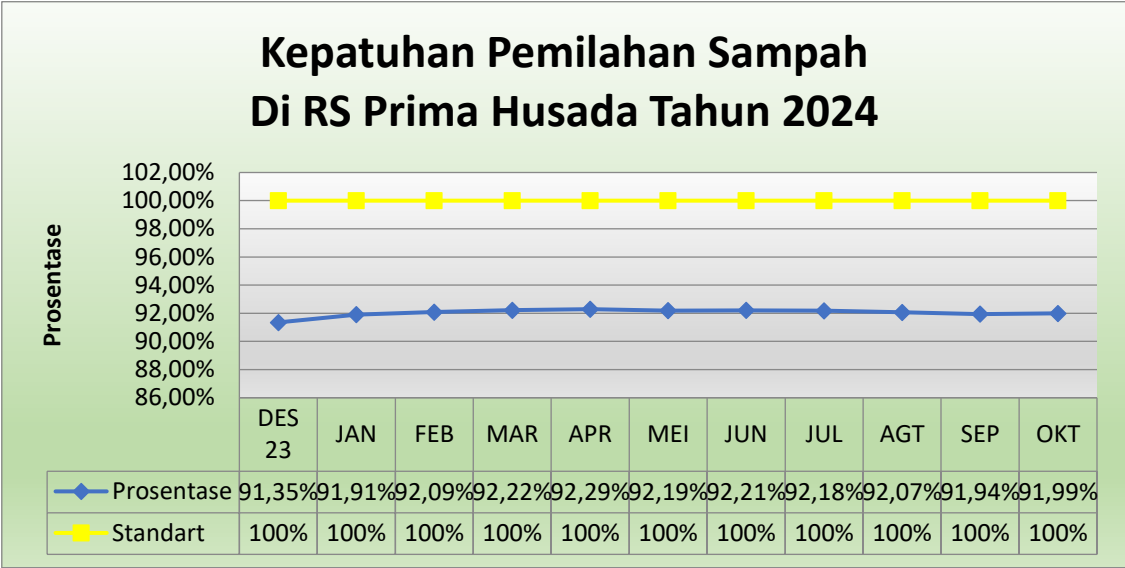
Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,21% menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan.				
Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi.				
Permasalahan sebelumnya	1. Ketidakpatuhan masih dilakukan oleh petugas dapur (pengolah makanan), yang tidak tertib memakai masker. 2. Ketidakpatuhan pemakaian APD juga masih dilakukan oleh DPJP dimana masih menggunakan APD lengkap saat hanya visite pasien saja.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.9

Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

3.6.1.1.9.1

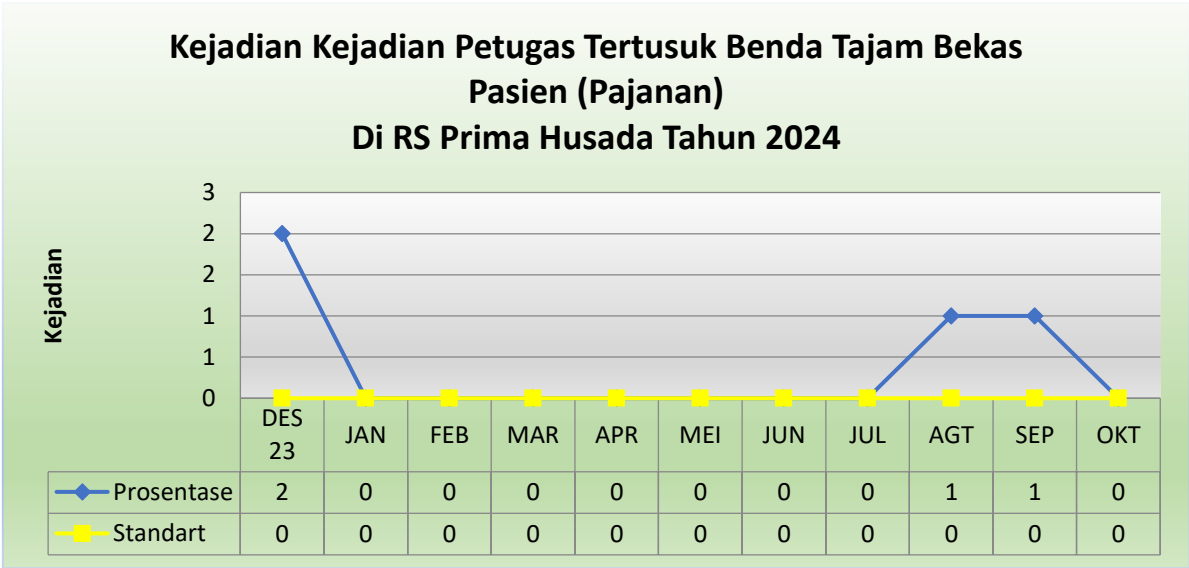
Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



			forum rapat PPI maupun grup WA.		
			4. Saran memindahkan sampah infeksius yang ada di area umum.		
			5. Ingatkan terkait aturan pembuangan cairan infus pada wastafel/spoelhoek sebelum membuang botolnya.		

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Terjadi penurunan kejadian pajanan pada bulan ini dimana tidak ditemukan kejadian pajanan sesuai dengan standar.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi pajanan				
Permasalahan sebelumnya	Ketidakpatuhan petugas melakukan pemilahan sampah pada saat melakukan tindakan sehingga merugikan orang lain.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mewajibkan penggunaan safety box pada troli tindakan saat melakukan tindakan dengan langsung membuang limbah benda tajam yang dihasilkan. 2. Menganjurkan kepala ruang & PJ shift untuk juga mengoperkan ruangan dan troli tindakan dalam keadaan bersih setiap pergantian shiftnya. 3. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 4. Memberikan konseling pada petugas yang pernah terpajan untuk lebih berhati-hati dan tidak takut untuk melaporkan kejadian pajanan. 5. Melakukan monitoring recapping tutup jarum, dimana 6 dari 10 petugas yang diamati tidak one hand saat melakukan recapping, 2 diantaranya melakukan one hand namun saat merasa tidak diawasi kembali tidak melakukan one hand.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

			yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.		
--	--	--	--	--	--

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	AGT	SEP	OKT	%	MANDOK	KETERANGAN
1	IRNA 2C	8x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Ada	
2	ICU HCU	8x/Bulan	50%	0%	100%	Tercapai	Ada	
3	IRNA 3C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
4	MATERNITAS	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
5	PERINATOLOGI	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
6	IRNA 5C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
7	IRNA 2A,3A,4A	8x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Ada	
8	IRNA 6A,7A,8A	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
9	IGD	8x/Bulan	100%	75%	100%	Tercapai	Ada	
10	FARMASI	8x/Bulan	100%	75%	75%	Tidak tercapai	Ada	
11	GIZI	8x/Bulan	100%	25%	100%	Tidak tercapai	Ada	
12	IRJA	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
13	PPI		100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
TOTAL				96%	82%	94%		

Analisis : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan oktober mengalami penurunan sejak bulan september , kinerja produktivitas saat ini kembali menjadi 94% diakibatkan unit Irna 2,3,4A, Irna 2C DAN Farmasi belum mencapai target edukasi kelompok

Rencana Tindak Lanjut : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan November.

3.6.3.2 KIE Individu

NO	UNIT	TARGET	AGT	SEP	OKT	%	KETERANGAN
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

Analisis : Hasil Edukasi individu unit pada bulan oktober tercapai 100%, terbukti dalam lembar edukasi kolaborasi DRM telah terisi.

Rencana Tindak Lanjut : -

3.6.3.3 Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Edukasi (DRM) Edukasi

NO	LEMBAR DRM	JML SAMPLE	KELENGKAPAN		ISI BENAR	VERIFIKASI KE PASIEN	KET
			YA	TIDAK			
1	General Consent	30	23	7			Pada TTD Petugas tidak tertulis nama Irna 3C dan 2,3,4 A Dan 1 DRM Tidak tertulis nama pasien/kelu arga pada TTD
2	SBAR	30	30	0	YA	YA	Seluruh DRM SBAR Terisi Lengkap
3	Perencanaan Edukasi / Rencana Asuhan	30	5	25	Tidak		Pengsian perencana an edukasi tidak sesuai, 25 drm pada perencana an edukasi tidak tertulis nama petugas dan pasien atau keluarga pada ttd
4	Pengkajian Kebutuhan KIE	30	30	0	YA	YA	
5	KIE Informed Consent	30	23	7			Pada TTD Petugas tidak tertulis nama Irna 3C dan 2,3,4 A Dan 1 DRM Tidak tertulis nama pasien/kelu arga pada TTD
6	CPPT	30	30	0	YA	YA	
7	Ringkasan Pasien Pulang	30	29	1			Tidak ditemukan Nama jelas padien pada ttd

							ringkasan pulang 1 DRM di IRNA 2,3,4 A
8	Discharged Planning	20	20	0	YA	YA	Pengisian oleh MPP Sudah lengkap
9	Edukasi kolaborasi	30	15	15			Disetiap unit ditemukan 2 DRM yang tidak lengkap yaitu kekurangan nama jelas pada petugas yang memberikan edukasi dan verifikator dilakukan oleh petugas itu sendiri bukap KARU
11	KIE Menjelang Akhir Kehidupan (Pada Pasien yang mau meninggal)	3	0	3			Perencanaan edukasi AS Menjelang akhir tidak terdokumentasikan pada drm
12	Form AMA	1	1	0			Form AMA Terisi lengkap di DRM Unit Maternitas
13	KIE Pre OP di Lembar Pre OP	6	6	0			Pre dan post op terisi lengkap

3.6.3.4 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

NO	UNIT	TARGET	KEGIATAN	JUL	AGT	OKT	%	MANDOK	KET
1	Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Hypnoterapi						
			KIE						
2	Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Hypnoterapi						
			KIE						
3	Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Karya wisata						

4	Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
5	Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	Ada	
6	General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		100%		100%		Terlaksana	
7	Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.5 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	AGT	SEP	OKT	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	100%	0%	0%	Menurun	-	
2	HIV	4X/Bulan	100%	0%	0%	Menurun	-	
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	

- Analisis

: PROGNAS telah memulai Kegiatan Edukasi di bulan Juli tetepi yang rutin melakukan hanya Prognas STUNTING
- Rencana Tindak Lanjut

: Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat ungtkan produktivitas Tim Prognas

3.6.4 Tim Prognas

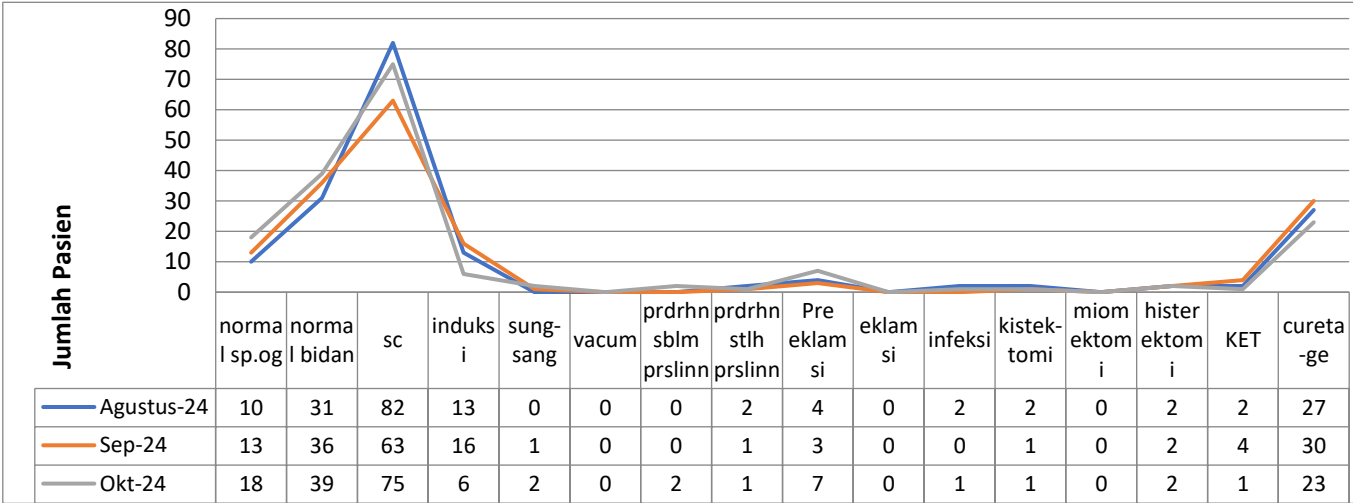
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Oktober 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGT 2024	BULAN SEP 2024	BULAN OKT 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	10	13	18
	b. Persalinan Normal Bidan	31	36	39
	c. <i>SectioCaesaria</i>	82	63	75
2				
	a. Induksi / Drip	13	16	6
	b. Sungsang	0	1	2
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	2
	b. Perdarahan setelah Persalinan	2	1	1
	c. Pre Eklamsi	4	3	7

	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	2	0	1
4				
	a. Curretage	27	30	23
	b. Kistektomi	2	1	1
	c. Miomektomi	0	0	0
	d. Histerectomy	2	2	2
	e. KET	2	4	1

1.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 75 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan Oktober 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 18 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 39 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Pada persalinan dengan sungsang pada bulan Oktober sedikit meningkat, yaitu 2 pasien, sedangkan pada bulan Septermber terdapat 1 pasien, dan tidak ada persalinan sungsang pada bulan Agustus 2024. Untuk persalinan dengan vacuum pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024 tidak ada.
4. Induksi Persalinan pada bulan Oktober mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 6 pasien
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Oktober sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan terakhir, yaitu 7 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024.

6. Jenis pelayanan curretage di bulan Oktober menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 23 pasien. *Curetage* dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

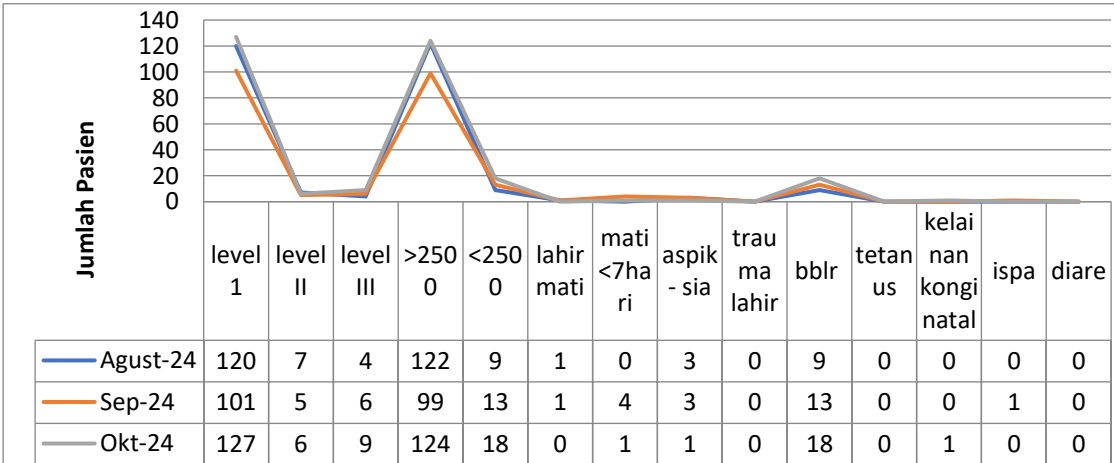
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponек Oktober 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGT 2024	BULAN SEP 2024	BULAN OKT 2024
1				
	a. Level 1	120	101	127
	b. Level II	7	5	6
	c. Level III	4	6	9
2				
	a. ≥ 2500 gram	122	99	124
	b. ≤ 2500 gram	9	13	18
3				
	a. Kelahiran Mati	1	1	0
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	1	4	1
4				
	a. Asphyxia	3	3	1
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	9	13	14
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	1	1
	f. ISPA	0	1	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

- 1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Oktober 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 127 bayi. Dan pada level 2 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 6 bayi. Sedangkan pada level 3 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 9 bayi.
- 2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Oktober 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya tetap sebanyak 124 bayi.
- 3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Oktober 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 18 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- 4. Kasus BBLR pada bulan Oktober 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 18 bayi.
- 5. Tidak ada kasus kelahiran mati pada bulan oktober, sedangkan [ada bulan Agustus dan September tetap yaitu sebanyak 1 kasus
- 6. Kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Oktober menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 kasus kematian

Rencana dan Tindak Lanjut

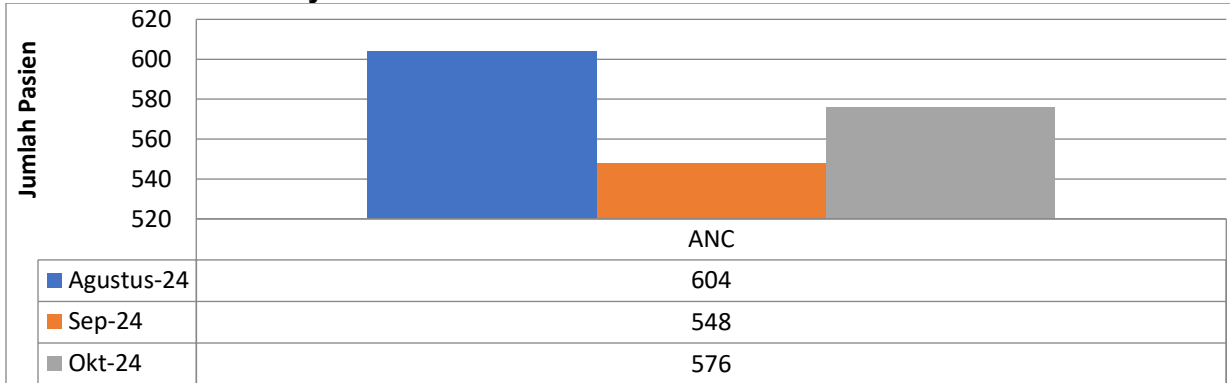
- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek Oktober 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN AGT 2024	BULAN SEP 2024	BULAN OKT 2024
1	ANC	604	548	576

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

Pelayanan ANC pada bulan Oktober 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 576 kunjungan.

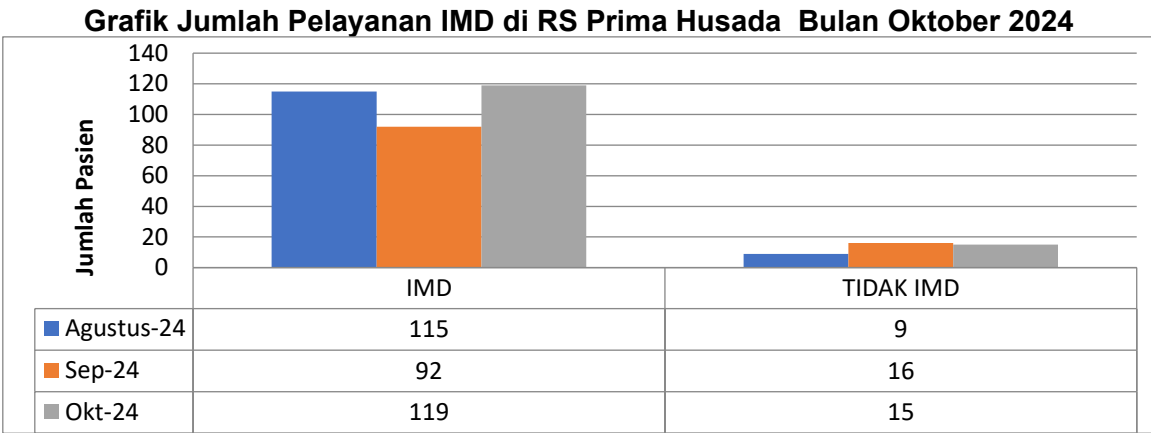
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Oktober 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	IMD	115	92	119
2	Tidak IMD	9	16	15



- Analisis :
- Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 119 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
 - Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Oktober 2024 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 15 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
 - Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :

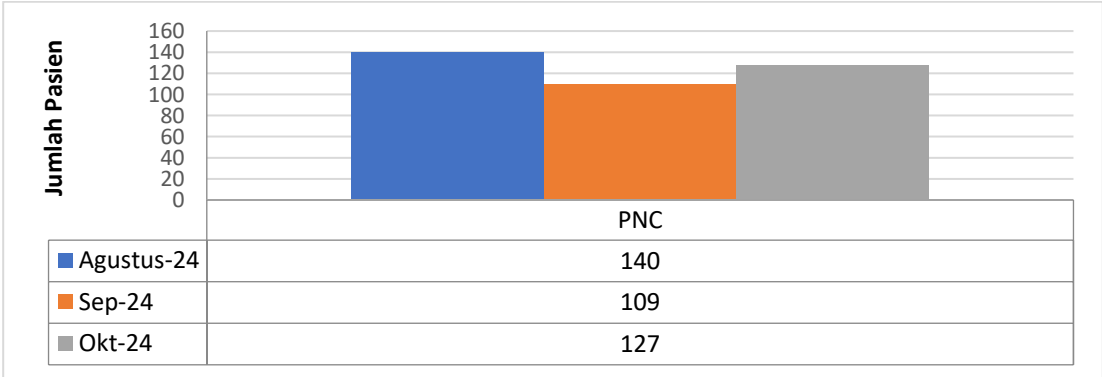
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Oktober 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	PNC	140	109	127

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

Pelayanan PNC pada bulan Oktober 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 127 kunjungan.

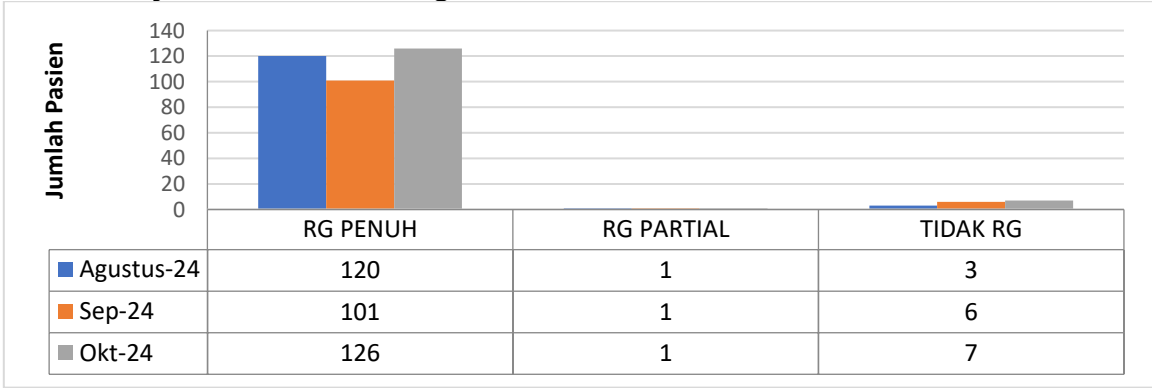
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Oktober 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	Rawat gabung penuh	120	101	126
2	Rawat gabung partial	1	1	1
3	Tidak Rawat gabung	3	6	7

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

- Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Oktober 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 126 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Oktober sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 7 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

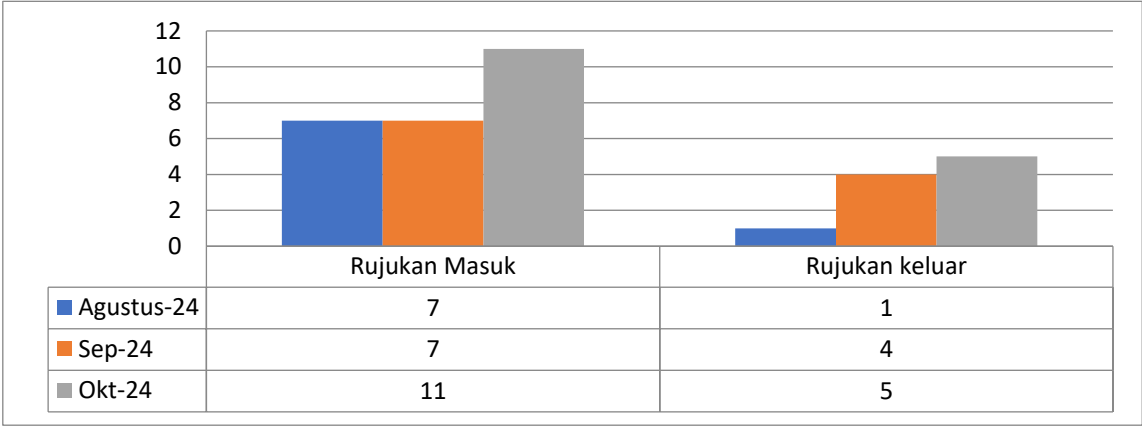
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponek Oktober 2024

NO	RUJUKAN	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	Rujukan Masuk	7	7	11
2	Rujukan keluar	1	4	5

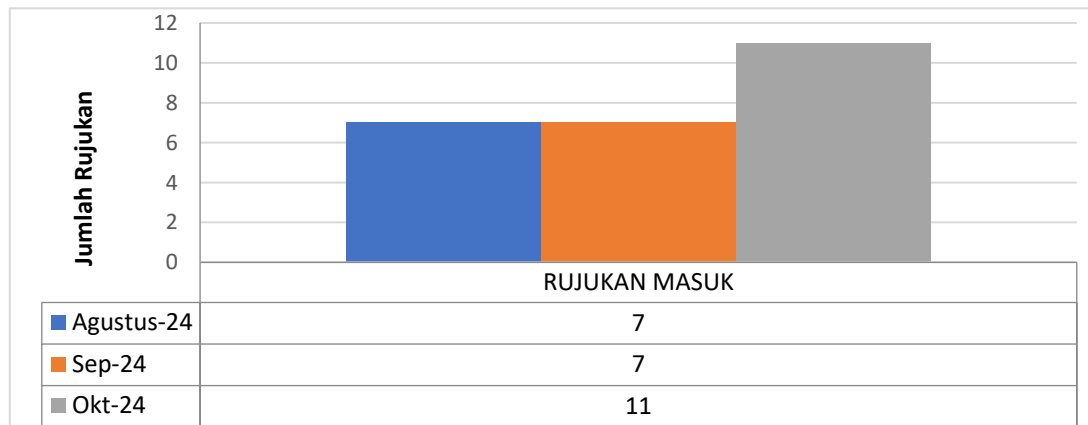
Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek Oktober 2024

BULAN AGUSTUS 2024		
1	G1 P0000 Ab000 UK 20-21 mgg dg KPD + PPI	PKM Singosari
2	G1 P0000 Ab000 UK 34-36 mgg dg KPD	Klinik Muslimat
3	G2 P1001 Ab000 UK 36-37 mgg dg KIFA + KPD	BPM Susmui
4	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 mgg dg PEB + Obesitas	PKM singosari
5	G2 P1001 Ab000 UK 22-24 mgg dg IUFD	BPM Nukina
6	P2002 Ab000 dg post partum dg ruptur perineum	BPM Heni
7	Prematur + BBLSR + Asfiksia	BPM Sofia
BULAN SEPTEMBER 2024		
1	G3 P2002 Ab000 UK 20-22 mgg dg PPI	BPM Tri W
2	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 mgg dg KPD	Poskesdes Lang-lang
3	G1 P0000 Ab000 UK 38-40 mgg dg KPD	PMB Indi
4	Intrauterin Abnormal Bleeding +anemia	Klinik Tirta Husada
5	G3 P2002 Ab000 UK 38-40 mgg dg BSC	PMB Indi
6	Abortus inkomplit	Klinik Rawat Inap Muslimat
7	G3 P2002 Ab000 UK 33-34 mgg dg PPI + Gemeli + BSC	RS Permata Bunda
BULAN OKTOBER 2024		
1	G1 P0000 Ab000 uk 10-12 mgg dengan Abortus Inkomplit	Bidan Tri Widiyawati
2	G1P0000 Ab000 uk 16-18 mgg dg Mola Hidatidosa	Bidan Tri Widiyawati
3	G1 P0000 Aboo uk 36-37 minggu dg Kifa	Pkm Tumpang
4	G2 P1001 Aboo uk 20-22 minggu + Missed Abortion	Bidan Zeni Dwi
5	P3 P2002 Ab000 uk 38-39 mgg dgn Kala 2 + Bsc	Bidan Herawati
6	G2 P1001 Ab000 uk 34-36 mdg PPI + BSC	RSUD Lawang
7	HPP a/i Retensio Plasenta + Ruptur Derajat 3	Bidan Munawaroh
8	G2 P1001 Ab000 uk 42-43 mgg dg Post Date + PER + KIFL	Bidan Wahyu
9	P2002 Ab000 dg Post Partum + HPP + Anemia	Bidan Tri Widiyawati
10	P3003 Ab000 dengan Retensio Plasenta	PKM Singosarei
11	G4 P3003 Ab 0 uk 37-38 mgg dgn KIFL + PE	Bidan Lilik Agustina

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

Jumlah rujukan masuk pada bulan Oktober 2024 meningkat menjadi 11 pasien, sedangkan pada bulan Agustus dan September yaitu 7 rujukan masuk

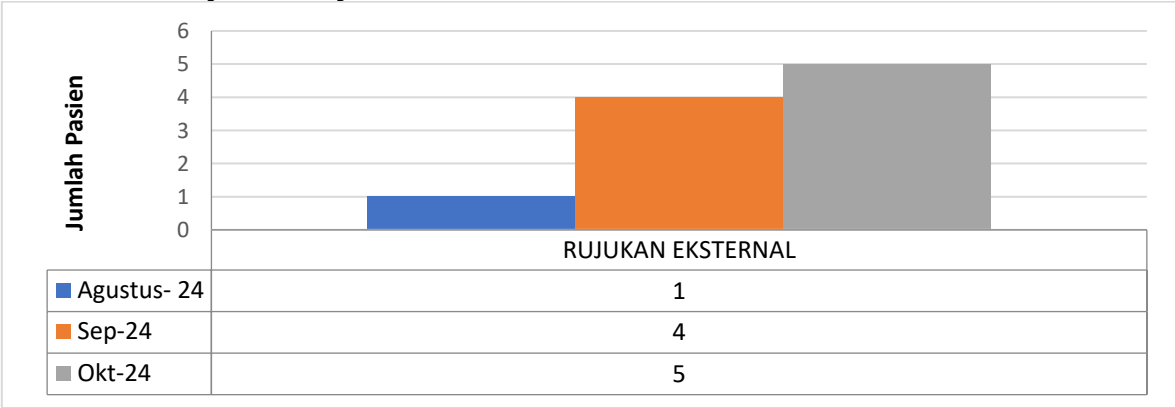
Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponpek Oktober 2024

BULAN AGUSTUS 2024		
1	RDS + BBLR	RS Saiful Anwar
BULAN SEPTEMBER 2024		
1	Neonatal pneumonia dd MAS, Susp PJB kritis dd PPHN, Asfiksia	RS Saiful Anwar
2	BBLR + obs distress nafas + neonatal pneumonia dd RDS Ok labiognatopalatoschizis	RS Soepreoen
3	RDS Ok HMD dd neonatal pneumonia	RS Soepraoen
4	Susp PPHN	RS Saiful Anwar
BULAN OKTOBER 2024		
1	NP-SC + BBLR + Obs distress nafas ok neonatal pneumonia dd RDS + Labiognatoplatoschizis	RS Saiful Anwar
2	Neonatal Pneumonia, NEC, Feeding problem of newborn, Na-SC	RS Soepraoen
3	Post Op Histerektomi H6 a/I Myoma Uteri + Anemia Gravis Berulang + Sepsis + Joundice	RS Saiful Anwar
4	NP-SP, BBLSR, Neonatal Pneumoia dd RDS, Apneu of Prematurity + Feeding Difficulty, Hematom Regio Cruris Dextra	RS Lavalette
5	G1 P0000 Ab000 Uk 8-10 mgg dg HEG + Colic Abdomen + Hipokalemi	RS. Saiful Anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

Pada bulan Oktober ada 5 pasien yang dirujuk keluar, sedangkan pada bulan September ada 4 pasien, dan 1 pasien yg dirujuk pada bulan Agustus 2024

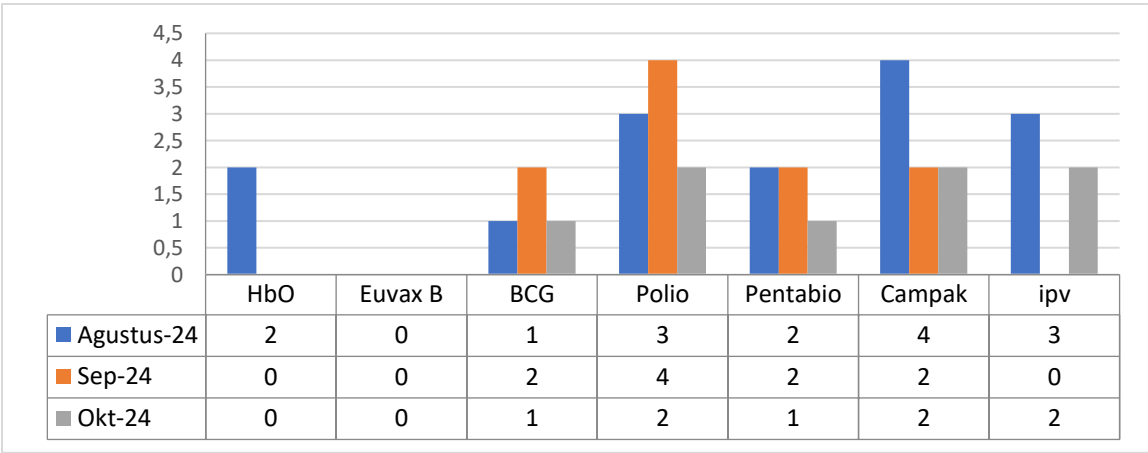
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Oktober 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	HbO	2	0	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	2	1
3	Polio	3	4	2
4	Pentabio	2	2	1
5	Campak	4	2	2
6	IPV	3	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Oktober 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Oktober dan September 2024 tidak ada, sedangkan pada Agustus 2024 sebanyak 2 bayi. Hal ini dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Oktober sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi. Sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 3 bayi, dan tidak ada bayi yang imunisasi IPV pada bulan September 2024
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Oktober 2024 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien.
5. Pada periode Oktober 2024 bayi yang melakukan imunisasi Campak sama dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Oktober 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi

7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Oktober 2024 sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 1 pasien

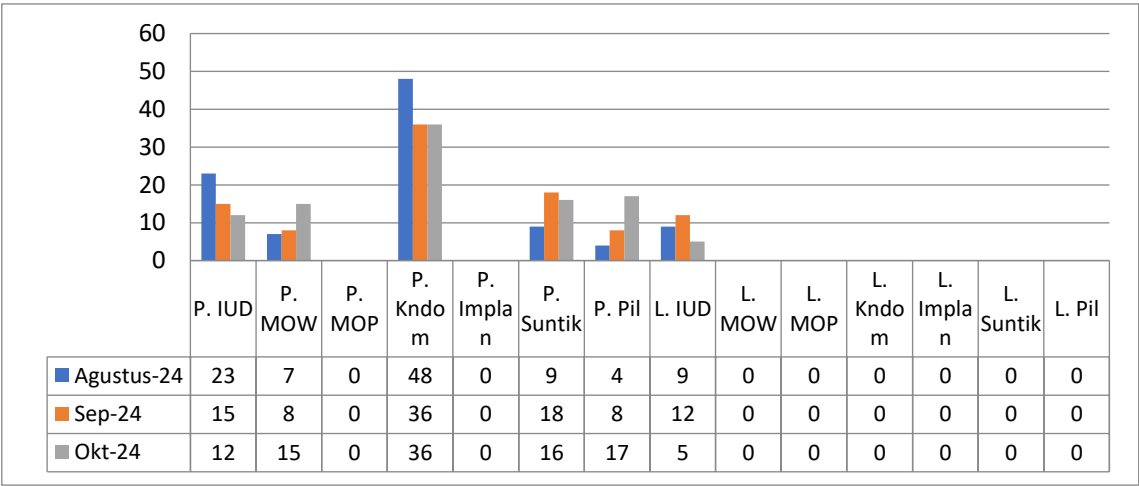
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek Oktober 2024

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	IUD	23	15	12	9	12	5
2	MOW	7	8	15	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	48	36	36	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	9	18	16	0	0	0
7	Pil	4	8	17	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Oktober menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 12 akseptor yang terdiri dari 3 akseptor IUD Nova T dan 9 akseptor IUD copper T
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Oktober 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 15 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Oktober sama dengan September 2024 yaitu 36 pengguna
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 17 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Oktober 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 16 penggunaan

Rencana dan Tindak Lanjut :

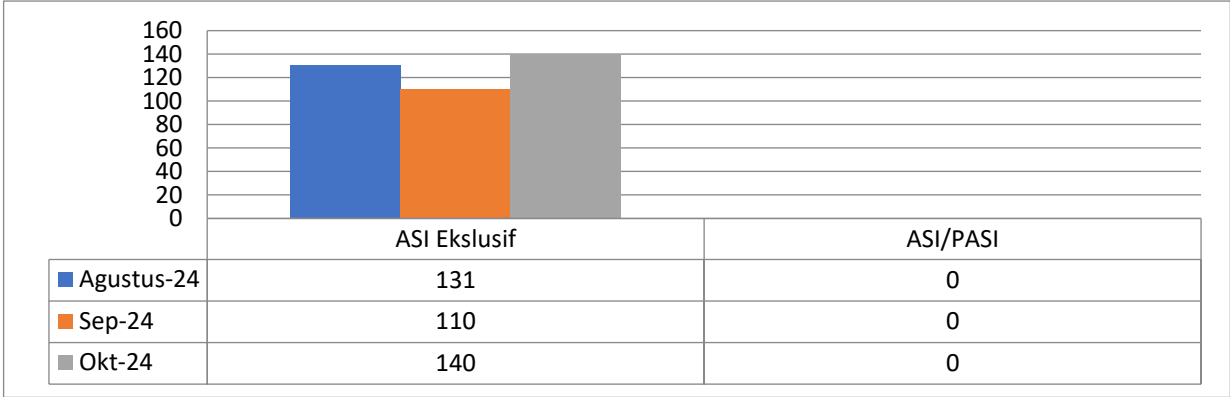
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponpek Oktober 2024

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	Asi eksklusif	131	110	140
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



- Analisis :
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 140 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 - 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

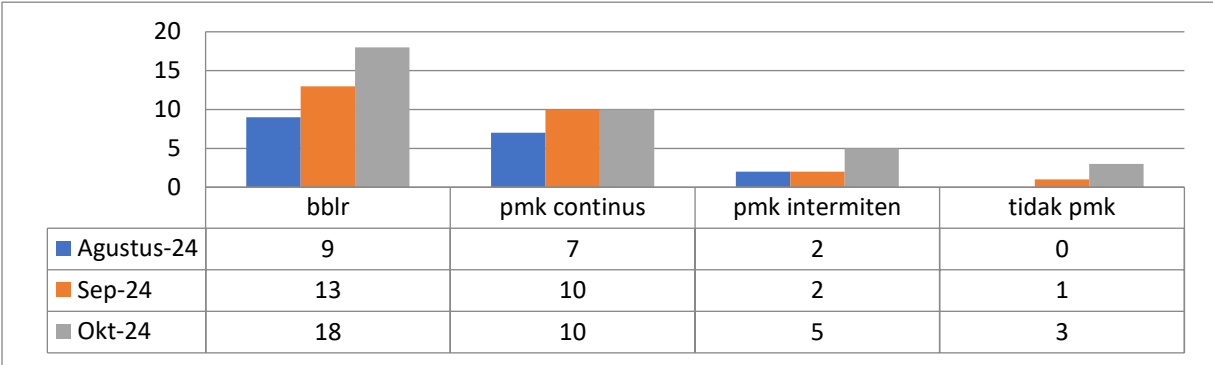
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponpek Oktober 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	Bayi BBLR	9	13	18
2	PMK continuos	7	10	10
3	PMK Intermiten	2	2	5
4	Tidak PMK	0	1	3

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Oktober 2024 naik jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 5 bayi, sedangkan pada bulan Agustus dan September terdapat 2 bayi
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Oktober 2024 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Dan ada 3 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Oktober 2024. Hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

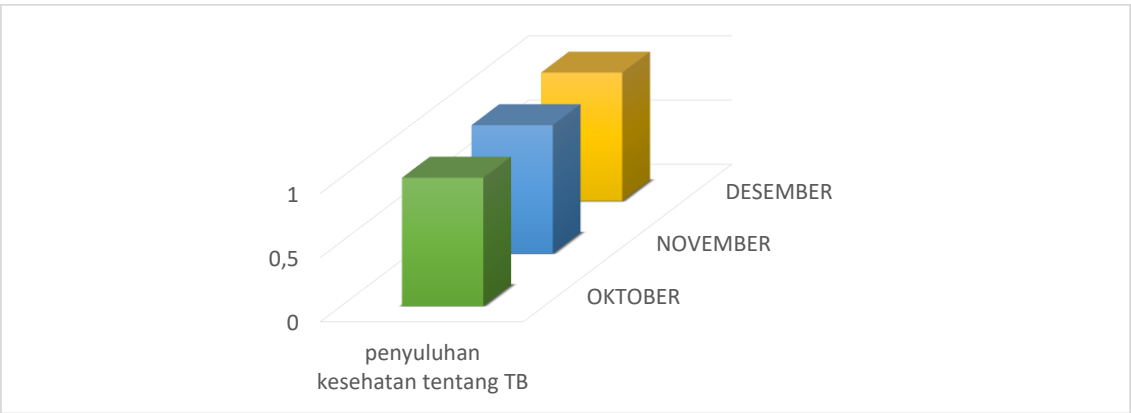
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1		

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

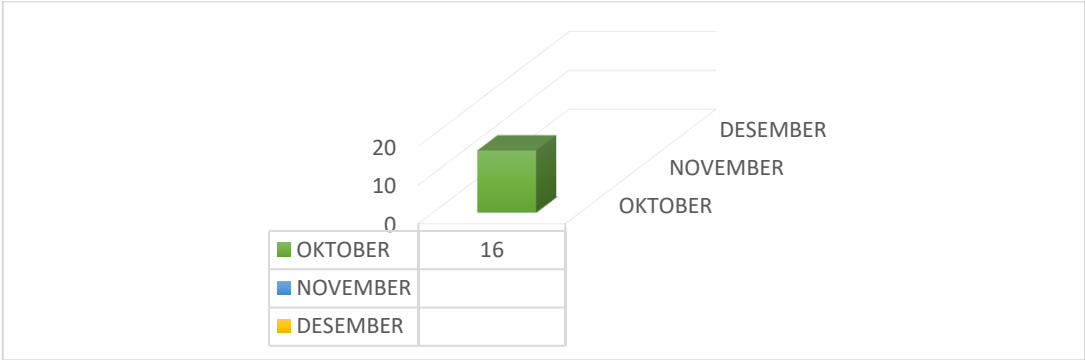
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut:
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dlls.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian Masker	16		

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



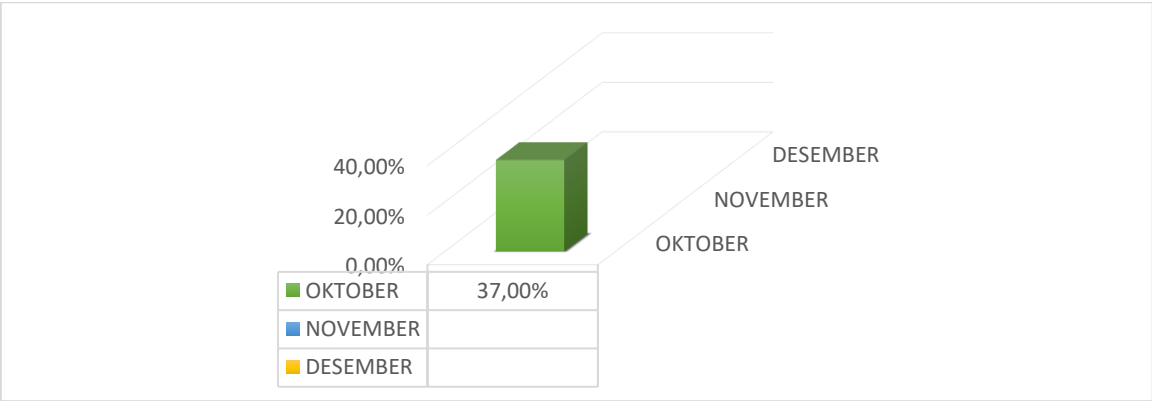
Analisis :
Pada bulan Oktober 2024 terdapat 16 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- Rencana dan Tindak Lanjut:**
- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
 - 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	37		

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



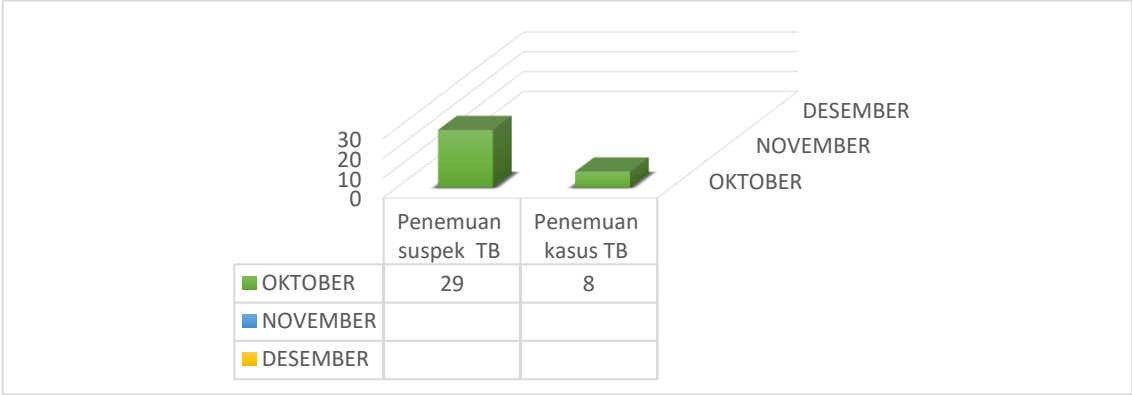
Analisis :
Pada bulan Oktober 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 37

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Penemuan suspek TB	29		
2	Penemuan kasus TB	8		

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



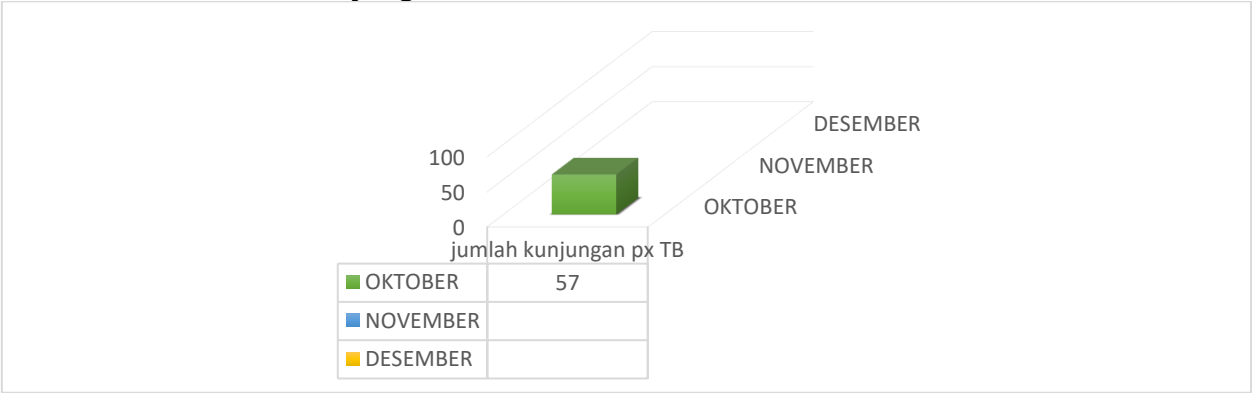
Analisis :
Pada bulan Oktober 2024 terdapat 29 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 8 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:
Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	57		

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



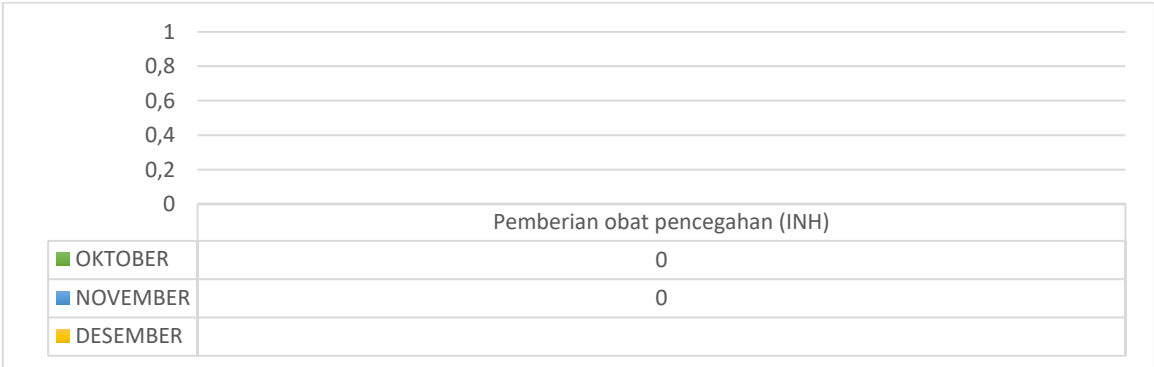
Analisis:
Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Oktober 2024 di poli pasien TBC mencapai 57 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

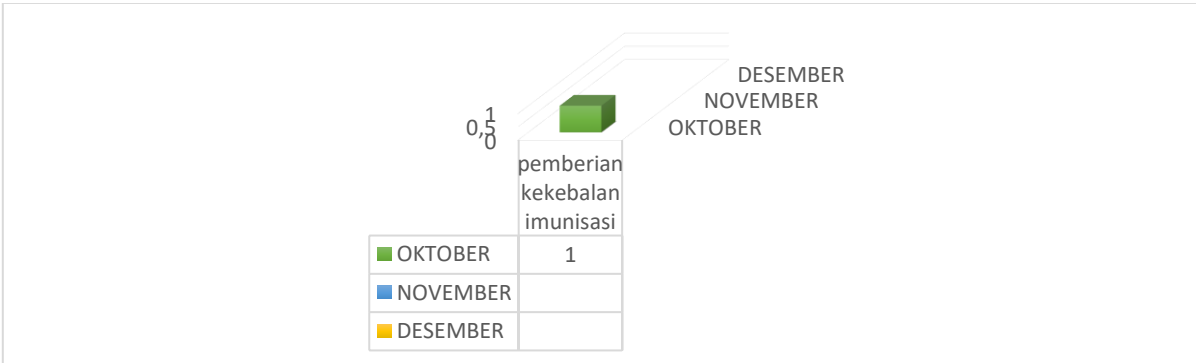
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian imunisasi BCG	1		

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



Analisis :
Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Oktober

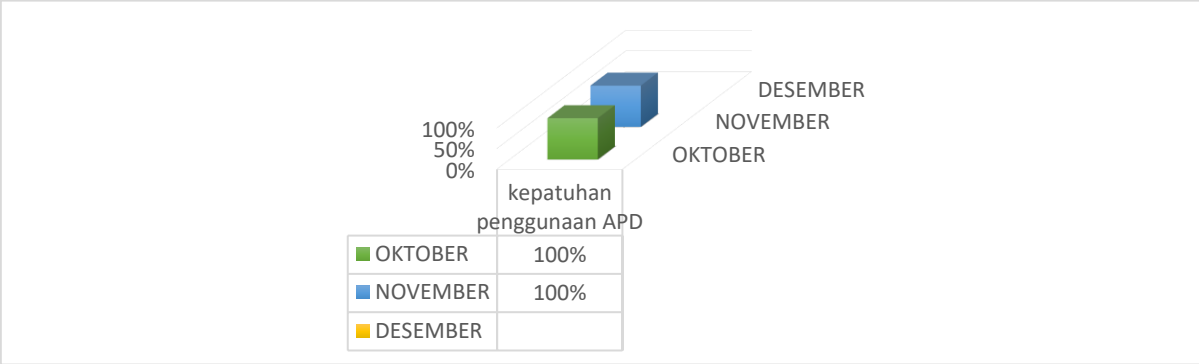
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulany

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



Analisis :

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

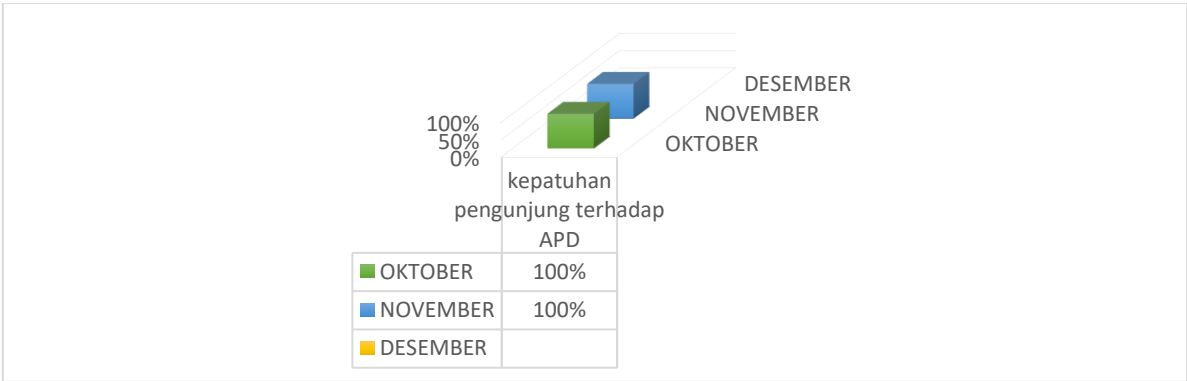
Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD di RS Prima Husada



Analisis:

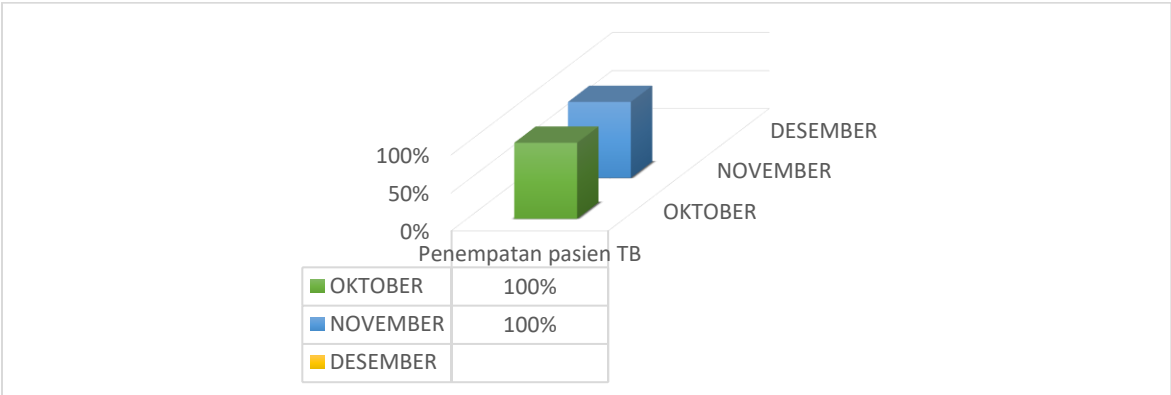
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



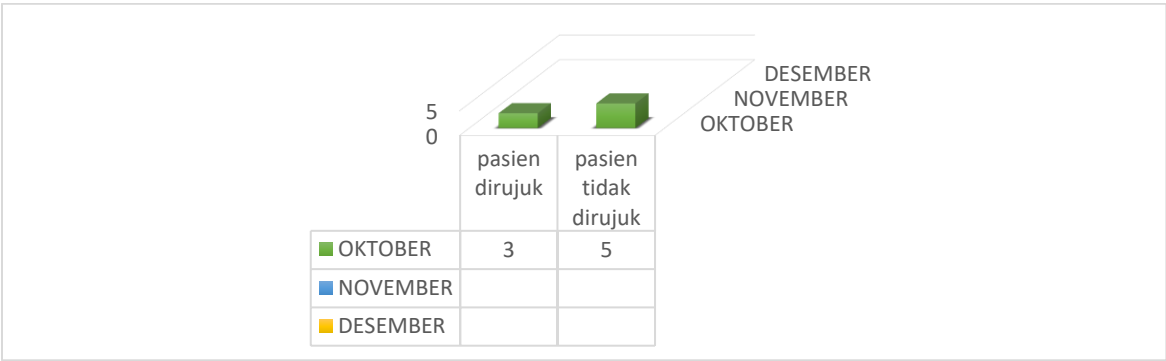
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pasien TB yang dirujuk	3		
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	5		

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



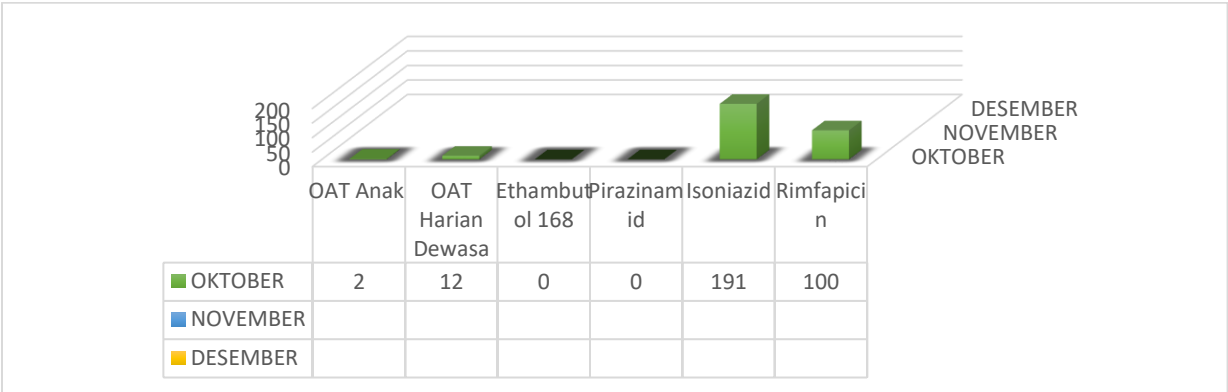
Analisis :
Pada bulan Oktober 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	OAT Anak	2		
2.	OAT Harian Dewasa	12		
3.	Ethambutol	0		
4.	Pirazinamid	0		
5.	Isoniazid	191		
6.	Rimfapicin	100		

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



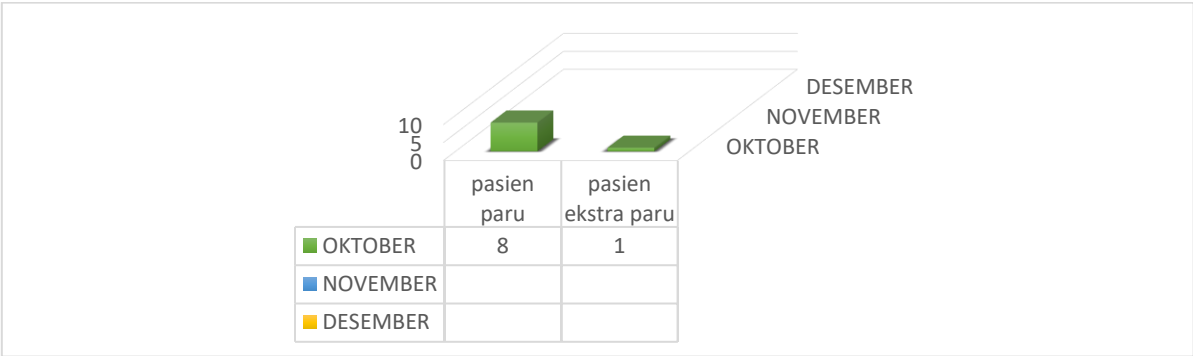
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pasien paru	7		
2.	Pasien Ekstra paru	1		

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



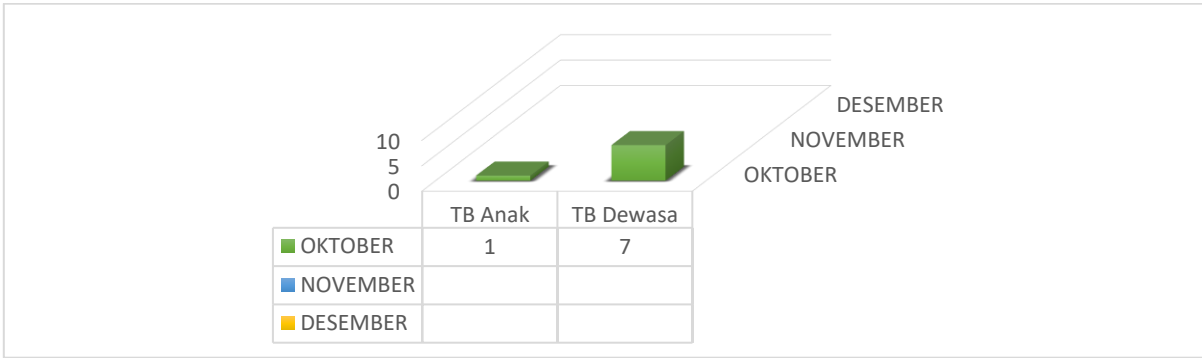
Evaluasi :
Pada bulan Oktober 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pasien Anak	1		
2.	Pasien Dewasa	7		

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Pada bulan Oktober terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 7 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Tn. P	V		
3.	Dr. Yunita, Sp. P	Ny. S	V		

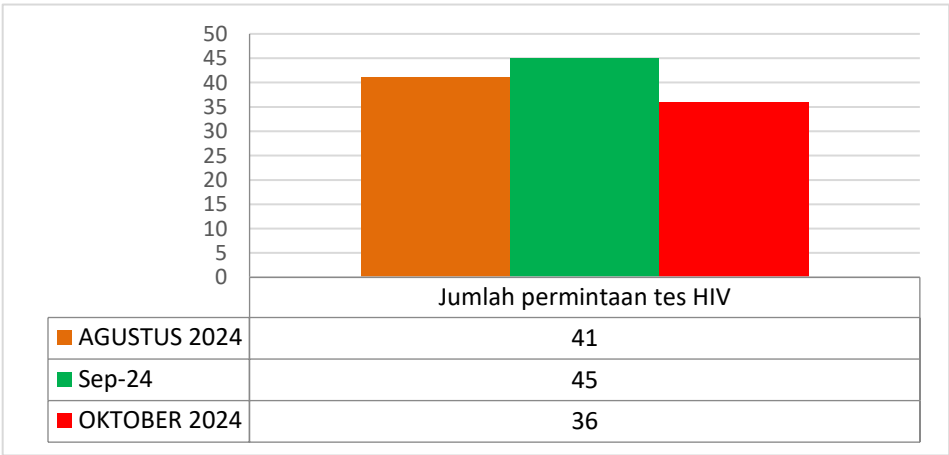
Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Permintaan Test HIV	41	45	36

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Oktober 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan oktober 2024 sebanyak 36 pemeriksaan, pada bulan September sebanyak 45 pemeriksaan, Agustus sebanyak 41 pemeriksaan, Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

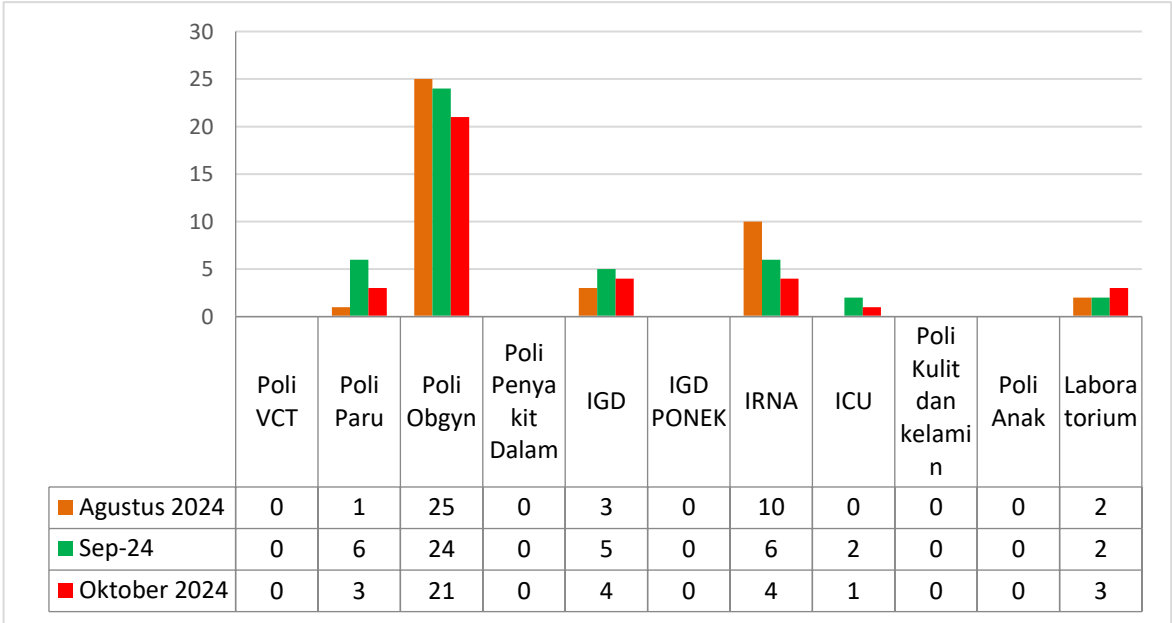
Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	1	6	3
3	Poli Obgyn	25	24	21
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	3	5	4
6	IGD PONEK	0	0	0

7	IRNA	10	6	4
8	ICU	0	2	1
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	2	2	3

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Oktober 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan Agustus 2024 sebanyak 25 pasien, pada bulan September 2024 sebanyak 24 pasien, Sedangkan pada bulan otober 2024 sebanyak 21 pasien

Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

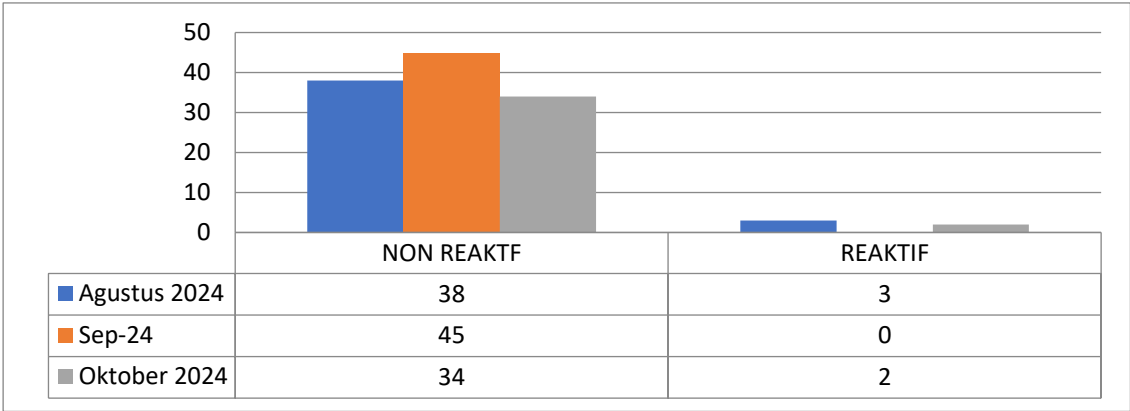
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Non Reaktif	38	45	34
2	Reaktif	3	0	2

Grafik Status HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Oktober 2024



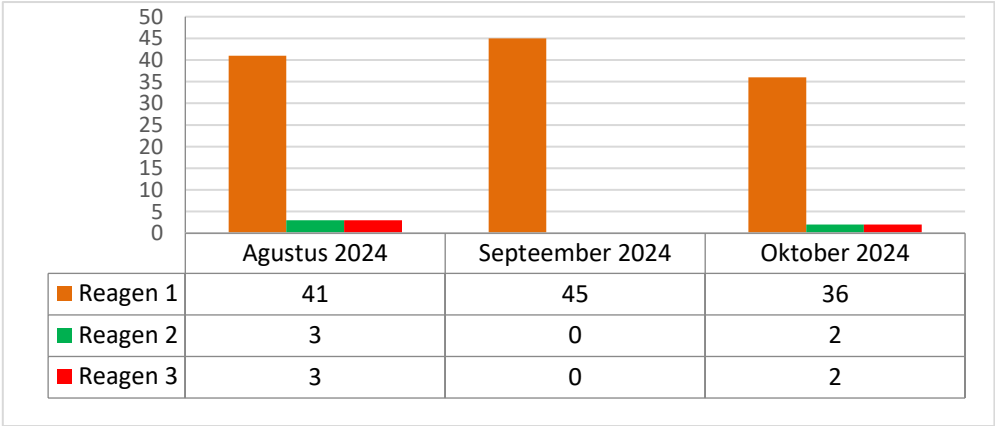
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Oktober 2024 sebanyak kasus dari IGD dan rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :
Rumah Sakit Prima Husada Malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Reagen 1	41	45	36
2	Reagen 2	3	0	2
3	Reagen 3	3	0	2

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Oktober 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Oktober 2024 memakai reagen 3. Dkarenakan ada pasien dengan hasil reaktif sebeanyak 2 pasien. Pada bulan agustus 2024 pemakaian reagen sampai dengan reagen 3 dikarenakan pada bulan agustus 2024 ditemukan pasien dengan HIV reaktif sebanyak 3 pasien. Pada bulan September 2024 pemakaian reagen hanya sampai reagen 1 saja dikarenakan tidak ditemukan pasien dengan hasil HIV positif.

Rencana Tindak Lanjut :

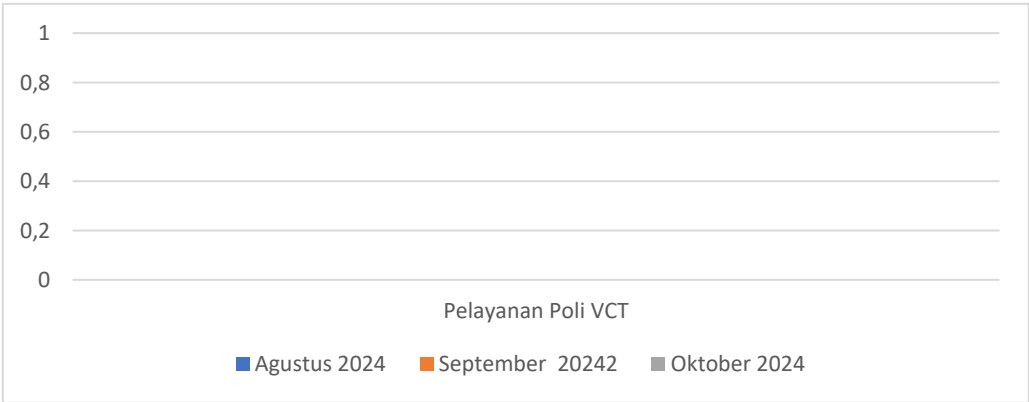
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apabila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

**Grafik Pelayanan Poli VCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Oktober 2024**



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

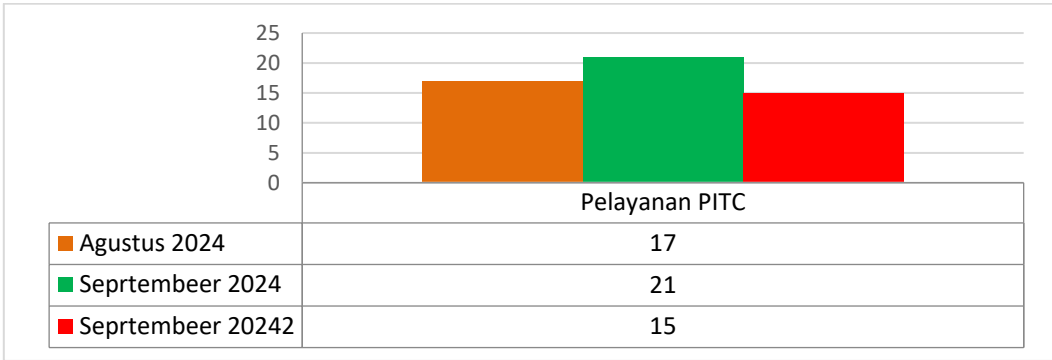
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Pelayanan PITC	17	21	15

Grafik Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Oktober 2024



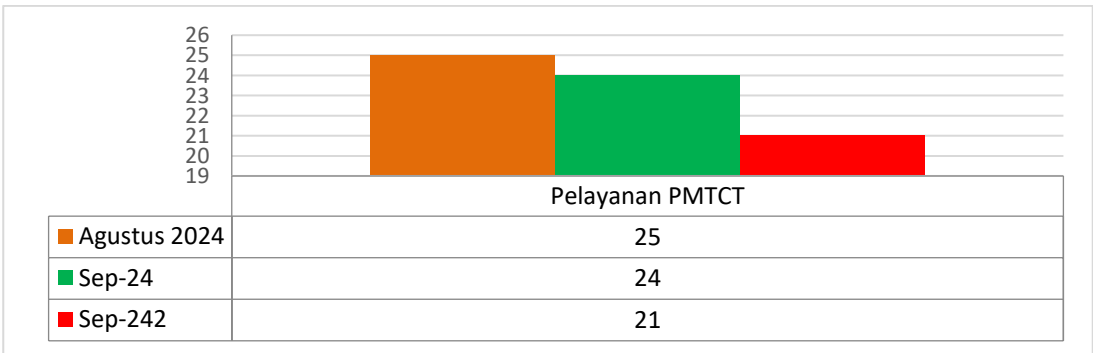
Analisis :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan agustus 2024 sebanyak 17 pasien. pada bulan September sebanyak 21 pasien. Sedangkan pada bulan oktober 2024 sebanyak 15 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangiran pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Pelayanan PMTCT	25	24	21

Grafik Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Oktober 2024



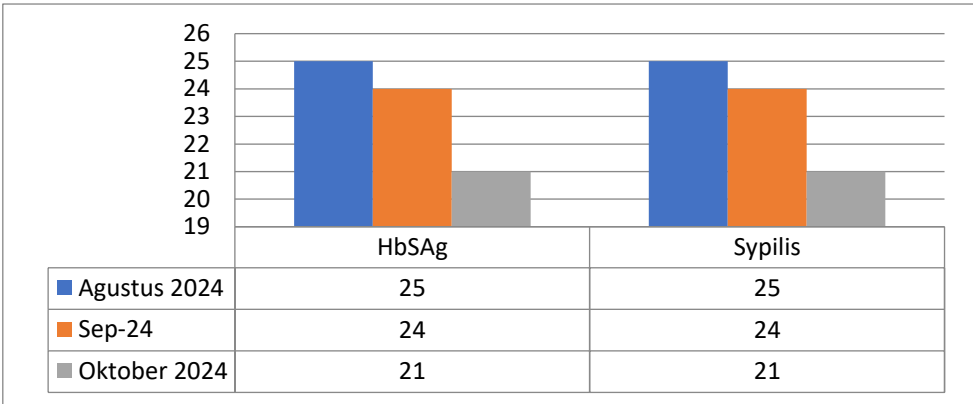
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan agustus 2024 sebanyak 25 pasien. pada bulan september 2024 sebanyak 24 pasien. Sedangkan pada buan oktober 2024 sebanyak 21 pasen.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :
Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	HbSAg	25	24	21
2	Sypilis	25	24	21

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



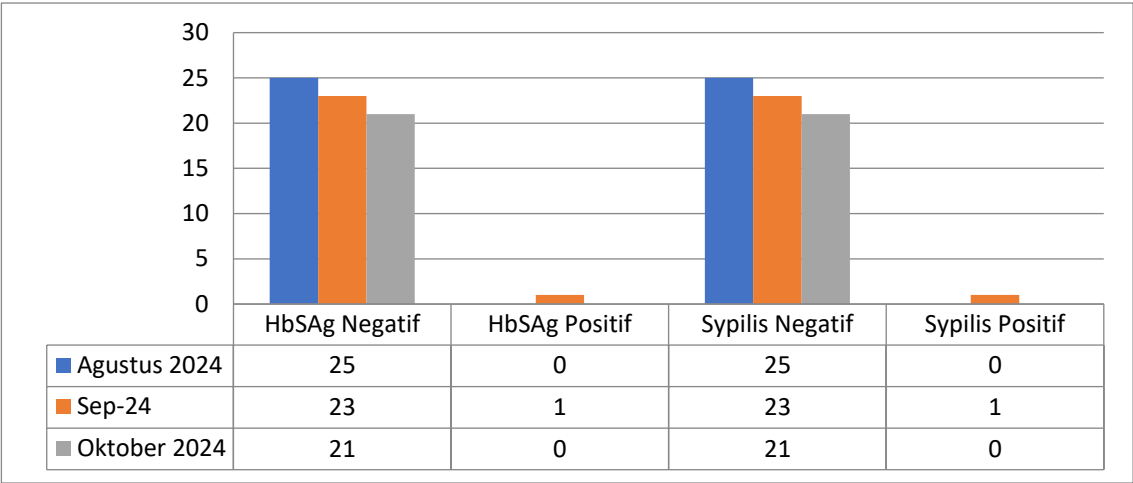
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan agustus 2024 sebanyak 25 pasien. pada bulan September 2024 sebanyak 24 pasien. Sedangkan pada bulan oktober 2024 sebanyak 21 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	HbSAg			
	Negatif	25	23	21
	Positif	0	1	0
2	Sypilis			
	Negatif	25	23	21
	Positif	0	1	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Agustus 2024 tidak ditemukan pasien HbSAG maupun Shypilis dengan hasil positif. pada bulan September 2024 ditemukan 1 pasien dengan HbSAG posiif Sedangkan pada bulan Oktober 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAG maupun Shypilis dengan hasil positif

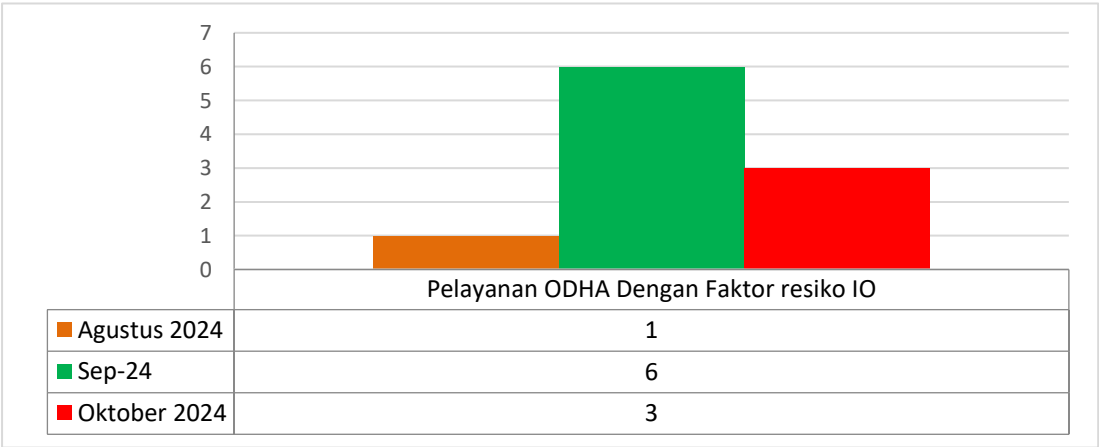
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Pada pasien HbSAG
Saat kelahiran akan ada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAG akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAG Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- 2. Pada pasien Sypilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	1	6	3

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan Agustus 2024 didapatkan 1 pasien. pada bulan September 2024 didapatkan 6 pasien. sedangkan pada bulan Oktober 2024 didapatkan 3 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

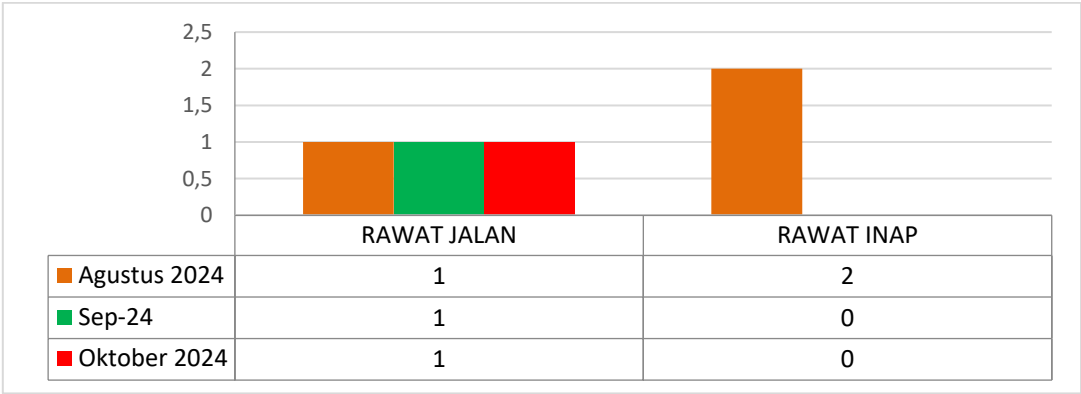
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
1	Rawat Jalan	1	1	1
2	Rawat Inap	2	0	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan Hiv/Aids Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan Agustus 2024 terdapat 3 pasien yang dilakukan rujuk yaitu 2 dari rawat inap dan 1 dari poli IPD. Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV . Pada bulan September 2024 terdapat 1 pasien rawat jalan yang dilakukan rujuk yang berasal dari poli anak. Sedangkan pada bulan Oktober 2024 terdapat 1 pasien yang dilakuka rujuk yaitu dari rawat jalan poli anak.

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Oktober 2024

NO	KEGIATAN POKOK SDM	PEMENUHAN RENCANA KEGIATAN
1	Kebutuhan SDM	Terdapat perubahan tim stunting dan wasting pada bulan Oktober 2024.
2	Orientasi	Terdapat orientasi pada anggota tim penurunan prevalensi stunting dan wasting pada bulan Oktober 2024

3	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan tentang stunting dan wasting dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai stunting dan wasting serta dampak dan faktor penyebab dari stunting dan wasting dimana materi disampaikan oleh ketua tim setiap rapat bulanan. Pendidikan dan pelatihan kepada staff RS Prima Husada tentang stunting telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024. Pelatihan diberikan kepada seluruh staff ahli gizi agar lebih teliti dalam menentukan status gizi pasien balita.
4	Evaluasi Kinerja	a. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan berkaitan dengan intervensi spesifik dan pencegahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasien dan keluarga pasien tentang stunting dan wasting. b. Melakukan beberapa intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit yaitu promosi tentang program 1000 HPK, Suplementasi tablet besi folat, Pemberian PMT pada ibu hamil, promosi konseling IMD dan ASI eksklusif, Pemberian makanan bayi dan anak, pemantauan pertumbuhan, dan pemberian makanan tambahan balita gizi kurang. c. ASI Eksklusif - Edukasi Pemberian ASI eksklusif sudah terlaksana dengan baik, - Dibentuknya Grup pendukung ASI eksklusif d. Senam Hamil - Senam Hamil dilaksanakan 2x dalam 1 bulan secara rutin - Pemberian edukasi seputar kesehatan atau perawatan - perawatan yang dibutuhkan ibu hamil. e. Merujuk pasien stunting kepada puskesmas wilayah tempat tinggal balita stunting dan wasting untuk evaluasi pertumbuhan dan perkembangan balita melalui whatsapp dan aplikasi eppgbm

Analisis

- Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
- Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1

	asam folat					
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	2	0	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun	Pasien anak	Rawat Inap	0	2	1

	menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan					
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

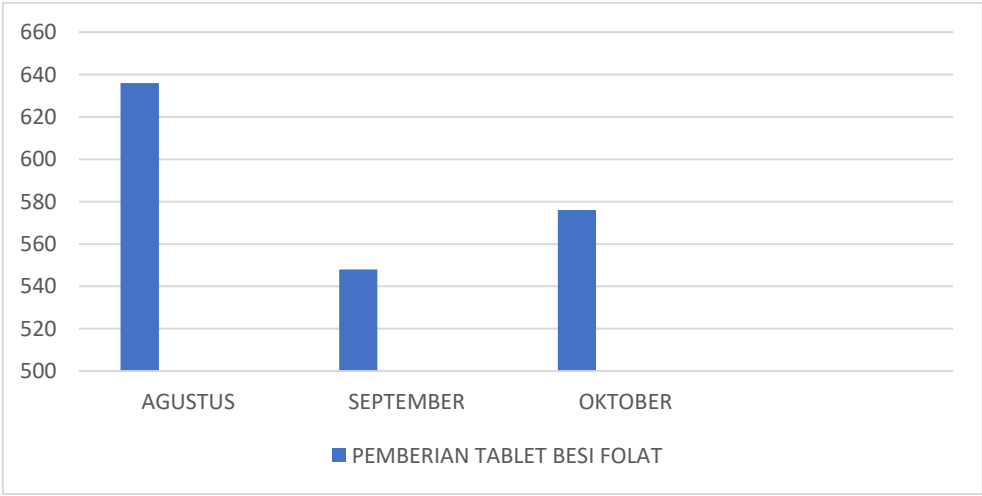
Analisis :
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	636	548	576

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat meningkat pada bulan Oktober yaitu 576 ibu hamil yang mendapat tablet besi folat.

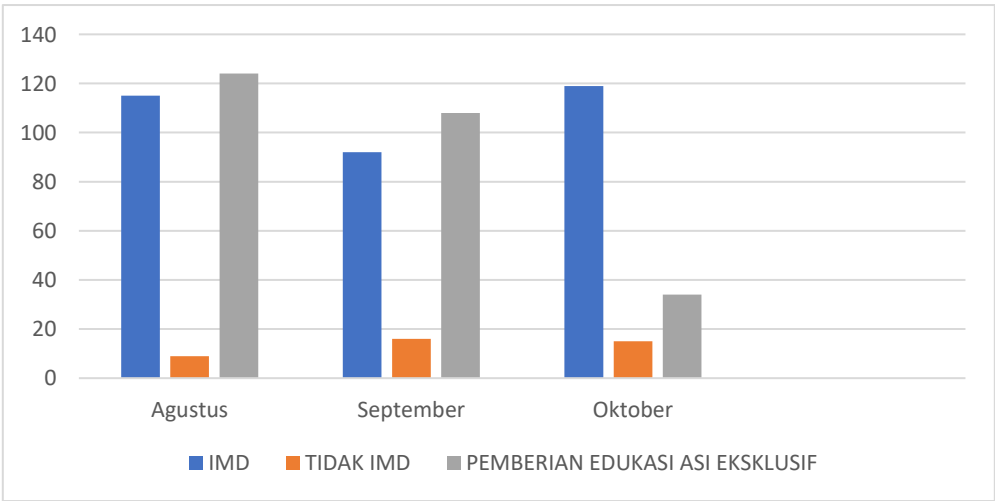
- Rencana Tindak Lanjut:**
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 - 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	IMD	115	92	119
2	Tidak IMD	9	16	15
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	124	108	134

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 119 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Oktober 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 15 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Oktober 2024 yaitu sebanyak 134 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

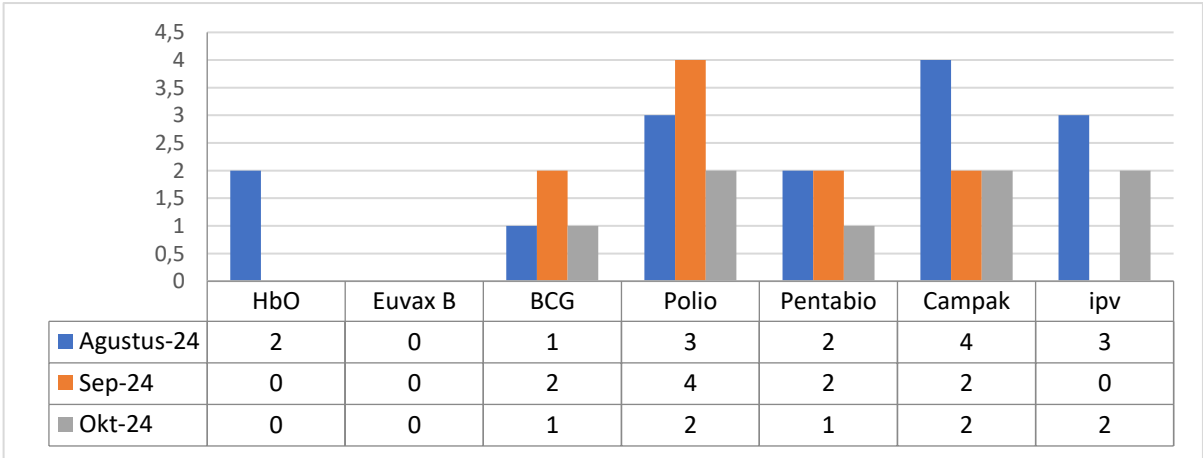
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	HbO	0	2	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	2	1	1
3	Polio	4	3	2
4	Pentabio	2	2	1
5	Campak	2	4	2
6	IPV	2	3	2

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis:

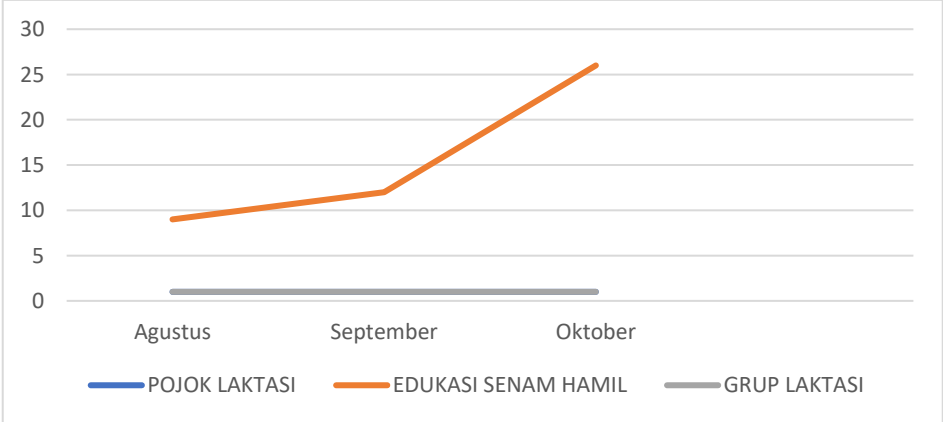
- 1. Tidak ada Imunisasi Hbo pada bulan Oktober dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
- 2. Terdapat 2 bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Oktober
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Oktober 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien.
- 4. Pada periode Oktober 2024 terdapat bayi yang melakukan Imunisasi Campak yaitu 2 bayi.
- 5. Terdapat 2 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Oktober 2024

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	9	12	26
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



Analisis :

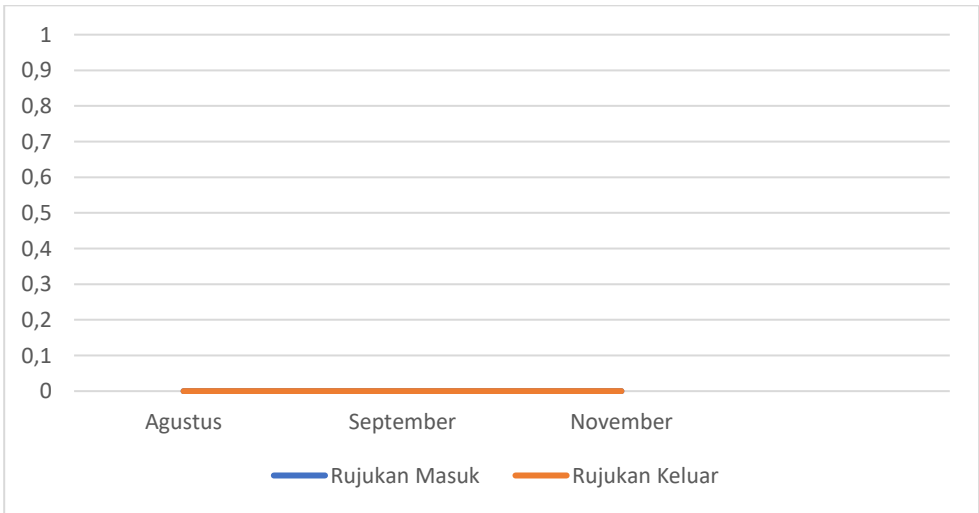
- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Jumlah peserta edukasi pada bulan Oktober meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 26 orang

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-



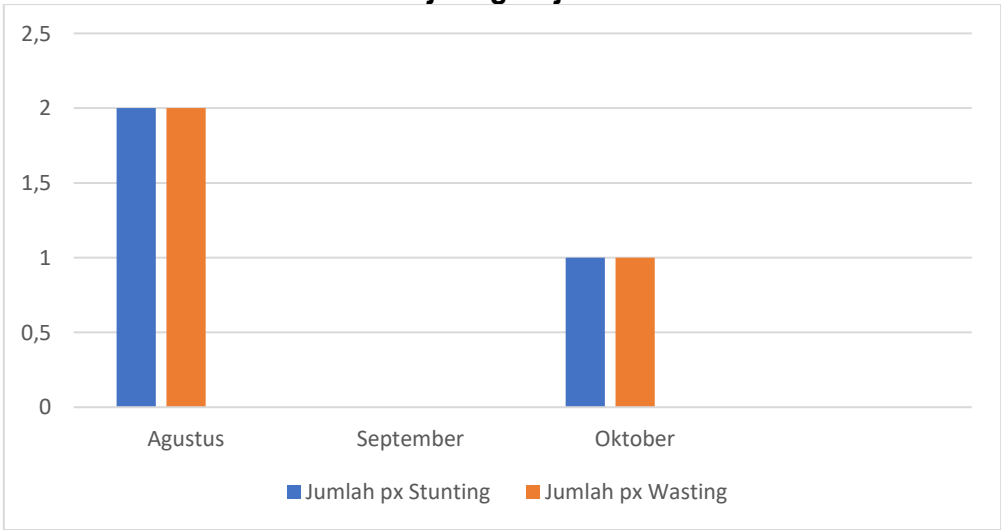
Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024
Jumlah Pasien Stunting	0	0	1
Jumlah Pasien Wasting	0	0	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :
Terdapat 1 pasien stunting dan wasting pada bulan Oktober. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan

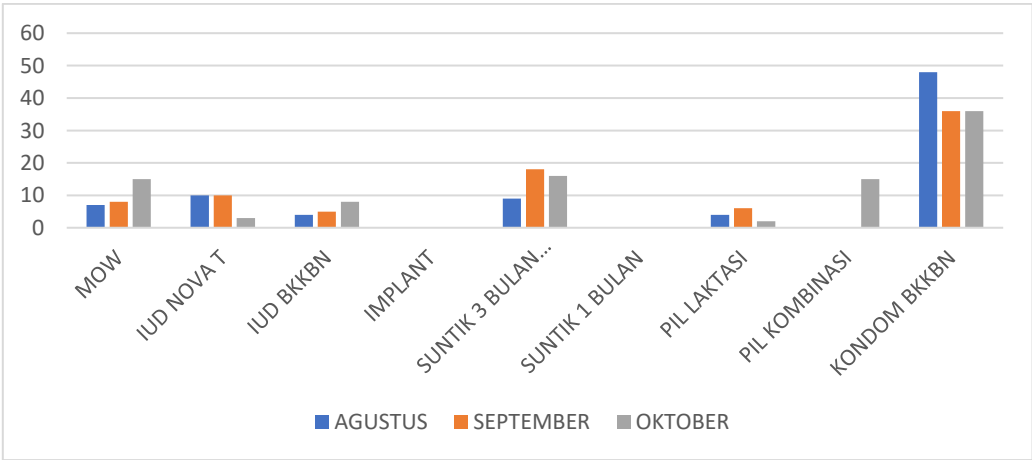
dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

3.1.2.5 KBRs

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	MOW	7	8	15
2	IUD Nova T	10	10	3
3	IUD BKKBN	14	5	8
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN BKKBN	9	18	16
6	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
7	PIL KOMBINASI	0	2	15
8	PIL LAKTASI	4	6	2
9	KONDOM BKKBN	48	36	36

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



- Evaluasi :
1. Peserta MOW pada bulan Agustus naik (7) September naik (8) Oktober naik (15)
 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Agustus (10) September (10) menurun Oktober (3)
 3. Peserta IUD BKKBN, pada bulan Agustus (14) menurun September (5) Meningkat Oktober (8)
 4. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan Agustus (9) meningkat September (18) menurun Oktober (16)
 5. Peserta KB pil kombinasi pada bulan September karena sempat kosong (2),Oktober meningkat (15),Pil KB laktasi Agustus (4) September (6) Oktober menurun (2)
 6. Peserta KB Kondom pada bulan Agustus (48) September (36) meningkat oktober (36)

- Analisis :
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.

- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

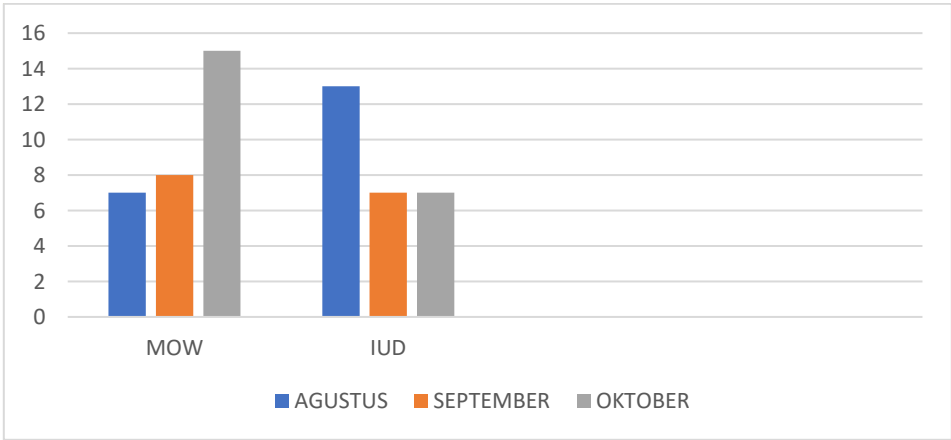
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

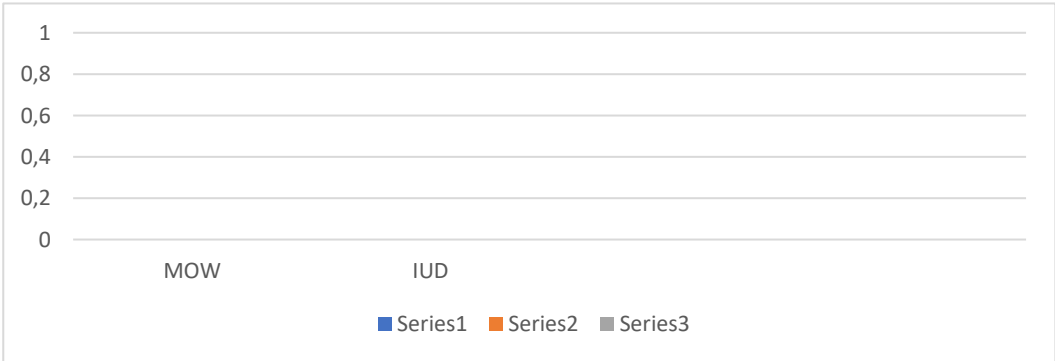
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	MOW	7	8	15
2	IUD	13	7	7

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Agustus-September - Oktober meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Agustus-September - Oktober menetap

Analisis :

1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2024

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Agustus 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Siti Rubaiyah	P/47	dr. Heri, Sp.PD	174600	Volume Depletion	29/07/2024	02/08/2024	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,8	0,8	3,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
2	Alfiyah	P/64	dr. Heri, Sp.PD	068249	DM Type 2	30/07/2024	05/08/2024	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,8	0,8	3,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
3	Etik Supriatin	P/64	dr. Anton, Sp.B	217659	Necrotizing	31/07/2024	02/08/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
4	Siti Lutfiyah	P/48	dr. Zaki, Sp.B	060461	Post of Debridement	02/08/2024	04/08/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
5	Syafira Widya	P/19	dr. Anton, Sp.B	217481	Ganglion Elbow (D)	02/08/2024	04/08/2024	3	Ceftizoxime	3	1x2	2	4	0,5
									Ceftizoxime		1x1	1	4	0,25
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	0,2
6	Sudjilah	P/75	dr. Miryanti, Sp.JP	185511	Chest Pain	03/08/2024	04/08/2024	2	Meropenem	1	2x1	3	3	1
7	Nining Nur Wahyu	P/33	dr. Aida, Sp.OG	122283	SC	03/08/2024	05/08/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
8	Siti Qomariah	P/22	dr. Zora, Sp. PD	124748	GEA + Volume Depletion	03/08/2024	05/08/2024	3	Ciprofloxacin inf	1	2x0,2	1	0,8	1,25
9	Masudah	P/47	dr. Zora, Sp.PD	174600	Unspecified renal colic	06/08/2024	09/08/2024	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,8	0,8	3,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
10	Siaman	L/59	dr. Arianto, Sp.OT	136807	Injury to the foot due to infection	08/08/2024	10/08/2024	3	Ceftraixone	2	1x1	4	2	2
									Metronidazole inf		1x0,5	1,5	1,5	1
11	Azizah Aprila	P/22	dr. Anton, Sp.B	210157		11/08/2024	13/08/2024	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5

					Nectrotizing Facitis Pedis				Ceftiaxone		2x1	5	2	2,5
12	Yunita Indrayana	P/37	dr. Aida, Sp.OG	218352	PEB	13/08/2024	14/08/2024	2	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Metronidazole inf		1x0,5	1	1,5	0,67
13	Wiwit Triani	P/52	dr. Anton, Sp.B	217659	Limpadenopathy Inguinal	16/08/2024	18/08/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
14	Syaiful Yuniasih	L/38	dr. Andy, Sp.P	218504	Dyspnea	17/08/2024	19/08/2024	3	Ceftiaxone	2	2x1	5	2	3,5
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
15	Samiaty	P/65	dr. Yoga, Sp.JP	218531	DOC, Syok Cardiogenic	18/08/2024	21/08/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin inf		1x0,5	2	0,5	4
16	Musdalifah	P/53	dr. Arianto, Sp.PD	148673	Ganglion	19/08/2024	21/08/2024	3	Cepoferazone	2	1x2	2	4	0,5
									Cepoferazone		2x1	2	4	0,5
17	Nisa Tri Y	P/35	dr. Humaira, Sp.OG	097429	SC	21/08/2024	23/08/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
18	Boby Juli	L/26	dr. Zaki, Sp.B	218719	Appendicitis	21/08/2024	25/08/2024	5	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	12	3
19	Sunarmi	P/63	dr. Miryanti, Sp.JP	109487	CHF	21/08/2024	26/08/2024	6	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Levofloxacin inf		1x0,75	3,75	0,5	7,5
20	Bunga Perdana P	P/36	dr. Humaira, Sp.OG	209242	Oligohydramnios	29/08/2024	30/08/2024	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		2x0,5	1	1,5	0,67

3.2.2.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan September 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Sutik	L/68	dr. Heri, Sp. Pd	219077	DM Type 2	30/08/2024	01/09/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Azitromycin po		1x0,5	1,5	0,3	5
2	Moch Lutfi	L/46	dr. Andy, Sp. P	175773	Acute respiratory failure	30/08/2024	07/09/2024	9	Ceftriaxone	3	2x1	5	2	0,5
									Cefoperazone sodium		2x1	5	4	1,25
									Meropenem		2x1	6	3	2
3	Joni Arifin	L/56	dr. Anton, Sp. B	218906	Other Hydrocele	03/09/2024	05/09/2024	3	Ceftizoxime	2	1x1	1	4	0,25
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
4	Arsita Fadillah	P/22	dr. Heri, Sp. Pd	185265	Gastroenteritis and colitis	03/09/2024	05/09/2024	3	Asam Pipemidat	1	2x1	2,4	0,8	3
5	Riyani	P/49	dr. Ardhi, Sp. Pd	201139	DM Hyperglikemi	04/09/2024	07/09/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Ciprofloxacin po		2x0,5	2	1	2
6	Sugeng Suyanto	L/57	dr. Anton, Sp.B	085988	Necrotizing fasciitis	06/09/2024	08/09/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
7	Muhammad Alif	L/18	dr. Zaki, Sp. B	114182	Abd. Pain	08/09/2024	10/09/2024	3	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8	Yusnia Kosi P	P/29	dr. Aida, Sp. OG	118463	SC	09/09/2024	11/09/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
9	Moch Yusron	L/70	dr. Anton, Sp.B	219561	With peripheral circulatory	10/09/2024	12/09/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
10	Vicky Octavianto	L/28	dr. Anton, Sp.B	219500	Fistula perianal	11/09/2024	13/09/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Gentamycin		3x0,08	0,24	0,24	1
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
11	Daseno	L/57	dr. Heri, Sp. Pd	219685	Febris H-14	12/09/2024	15/09/2024	4	Levofloxacin po	1	1x0,75	2,25	0,5	4,5

12	Supriadi	L/71	dr. Andy, Sp. P	219809	COPD AE	15/09/2024	19/09/2024	5	Azithromycin	1	1x0,5	2,5	0,3	8,3
13	M Agus Salim	L/53	dr. Heri, Sp. Pd	219813	Sepsis	16/09/2024	21/09/2024	6	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	8,5	1,5	5,6
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
14	Suning	P/53	dr. Zora, Sp.Pd	125963	DM Hiperglikemi	16/09/2024	23/09/2024	8	Ceftraixone	2	2x2	24	2	12
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
15	M. Hadyan	L/16	dr. Edi, Sp. U	217145	Scrotal varices	17/09/2024	19/09/2024	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Siti Nurrohmah	P/54	dr. Ardhi, Sp.Pd	160161	DM Type 2	23/09/2024	27/09/2024	5	Ceftraixone	2	2x1	8	2	4
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
17	Badariyah	P/54	dr. Yunita, Sp.P	220134	Obs Dyspneu + Pneumoni CAP	23/09/2024	28/08/2024	6	Levofloxacin inf	3	1x0,75	2,25	0,5	4,5
									Levofloxacin po		1x0,75	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
18	Dina Asma'ul	P/26	dr. Zora, Sp.Pd	220223	TF	24/09/2024	26/09/2024	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1	0,5	2
19	Yuni Anisa C	P/22	dr. Humairi, Sp.OG	220187	Prematur Rupture	24/09/2024	26/09/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
20	Teddi Hendrawan	L/49	dr. Oka, Sp.OT	220254	Dislocation of Wrist	25/09/2024	27/09/2024	3	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1

3.2.2.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Oktober 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Akhmah Yani	L/60	dr. Mira, Sp. JP	220451	Dyspnea	30/09/2024	02/10/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Azitromycin po		1x0,5	1,5	0,3	5
2	Abd. Fatah	L/55	dr. Edi, Sp. U	158634	Colic renal	03/10/2024	05/10/2024	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
3	Yuli Prawesti	P/53	dr. Mira, Sp. JP	073181	Syock cardiogenik	04/10/2024	16/10/2024	13	Ceftriaxone	3	2x1	20	2	10
									Levofloxacin inf		1x0,75	6	0,5	12
									Azitromycin po		1x0,5	1,5	0,3	5
4	Yuda Achadi	L/47	dr. Andi, Sp. B	220875	Apenddix	08/10/2024	12/10/2024	5	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	8	2	4
5	Lela Sulistiya	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	063244	SC	09/10/2024	11/10/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
6	Nurizza Aroh	P/33	dr. Elvi, Sp. P	051685	Efusi Pleura	09/10/2024	12/10/2024	4	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3,5
									Levofloxacin inf		1x0,5	1	0,5	2
									Metronidazole inf		3x0,5	3	1,5	2
7	Rahayu	P/49	dr. Ardhi, Sp. Pd	197161	DM Hiperglikemi	09/10/2024	12/10/2024	4	Asam Pipemidat	2	1x0,4	2,4	0,8	3
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
8	Anis Suyanah	P/52	dr. Zora, Sp. Pd	062888	Febris + Hipertiroid	09/10/2024	12/10/2024	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	4	0,5	8
9	Hartono	L/65	dr. Anton, Sp. B	135321	Tumor Manus	10/10/2024	12/09/2024	3	Cefoperazone sodium	2	2x1	1	4	0,25
									Cefixime		2x0,1	0,5	4	0,125
10	Dwi Fransiska N	P/25	dr. Anton, Sp. B	184587	Necrotizing facitis	13/10/2024	15/10/2024	3	Ceftizoxime	2	1x1	1	4	0,25
									Clindamycin po		2x0,3	0,6	1,2	5
11	Djuman	P/65	dr. Andi, Sp. P	102264	Susp Pneumoni	15/10/2024	17/10/2024	3	Azithromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
12	Arofatul Magfiroh	P/29		088305	PRM	15/10/2024	17/10/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

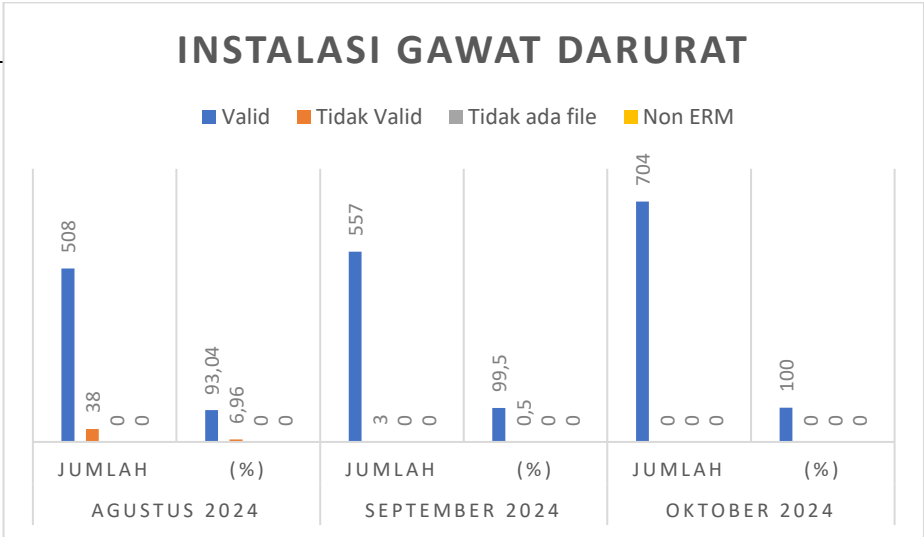
			dr. Humaira, Sp. OG						Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
13	Supriyadi	L/42	dr. Pradana, Sp. U	221142	Injury of unspecified body region	15/10/2024	18/10/2024	4	Cefoperazone sodium	2	2x1	6	4	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	5,5	1,5	3,67
14	Kevin Dwi A	L/24	dr. Kuntadi, Sp. OT	221199	Superficial injury	16/10/2024	18/10/2024	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
15	Yunia Iffa	P/34	dr. Zaki, Sp.B	221194	CKR 456	17/10/2024	18/10/2024	2	Cefoperazone sodium	2	1x1	1	4	0,25
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
16	Moch Rupiono	L/68	dr. Edi, Sp.U	094231	Inflammatory Disorder	18/10/2024	21/10/2024	4	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone sodium		2x1	4	4	1
17	Ngaturi	L/53	dr. Anton, Sp.B	221207	Tumor rectum	19/10/2024	21/10/2024	3	Cefoperzone sodium	3	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone sodium		1x1	1	4	0,25
									Ciprofloxacin po		2x0,5	1	1	1
18	Ainun Purnomo	P/54	dr. Heri, Sp. Pd	170372	DM	19/10/2024	27/10/2024	9	Ceftriaxone	2	2x1	16	2	8
									Metronidazole po		2x0,5	5	2	2,5
19	Kusnadi	L/53	dr. Ardhani, Sp. Pd, K-GH	062270	TF, DF	21/10/2024	23/10/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Azitromycin po		1x0,5	1,5	0,3	5
20	Neny Lia	P/44	dr. Andy, Sp. P	221652	Dyspnea	27/10/2024	29/10/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

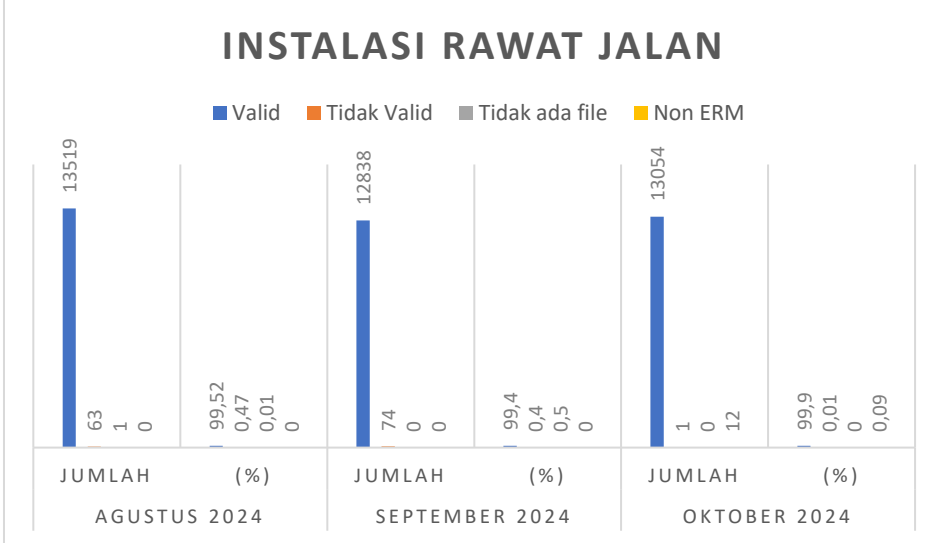
3.6.6.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Agustus - Oktober 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			AGUSTUS 2024		SEPTEMBER 2024		OKTOBER 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	508	93,04	557	99,5	704	100
		Tidak Valid	38	6,96	3	0,5	0	0
		Tidak ada file	0	0	0	0	0	0
		Non ERM	0	0	0	0	0	0
Total			546		560		704	
2.	IRJA/POLI	Valid	13519	99,52	12838	99,4	13054	99,90
		Tidak Valid	63	0,47	74	0,4	1	0,01
		Tidak ada file	1	0,01	0	0,5	0	0
		Non ERM	0	0	0	0	12	0,09
Total			13583		12912		13067	

3.6.6.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Agustus - Oktober 2024



3.6.6.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Agustus - Oktober 2024



Analisis :

- 1. Validasi Data E-RM di IGD sudah mencapai 100% dari 704 data yang diterima.
- 2. Capaian 100% validasi data E-RM di IGD dikarenakan temuan masalah seperti

- “Skrining IGD” yang masih kosong meskipun sudah diisi oleh perawat langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh programmer.
3. Pada Bulan Oktober 2024 tidak ditemukan tarikan data yang tidak ada file baik di IGD maupun di IRJA, yaitu 0%.
 4. Masih ditemukan layanan IRJA yang belum E-RM, yaitu Poli KIA dan Poli Gizi.

Masalah :

1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
2. Pencatatan Poli Gizi masih menggunakan lembar konsultasi manual, resiko hilang dan tidak terekap dengan baik pada system sehingga DPJP tidak bisa membaca hasil pada Billing E-RM.
3. Ditemukan kunjungan Poli KIA saat petugas RM melakukan review dan belum masuk kedalam E-RM.
4. Berikut link permasalahan yang ditemui
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

- Ketidakiengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :
1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
 2. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
 3. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat menyetorkan berkas ke kasir jaminan.
 4. Pada akhir Bulan Oktober 2024 casemix yang disetor sudah tidak dicetak, RS sudah menerapkan E-Casemix.
 5. Melakukan pencatatan kunjungan pasien harian setiap DPJP pada google spreadsheet untuk dilakukan cek kesesuaian dan kelengkapan data oleh Petugas RM dan Verifikator RS.
 6. Flow Chart alur pelayanan Poli Gizi sudah diberikan kepada Programmer PT.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Banyaknya obat sisa atau obat yang belum digunakan tidak di return	P	Menetapkan alur yang jelas untuk return obat di farmasi setelah pemakaian
		D	Koordinasi dengan farmasi untuk obat sisa dan return obat terutama obat setelah post operasi
		S	Banyaknya kasus obat sisa atau obat yang seharusnya di retun tidak di return atau tidak di letakan kerajang
		A	Kolaborasi dan kordinasi dengan tim farmasi untuk return obat sehingga tidak ada obat tertinggal di dalam unit iko

2	Pengenputan obat /BMHP jika pasien operasi cito, terkadang pasien belum di daftarkan oleh pendafrtan IGD sehingga ini menjadi memperlambat persiapan pengenputan persiapan alat dan harus menyiapkan barang jika tidak ada TTK yang standby di dalam IKO	P	Mengajukan ada admin di IKO
		D	Mengajukan admin iko yang standby di IKO untuk menyiapkan BMHP dan pengenputan resep sehingga real time
		S	Banyaknya kasus pasien operasi cito yang belum di input karena banyak kendala belum di daftar oleh pendaftaran IGD,dan untuk menyiapkan barang bmhp masih oleh pihak perawat IKO Pengajuan admin IKO ditolak
		A	Meminta kerja sama IKO dan farmasi dalam mengontrol floorstock IKO, jika masih terjadi human error akan diberi SP
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
2	Dokter anastesi saat tidak ada yang masuk tidak koordinasi dengan tim manajemen	P	Mencegah kejadian serupa terjadi lagi, menegakkan kedisiplinan DPJP Anestesi
		D	Koordinasi dengan DPJP anestesi, mengingatkan kembali bahwa hanya dokter yang ber SIP yang boleh praktek
		S	DPJP baru belum paham bahwa harus izin manajemen jika akan cuti karena tidak ada di kontrak
		A	Membuat alur jika ada dokter anastesi dua-duanya yang libur sehingga bisa di kondisikan oleh kabid pelayanan

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Terjadi beberapa IKP di IGD	P	Melakukan telusur penyebab banyaknya IKP yang ada di IGD
		D	Koordinasi dengan kabid keperawatan ,kabid pelayanan,kains dan karu IGD untuk mencari solusi
		S	Kurangnya komunikasi antar PPA
		A	Membuat alur yang benar dan Berkoordinasi dengan baik ,baik perawat igd,dokter igd maupun dpjp jika dpjp memberi advice yang kurang jelas bisa di konfirmasi kembali
2	Petugas IGD masih kurang ramah dalam pemberian pelayanan	P	Melakukan telusur terlebih dahulu perawat yang kurang ramah ini
		D	Koordinasi dengan karu IGD untuk melakukan konseling terhadap perawat yang bersangkutan dan sosialisasi kembali kepada semua staf IGD pentingaya keramahan ke pasien
		S	Ada 1 kasus /komplain pasien dalam bulan oktober ini tentang perawat yang kurang ramah
		A	Membuat aturan saat pelayanan harus menggunakan 5s dan hal ini harus di supervisi oleh karu
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Pengisian rekam medis yang di tulis oleh dr IGD tidak sesuai	P	Memaksimalkan kinerja dokter IGD agar tidak terjadi komplain serupa

	dengan kondisi pasien sehingga banyak DPJP yang komplain terkait pemeriksaan dokter IGD	D	Berkoordinasi dengan kains IGD untuk memperhatikan kembali dalam pengakajian dan pemeriksaan di dalam IGD sesuai dengan kondisi pasien
		S	Pemeriksaan dokter IGD kurang komprehensif karena system IGD, dokter IGD harus bekerja cepat, hanya memeriksa sesuai keluhan pasien
		A	Memberikan masukan ke dokter IGD untuk pemeriksaan yang benar dan penulisan rekam medis yang sesuai melalui kains dokter IGD
2	Transfer pasien dari IGD ke IKO yang akan di lakukan operasi cito belum di berikan obat premed sudah di kirim terlebih dahulu sehingga dokter anastesi marah karena tidak sesuai dengan spo	P	Melakukan rencana penelusuran masalah yang di lakukan oleh IGD
		D	Menelusur terlebih dahulu ke perawat igd dan dokter IGD selama di IGD
		S	Menemukan 1 kasus pasien dr anton pindah ke IKO sebelum di berikan advice oleh dr anastesi sudah di pindah
		A	Perawat dan dokter IGD menemui dokter anastesi untuk meminta maaf karena tidak sesuai dengan spo, dan setiap pasien yang akan di rencanakan operasi transfer pasien harus sesuai dengan spo yang benar

3.7.3
Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Dokter anastesi sudah tidak sesuai dengan paket SC dalam pemberian obat	P	Koordinasi dengan kabinid pelayanan untuk kolaborasi dengan dr anastesi
		D	Bertemu dengan dr anastesi membahas pakets SC
		S	Terdapat banyak kasus advice dr anastesi beda dengan paket sc
		A	Mengadakan rapat dan harus ada kesepakatan untuk obat paket sc
2	Absen dokter	P	Menelusur terlebih dahulu kendala yang di alami kasir saat perawat menurunkan absensi ke kasir
		D	Koordinasi dengan kasir jika ada pasien umum di dahulukan terlebih dahulu adminitrasinya sehingga pasien tidak perlu menunggu terlalu lama
		S	Ada beberapa pasien umum absen sudah di turunkan oleh perawat sudah 2 jam tetapi pada saat di konfirmasi ke kasir ,kasir baru di lihat tidak langsung di hitung pas awal di berikan
		A	Menjalankan sessuai dengan arahan kabinid jika ada pasien pulang absen dokter tetap di turunkan tetapi langsung diberikan di meja kasir
3	Petugas IGD saat memindahkan ke ruangan ICU masih sering lupa membawah foto thorak basahannya	P	Rapat antara kepala IGD dan ICU serta kabinid dalam kesepakatan
		D	Membuat kesepakatan antara ruangan ICU dan IGD memindahkan dengan foto thorak basanya
		S	Dalam 1 bulan ini ada 2 kasus memindahkkan pasien ke ICU tidak membawah foto thorak
		A	Menjalankan sesuai dengan kesepakatan anatara

			kepala ruangan dan di sosialisasikan kepada perawat pelaksana
4	Petugas Rawat Inap masih kurang ramah dalam pemberian pelayanan	P	Melakukan telusur terlebih dahulu perawat yang kurang ramah ini
		D	Koordinasi dengan karu Irna untuk melakukan konseling terhadap perawat yang bersangkutan dan sosialisasi kembali kepada semua staf Irna penting gaya keramahan ke pasien
		S	Pada saat kbid keperawatan keliling dan langsung menanyakan ke pasien banyaknya pasien mengeluh terhadap pelayanan oleh perawat
		A	Membuat aturan saat pelayanan harus menggunakan 5s dan hal ini harus di supervisi

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Penyesuaian surat kontrol	P	Koordinasi dengan pendaftaran untuk kie jika mundur kontrol harus konfirmasi terlebih dahulu
		D	Sosialisasi ke semua pasien lewat media sosial untuk kontrol mundur tidak bisa di layani
		S	Beberapa pasien komplain terkait tidak bisa di layani dengan tidak sesuai jadwal kontrol
		A	Berkoordinasi dengan asisten dan pendafran tentang sosialisasi ini
2	Obat tertinggal	P	Mengadakan rapat ke semua bagian yang bersangkutan untuk meminimalisirkan obat tertinggal
		D	Berkoordinasi dengan dokter dpjp, asisten dan farmasi jika ada pasien datang dan tidak pernah mengambil obat harus di ingatkan kembali oleh DPJP
		S	Banyaknya pasien yang tidak mengambil obat untuk bulan oktober ini 65 pasien
		A	Menjalankan ini sehingga tidak ada obat yang tertinggal di apotik
3	Rujukan FKTP	P	Menelusur terlebih dahulu rujukan dari FKTP yang tidak sesuai dengan pemeriksaan DPJP yang ada di rumah saki
		D	Koordinasi dengan tim ferif dan kbid pelayanan potensi terkena audit BPJS
		S	Pasien rujukan dari FKTP ke rumah sakit untuk mencantumkan pada rekam medis rumah sakit adalah diagnosa spesialsitik (di luar 144 diagnosa FKTP) misalnya rujukan dengan bronkiolitis setelah di lakukan pemeriksaan di RS oleh DPJP bronkitis
		A	Jika ditemukan diagnosa yang tidak sesuai dengan diagnosa rujukan ,maka pasien dapat di PRB atau di tulis di surat rujuk baliknya bahwa pasien bisa di layani di FKTP

3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif.	P	Perencanaan scan barcode.
		D	1. Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. 2. Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.
		S	Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien.
		A	Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
2.	Ruang Pencampuran Obat (LAF) tidak sesuai standar akreditasi.	P	Melakukan renovasi LAF.
		D	Melakukan survey lokasi yang cocok untuk perpindahan ruangan LAF yang baru.
		S	Mengacu pada penilaian ruangan LAF pada akreditasi Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan standar.
		A	3. Kolaborasi dengan PT untuk meminta tukang melakukan renovasi sesuai dengan standar akreditasi (denah sudah diberikan). 4. Penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-bock air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril.
3.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 76.95% dan waktu tunggu obat racikan 59.54%	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	2. Follow up ke Programmer. 3. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 408 KPO.
4.	Penulisan kartu stok tidak lengkap, baik di Depo Farmasi maupun di Depo IKO.	P	Memperbaiki supervise petugas farmasi.
		D	Menentukan PJ supervise setiap unit, yaitu Asharul Fahrizi (PJ Rawat Inap), Diryati Barin (PJ Rawat Jalan), Fadilah Maulana (PJ Depo IKO).
		S	1. Supervisi petugas farmasi dalam

			melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok. 2. Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
		A	Semua staff farmasi sudah mendapatkan teguran lisan dan membuat surat pernyataan komitmen penulisan kartu stok.
5.	Pending Resep meningkat dikarenakan ada hutang obat yang diakibatkan dari kekosongan obat.	P	Mengajukan substitusi obat.
		D	Melakukan koordinasi dengan DPJP dan Pengadaan terkait substitusi obat dan pelayanan resep.
		S	DPJP meminta obat tetap diberikan sehingga resep yang sudah masuk tetap dilayani, dan obat yang belum ready menjadi hutang farmasi sampai barang datang.
		A	1. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk mencari ke seluruh distributor. 2. Membuatkan SE kekosongan obat dan dishare kepada seluruh DPJP. 3. Mengajukan pengadaan sediaan obat paten yang memiliki kandungan sama dengan obat yang kosong dan tidak ada substitusi, seperti spinorolactone.
6.	Waktu tunggu pelayanan farmasi rawat jalan lama sehingga banyak complain pasien.	P	Mengurangi waktu tunggu di Farmasi. Mendisiplinkan DPJP dalam penginputan e-resep per pasien (tidak dilakukan rapel).
		D	Koordinasi dengan Kabid Pelayanan untuk mengedukasi DPJP.
		S	Jumlah pasien rawat jalan per kunjungan tidak ada batasan sehingga terjadi penumpukan pasien di Poli sampai menunggu di Farmasi.
		A	1. Pasien ditawarkan PRIMANTARA agar tidak menunggu obat lama. 2. Resep obat diinput per pasien oleh DPJP. 3. Rencana diadakan nomor antrian untuk pasien yang menunggu obat.
7.	Sediaan vaksin yang tidak segera digunakan oleh pasien sejak tahun 2023, barang ada di Kulkas Depo Farmasi.	P	Memperbaiki pencatatan keluar masuknya inden vaksin. Memperbaiki kebijakan inden vaksin dari Poli Spesialis.
		D	Kolaborasi dengan Kains Farmasi, Gudang Farmasi, MOD, Kasir dan Karu IRJA.
		S	Pemesanan vaksin hexaxim an An Yahya Hermawan sejak Juli 2023 belum digunakan, inden vaksin menggunakan jaminan Asuransi.
		A	5. Membuatkan spreadsheet pemesanan vaksin dengan keterangan jadwal vaksin dan ED vaksin untuk memudahkan MOD menginformasikan kepada pasien. 6. Membuat kebijakan pembayaran penuh untuk inden vaksin meskipun jaminan asuransi, uang akan direture jika pasien datang untuk pelaksanaan

			vaksin. 7. Menghubungi pasien-pasien yang tidak datang sesuai jadwal untuk kepastian jadwal pelaksanaan, jika tidak ada DP maka dialihkan kebutuhannya untuk pasien lain.
8.	Kebutuhan tenaga di Gudang Farmasi	P	Menghitung ulang analisa beban kerja.
		D	Melakukan evaluasi kinerja dan melakukan rotasi petugas dari unit lain yang berkompetensi untuk dirotasi menjadi Admin Gudang Farmasi.
		S	Beban kerja berkurang, sesuai dengan job desk sehingga pelayanan optimal.
		A	Melakukan rotasi per tanggal 01 November 2024.

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Pengadaan BDRS belum berjalan.	P	Membuat target pelaksanaan BDRS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Follow up ke Pengadaan PT.
		S	BDRS disiapkan sebelum kredensialing BPJS pada tanggal 18 November 2024.
		A	Follow up berkala ke Pengadaan PT. Hasil follow up : 8. Refrigerator sudah diproses, sedang dibuatkan PJB (perjanjian jual beli), estimasi datang pada minggu kedua di Bulan November 2024.
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	9. Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 10. Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 11. Menentukan stok minimal untuk order reagen.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Pengadaan BDRS belum berjalan.	P	Membuat target pelaksanaan BDRS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Follow up ke Pengadaan PT.
		S	BDRS disiapkan sebelum kredensialing BPJS pada tanggal 18 November 2024.
		A	Follow up berkala ke Pengadaan PT. Hasil follow up : 12. Refrigerator sudah diproses, sedang dibuatkan PJB (perjanjian jual beli), estimasi datang pada minggu kedua di Bulan November 2024.
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	13. Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 14. Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 15. Menentukan stok minimal untuk order reagen.
NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Layanan Poli yang belum masuk kedalam E-RM -Poli KIA -Poli Gizi	P	Melakukan permintaan fitur kepada Programmer PT.
		D	Membuat flow chart alur pelayanan pada Poli KIA dan Poli Gizi untuk diterapkan pada E-RM.
		S	Kekurangan jika kunjungan Poli KIA dan Poli Gizi dilakukan pencatatan secara manual maka hasil konseling tidak terekap dengan baik dan tidak bisa diakses oleh DPJP, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan lanjutan yang terintegrasi. Pencatatan manual resiko hilangnya sangat tinggi.
		A	Follow up ke Programmer PT. Hasil konseling disampaikan kepada

			asisten setiap DPJP.
2.	Kebijakan baru dari BPJS Kesehatan tentang Kunjungan Kontrol Poli Rawat Jalan	P	Menjalankan kebijakan baru dengan meminimalisir complain.
		D	Melakukan pemberitahuan melalui social media sebelum kebijakan dijalankan.
		S	Menertibkan pasien control sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
		A	16. Melakukan edukasi kepada pasien yang pulang rawat inap atau selesai control di IRJA untuk control sesuai dengan jadwal yang tertera di surat control, jika ingin mundur maka konfirmasi H-1 ke RS untuk dibantu edit surat control oleh petugas. 17. Melakukan edukasi berkala kepada pasien saat melakukan pendaftaran di Pendaftaran Central. 18. Membuat grup dengan unit-unit terkait untuk mendiskusikan masalah yang ditemui dan dikonsulkan dengan petugas verifikator supaya mendapatkan pemecahan masalah.

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1. Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2. Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid	P	Memperbaiki pencatatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai pada awal Bulan Januari 2025, sebelumnya akan dilakukan SO. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan.

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Petugas melakukan double job di 2 RS yang berbeda.	P	Melakukan tindak lanjut terhadap petugas.
		D	Melakukan telusur dan konfirmasi kepada RS lain.
		S	Pelayanan terganggu karena petugas tidak datang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Karu, selalu terlambat dalam 1 minggu akhir Bulan September 2024.
		A	Koordinasi dengan SDM untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib yang ada di RS Prima Husada Malang.
2.	Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan DPJP tidak tertera pada Billing SIMRS	P	Mengajukan review tarif CTA Cardiac.
		D	Mendata BHP yang dibutuhkan dan mengajukan review tarif ke Keuangan PT.
		S	Dengan adanya tarif baru CTA Cardiac di Billing SIMRS dapat mempermudah petugas saat konfirmasi petugas asuransi/jaminan yang dimiliki oleh pasien, apakah pemeriksaan tersebut tercover atau tidak.
		A	Memastikan nama dan tarif pemeriksaan penunjang sudah tertera pada Billing SIMRS.

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	41	14	0	14	0
		S1 Farmasi		4	3	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		D3 Farmasi		19	3	16	0
		SMK		3	0	7	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	11	1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	0	8	0

		SMK		1	1	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	2	1	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
		SMK		2	1	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	3	1	2	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	1
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketng	Profesi Ners	2	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	25	10	2	8	0
		D3 Keperawatan		9	0	9	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	2	0
		D3 Kebidanan		3	0	3	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	2	5	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	0	1	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
19	IRJA	Profesi Ners	27	7	4	3	0
		D3 Keperawatan		15	5	10	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		4	3	1	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	7	4	1	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		2	0	2	0
21	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	20	16	1	15	0
		D3 Keperawatan		4	0	4	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	16	6	0	6	0
		D4		1	0	1	0

		Keperawatan					
		D3 Keperawatan		8	0	8	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
23	IRNA 5C Anak	Profesi Ners	9	2	0	2	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		6	0	6	0
24	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	24	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		D3 Keperawatan		12	0	12	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Kebidanan		8	0	8	0
26	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	1	4	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		2	1	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		3	3	0	0
		SMA		1	0	1	0
28	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	0	2	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	0	8	0
29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	4	6	0
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Ilmu Sosial		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	0	1	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	2	4	0
		SMK		5	0	5	0
		SMA		1	1	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	6	2	1	1	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0

34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
36	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	0	3	0
38	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	25	5	20	0
		SMA		15	0	15	0
40	Security	SMK	12	7	4	3	0
		SMA		5	2	3	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0
		SMP		2	0	2	0
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
48	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
50	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
51	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
52	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
53	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
54	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0

56	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			459				

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta menterbitkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Oktober 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan September 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 November 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	INSTANSI	NAMA PKS	NOMOR RS	NOMOR INSTANSI	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017	12 Desember 2017	Berlaku
2	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
3	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
4	PT Prudential Life Insurance	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan		3143/PMN-PA/IV/2020	13 April 2020	Berlaku
5	PT AIA Financial	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	069/DPM/E-PKS/DIR/X/2020	639/AIA-DPM/XI/2020	4 November 2020	Berlaku
6	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	150/ PKS-RSPRIMAHUSADA-MAT/DIR/XI/2016		28 November 2016	Berlaku
7	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015	19 September 2019	Berlaku
8	PT. Suprima Mitra Adihusada	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019	26 agustus 2019	Berlaku
9	PT. Equity Life IND-Corporate	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		091/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
10	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013	15 Agustus 2013	Berlaku
11	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012	9 Oktober 2012	Berlaku

	Sinarmas Msig	Kerjasama Pelayanan Kesehatan				
12	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	010/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019	9 April 2019	Berlaku
13	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015	16 Maret 2015	Berlaku
14	PT. Equity Life IND-Cassles	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		090/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
15	PT. Asuransi Adira Dinamika	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013	24 Oktober 2013	Berlaku
16	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018	17 September 2018	Berlaku
17	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	082/RSPH/E-IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716	24 Juli 2019	Berlaku
18	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	025/RSPH/E-PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015	28 April 2018	Berlaku
19	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	070/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019	10 Oktober 2019	Berlaku
20	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015	25 Februari 2015	Berlaku
21	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	508/RSPH/E-IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/II/2017	02 Januari 2017	Berlaku
22	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	017/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020	2 Maret 2020	Berlaku

	Manulife Indonesia	Pelayanan Kesehatan Peserta Individu				
23	PT. AJ Central Asia Raya (CAR)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019	29 November 2019	Berlaku
24	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C	21 Agustus 2020	Berlaku
25	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	612/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2019	300/PKS/TKI/X/2019	30 Oktober 2019	Berlaku
26	PT. Asuransi Jasa Indonesia	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	PKS.031/GHASKES/157-1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020	28 Agustus 2020	Berlaku
27	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	490/RSPH/I-IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016	7 September 2020	Berlaku
28	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	017/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS-PHMS/VIII/2020	31 Agustus 2020	Berlaku
29	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	-	-	4 Januari 2014	Berlaku
30	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022	10 maret 2022	Berlaku
31	PT. Asuransi Jiwa BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan Kesehatan	149/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023	10 Oktober 2023	Berlaku
32	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang			11 September 2012	Berlaku
33	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	-	55/Perj/HMS/IX/2014	1 Juni 2014	Berlaku
34	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku

		Pemeriksaan Medicak Chek Up				
35	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan			1 April 2013	Berlaku
36	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85	5 januari 2012	Berlaku
37	PT. Coca Cola Distribution Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019	9 Januari 2019	Berlaku
38	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)			1 Oktober 2014	Berlaku
39	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan			20 Maret 2015	Berlaku
40	Harris Hotel & Convensions Malang	Rujuka Pelayanan Kesehatan	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018	14 Oktober 2019	Berlaku
41	PT. Duha Mulya Abadi	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac			11 januari 2019	Berlaku
42	RS Sahabat Pasuruan	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	1097.1/E.PKS/DIR/VIII/2021		2 Desember 2016	Berlaku
43	PT. Asuransi Dayin Mitra TBK		003/MKT/HLT/PKS/II/2015	PH/IKS/269/XII/2014	1 Mei 2015	Berlaku
44	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkitan Umum dan Lalu Lintas Jalan	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022	4 Juli 2022	Berlaku
45	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan			7 Februari 2023	Berlaku

		Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan				
46	Klinik Pratama Rawat Jalan Mawar Waskitha Husada	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024		23 Januari 2024	Berlaku
47	Klinik Losari Medika	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024		6 Februari 2024	Berlaku
48	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850	1 September 2022	Berlaku
49	RS Persada	Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog	152.42/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022	10 Oktober 2022	Berlaku
50	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	103.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023	26 Juni 2023	Berlaku
51	ASABRI	PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF	1902/E-PKS/DIR/XII/2023	PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023	13 Desember 2023	Berlaku
52	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023	15 April 2023	Berlaku
53	Klinik Tirto Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023	18 September 2023	Berlaku
54	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23	24 April 2023	Berlaku
55	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023	3 Juli 2023	Proses di Pihak Kedua

56	Klinik Jantung Hasna Medika Malang	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR/HMMALANG/XII/2023	1 Desember 2023	Berlaku
57	Klinik Rawat Inap Wijaya Husada	Rujukan Asuhan Pasien	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	15 April 2023	Berlaku
58	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH	21 Juli 2023	Berlaku
59	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	188/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023	3 Oktober 2023	Berlaku
60	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	131.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023	31 Mei 2023	Berlaku
61	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023	5 Juni 2023	Berlaku
62	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	142.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023	22 Juni 2023	Berlaku
63	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023	1 November 2023	Berlaku
64	PT. Arthawena Sakti Gemilang	Pelayanan Rujukan kesehatan	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	-	15 Juni 2023	Berlaku
65	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit			22 April 2022	Berlaku
66	CV. Aumireta Anggun	Rujukan Pelayanan Kesehatan	164.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	-	28 Agustus 2023	Berlaku
67	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan	220.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023	30 Oktober 2023	Berlaku
68	RS Islam Unisma Malang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	MENUNGGU SEKRETARIAT	1 Januari 2024	Berlaku
69	RS Puri Bunda	Rujukan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/II/2024	6 Februari 2024	Berlaku

		Pelayanan Kesehatan dan Penunjang				
70	RSUD Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	245.1/E-PKS/DIR/II/2024	074.3/35.07.302.102/2024	1 Maret 2024	Berlaku
71	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023		24 Agustus 2023	Berlaku
72	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123	30 Januari 2023	Berlaku
73	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan Pasien	004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022	-	10 Januari 2022	Berlaku
74	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang			2 Agustus 2022	Berlaku
75	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	200.11/DPM/I-PKS/DIR/I/2022		5 Januari 2022	Berlaku
76	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	112.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022	2 Agustus 2022	Berlaku
77	PT. Jaya Obayashi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	360/DPM/I-PKS/VIII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
78	PT. Malang Intermedia Pers	Pelayanan Kesehatan	025/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020	1 Juli 2020	Berlaku
79	PT. Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	032/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
80	PT. Yamaha Musical Product Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP BAGI KARYAWAN DAN KELUARGA	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/II/PKS/III/2020	1 Juni 2022	Berlaku
81	PT. Tirta Investama	PELAYANAN			31 Agustus 2020	Berlaku

		KESEHATAN KARYAWAN & KELUARGA				
82	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023	1 Januari 2023	Berlaku
83	PT. Kemas Super Indonesia (KSI)	Pelayanan Kesehatan				Berlaku
84	PT. Nayaka Era Husada	Pelayanan Kesehatan	143.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PKS/106/072023	30 Mei 2023	Berlaku
85	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	768/E-PKS/DIR/V/2023	#REF!	1 Juni 2023	Berlaku
86	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	1790/E-PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023	20 November 2023	Berlaku
87	RS Lavalette	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	155.2/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124	10 Agustus 2023	Berlaku
88	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E-PKS/III 2019	21 Februari 2022	Berlaku
89	RS Panti Nirmala	Kerjasama Pelayanan Rujukan	152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022	7 Oktober 2022	Berlaku
90	PT Kimberly Clark	Pasokan produk		106/KCS-PNS/MOU/II/2023	1 Januari 2024	BERLAKU
91	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	267/RSPHS/E-PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019	18 September 2019	Berlaku
92	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG)	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan	015/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2	28 Januari 2020	Perpanjang Otomatis
93	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan	1879/E-PKS/DIR/XII/2023	602/KTR/VII-05/1223	1 Januari 2024	Berlaku

		Bagi Peserta Program JKN				
94	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022	1 Januari 2023	Berlaku
95	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	031/DPM/E-PKS/DIR/III/2022		10 Maret 2021	Progres Pihak Kedua
96	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	347/DPM/I-PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021	16 Juni 2021	Progres Pihak Kedua
97	PT. Etercon Pharma	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien Maternitas	132.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023	1 Juni 2023	Proses Pihak Kedua
98	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	339.6/E-PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022	1 Maret 2022	Proses Review Kabid
99	PT. Kencana Tiara Gemilang (KTG)	Pelayanan Kesehatan	174.1/DPM/E- PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021	12 Desember 2021	Berlaku
100	PT. Rentokil	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station	173.1/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG-37/52400326/IX/2023	11 September 2023	Berlaku
101	PT. Pillar Utama Cortindo	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023	1 Juni 2023	Progres di PT
102	PT. Global Trans Jaya Mulia & PT Global Enviro Nusa	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	115/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	044/SPK-T/DPM-GTJM/GEN/IV/2024	15 April 2024	Berlaku

103	PT. Uniplastindo Interbuana	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	302/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021	8 Juni 2023	Proses TTD Pihak Kedua
104	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019	1 November 2022	Berlaku
105	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	152.40/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022	16 September 2022	Berlaku
106	RS Siti Miriam Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	151.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022	4 Oktober 2022	Berlaku
107	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	234/DPM/E-PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024	1 November 2024	Berlaku
108	RSU Muhammadiyah (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi	159.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023	21 Agustus 2023	Disposisi SIMRS
109	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis	1183/E-PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023		PROSES PERMOHONAN
110	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			23 Februari 2024	Berlaku
111	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan				PROSES TTD DILUAR

112	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan				PROSES DISPOSISI SIM
113	PT Teknologi Pamadya Analitika (Meditap)	Asuransi Pelayanan Keshatan				PROSES PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN PKS
114	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	294/E-PKS/DIR/I/2024		17 Januari 2024	Berlaku
115	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Protesa Ortesa				PROSES DISPOSISI SIM
116	PT Pesta Pora Abadi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024			Review Pihak kedua
117	Batas Media 99	Rujukan Pelayanan Kesehatan			5 Juni 2024	Berlaku
118	PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia	Rujukan Pelayanan Kesehatan				TTD Dir PT
119	PT Tentrem Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan			Review Pihak kedua	
120	Klinik Utana Rawat Jalan Akasia	Rujukan Pelayanan Kesehatan	25 April 2024		Berlaku	
121	PT Ustegra	Rujukan Pelayanan Kesehatan			Review Pihak kedua	
122	PT Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	12 Juni 2024		Berlaku	
123	PT Unggul Anugerah Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan	4 Juni 2024		Berlaku	
124	PT Bestari Murni Anugerah	Rujukan Pelayanan Kesehatan	4 Juni 2024		Berlaku	
125	PT Indonesian Marine	Rujukan			Review Pihak kedua	

		Pelayanan Kesehatan					
126	PT Randi Cones Indonesia	Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
127	PT Indonesian Tobacco	Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
128	PT Tonggak Ampuh	Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
129	Klinik Beauty Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	145/DPM/E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2004	25 Mei 2024		Berlaku
130	Ibazz Aesthetic and Medical Center	Rujukan Pelayanan Kesehatan	180/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024		14 Juni 2024		Berlaku
131	RS Universitas Brawijaya	Rujukan Pelayanan Kesehatan	178/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024				Review Pihak kedua
132	PT Citra Karsa Dinamika	Rujukan Pelayanan Kesehatan					Proses TTD Pihak Kedua
133	PT Moor Sukses Internasional	Rujukan Pelayanan Kesehatan	200/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	001/MSI/VI/2024	8 Juli 2024		Berlaku
134	BPM Nia Irawati	Rujukan Pelayanan Kesehatan	081/DPM/E-PKS/DIR/III/2024		7 Februari 2024		Berlaku
135	Instruktur Zumba	Instruktur Zumba			23 Februari 2024		Berlaku
136	Klinik Esweje	Rujukan Pelayanan Kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9120200211338	1 Maret 2024		Berlaku
137	PT Alfiza Medika Utama	Rujukan Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024	7 Maret 2024		Berlaku
138	PT Medilink Digital Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024	22 Maret 2024		Berlaku

139	BPM Riza Khutmi	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
140	BPM Indah Maharany	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
141	PT Indostar Building Material	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
142	Rajawali Plastik	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Proses TTD Pihak Kedua
143	Green Mountain Natural Foods	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
144	PT Indonusa Algaemas Prima	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak Kedua
145	RSUD Bangil	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024	22 Juli 2024	Berlaku